



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN APRIL
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang 2

2.1 Visi 2

2.2 Misi..... 2

2.3 Motto 2

2.4 7 Nilai Budi Utama 2

2.5 Struktur Organisasi 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan..... 4

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI) 4

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut 4

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan 5

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada 6

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan 31

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik 31

3.3.2 Rawat Inap 33

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU) 41

3.3.4 High Care Unit (HCU) 42

3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 43

3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO) 44

3.4 Kinerja Bidang Penunjang 46

3.4.1 Instalasi Farmasi 46

3.4.2 Laboratorium 65

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran..... 69

3.4.4 Radiologi 75

3.4.5 Gizi 80

3.4.6 CSSD - Laundry 91

3.5 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan 99

3.5.1 SDM 99

3.5.2 IPSRS 107

3.5.3 Security 111

3.5.4 Parkir..... 115

3.5.5 Humas Marketing 115

3.5.6 Penjaminan 120

3.5.7 PIPP – MOD - MPP..... 121

3.5.8 *Cleaning Service* 130

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum..... 131

3.6 Komite dan Tim 133

3.6.1 Komite Mutu 133

3.6.2 Komite PPI 186

3.6.3 Tim PKRS..... 199

3.6.4 Tim Prognas..... 200

3.6.5 Tim PPRA..... 240

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT 246

3.7 Permasalahan Rumah Sakit 248

3.8 Profil SDM 263

Bab IV Kesimpulan dan Saran..... 268

Bab V Penutup..... 269

Lampiran 270

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan April Tahun 2025 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



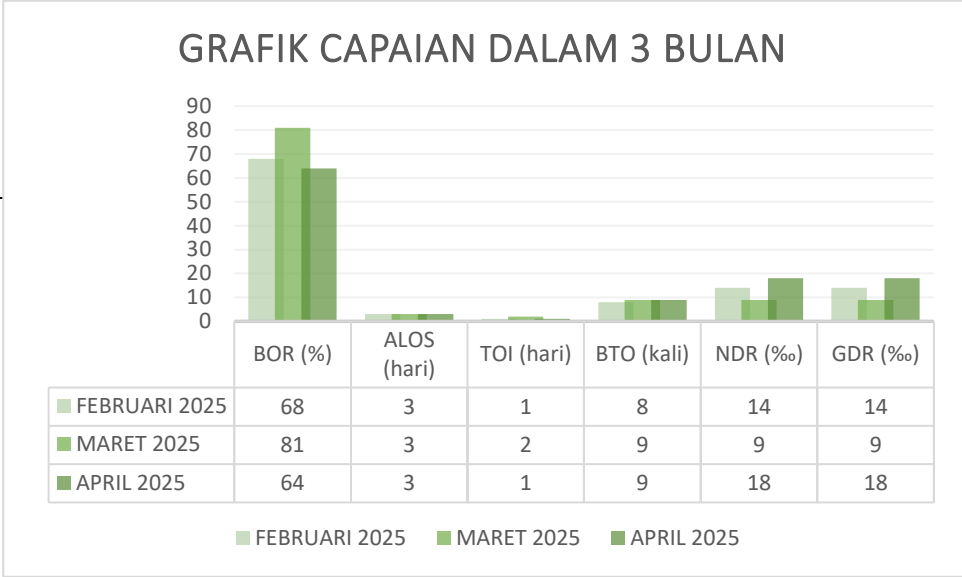
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

NO	INDIKATOR	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025	STANDAR IDEAL	EVALUASI UMUM
1	BOR	68	81	64	60–85%	Semua dalam standar, fluktuatif
2	ALOS	3	3	3	BPJS : 3 Umum: 6–12	Stabil, sesuai untuk BPJS
3	TOI	1	2	1	1–3 hari	Berfluktuasi, masih wajar
4	BTO	8	9	9	4–5 kali	Konsisten tinggi, di atas standar

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

Analisis Tren Per Bulan :

1. BOR :
- 1) Februari (68%) : Dalam standar, utilisasi cukup baik.
 - 2) Maret (81%) : Mendekati batas atas, tempat tidur hampir penuh.
 - 3) April (64%) : Terjadi penurunan signifikan dari Maret.

Tren :
Fluktuasi tajam → Perlu ditelusuri penyebab naiknya BOR di Maret dan penurunannya di April. Mungkin terkait volume pasien, outbreak penyakit, atau perubahan kebijakan.

2. LOS :
- 1) Stabil di angka 3 hari untuk tiga bulan berturut-turut
 - 2) Sesuai Surat Edaran PT. Disa Prima Medika untuk pasien BPJS, tetapi terlalu rendah untuk pasien umum (standar: 6–12 hari).

Tren :
Konsisten, tetapi perlu audit LOS pasien umum

3. TOI
- 1) Februari : 1 hari → efisien
 - 2) Maret : 2 hari → sedikit lebih lama waktu kosong antar pasien
 - 3) April : 1 hari → kembali efisien

Tren :
Berfluktuasi ringan namun masih dalam rentang standar

4. BTO
- 1) Februari

: 8 kali
- 2) Maret

: 9 kali
- 3) April

: 9 kali
- Tren :
- Terlalu tinggi dari standar ideal (4–5 kali), yang bisa menandakan rotasi pasien sangat cepat → perlu dievaluasi dari aspek beban kerja, mutu layanan, dan risiko infeksi silang.

Masalah :

NO	ISU	PENJELASAN
1	Fluktuasi BOR	Bisa mencerminkan ketidakteraturan alur pasien atau perbedaan kebijakan antar bulan.
2	LOS terlalu singkat untuk pasien umum	Risiko pemulangan dini, kemungkinan readmisi meningkat.
3	BTO tinggi secara konsisten	Potensi beban kerja berat bagi tenaga medis, penurunan mutu perawatan, dan tekanan administratif.
4	TOI rendah	Efisien, tetapi dalam konteks BTO tinggi → bisa berarti pasien terlalu cepat digantikan.

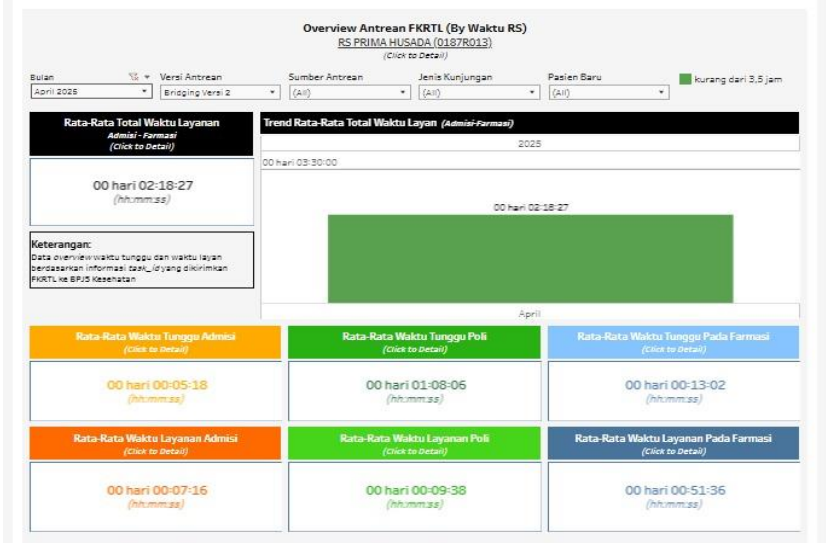
- Rencana Tindak Lanjut :
1. Evaluasi Manajemen Pelayanan Rawat Inap
- a) Tinjau alur pasien dan penyebab fluktuasi BOR

b) Koordinasi antar unit untuk menjaga kestabilan utilisasi tempat tidur.
2. Audit LOS Berdasarkan Jenis Pasien
- a) Pisahkan analisa LOS pasien BPJS dan umum

b) Cek outcome klinis untuk mendeteksi risiko pemulangan terlalu dini
3. Kaji Kembali Beban Kerja SDM
- a) Lakukan survei kepuasan dan kelelahan staf medis akibat BTO tinggi

b) Pertimbangkan redistribusi staf atau perekrutan tambahan jika diperlukan
4. Implementasi Sistem Bed Management
- Gunakan sistem digital untuk manajemen tempat tidur real-time dan efisiensi ruang rawat inap
5. Monitoring Mutu Layanan
- Pantau indikator mutu lain seperti readmisi, komplain pasien, dan kepuasan pasien pasca rawat inap
6. Kesimpulan :
- Ada fluktuasi tajam BOR yang perlu distabilkan, BTO terlalu tinggi secara konsisten, bisa berdampak pada mutu dan beban kerja dan LOS tetap 3 hari, ideal untuk pasien BPJS, namun harus diawasi untuk pasien umum

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN		BULAN (2025)			
	Waktu Rata-Rata	Rata-Rata Tahun 2024	Januari	Februari	Maret	April
1	Total Waktu Layanan	2:12:37	02:07:27	01:59:21	02:09:52	02:18:27
2	Waktu Tunggu Admisi	0:11:52	00:07:37	00:04:57	00:06:52	00:05:18
3	Waktu Layanan Admisi	0:07:49	00:05:49	00:04:58	00:05:36	00:07:16
4	Waktu Tunggu Poli	1:03:51	01:06:01	01:05:56	01:02:05	01:08:06
5	Waktu Layanan Poli	0:14:56	00:09:41	00:10:08	00:10:47	00:09:38

Analisis :
 Pada bulan ini jika dibandingkan rata-rata tahun 2024 maka bulan ini masih lebih baik dilihat dari waktu total layanan. Namun terjadi peningkatan dari bulan sebelumnya.

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer
Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

NO	JENIS	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	>30%	45,98%	46,43%	47.64%	
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	96,72%	95.11%	94.28%	

Analisis :
 Pemanfaatan antrian online sudah mencapai target yang disyaratkan (>30%) dan (>90%)

Plan	Mempertahankan hasil > 30% dan meningkatkan untuk kinerja di bulan selanjutnya
Do	Sosialisasi ke unit terkait
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabid

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Bimbingan Doa pada pasien IRNA	Sudah berjalan rutin 3x seminggu	Berjalan dengan baik dan respon pasien baik
2	IRNA	Senam hamil	Senam hamil berjalan rutin	-
		Penambahan TT rawat inap, untuk VIP kelas 1 dan kelas 2	Sudah selesai	Fasilitas seperti tv masih belum terpasang
		Foto bayi	Sudah berjalan	Fasilitas dari unit sendiri
		ERM rawat inap	Belum berjalan tetapi sudah ada progres dengan trial	Masih banyak yang eror
3	IRJA	Poli Eksekutif	Sudah berjalan mulai dari 2024 untuk bulan april 2025 ada 31 pasien, 15 pasien di dominasi oleh pasien obgyn dan anak 10 pasien	Pasien saraf sakura masih belum ada pasien sama sekali untuk bulan april 2025
4	IGD	Edukasi mengenai kriteria kegawatan menurut BPJS	Membuat video edukasi, sudah terpasang poster di IGD tentang pelayakit yang tidak terkafer bpjs	Sudah terpasang di IGD
BIDANG PENUNJANG				
1	Depo Farmasi	1. KPO Elektronik (E-KPO)	a. Penulisan KPO (Kartu Pengambilan Obat) menulis manual sehingga memperlama waktu tunggu obat rawat jalan. b. Pengajuan form penambahan fitur E-KPO ke programmer yaitu data obat di print dengan printer thermal kemudian di tempel ke KPO pasien. c. DPJP bisa mengakses e-KPO di SIMRS. d. Jumlah KPO tertinggal : 126. 1. Belum tersedia printer thermal untuk cetak e-	Dalam antrian progamer

			KPO.	
		2. Perbaikan sistem ROP Depo Farmasi dan Gudang Farmasi	a. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan barang dari depo ke Gudang Farmasi melalui rumus ROP. b. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan pembelian Gudang Farmasi melalui rumus ROP. 1. Fitur sisa stok depo pada sistem ROP sudah tersedia.	Monitoring dan evaluasi rumus ROP yang sudah ada
		3. Renovasi ruang Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart	a. Renovasi Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart selesai tanggal 20/03/2025, ruangan steril dilapisi vinyl dan monitoring tekanan ruangan dengan magnehelic dan dicatat pada spreadsheet. b. Form pengajuan penambahan 1 unit Laminar Air Flow (LAF) untuk dispensing sediaan steril dan 1 unit pass-box air lock untuk tempat masuk dan keluarnya alat kesehatan dan bahan obat sebelum dan sesudah dilakukan pencampuran. <i>Pass box</i> ini terletak di antara ruang persiapan dan ruang steril. Form sudah masuk ke Pengadaan PT. Disa Prima Medika.	Follow up form pengajuan LAF dan pass-box air lock
		4. Perluasan ruang Depo Farmasi sesuai standart	a. Pengajuan perluasan ruangan di depo farmasi untuk penggantian lemari pendingin yaitu penyimpanan obat ke lemari pendingin yang lebih besar dan vaksin di letakkan dalam <i>vaccine refirigerator</i> disertai Log tag. b. Perluasan ruang buffer stok 6 Maret 2025,	Koordinasi dengan kepala bidang terkait rencana lokasi penyimpanan showcase 2 pintu (785 liter) dan <i>vaccine refirigerator</i> .

			sudah tersedia cctv dan smart door lock.	
		5. Website PRIMANTARA	a. Presentasi MOCKUP oleh Programmer PT sudah dilakukan pada tanggal 23/09/2024. b. Presentasi MOCKUP oleh Vendor pada tanggal 20/12/2024, notulen sudah masuk ke PT, menunggu ACC Pendaftaran pasien PRIMANTARA ke farmasi masih menggunakan kertas manual. c. Belum ada fitur jasa pengiriman obat (Primantara) ke rumah pasien di SIMRS dan diperlukan penanda di resep bahwa obat dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat telah disiapkan.	Permintaan dihold menunggu kenaikan pasien PRIMANTARA. Monitoring dan Evaluasi
		6. Jasa pengantaran obat	a. Pendataan pasien masih menggunakan google spreadsheet dan kitir manual, belum ada fitur yang bridging dengan SIMRS sebagai penanda resep bahwa obat dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat sudah siap. b. Promo Lifetime diskon 50% untuk pengguna baru berjalan mulai Bulan Desember 2024. c. Subsidi promo untuk obat tertinggal menggunakan pengantaran gratis. d. Perubahan alur pembayaran PRIMANTARA di kasir sudah dilakukan pada tanggal 08/01/2025.	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS. Sementara menggunakan spreadsheet dan perubahan alur pembayaran di Kasir.
		7. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis	a. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih	Pengajuan fitur ke progamer.

			terkendala tenaga TTK kurang (jika ada staf yang sakit). b. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak. c. Masih ada komplain pasien terkait waktu tunggu. e. Belum ada fitur pemisahan resep masuk kronis dan non kronis.	
		8. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	a. TTD elektronik pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriaksi kelengkapan obat kronis, namun terkendala pada jaringan yang lemah. b. TTD elektronik pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien rawat inap pulang masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.	Dalam antrian progamer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.
		9. Pelayanan retriaksi obat kronis: penambahan fitur Centang "Perlu Hasil Penunjang Lab dan Hasil Pemeriksaan Lab dimunculkan saat DPJP input e-resep; Hasil Pemeriksaan Lab di Fitur Penjualan Farmasi	Pengajuan form penambahan fitur agar DPJP input resep dan penjaminan pelayanan obat bagi peserta JKN sesuai dengan ketentuan retriaksi dan/atau peresepan maksimal obat, memudahkan Farmasi mengecek kesesuaian hasil penunjang dan obat yang diresepkan sesuai retriaksi obat kronis.	Pengajuan fitur ke progamer.
		10. Penambahan fitur laporan berkas obat kronis, laporan resep iter, dan laporan reep PRB di SIMRS	Pengajuan form penambahan fitur laporan di SIMRS yaitu : a. Format laporan berkas obat kronis, berisi : nomor, tanggal registrasi, no. registrasi, no. rm, nama pasien, unit asal, nama dokter, no. sep, nama obat, hasil pemeriksaan penunjang. Tujuan untuk memudahkan	Penambahan fitur laporan berkas obat kronis, laporan resep iter, dan laporan reep PRB di SIMRS

			farmasi melihat kelengkapan berkas klaim obat kronis yaitu Resep, SEP, Hasil Pemeriksaan Penunjang b. Format laporan resep iter, berisi : nomor, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, unit asal, nama dokter, jumlah iter, nama obat, aturan pakai, jumlah obat, tanggal kunjungan berikutnya, status iter (terlayani/ belum). Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep iter dan target iter. c. Format laporan resep PRB, berisi : nomor, nama dokter, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, alamat, no. telp, diagnosa PRB, asal FKTP perujuk, asal SRB (FKTL/RS), nama obat, aturan pakai, jumlah obat. Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep PRB dan target PRB.	
		11. Penambahan fitur warning di SIMRS DPJP "Pasien tidak ambil obat"	Pengajuan form penambahan fitur warning di SIMRS DPJP "Pasien tidak ambil obat" untuk mengurangi retur obat tertinggal.	Pengajuan fitur ke progamer.

2	Gudang Farmasi	Pengembangan fitur scan barcode gudang farmasi dan depo farmasi untuk pemasukan dan pengeluaran stok.	a. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT pada tanggal 01/10/2024. b. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04/10/2024. c. Pendataan master barcode sudah diserahkan ke Programmer PT. Tindak lanjut untuk barang yang tidak memiliki barcode yaitu dibuatkan barcode internal oleh progamer. d. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah tersedia pada tanggal 16/11/2024. e. Software aplikasi barcode dalam tahap dikerjakan oleh progamer.	Rencana trial menunggu Programmer PT
		Perluasan Gudang Farmasi	a. Perluasan Gudang Farmasi di Lantai 2, karena pallet buffer sudah tidak cukup. b. Pengajuan katrol untuk penurunan buffer dari lantai 2.	Sudah berjalan. Follow up pengadaan katrol.
3	Floorstok IKO	Perbaiki sistem penyimpanan floorstok IKO	Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2023 : a. Tanggal 03 Januari 2023 dilakukan rapat koordinasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Tidak adanya petugas farmasi khusus IKO sehingga monitoring stok di IKO tidak berjalan → Pengajuan petugas farmasi di IKO. - Perubahan alur dari depo iko ke floorstok IKO. - Karu IKO menentukan obat dan BMHP yang	Monitoring dan Evaluasi.

			dimasukkan dalam list floorstok. - Perbaiki alur floorstok iko ke depo farmasi. - List barang yang masuk dalam kategori floorstok dan jumlahnya. - List barang yang masuk dalam kategori BMHP. - Penggunaan BMHP yang diambil dari Gudang Farmasi apakah perlu di inputkan tindakan dan ditagihkan ke pasien → Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan BMHP yang digunakan IKO. - Koordinasi dengan karu IKO penentuan barang sharing dose. - Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan pasien untuk penggunaan obat maupun alkes sharing. - Konsul dengan programmer terkait alur penginputan sharing dose. b. Tanggal 17 Maret 2023 dilakukan sosialisasi alur floorstok IKO oleh progamer yaitu : - Alur input obat dan bmhp oleh perawat IKO di SIMRS → perawat menulis resep manual – barang disiapkan, kemudian input resep setelah operasi sesuai yang terpakai.	
--	--	--	---	--

			- Alur permintaan floorstok iko ke depo farmasi oleh perawat IKO di SIMRS. - Alur release stok oleh depo farmasi di SIMRS. - Alur minta barang BMHP IKO ke gudang farmasi oleh perawat di SIMRS. c. SPO alur Pelayanan Sediaan Farmasi Sistem Floorstock Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 24 Maret 2023. d. Tanggal 03 April 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Petugas IKO ditemukan salah memilih unit tujuan saat input permintaan sehingga dapat menyebabkan selisih stok → Petugas IKO diharap lebih teliti dalam melakukan inputan permintaan (memperhatikan tujuan permintaan BMHP ke Gudang dan permintaan barang floorstok ke depo farmasi). - Melakukan double check oleh petugas farmasi, apabila IKO salah input permintaan maka konfirmasi ke petugas IKO untuk revisi inputan sesuai	
--	--	--	---	--

			tujuan permintaan - Pembuatan SPO alur floorstok iko. - Jumlah stok di sistem Floorstok IKO bisa sampai minus → Pengajuan ke programmer untuk stok sistem di lock hanya sampai angka 0 (tidak sampai minus). - Penetapan alur bmhp IKO bahwa list bmhp yang sudah disetor ke keuangan PT dimasukkan dalam paket tindakan operasi sehingga tidak perawat tidak input ke pasien. e. Tanggal 08 Mei 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Terdapat stok yang tidak sesuai antara kartu stok, jumlah fisik, dan jumlah sistem. Stok sistem belum di lock. Dengan adanya penyesuaian item dan jumlah floorstok di IKO sehingga terdapat stok yang kelebihan dan atau kurang → Melakukan stok opname floorstok IKO. Mengajukan pemutihan stok IKO untuk penyesuaian dengan kesepakatan jumlah floorstok terbaru. Kelebihan dan	
--	--	--	--	--

			atau kekurangan stok dibuatkan berita acara untuk penyesuaian stok. Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2024 : a. Fitur Floorstok unit IKO sudah tersedia dan sudah dijalankan. b. Fitur minta barang floor stock sudah tersedia dan sudah dijalankan. c. Sistem stok IKO sudah dikunci. d. Ada petugas farmasi di IKO untuk monitoring stok. e. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Ditemukan input permintaan FS menggunakan tipe trans "farmasi" bukan fitur "floor stok unit" sehingga terjadi kelebihan barang yang tidak sesuai jumlah FS, dikarenakan barang yang dikirimkan ada yang kurang dari yang dimintakan. Hal ini terjadi dikarenakan selisih stok di IKO di sistem stoknya tidak ada namun fisiknya ada sehingga staf farmasi yang diiko tidak mencatat di barang menipis sehingga tidak disiapkan permintaan FS ketika malam	
--	--	--	--	--

			hari karena secara fisik stoknya masih ada → Menyamakan persepsi antara permintaan FS dengan permintaan hutang input ke pasien. Jika staf farmasi melakukan random stok dan ditemukan selisih stok lebih disistem maka akan konfirmasi ke perawat untuk diinputkan ke pasien. Jika terdapat selisih stok fisik lebih dan stok simrs 0 maka farmasi mengecek stok yang ada didepo farmasi dan simrs depo farmasi. Jika stok simrs berlebih maka release stok ke iko. - Ditemukan perbedaan barang di resep manual dan inputan simrs, farmasi menuliskan apa yang ada diinputan resep, perawat iko mengambil barang namun tidak ada di tulisan resep manual hari itu → Farmasi melakukan double cek resep manual dan inputan simrs jika ada yang belum diinputkan maka akan di stabilo di resep manual dan resep diserahkan ke perawat untuk	
--	--	--	--	--

			diinputkan kembali. Resep akan dibedakan, untuk resep yang belum selesai diinput akan ada didekat komputer iko. Untuk resep yang sudah diinput akan ditaruh dikeranjang di lemari obat. f. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Konsinyasi implant IKO belum di lock → dilakukan stok opname. Data diberikan ke progamer agar dilakukan penyesuaian stok. Programmer langsung merubah dan sistem di lock. - Perubahan alur penyiapan obat dan bmhp operasi → perawat input resep sesuai advice DPJP – farmasi menyiapkan – jika ada barang yang tidak terpakai maka di retur penjualan. g. Revisi SPO : - SPO Pelayanan Kefarmasian Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 12 November 2024. - SPO Permintaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Instalasi Kamar Operasi Kepada Instalasi Farmasi.	
--	--	--	--	--

		h. Tersedia alur penggunaan sediaan sharing dose. Contoh : Isonest. i. Menggunakan tabel penggunaan obat sharing dose. j. Ada petugas farmasi di IKO	
	1. Perbaikan sistem penyimpanan floorstok IKO	Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2023 : f. Tanggal 03 Januari 2023 dilakukan rapat koordinasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Tidak adanya petugas farmasi khusus IKO sehingga monitoring stok di IKO tidak berjalan → Pengajuan petugas farmasi di IKO. - Perubahan alur dari depo iko ke floorstok IKO. - Karu IKO menentukan obat dan BMHP yang dimasukkan dalam list floorstok. - Perbaikan alur floorstok iko ke depo farmasi. - List barang yang masuk dalam kategori floorstok dan jumlahnya. - List barang yang masuk dalam kategori BMHP. - Penggunaan BMHP yang diambil dari Gudang Farmasi apakah perlu di inputkan tindakan dan ditagihkan ke pasien → Konsul dengan keuangan PT	Floorstok IKO

			terkait tagihan BMHP yang digunakan IKO. - Koordinasi dengan karu IKO penentuan barang sharing dose. - Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan pasien untuk penggunaan obat maupun alkes sharing. - Konsul dengan programmer terkait alur penginputan sharing dose. g. Tanggal 17 Maret 2023 dilakukan sosialisasi alur floorstok IKO oleh progamer yaitu : - Alur input obat dan bmhp oleh perawat IKO di SIMRS → perawat menulis resep manual – barang disiapkan, kemudian input resep setelah operasi sesuai yang terpakai. - Alur permintaan floorstok iko ke depo farmasi oleh perawat IKO di SIMRS. - Alur release stok oleh depo farmasi di SIMRS. - Alur minta barang BMHP IKO ke gudang farmasi oleh perawat di SIMRS. h. SPO alur Pelayanan Sediaan Farmasi Sistem Floorstock Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 24 Maret 2023. i. Tanggal 03 April 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok	
--	--	--	--	--

			IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Petugas IKO ditemukan salah memilih unit tujuan saat input permintaan sehingga dapat menyebabkan selisih stok → Petugas IKO diharap lebih teliti dalam melakukan inputan permintaan (memperhatikan tujuan permintaan BMHP ke Gudang dan permintaan barang floorstok ke depo farmasi). - Melakukan double check oleh petugas farmasi, apabila IKO salah input permintaan maka konfirmasi ke petugas IKO untuk revisi inputan sesuai tujuan permintaan - Pembuatan SPO alur floorstok iko. - Jumlah stok di sistem Floorstok IKO bisa sampai minus → Pengajuan ke programmer untuk stok sistem di lock hanya sampai angka 0 (tidak sampai minus). - Penetapan alur bmhp IKO bahwa list bmhp yang sudah disetor ke keuangan PT dimasukkan dalam paket tindakan operasi sehingga tidak	
--	--	--	--	--

			perawat tidak input ke pasien. j. Tanggal 08 Mei 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Terdapat stok yang tidak sesuai antara kartu stok, jumlah fisik, dan jumlah sistem. Stok sistem belum di lock. Dengan adanya penyesuaian item dan jumlah floorstok di IKO sehingga terdapat stok yang kelebihan dan atau kurang → Melakukan stok opname floorstok IKO. Mengajukan pemutihan stok IKO untuk penyesuaian dengan kesepakatan jumlah floorstok terbaru. Kelebihan dan atau kekurangan stok dibuatkan berita acara untuk penyesuaian stok. Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2024 : k. Fitur Floorstok unit IKO sudah tersedia dan sudah dijalankan. l. Fitur minta barang floor stock sudah tersedia dan sudah dijalankan. m. Sistem stok IKO sudah dikunci. n. Ada petugas farmasi di IKO untuk monitoring stok. o. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat	
--	--	--	---	--

			evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Ditemukan input permintaan FS menggunakan tipe trans “farmasi” bukan fitur “floor stok unit” sehingga terjadi kelebihan barang yang tidak sesuai jumlah FS, dikarenakan barang yang dikirimkan ada yang kurang dari yang dimintakan. Hal ini terjadi dikarenakan selisih stok di IKO di sistem stoknya tidak ada namun fisiknya ada sehingga staf farmasi yang diiko tidak mencatat di barang menipis sehingga tidak disiapkan permintaan FS ketika malam hari karena secara fisik stoknya masih ada → Menyamakan persepsi antara permintaan FS dengan permintaan hutang input ke pasien. Jika staf farmasi melakukan random stok dan ditemukan selisih stok lebih disistem maka akan konfirmasi ke perawat untuk diinputkan ke pasien. Jika terdapat selisih stok fisik lebih dan stok simrs 0 maka farmasi	
--	--	--	---	--

			mengecek stok yang ada didepo farmasi dan simrs depo farmasi. Jika stok simrs berlebih maka release stok ke iko. - Ditemukan perbedaan barang di resep manual dan inputan simrs, farmasi menuliskan apa yang ada diinputan resep, perawat iko mengambil barang namun tidak ada di tulisan resep manual hari itu → Farmasi melakukan double cek resep manual dan inputan simrs jika ada yang belum diinputkan maka akan di stabilo di resep manual dan resep diserahkan ke perawat untuk diinputkan kembali. Resep akan dibedakan, untuk resep yang belum selesai diinput akan ada didekat komputer iko. Untuk resep yang sudah diinput akan ditaruh dikeranjang di lemari obat. p. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Konsinyasi implant IKO belum di lock → dilakukan stok	
--	--	--	---	--

			opname. Data diberikan ke progamer agar dilakukan penyesuaian stok. Programmer langsung merubah dan sistem di lock. - Perubahan alur penyiapan obat dan bmhp operasi → perawat input resep sesuai advice DPJP – farmasi menyiapkan – jika ada barang yang tidak terpakai maka di retur penjualan. q. Revisi SPO : - SPO Pelayanan Kefarmasian Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 12 November 2024. - SPO Permintaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Instalasi Kamar Operasi Kepada Instalasi Farmasi. r. Tersedia alur penggunaan sediaan sharing dose. Contoh : Isonest. s. Menggunakan tabel penggunaan obat sharing dose. 1. Ada petugas farmasi di IKO	
4	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA).	1. Sudah terealisasi E-RM Rawat Jalan IGD dan IRJA. Rehab sudah berjalan mulai tanggal 01-05-2024. IRNA dalam proses tahap akhir, target pada Bulan Juni 2025. 2. Melakukan pendataan fitur yang dibutuhkan pada SIMRS, lalu	Kurang sinkron antara fitur perawat dan rekam medis, seperti : TTD tidak terisi, belum muncul pengkajian fisioterapis di fitur rekam medis. Permasalahan E-RM dan layanan Poli yang belum masuk E-RM sudah disampaikan kepada Programmer PT sekaligus flow chart.

			diserahkan kepada Programmer PT.	
		2. Penggunaan ERM Rawat Inap	1. Kolaborasi dengan Programmer PT. 2. Melakukan trial pada awal Bulan Mei 2025.	Follow up. Monitoring dan Evaluasi.
		3. Kirim ke Satu Sehat untuk Pasien Rawat Jalan (Baik ERM ataupun Non ERM)	Pengiriman data ke satu sehat (untuk data kunjungan dan diagnosis) dilakukan setiap hari. Temuan dan TL : 1. ERM yang belum lengkap dan valid. TL : Koordinasi dengan Tim Pendaftaran terkait identitas pasien yang tidak lengkap. 2. Bayi baru lahir yang belum mempunyai NIK. TL : Kie ke keluarga pasien agar segera pengurusan KK. 3. Pasien yang tidak membawa identitas dengan lengkap. TL : KIE ke keluarga pasien untuk mengirimkan identitas melalui chat WA.	Monitoring dan Evaluasi.
		4. Dokumentasi DRM lama.	1. Melakukan scanning form kedalam SIMRS. 2. Tarikan data bisa diambil pada rekap kunjungan di SIMRS. 3. Menunggu programmer membuat fitur scanning.	Koordinasi dengan Programmer. Pengajuan ke PT.
		5. Retensi DRM	1. Data DRM yang akan diretensi menunggu Programmer PT sebelum dilakukan pemilahan dan pemusnahan DRM. 2. Pemusnahan terakhir dilakukan pada Tahun 2018.	Follow up Programmer PT.
		6. Rekap Data Laporan Dinkes	1. Data yang dibutuhkan tidak semua bisa ditarik oleh system. 2. Pengajuan fitur ke Programmer PT.	Dalam Proses.

			3. RM membuat Google Spreadsheet untuk diisi oleh unit-unit terkait setiap harinya. 3. Tujuannya untuk memudahkan Karu RM dalam pelaporan RL ke Dinkes tepat waktu.	
4	Pendaftaran	1. Anjungan Pasien Mandiri.	1. Melakukan studi banding atau mencari informasi terkait penggunaan APM di RS lain. 2. Membuat flowchart dan diajukan ke Programmer PT.	Dalam proses dan diajukan ke Program Kerja Tahun 2025.
		2. Penetapan petugas jaga.	Melakukan penetapan PJ disetiap divisi, Pendaftaran Central, CSO dan Pendaftaran IGD dengan personil tetap, dengan tujuan supaya petugas menguasai permasalahan dan fokus pelayanan, memudahkan telusur dan perbaikan jika ada komplain dan masalah.	PJ Pendaftaran Central : Tyas PJ Pendaftaran IGD : Riri Pendaftaran CSO : Shinta Bella
		3. Pendaftaran pasien	1. Reservasi pasien umum dan asuransi melalui web, disertai pembayaran melalui VA. 2. Kolaborasi dengan IT dan SIMRS.	Proses mengerjakan TOR
5	Radiologi	1. Menambahkan fitur hasil radiologi di SIMRS supaya hasil JPEG dapat diakses.	Sudah dirapatkan dengan Programmer untuk dibuatkan fitur tersendiri.	Dalam antrian programmer.
		2. Menambah jam pelayanan supaya pelayanan maksimal.	Melakukan close recruitmen untuk mengisi jam kosong pada siang hari.	Surat pemberitahuan kebutuhan Sp.Rad sudah diterima oleh Ketua Kolegium.
		3. Respon Time Radiologi	1. Kolaborasi dengan perawat untuk melakukan pencatatan di Google Spreadsheet secara real time.	Mulai dijalankan awal Tahun 2024.
6	Laboratorium	1. Pengadaan LIS.	1. Hardware sudah dipasang di Laboratorium. 2. Software proses dikerjakan oleh Programmer dan Vendor.	Dalam antrian programmer.
		2. Stok Opname	BDRS berjalan mulai 29	SO akan dilakukan

		BDRS	November 2024.	Pada hari Sabtu, 22 Maret 2025.
		3. Penambahan fitur	1. Penambahan fitur upload hasil laboratorium rujukan dari luar RS. 2. Penambahan fitur centang otomatis hasil pemeriksaan yang abnormal, batas atas dan batas bawah sudah dicatat dan diajukan ke Programmer PT.	Dalam antrian Programmer PT.
7	Gizi	1. Pengaktifan Poli Gizi di Rawat Jalan/MCU Gizi.	2. Kolaborasi dengan Humas&Marketing. 3. Kolaborasi dengan pelayanan antar obat (PRIMANTARA), free MCU Gizi.	Monitoring dan evaluasi setiap bulan.
		2. Prima Healthy Meal.	Sudah pengajuan TOR ke PT.	Menunggu ACC.
		3. Daftar Menu Makanan Penunggu VIP.	Book Menu sudah proses dikerjakan oleh PKRS.	Dalam proses.
		4. Registrasi alat makan	1. Kolaborasi dengan penyaji untuk melakukan pencatatan keluar masuknya sendok di Google Spreadsheet. 2. Perbaikan alur saat mengambil peralatan makan di ruangan, jika ditemukan sendok hilang maka dicatat di Google Spreadsheet dan dioperkan ke perawat ruangan untuk ditagihkan ke saat pasien KRS. 3. Dilakukan stok opname setiap bulan untuk menghitung peralatan makan. 4. Membuat SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS.	Registrasi alat makan sudah berjalan sejak Bulan Januari 2024 Proses dibuatkan SPO kehilangan alat makan, penggantian biaya dilakukan di Kasir, jika tidak tertagihkan maka tanggungjawab unit bersama.
		5. Pemesanan diet melalui SIMRS	1. Memastikan proses pemesanan diet lebih efisien dan mengurangi kesalahan pemesanan diet dari DPJP ke perawat, perawat ke ahli gizi. 2. Ahli gizi mengkonfirmasi diet di SIM-RS jika ada penambahan diet/ganti diet saat selesai visitasi di ruangan. 3. Proses cetak label	Monitoring dan evaluasi.

			langsung efisien tanpa harus mengetik ulang dan tidak menulis manual di label. 5. Koordinasi dengan bagian SIM-RS supaya segera di realisasikan ke unit.	
		6. QC sesuai sistem HACCP	1. Pelatihan HACCP dilakukan oleh seluruh Ahli Gizi. 2. Memastikan proses quality control makanan sesuai standar. 3. Memastikan 7 prinsip HACCP. 4. Koordinasi dengan SDM jika ada informasi terkait pelatihan tersebut.	Menunggu jadwal pelatihan.
8	Dapur	1. Perbaiki menu makanan dan plating.	1. Sudah dilakukan supervisi oleh Direktur Utama PT DPM pada hari Senin, 18 November 2024. 2. Kebijakan penggunaan alat makan dan SPO plating sudah dibuatkan sebagai pedoman penyaji dalam melakukan pekerjaan.	Monitoring dan Evaluasi. Revisi tampilan sedang diproses oleh PKRS (Eriko).
		2. Menu makanan buka puasa senin-kamis.	Program PT berjalan mulai tanggal 09 Desember 2024. Yang sudah disiapkan : 1. Daftar siklus menu makanan. 2. SPO pemesanan makanan buka puasa (+). 3. Link google form untuk pemesanan (+). 4. Kebijakan pemesanan makanan hari H maksimal pukul 06.00 WIB.	Monitoring dan Evaluasi.
7	Pantry	1. Food Waste	Perbaiki pencatatan sisa makanan berdasarkan menu makanan untuk mengetahui makanan yang kurang diminati.	Monitoring dan Evaluasi
8	CSSD	1. Mengajukan mesin sterilitor (steam plasma).	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi permintaan sterilisasi alat semi critical sesuai kebutuhan sterilisasi instrument bedah syaraf.

		2. Perbaikan serah terima menggunakan digital form.	Sudah berjalan di Bulan Juli 2024.	1. Kolom tidak terisi lengkap. 2. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabid.
		3. Perbaikan jam kerja	Pelayanan mulai pukul 06.30-21.00 WIB, jika ada alat yang akan disetor diatas jam pelayanan maka dilakukan pre-cleaning di unit masing-masing.	Berjalan per Bulan Desember 2024. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabid.
9	Laundry	1. Mengajukan mesin cuci industry dengan kapasitas 30kg.	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi penggunaan mesin cuci industry utama.
		2. Membuat digital form untuk permintaan linen.	1. Rencana permintaan sehari 2 kali oleh unit sesuai dengan kebutuhan. 2. Belum terealisasi.	Berjwal awal Tahun 2025.
		3. Pengadaan Bedcover untuk pasien VIP dan LINEN IKO.	Rencana diajukan ulang dengan melampirkan keluhan pasien VIP, kerusakan linen IKO.	Linen IKO dan VIP sudah diproses. Selimut VIP sudah diajukan.
		4. Perbaikan jam kerja	Pelayanan ada 3 shift, shift malam dimulai pukul 22.00-04.00 WIB tanpa jam istirahat, dan memenuhi stok di unit.	Berjalan per Bulan Desember 2024.
10	Lain-lain	Rapat Bulanan masing-masing Unit dengan Kabid.	Dilakukan per Bulan November 2024. Supervisi pemahaman pelaksana tentang pedoman pelayanan, pengorganisasian, dan pelayanan sesuai dengan akreditasi. Pelaksanaan : 2. Tanya Jawab 1. Role Play	1. RM dan Pendaftaran Hari : Senin, 19-05-2025. Waktu : 13.00 WIB sd selesai. Tempat : Hall Sakura Lt 5 (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom). 2. Farmasi Hari : Selasa, 20-05-2025. Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Hall Sakura Lt 5 (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 3. Gizi Hari : Rabu, 15-05-2025 Waktu : 11.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir

				menggunakan Zoom) 4. Laboratorium Hari : Rabu, 21-05-2025 Waktu : 14.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 5. Radiologi Hari : Senin, 26-05-2025 Waktu : 14.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 6. CSSD dan Laundry Hari : Sabtu, 24-05-2025 Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Laundry (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 7. Rapat All Karu Penunjang Hari : Sabtu, 31-05-2025 Waktu : 15.00 WIB sd selesai Tempat : Ruang Direktur RS
--	--	--	--	--

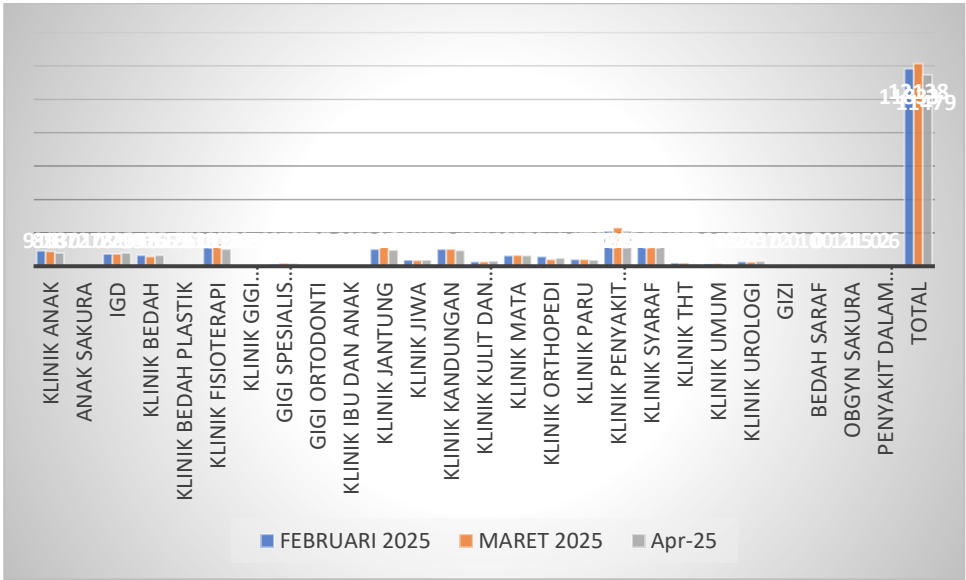
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

NO	NAMA UNIT	FEBRUARI 2025			MARET 2025			April 2025		
		BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL
1	Klinik Anak	49	867	916	42	851	893	50	737	787
2	Anak sakura	0	0	0	0	2	2	2	8	10
3	IGD	228	503	731	227	502	729	260	534	794
4	Klinik Bedah	47	601	648	28	548	576	55	610	665
5	Klinik Bedah Plastik	1	18	19	2	24	26	2	31	33

6	Klinik Fisioterapi	5	117	1112	1	1317	1318	2	1027	1029
7	Klinik Gigi Periodonti	9	38	47	7	38	45	12	41	53
8	Gigi spesialis pedodontis	18	105	123	17	156	173	14	151	165
9	Gigi Ortodonti	5	23	28	7	23	30	1	5	6
10	Klinik Ibu dan Anak	0	3	3	0	9	9	0	6	6
11	Klinik Jantung	25	1003	1028	23	1134	1157	11	958	969
12	Klinik Jiwa	8	351	359	12	335	347	13	354	367
13	Klinik Kandungan	116	898	1014	80	937	1017	102	848	950
14	Klinik Kulit dan Kelamin	27	251	278	20	251	271	39	279	316
15	Klinik Mata	47	594	641	46	602	648	44	585	629
16	Klinik Orthopedi	21	550	571	14	400	414	20	471	491
17	Klinik Paru	8	394	402	4	402	406	8	336	374
18	Klinik Penyakit Dalam	54	2034	2088	35	2272	2307	47	2063	2120
19	Klinik Syaraf	35	1174	1209	34	1104	1138	35	1178	1213
20	Klinik THT	38	151	189	36	157	193	40	91	131
21	Klinik Umum	122	13	135	125	24	149	29	24	53
22	Klinik Urologi	32	239	271	18	243	261	30	267	297
23	Gizi	0	0	0	1	1	2	0	0	0
24	Bedah Saraf	3	7	10	0	0	0	0	0	0
25	Obgyn Sakura	2	9	11	4	17	21	3	12	15
26	Penyakit dalam sakura	0	0	0	1	1	2	2	4	6
Total		900	10933	11833	784	11354	12138	821	10620	11479



Analisis :

1. Kunjungan di bulan april menurun dari bulan sebelumnya,sebanyak 5,4% dari bulan maret 2025. Analisnya banyak dokter cuti hari raya sehingga poli banyak yang tidak praktek sehingga jumlah kunjungan dirawat jalan menurun
2. Jumlah pasien terbanyak ada di Poli penyakit dalam sebanyak 2120 ,jumlah pasien ini menurun dibandingkan bulan maret 2025 karena dokter IPD banyak yang cuti lebaran
3. Kunjungan poli bedah saraf sangat menurun 100% dari bulan sebelumnya, karena dokter bedah saraf cuti panjang selama 3 bulan
4. Untuk poli pedodonti anak untuk bulan maret sempat meningkat dikarenakan dokter sudah paham terkait opening BPJS ,untuk bulan april 2025 ini menurun 4,6%
5. Kunjungan poli eksekutif adalah bulan april meningkat 8% dari bulan maret 2025 disebabkan banyaknya kolaborasi baik dari pendaftaran dan rawat inap untuk menginformasikan tentang poli sakura

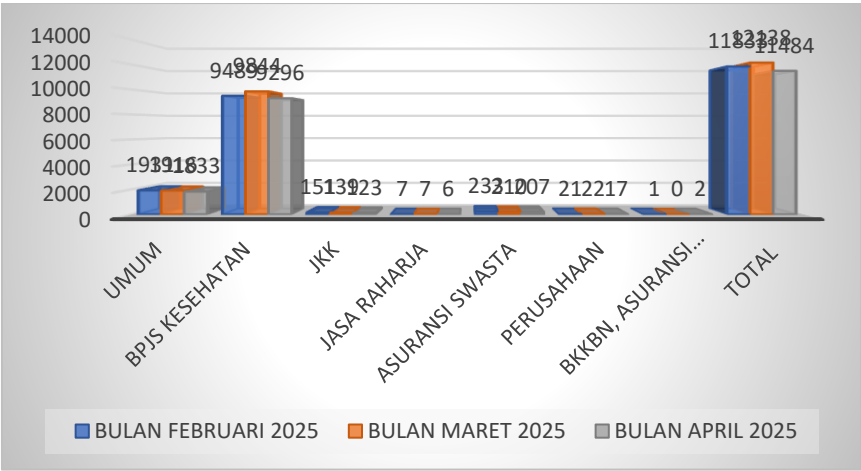
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli sakura
- 2. Menginformasikan kepada seluruh unit rawat inap wajib edukasi saat krs untuk pasien umum,asuransi tentang pelayanan poli sakura
- 3. Menambah jam HFIS untuk poli pedodonti sehingga akan menambah jumlah pasien
- 4. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
- 5. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
- 6. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
- 7. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
- 8. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.
- 9. Sosialisasi pada komunitas pasien geriatri maupu prolanis klinis MS,bahwa dokter gigi ortodonti (perawat gigi) dan poli sakura
- 10. Sosialisasi pada perusahaan dan stakeholder bahwa ada poli sakura yang menyediakan layanan one stop service
- 11. Mengajukan pelayanan baru otho,bedah,uro dan kulit di Poli Sakura

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	BULAN FEBRUARI 2025	%	BULAN MARET 2025	%	BULAN APRIL 2025	%
1	Umum	1931	16,32%	1916	15,8%	1833	15,96%
2	BPJS Kesehatan	9489	80,19%	9844	81,1%	9296	80,95%
3	JKK	151	1,28%	139	1,1%	123	1,07%
4	Jasa raharja	7	0,06%	7	0,1%	6	0,05%
5	Asuransi swasta	233	1,97%	210	1,7%	207	1,80%
6	Perusahaan	21	0,18%	22	0,2%	17	0,15%
7	BKKBN, Asuransi Pemerintah	1	0,01%	0	0%	2	0,02%
	Total	11833	100%	12138	100%	11484	100%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :
Kunjungan pasien bulan April 2025 berdasarkan cara pembayaran menurun 5,4% dari bulan maret 2025 . Kunjungan terbanyak adalah pasien dengan penjamin BPJS Kesehatan sebesar 80,95%. Kunjungan bpjs meningkat di dibandingkan bulan maret 2025 dikarenakan banyaknya kunjungan karena dokter spesialis akhir bulan banyak yang cuti jadi kunjunganya di maksimalkan pertengahan bulan april 2025
Kunjungan terendah berdasarkan cara pembayaran kunjungan asuransi pemerintah dengan 0,02% ada 2 kunjungan

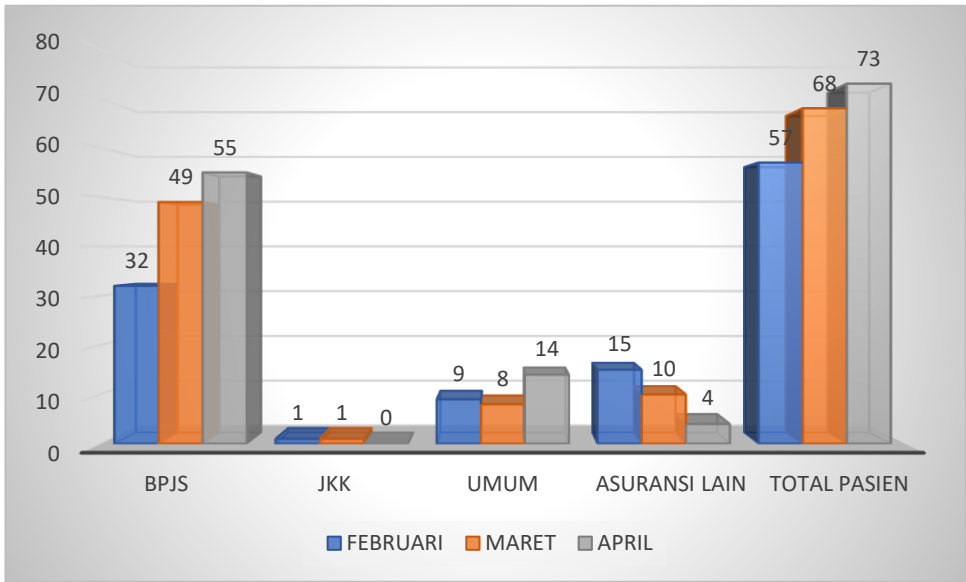
Rencana Tindak Lanjut :
Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak. bekerjasama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional.

3.3.2 Rawat Inap
3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-April 2025)

NO	HAL	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	32	49	55	↑ 10,9%
2	JKK	1	1	0	↓ 100%
3	Umum	9	8	14	↑ 42,8%
4	Asuransi Lain	15	10	4	↓ 60%
Total Pasien		57	68	73	↑ 6,8%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (Februari-April 2025)



3.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANS I	
1	April 2025	55	14	0	4	68
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir meningkat untuk bulan april meningkat 10,9% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan dari di IGD banyak yang naik kelas dan pasien VIP dan VVIP	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan april mengalami peningkatan 42,8% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan lodingan pasien SC yang naik kelas juga meningkat	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan apri pasien di irna 2c mengalmi penurunan 100% di bandingka n bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan April mengalami penurunan 60% dari bulan sebelumnya	Total pasien bulan april 2025 mengalami peningkatan 6,8% (5 pasien) dari bulan sebelumnya
	RTL	1. Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran 2. Rencana penambahan VVIP 1 TT 3. Memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti paket alat, mandi, baju pasien khusus VIP/VVIP 4. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap 5. Bekerjasama dengan marketing untuk meningkatkan pasien pasien asuransi terutama peusahaan perusahaan yang baru 6. Meningkatkan pelayanan yang lebih ekstra kepada pasien 7. Mempromosikan ruangan vip/vvip lewat sosial media				

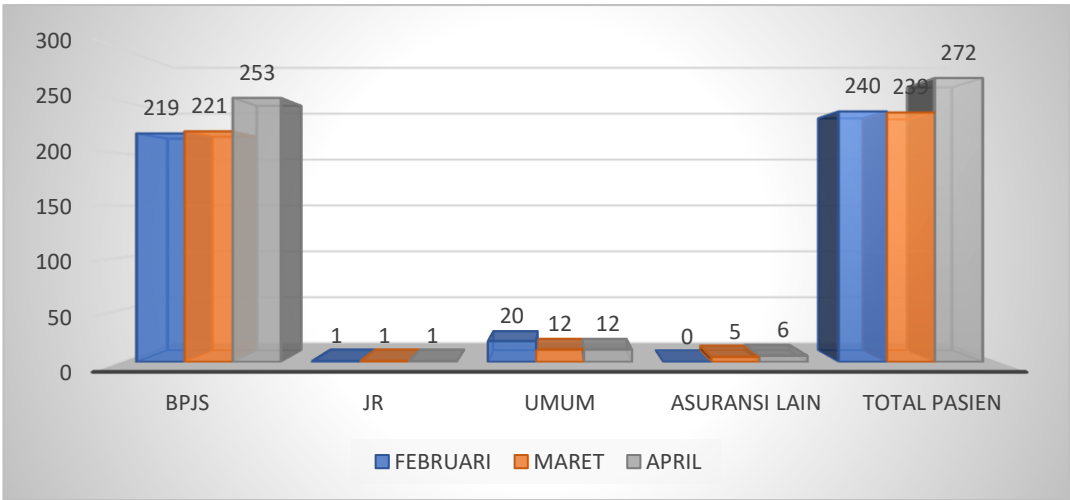
3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar

(Februari - April 2025)

NO	HAL	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	219	221	253	↑ 12,6%
2	JR	1	1	1	0%
3	Umum	20	12	12	0%
4	Asuransi Lain	0	5	6	↑ 16,6%
Total Pasien		240	239	272	↑ 12%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(Februari - April 2025)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN APRIL 2025	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JR	ASURANSI	
1	Analisis	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir meningkat untuk bulan april 2025 mengalami peningkatan 12,6% dari bulan maret 2025 di sebabkan kunjungan dari IGD terutama pasien anak meingkat dan banyaknya pasien yang MRS saat periksa di rawat jalan	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil,untuk bulan april 2025 mengalami stagnan dari bulan sebelumnya	Pasien JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan april 2025 mengalami stagnan dari bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir meningkat untuk bulan april 2025 mengalami peningkatan 16,6% dari bulan sebelumnya	Total keseluruhan bulan April mengalami peningkatan 12% dari bulan maret 2025 (33 pasien)

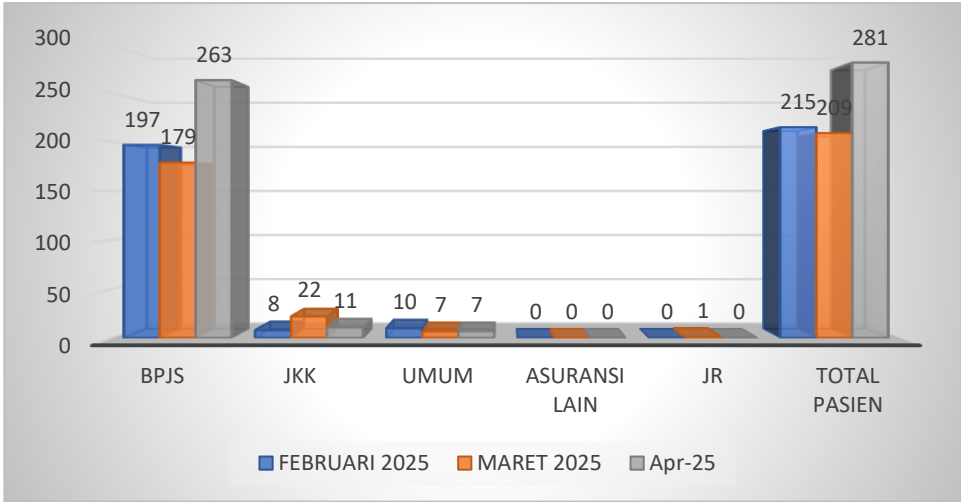
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulanya 2. Memperbaiki setiap fasilitas yang ada di unit jika ada yang rusak 3. Promosi ruangan anak lewat media sosial ,tiktok dan IG 4. Program taman anak-anak harus di terealisasikan di irna anak untuk tahun ini 5. Berkoordinasi dengan Marketing untuk kunjungan ke TK atau paud tentang pelayanan gigi anak baru
--	-----	---

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2025)

NO	HAL	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	197	179	263	↑ 46,9%
2	JKK	8	22	11	↓ 50%
3	Umum	10	7	7	0%
4	Asuransi Lain	0	0	0	0%
5	JR	0	1	0	↓ 100%
Total Pasien		215	209	281	↑ 34,5 %

3.1.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2025)



3.1.1.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

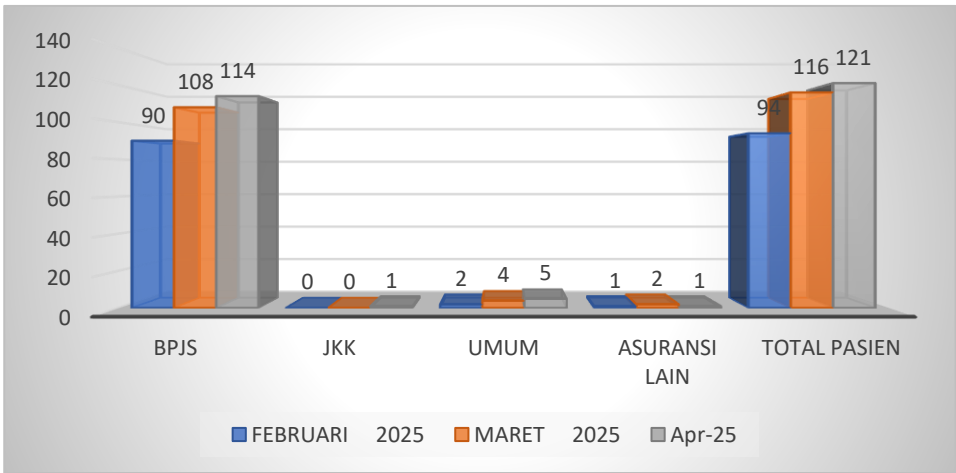
NO.	BULAN APRIL	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian april 2025	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan april mengalami peningkatan 46,9% dari bulan sebelumnya disebabkan banyaknya kunjungan di IGD dan lodingan dari poli	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan april mengalami stagnan dari bulan sebelumnya	Pasien JKK 3 dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk kunjungan bulan april mengalami penurunan 50% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan rujukan dari perusahaan menurun	Pasien JR/Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan April 2024 mengalami penurunan 100% dari bulan sebelumnya	Total pasien di lantai 2,3,dan 4 mengala mi peningkat an 34,5% (72 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Pemberian edukasi yang baik 7. Berkoordinasi dengan bagian humas marketing untuk melakukan kunjungan di perusahaan-perusahaan untuk melakukan pendekatan ke HRD				

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari – April 2025)

NO	HAL	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	90	108	114	↑5,26%
2	JKK	0	0	1	↑100%
3	Umum	2	4	5	↑20%
4	Asuransi Lain	1	2	1	↓50%
Total Pasien		94	116	121	↑4,13%

3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari – April 2025)



3.1.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

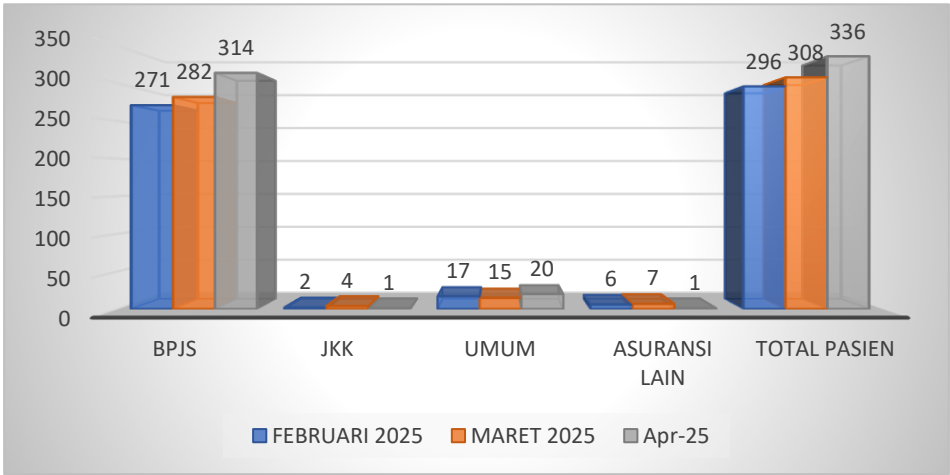
NO.	BULAN APRIL	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan April meningkat 5,26% dari bulan sebelumnya	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan april mengalami peningkatan 20% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan belum stabil untuk bulan April 2025 mengalami peningkatan 100% dari bulan sebelumnya	Pasien Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan April 2025 mengalami penurunan 50% dari bulan sebelumnya	Pada bulan april 2025 total pasien mengalami peningkatan 4,13% dari bulan sebelumnya
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan berkoordinasi dengan marketing untuk selalu koordinasi dengan faskes tentang pelayanan pasien TB di rumah sakit prima husada				

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2025)

NO	PENJAMIN	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	271	282	314	↑ 11,3%
2	JKK	2	4	1	↓ 75%
3	Umum	17	15	20	↑ 20%
4	Asuransi Lain	6	7	1	↓ 85,7%
Total Pasien		296	308	336	↑ 9,09%

3.1.1.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2025)



3.1.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

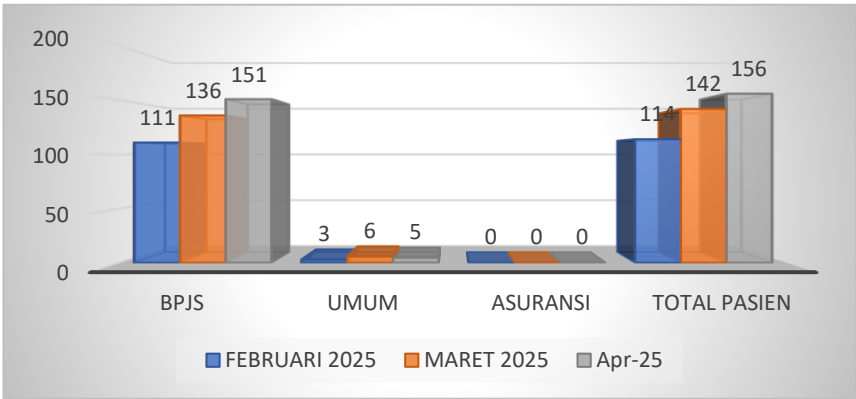
NO.	BULAN APRIL	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir kunjungan di irna 6,7 dan 8 A meningkat untuk bulan april 2025 mengalami peningkatan 11,3% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan di IGD sudah stabil meningkat	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan April 2025 mengalami peningkatan 33,3% di bandingkan bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan april 2025 mengalami penurunan 75% dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan belum stabil untuk bulan april 2025 mengalami penurunan 85,7%di bandingkan bulan sebelumnya	Total semua pasien mengalami peningkatan pasien 9,09 % dari bulan sebelumnya
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Berkoordinasi dengan bagian humas marketing untuk melakukan kunjungan di perusahaan-perusahaan untuk melakukan pendekatan ke HRD				

3.1.1.5 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2025)

NO	HAL	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	111	136	151	↑ 9,9%
2	Umum	3	6	5	↓ 16,6%
3	Asuransi	0	0	0	0%
Total Pasien		114	142	156	↑ 9,97%

3.1.1.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2025)



3.1.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

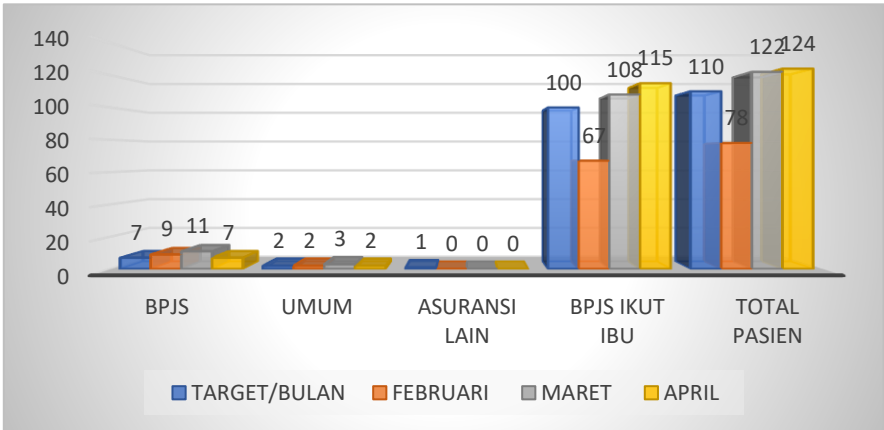
NO	BULAN MARET	RAWAT INAP			KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian maret 2025	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami peningkatan 18,3% dari bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami peningkatan 50% dari bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan maret 2025 tidak ada pasien	Total pasien bulan maret 2025 mengalami peningkatan 19,71%
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan bekerja sama dengan humas marketing terutama untuk kunjungan ke bidan bidan praktek yang mempunyai BPJS	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,bekerjasama dengan humas marketing untuk posting di ig tentang pelayanan di maternitas	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,dan mengadakan corporate gatreing dengan perusahaan setiap 1 tahun sekali	

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari 2025- April 2025)

NO	HAL	TARGET/BULAN	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	9	11	7	↓ 36,3%
2	Umum	2	2	3	2	↓ 33,3%
3	Asuransi Lain	1	0	0	0	0%
4	BPJS IKUT IBU	100	67	108	115	↑ 6,48%
Total Pasien		110	78	122	124	↑ 1,64%

1.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari 2025-April 2025)



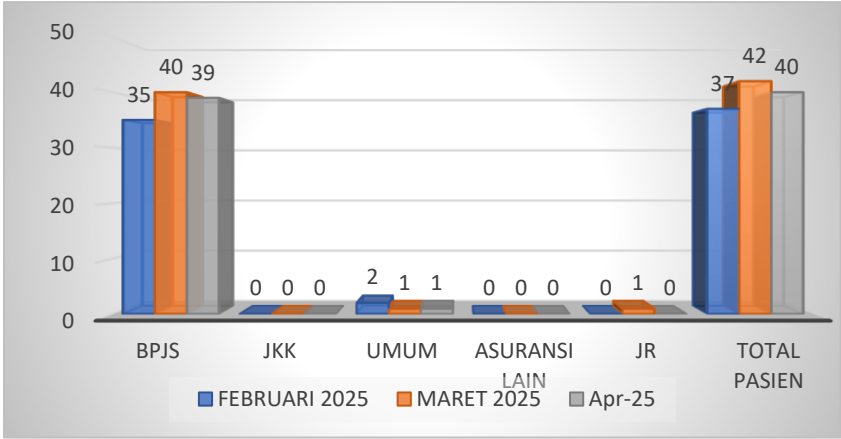
3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	Total Pasien
1	April 2025	7	2	0	115	124
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan April 2025 mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebanyak 36,6%	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan April 2025 mengalami penurunan 33,3% dari bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan april 2025 tidak ada pasien sama sekali	Pasien BPJS ikut ibu dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan april 2025 mengalami peningkatan 6,48 % dibandingkan bulan sebelumnya	Total pasien dalam bulan april 2025 mengalami peningkatan % di bandingkan bulan sebelumnya 1,64%
	RTL	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, dan berkoordinasi dengan marketing untuk menginformasikan ke bidan bidan jejaring	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya,kerjasama dengan marketing, membuat program pelayanan baru seperti pijat bayi sehingga menarik banyak pasien	Meningkatkan pelayanan dan koordinasi dengan bagian marketing untuk meningkatkan pasien asuransi	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya,kerjasama dengan marketing	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya,kerjasama dengan marketing,membuat program foto bayi dari unit neo

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)
3.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(Februari - April 2025)

NO	PENJAMIN	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	35	40	39	↓ 2,5%
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	2	1	1	0%
4	Asuransi Lain	0	0	0	0%
5	JR	0	1	0	↓ 100%
Total Pasien		37	42	40	↓ 4,76%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(Februari - April 2025)



3.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

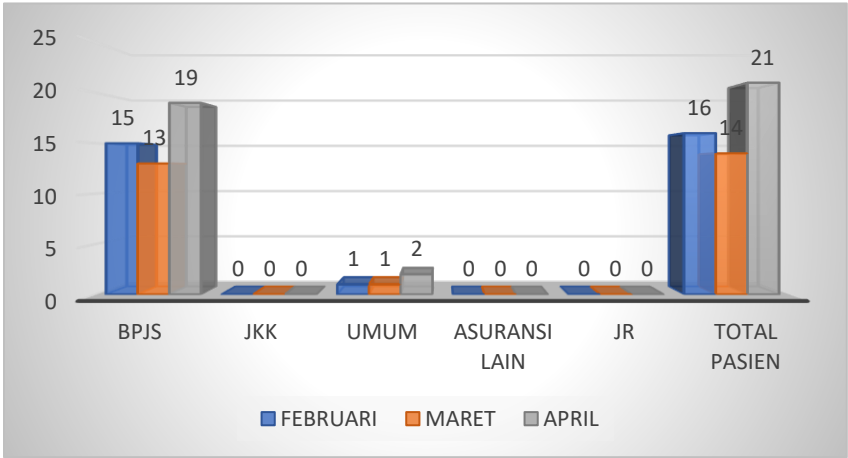
NO.	BULAN APRIL	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan april 2025 mengalami penurunan 2,5% dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan april 2025 jumlah kunjungan tetap dengan bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien 0	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan april 2025 menurun 100% di bandingkan bulan sebelumnya	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien belum stabil untuk bulan april total pasien menurun 4,76% dibandingkan bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat 5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU				

3.1.2 High Care Unit (HCU)

3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2025)

NO	HAL	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	15	13	19	↑31,5%
2	JKK	0	0	0	tetap
3	Umum	1	1	2	↑ 50
4	Asuransi Lain	0	0	0	0%
5	JR	0	0	0	0%
Total Pasien		16	14	21	↑ 33,3%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2025)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN APRIL	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan	Pasien BPJS dalam 3	Pasien umum dalam	Tidak ada pasien JKK	Pasien JR/ Asuransi dalam	Pada 3 bulan

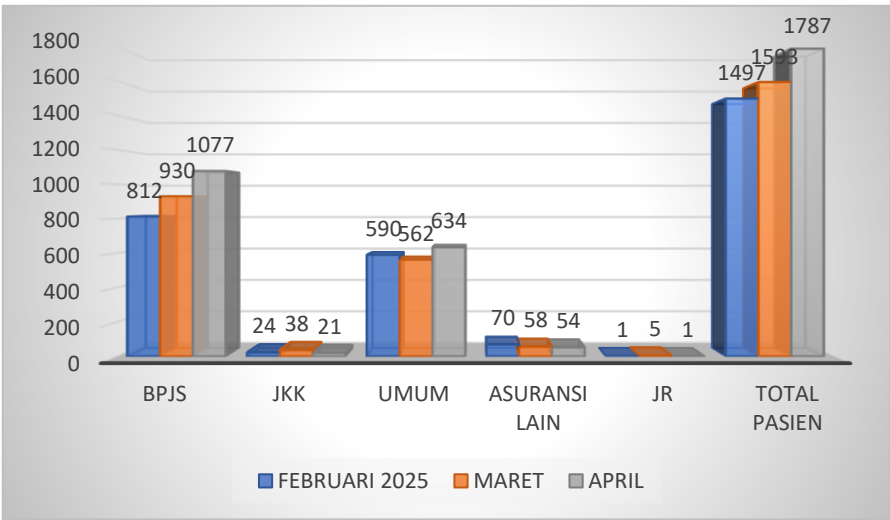
	terakhir	bulan terakhir belum stabil, untuk bulan april 2025 mengalami peningkatan 31,5% di bandingkan bulan lalu	3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan april 2025 mengalami peningkatan 100% dari bulan sebelumnya	selama 3 bulan	3 bulan terakhir masih belum ada pasien	terakhir jumlah total pasien bulan April 2025 mengalami peningkatan 33,5% dari bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat				

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2025)

NO	HAL	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	812	930	1077	Type equation h ↑ 13,64%
2	JKK	24	38	21	↓ 81%
3	Umum	590	562	634	Type equation h ↑ 11,35%
4	Asuransi Lain	70	58	54	↓ 7,40%
5	JR	1	5	1	Type equation h ↓ 80%
Total Pasien		1497	1593	1787	↑ 11%

3.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2025)



3.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN APRIL 2025	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis	Kunjungan pasien BPJS dari 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan april 2025 mengalami peningkatan 13,64% dari bulan sebelumnya di karenakan untuk penerimaan pasien di IGD untuk alur dan kains sudah berubah sehingga pelayanan di IGD sangat cepat dan pasien merasa puas	Kunjungan pasien dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan april 2025 mengalami peningkatan 11,35% dari bulan sebelumnya disebabkan kunjungan di IGD masih banyak yang false emergency sehingga BPJS tidak bisa di gunakan sehingga pasien menggunakan cara bayar umum	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK dari 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan april 2025 mengalami penurunan 81% dari bulan sebelumnya	Kunjungan pasien dengan jaminan JR dan asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan april 2025 mengalami penurunan 9,8% dari bulan sebelumnya	total Kunjungan pasien IGD semua jaminan bulan april 2025 mengalami peningkatan 11% dari bulan sebelumnya
2	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD dengan memperbaiki pelayanan dan mengurangi komplain serta bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)

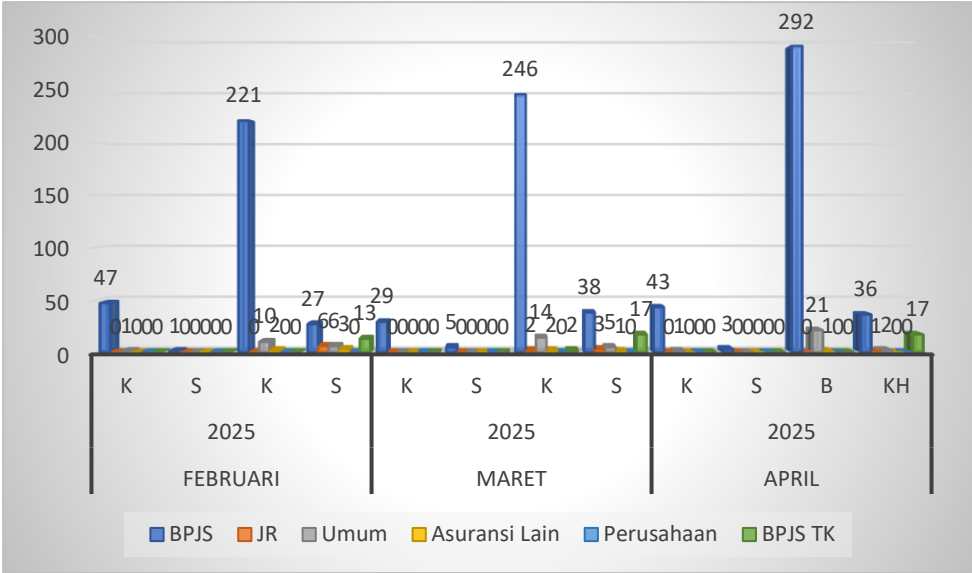
3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.4.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Februari -April 2025)

NO	HAL	FEBRUARI 2025				MARET 2025				APRIL 2025				MARET 2025
		k	s	k	s	k	s	k	s	k	s	b	kh	
1	BPJS	47	1	22	27	2	5	24	38	43	3	292	36	Peningkatan 12,7%
2	JR	0	0	0	6	0	0	2	3	0	0	0	1	
3	Umum	1	0	10	6	0	0	14	5	1	0	21	2	
4	Asuransi Lain	0	0	2	3	0	0	2	1	0	0	1	0	

5	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	BPJS TK	0	0	0	13	0	0	2	17	0	0	0	17	
	Total Pasien	366				364				417				

3.1.4.2 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Februari -April 2025)



3.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN APRIL	IKO					KESIMPULAN
		BPJS	BPJS TK	UMUM	PERUSAHAAN	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir pasien operasi yang menggunakan BPJS meningkat untuk bulan april 2025 meningkat 14,9% dari bulan sebelumnya	Pasien BPJS TK dalam 3 bulan operasi belum stabil untuk bpjs TK menurun,untuk bulan april 2025 10,5% di bandingkan bulan sebelumnya	Pasien Umum operasi dalam 3 bulan terakhir meningkat untuk bulan april 2025 mengalami peningkatan 20,8 % dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien perusahaan dalam 3 bulan terakhir stagnan tidak ada operasi selama 3 bulan terakhir	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan terakhir menurun untuk bulan april 2025 mengalami penurunan 75 % di bandingkan bulan sebelumnya	Total pasien untuk bulan april 2025 meningkat 12,7%
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan mengurangi pasien IDO sehingga pasien puas dengan pelayanan operasi di prima husada 2. Berkoordinasi dengan bagian marketing untuk ekspos ruangan IKO yang sudah di ganti vinyl 3. Mengikuti pelatihan yang terbaru sehingga menunjang pelayanan yang terbaik di IKO 4. Berkoordinasi dengan humas marketing,terutama kunjungan ke perusahaan-perusahaan dan psc untuk mengirim ke prima husada malang 5. mengirimkan pelatihan asisten bedah saraf 6. Memberikan edukasi yang bagus untuk pasien pasien operasi					

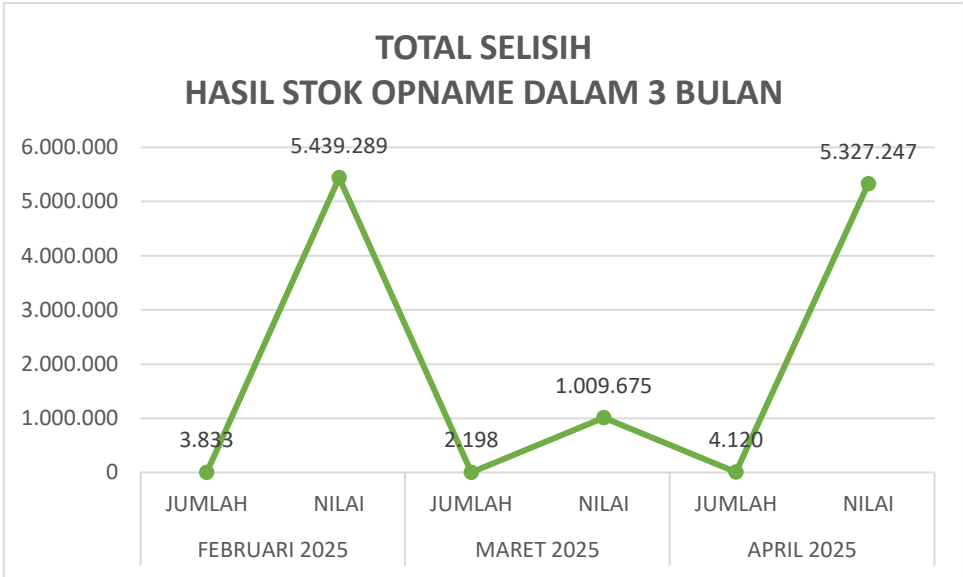
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Februari – April 2025

UNIT	JUMLAH STOK	JUMLAH PERSEDIAAN					
		FEBRUARI 2025		MARET 2025		APRIL 2025	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
GUDANG	FISIK	915.745	1.761.987.563	1.035.559	1.873.594.700	965.498	1.728.454.181
	SISTEM	915.745	1.761.987.563	1.035.558	1.874.036.506	965.498	1.728.454.181
	SELISIH	0	0	1	+34.860	0	0
DEPO FARMASI	FISIK	157.013	480.400.038	163.384	504.874.177	225.599	642.691.694
	SISTEM	153.182	474.904.947	161.212	505.093.452	221.475	635.531.901
	SELISIH	3.832	+5.495.099	2.173	-219.275	4.126	7.159.787
IKO	FISIK	1.905	89.600.086	1.891	91.545.201	1.670	81.173.371
	SISTEM	1.904	89.655.896	1.867	90.351.111	1.686	83.005.912
	SELISIH	1	-55.810	24	+1.194.090	-6	-1.832.540
GUDANG RETURE	FISIK	0	0	0	0	0	0
	SISTEM	0	0	0	0	0	0
	SELISIH	0	0	0	0	0	0
TOTAL SELISIH		3.833	+5.439.289	2.198	+1.009.675	4.120	+5.327.247

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Februari – April 2025



3.2.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

Hasil stok opname pada Bulan April 2025 belum mendekati target (+5.327.247), analisisnya sebagai berikut :		
NO	ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT
GUDANG FARMASI Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname sudah mencapai target (0). Analisa :		
1.	Barang datang yang belum diinput kurang penandaan. Tedapat Vaksin Imojev (F00793) barang baru datang faktur belum diinput pembelian, penataan di kulkas tanpa penandaan sehingga ditulis di kertas kerja, berpotensi selisih.	Barang datang yang belum diinput/ masuk stok sistem diberi penandaan.
2.	Penandaan nama pada rak sudah tertata dan kartu stok sudah berjalan	Supervisi secara berkala
DEPO FARMASI Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar +Rp 7.159.787, hal ini disebabkan karena :		
1.	Penataan buffer di ruang buffer stok tidak ada label dan campur menjadi satu dan tidak	1. Perbaikan penataan ulang buffer stok sesuai rak di ruang buffer stok.

	berdasarkan alfabetis sehingga perhitungan buffer terhambat.	2. Penambahan lemari buffer stok.
2.	- Paracetamol tab selisih lebih 103 tab. - Phenytoin caps selisih lebih 100 caps. - Clopidogrel tab 75 mg hexparm selisih lebih 1331 tab. - Ambroxol tab 30 mg & domperidone tab 10 mg terdapat selisih decimal. - Cairan infus 0,9% 1000 ml Otsuka selisih kurang 30 flash.	Meningkatkan ketelitian petugas dalam input resep dan penyiapan.
3.	Kartu stok sebagian sudah berjalan	Supervisi secara berkala
4.	Permintaan obat menggunakan resep manual di IGD	Resep akan diarsipkan oleh Petugas Farmasi dan dilakukan double crosscheck, jika ada yang belum terinput maka akan dishare di Grup dan meminta bukti inputan. Perubahan alur untuk meminimalisir selisih SO.
5.	Inputan nama barang sama namun beda pabrik atau beda ukuran sehingga perawat sering tertukar saat input resep dan barang yang diambil, seperti: - F00715 Spiriva respimat 25 mcg (alat + isi) - boehringer = -1 - F03249 Spiriva respimat 25 mcg refill - boehringer = +1 - F00101 Cairan inf d10% 500 ml - otsuka = +2 - F00103 Cairan inf d40% 25 ml - otsuka = -2 - F04650 Candesartan tab 8 mg - hexpharm jaya = -250 - F00136 Candesartan tab 8 mg - ogb dexta = +348 - F01353 Ett cuff no 7.0 - work = -1 - F01354 Ett cuff no 7.5 - work = +1 - F01386 Foley cath no 12 - rusch = +1 - F01393 Foley cath no 8 - rusch = -1 - F01642 Masker nebulizer set anak - onemed = +2 - F01643 Masker nebulizer set dewasa - onemed = -3	Perbaiki prosedur menghabiskan stok lama dan mengingatkan petugas agar penyiapan barang sesuai yang diinput penjualan.
6.	Peralihan distribusi obat dari UDD ke ODD menyebabkan selisih lebih, yaitu - Retur ODD yang belum diturunkan ke depo farmasi tapi sudah dilakukan input retur. - Proses retur yang tidak optimal dari rawat inap (perawat tidak input retur disistem). - Obat di retur ke depo farmasi tanpa etiket sehingga farmasi kesulitan tracking obat tidak beretiket.	Perbaiki prosedur retur barang tidak bertujuan: secara sistem proses retur barang tidak bertujuan wajib ada validasi dari keuangan PT. Kains membuat Berita Acara Obat Tidak bertujuan → Input penerimaan farmasi lainnya → di approve oleh PT → menambah stok di depo. Retur barang bertujuan ke depo farmasi wajib sesuai di hari yang sama dengan inputan retur penjualan sebelum pasien KRS
FLOORSTOK IKO Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar – Rp 1.832.540, hal ini disebabkan karena :		
1.	Jadwal operasi sering berbenturan dengan waktu perhitungan stok floorstock	Menghitung barang yang sudah tidak terpakai untuk operasi dan memastikan barang yang di gunakan sebelumnya sudah terinput
2.	Inputan nama barang sama namun beda pabrik atau beda ukuran sehingga perawat sering tertukar saat input resep dan barang yang diambil, seperti :	Perbaiki prosedur penyiapan barang sesuai yang diinput penjualan.

	- F01362 ett non king no 6.5 - work = -1 - F01352 ett cuff no 6.5 - work = +1 - F01414 Guedel airway 60 mm/no 0 - hospitech = +1 - F01419 Guedel airway 90 mm/no 3 - hospitech = -1	
GUDANG RETUR		
Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname sudah sesuai dengan target (0).		
1.	Tidak terdapat rak Gudang Retur.	Sentralisasi master barang PT. DPM dan mengajukan gudang retur kembali dimunculkan.

3.2.1.4 Tabel Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (Februari - April 2025)

No	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tanggal Expired	No Batch	Jumlah Fisik Baik (BULAN)			Total Harga	Laporan Penjualan 1 Tahun Terakhir
							Februari	Maret	April		
1	F01348	Ett cuff no 4.5 - work	Pcs	36.500	30/03/2025	200321	12	12	12	483.000	1
2	F00939	Benang t-lene 5-0 I17 - triton	Pcs	80.000	30/06/2025	200601AC	28	28	25	2.000.000	103
3	F00550	Nuvison tab - guardian	Tab	5.800	30/06/2025	2306083	626	424	65	377.000	1.569
4	F00796	Vaksin influenza - flubio - biofarma	Vial	121.032	30/06/2025	3020124	0	3	1	121.032	23
5	F00517	Neostigmine inj 05 mg/ml - ethica	Amp	10.901	30/07/2025	E23H0142A	15	15	15	163.515	2
6	F00542	Ntg inj 1 mg/ml - ferron	Vial	65.000	30/07/2025	BN4832412A	16	16	16	1.040.000	31
7	F00580	Oseltamivir caps 75 mg (hibah dinkes) - indofarma	Caps	10.010	30/07/2025	210V2062	1.100	1.100	1.100	11.011.000	0
8	F00030	Aminophylline inj 24 mg/ml - phapros	Amp	4.000	30/08/2025	66307030-1	36	34	29	116.000	243
9	F00307	Ferriprox tab 500 mg - apotex inc	Tab	35.100	30/08/2025	ry1625	194	194	194	6.809.400	0
10	F00603	Perossal 2x6 - dipa pharmalab	Pcs	231.000	30/08/2025	22HA14780	16	16	10	2.310.000	87
11	F00228	Cotrimoxazole syr 240 mg/5 ml - mersi	Btl	2.773	30/09/2025	A21797	82	76	64	177.472	258
12	F00176	Cendo pantocain 2% - cendo	Flash	13.250	30/09/2025	2P30926	5	5	5	66.250	14
13	F01337	Dj stent 6 fr close end - medika	Pcs	280.000	30/09/2025	76122032	14	14	14	3.920.000	17
14	F01394	Foley cath silicon no 10 - rusch	Pcs	110.000	30/09/2025	KME20K3008	5	5	5	550.000	2
15	F01680	Nelaton cath no 12 - rusch	Pcs	16.500	30/09/2025	KMA2050441	2	2	2	33.000	1

16	F00607	Phenobarbital tab 30 mg - kimia farma	Tab	200	30/09/2025	I31729N	0	100	10	2.000	90
17	F00735	Tekasol ointment cr 10 g - sdm	Tub	40.950	30/09/2025	D000IAI	7	7	7	286.650	32
18	F04623	Tobramycin eye drop 5 ml - ferron	Btl	15.856	30/09/2025	4630910	40	40	40	634.240	0
Total										30.055.559	

3.2.1.5 Analisis Obat Near ED < 6 bulan (Bulan Februari - April 2025)

ANALISIS	TINDAK LANJUT
Rekap Near ED < 6 bulan (Bulan Maret - September 2025 karena obat dan alkes slow moving: 1. Ett cuff no 4.5 - work, dimasukkan ke dalam trakea untuk memastikan tidak tertutupnya trakea sebagai saluran pernapasan dan udara pernapasan dapat masuk kedalam paru-paru. Faktur pembelian terakhir tanggal 19/07/2024 dari distributor sejumlah 8 pcs, penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. 2. Benang t-lene 5-0 I17 – triton, digunakan untuk operasi. Penyimpanan di IKO tidak FEFO sehingga ditemukan barang near ED, faktur pembelian terakhir tanggal 28/09/2021 dari distributor sejumlah 24 pcs. 3. Nuvision tab - guardian, digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk memelihara kesehatan mata. Faktur pembelian terakhir tanggal 23/10/2023 dari distributor sejumlah 1980 tab. Harga obat mahal sehingga tidak cukup plafon untuk pasien BPJS. 4. Vaksin influenza - flubio – biofarma, digunakan untuk melindungi tubuh dari penyakit akibat virus influenza. Faktur pembelian terakhir tanggal 20/03/2025 dari distributor sejumlah 4 vial, penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. 5. Neostigmine inj 05 mg/ml – ethica untuk meringankan gejala myasthenia gravis, pengobatan ileus paralitik, retensi urin pasca operasi. Faktur pembelian terakhir tanggal 28/11/2024 dari distributor sejumlah 10 ampul. Penggunaan obat slow moving tapi termasuk obat emergency. 6. Ntg inj 1 mg/ml - ferron, indikasi untuk mengontrol hipertensi dengan cepat selama pembedahan jantung, Menurunkan tekanan darah dan menjaga hipotensi yang terkontrol selama prosedur pembedahan, Mengontrol iskemia miokard selama dan setelah pembedahan, Gagal jantung kongestif yang tidak responsif karena infark miokard akut, Angina tidak stabil yang sulit disembuhkan dengan beta blocker dan nitrat sublingual. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 25/06/2024 dari distributor sejumlah 10 amp. 7. Oseltamivir caps 75 mg (hibah dinkes) – indofarma, untuk mengatasi infeksi virus influenza tipe A atau B. Penggunaan obat death moving. Penerimaan obat dari dinas kesehatan tanggal 06/08/2021 sejumlah 700 tablet untuk pengobatan covid-19. 8. Aminophylline inj 24 mg/ml – phapros, untuk mengatasi serangan asma bronkial. Pembelian terakhir tanggal 27/11/2024 dari RS Prima Husada Sukorejo sejumlah 30 ampul. Penggunaan obat slow moving tapi termasuk obat emergency. 9. Ferriprox tab 500 mg - apotex inc untuk terapi kelebihan Fe (zat besi) pada pasien talasemia mayor. Faktur pembelian terakhir tanggal 21/02/2021 dari distributor sejumlah 300 tablet. Penggunaan obat death moving karena obat tidak bisa di klaim obat kronis di FKRTL.	1. Sediaan farmasi near ED akan dilakukan koordinasi dengan DPJP untuk peresepan. 2. Membuat surat edaran ke DPJP untuk meresepkan obat/ alkes yang near ed. 3. Koordinasi dengan karu untuk menggunakan alkes yang near ed. 4. Koordinasi dengan PT. DPM untuk melakukan retur ke distributor. 5. Koordinasi dengan DPJP obat yang <i>death moving</i> di <i>stop order</i> dan dikeluarkan dari Formularium RS.

10. Perossal 2x6 - dipa pharmlab merupakan material sintetik pengganti tulang yang resorbable, digunakan untuk pengisian atau rekonstruksi tulang pada tulang yang rusak. Faktur pembelian terakhir tanggal 15/01/2025 dari distributor sejumlah 12 pcs, penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. 11. Cotrimoxazole syr 240 mg/5 ml – mersi untuk infeksi saluran nafas, kulit, saluran kemih dan kelain, gastrointestinal, infeksi THT. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 04/12/2024 dari distributor sejumlah 30 botol. 12. Cendo pantocain 2% - cendo, digunakan untuk anestesi lokal. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 10/07/2023 dari distributor sejumlah 16 flash. 13. Dj stent 6 fr close end – medika dimasukkan ke dalam ureter untuk mencegah atau menangani penyumbatan aliran urine dari ginjal. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/11/2024 dari distributor sejumlah 5 pcs. 14. Foley cath silicon no 10 – rusch, dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Faktur pembelian terakhir tanggal 17/01/2023 dari distributor sejumlah 10 pcs. 15. Nelaton cath no 12 – rusch, digunakan untuk kateterisasi kandung kemih jangka pendek. 16. Phenobarbital tab 30 mg - kimia farma, digunakan untuk mengobati atau mencegah kejang. Peresepan terakhir tanggal 01/04/2023 penggunaan obat jadi death moving, faktur pembelian terakhir tanggal 16/02/2024 dari distributor sejumlah 100 tab. 17. Tekasol ointment cr 10 g – sdm, digunakan untuk mengurangi gejala luka keloid pada operasi minor dan mempercepat penyembuhan luka. Penggunaan obat death moving, faktur pembelian terakhir tanggal 16/12/2022 dari distributor sejumlah 78 tube. 18. Tobramycin eye drop 5 ml – ferron, digunakan untuk mengatasi iritasi mata akibat infeksi bakteri. Faktur pembelian terakhir tanggal 18/02/2025 dari distributor sejumlah 40 botol, penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor	
---	--

3.2.1.6 Managemen Resiko dan Aksi Mitigasi

No Risk	Divisi	Spesialis terkait	Pemilik Risk	Tipe Risk	Deskripsi Risk	Pengendalian yang sudah ada	Skor Risk Sebelumnya	Dampak	Kemungkinan	Status Perubahan Rating Risiko	Mitigasi yang sedang dijalankan	Target Penyelesaian	Target Skor Risk	Indikator Kunci Mitigasi	Rencana Review
1	Komit e medik	Dokter/ Dokter spesialis	Pasien	Klini s	Kesalahan input e-resep	Kontrol dan supervisi	9	Ekstri m	Kemungkin an besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	SPO penulisan dan input resep serta supervisi	Meninjau ulang setiap tahun terkait kompetensi dokter

2	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan penyiapan obat	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi serta pelatihan berkelanjutan	3 bulan - 6 bulan	6	SPO alur pelayanan resep rawat jalan dan resep pulang pasien rawat inap. Jumlah TTK/ apoteker terpenuhi sesuai dengan kebutuhan tenaga. Terdapat diklat dan motivasi kerja	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
3	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan penulisan pada etiket obat	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
4	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Obat tidak dilengkapi <i>expired date/ beyond use date</i>	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

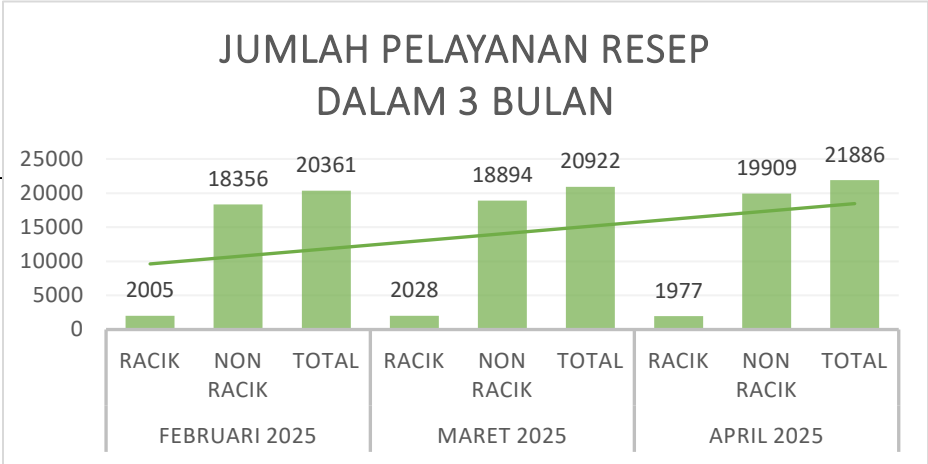
5	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan identifikasi pasien	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
6	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan pemberian obat pada pasien	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	SPO telaah obat, SPO verifikasi pemberian obat rawat inap. Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
7	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat jalan	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	3	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
8	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat inap	Kontrol dan supervisi	3	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

9	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden reaksi alergi obat	Kontrol dan supervisi	11	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
10	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kesalahan dosis obat	Kontrol dan supervisi	8	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

3.2.1.7 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Februari - April 2025

UNIT	JUMLAH RESEP					
	FEBRUARI 2025		MARET 2025		APRIL 2025	
	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK
IRNA	195	8229	220	8506	207	9245
IRJA	1726	7389	1686	7529	1676	7533
IKO	0	794	0	919	0	1058
IGD	84	1944	122	1940	94	2073
TOTAL	2005	18356	2028	18894	1977	19909
JUMLAH RESEP OBAT	20.361		20.922		21.886	

3.2.1.8 Grafik Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Februari - April 2025



Analisis :

Secara keseluruhan total resep pada Bulan April 2025 mengalami peningkatan namun tidak signifikan, hal ini sebanding dengan peningkatan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap.

Peningkatan yang tidak signifikan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1. Jumlah pasien baru tidak banyak.
- 2. Target PRB rawat jalan juga tetap berjalan, dimana pasien rujuk balik ke FKTP dikarenakan pasien sudah stabil dan retur obat tertinggal rawat jalan yang tidak diambil pasien.
- 3. Kenaikan pasien rawat inap tidak signifikan, karena terdapat penurunan jumlah pasien rawat inap di akhir bulan (cuti bersama).

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di sosial media RS agar kunjungan pasien meningkat.
- 2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.
- 3. Mengajukan fitur cek hasil laboratorium dalam batas waktu 6 bulan dari IRNA dan IRJA untuk memudahkan pemberian obat sesuai dengan retriksi yang ditentukan.
- 4. Menciptakan inovasi pengembangan pelayanan pengantaran obat dengan penambahan jumlah driver.
- 5. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru dan obat tertinggal.
- 6. Perubahan alur distribusi obat, petugas melebur menjadi satu. Penambahan petugas shift malam supaya tidak terjadi lembur menyelesaikan obat rawat jalan.
- 7. Penambahan admin IKO untuk focus pada mutase barang di Floorstok IKO.

3.2.1.9 Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Bulan Februari - April 2025

No	Kegiatan	Standard	Pencapaian			Keterangan
			Februari 2025	Maret 2025	April 2025	
1.	Pengkajian Resep	100%	99.17%	99.14%	98.83%	Jumlah pengkajian resep, yaitu Januari 2025 = 22.046 Februari 2025 = 20.361 Maret 2025 = 20.922 April 2025 = 21.886 Jumlah ketidaklengkapan penulisan resep, yaitu Januari 2025 = 128 Februari 2025 = 168 Maret 2025 = 180 April 2025 = 255
2.	Dispensing sediaan steril	100%	100%	100%	100%	Dispensing sediaan steril dilakukan oleh apoteker di Ruang Pencampuran Obat Steril (LAF).
3.	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	100%	100%	100%	100%	Form PTO sudah terlaksana dimana apoteker melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria PTO. Form PTO diletakkan dalam RM.
4.	Kejadian Efek Samping Obat	0	1	0	0	Tidak ditemukan pelaporan efek samping obat pada Bulan April 2025.
5.	Edukasi Obat pada pasien dan keluarga	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan rekam medis dan resep obat yang ditandatangani oleh penerima obat.
6.	Konseling	100%	100%	100%	100%	Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di Lembar Edukasi (pasien rawat inap) dan tanda-tangan penerima obat di resep (pasien rawat jalan).
7.	Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah	TDD	TDD	TDD	TDD	Tidak punya alat untuk pemantauan kadar obat dalam darah. TTD RS tipe C tidak wajib.
8.	Visite Ronde Besar	100%	0%	0.08%	0%	Koordinasi dengan PPA (Professional Pemberi Asuhan) agar dilakukan visite ronde besar. Dilakukan pada hari Kamis, 27-03-2025 dengan dr Adhya Aji, Sp.PD.

9.	Visite Pasien/ Farmasi Klinik	100%	100%	100%	100%	Seluruh pasien rawat inap dilakukan visite mandiri dibuktikan dengan pengisian CPPT oleh Apoteker di RM.
10.	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan map informasi obat, MIMS, aplikasi Medscape.
11.	Obat tidak bertuan	0	0	365	10	Ditemukan retur obat tidak bertuan dilakukan penyesuaian saat stok opname
12.	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien	0	50	34	30	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien dilakukan Penerimaan Hibah Lainnya ke gudang retur
13.	Penempelan label obat rawat inap	100%	100%	100%	100%	Tidak ada laporan penempelan label obat rawat inap yang tidak ada dan tidak ada laporan IKP kejadian kesalahan penulisan etiket obat.

3.2.1.10 **Tabel Analisa dan Tindakanlanjut Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada pada Bulan Februari - April 2025**

KINERJA	ANALISA	TINDAKLANJUT
Pengkajian Resep	Penulisan resep yang lengkap bulan April 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2025, dengan prosentase resep yang tidak lengkap yaitu : bulan Maret 2025 sebanyak 99.14% dan bulan April 2025 sebanyak 98.83%. Dari data di atas ditemukan pengkajian resep : 1. Dari segi telaah adminitrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep melalui SIMRS 2. Dari segi telaah farmasetik : masih ditemukan dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi. 3. Dari segi telaah klinis : sudah terlaksana oleh apoteker karena jika ada interaksi obat langsung diberi jeda pemberian obat oleh apoteker.	1. Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke IFRS. 2. Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual). 3. Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.

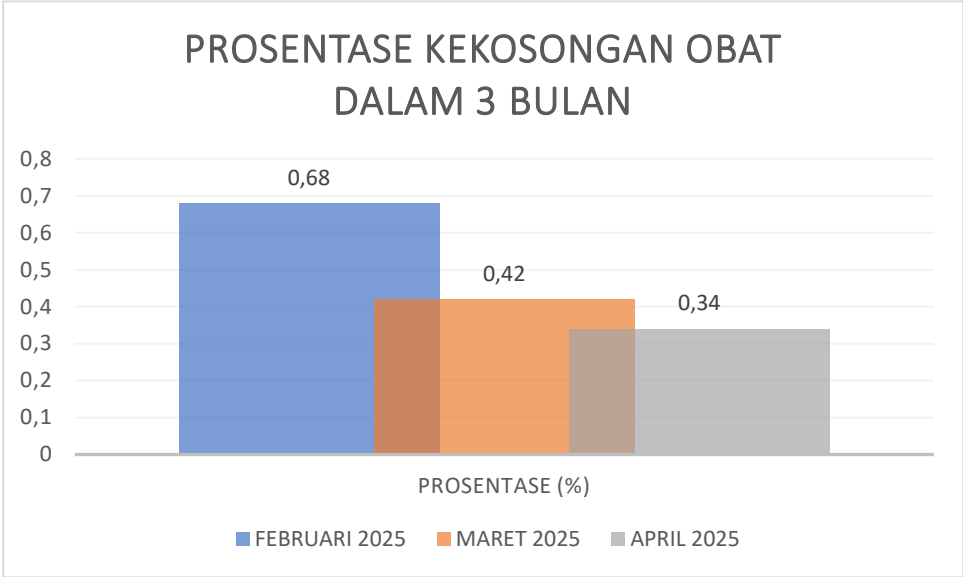
Kejadian Efek Samping Obat	- Hasil monitoring pelaporan MESO bulan April 2025 tidak ditemukan terjadinya efek samping obat. - Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.	- Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan. - Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien. - Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO). - Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO. - Menganalisa laporan ESO. - Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO). - Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.
Edukasi Obat Pada Pasien dan Keluarga	- Hasil supervisi dari rekam medis di rawat inap pada form edukasi bahwa apoteker sudah melakukan edukasi dibuktikan dengan ttd pasien/ keluarga di form edukasi. - Hasil supervisi dirawat jalan petugas farmasi sudah melakukan edukasi ke pasien dibuktikan dengan ttd penerima obat beserta KIE.	Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan edukasi obat di rawat inap dan rawat jalan.
Pelayanan Informasi Obat (PIO)	PPA dapat megakses Map informasi obat berisi : daftar dosis maksimal prorenata (jika perlu), daftar obat automatic stop order, daftar obat high alert update, daftar obat resiko jatuh, informasi cara pengenceran obat, informasi pembatasan resep, tabel rekonstitusi untuk pemberian intravena; MIMS; aplikasi Medscape di nurse station atau di poli.	Map informasi obat, MIMS, aplikasi Medscape sudah tersedia di unit pelayanan
Obat Tidak Bertuan	- Retur obat tidak bertujuan dikarenakan proses retur yang tidak optimal dari rawat inap dan rawat jalan (perawat tidak input retur disistem). - Obat di retur ke depo farmasi tanpa etiket sehingga farmasi kesulitan tracking obat tidak beretiket.	- Obat tidak layak dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan. - Obat layak di retur ke gudang retur farmasi dengan berita acara obat/ alkes tidak bertujuan yang sudah di tandatangani oleh Direktur RS, kemudian keuangan PT memberikan persetujuan akhir dan dilakukan Penerimaan Farmasi Lain di SIMRS. - Pembuatan fitur khusus untuk obat tidak bertujuan dan pengembangan fitur approval berjenjang. - Peningkatan akurasi manajemen stok obat.

Obat Tertinggal Yang Tidak Diambil Pasien	Data obat tertinggal yang tidak diambil pasien bulan April 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2025, dengan total resep yang di retur yaitu bulan Maret 2025 sebanyak 29 dan bulan April 2025 sebanyak 30. Hal ini disebabkan beberapa pasien tidak mengetahui mendapatkan resep sehingga obat ditinggal dalam waktu 3x24 jam dan keterlambatan penyiapan obat sehingga waktu tunggu obat lama.	1. Menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal. 2. Terdapat program pengantaran obat gratis melalui Primantara sehingga mengurangi jumlah obat tertinggal.
--	---	--

3.2.1.11 Tabel Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Februari - April 2025

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
FEBRUARI 2025					
1.	1/2/2025-28/2/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2.	1/2/2025-28/2/2025	Spironolakton tab 100 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Substitusi ke Spironolakton tab 25 mg
3.	1/2/2025-28/2/2025	Orezinc syr 60 ml	Obat untuk diare	PT. Antar Mitra Sembada	Zincpro syr 60 ml
4.	1/2/2025-28/2/2025	Quetvell tab 200 mg	Anti psikosis	PT. Antar Mitra Sembada	Soroquin tab 200 m
5.	1/2/2025-28/2/2025	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
6.	1/2/2025-28/2/2025	Methylegometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
7.	1/2/2025-28/2/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
8.	1/2/2025-28/2/2025	Gliquidone tab 30 mg	Antidiabetes	PT. Anugrah Argon Medica	Substitusi dengan golongan Antidiabetes Oral lain
Total prosentase Januari 2025 = 0.68%					
MARET 2025					
1.	1/3/2025-31/3/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2.	1/3/2025-31/3/2025	Quetvell tab 200 mg	Anti psikosis	PT. Antar Mitra Sembada	Soroquin tab 200 mg
3.	1/3/2025-31/3/2025	Methylegometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
4.	1/3/2025-31/3/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
5.	1/3/2025-31/3/2025	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
Total Prosentase Februari 2025 = 0.42%					
APRIL 2025					
1.	1/4/2025-31/4/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2.	1/4/2025-31/4/2025	Quetvell tab 200 mg	Anti psikosis	PT. Antar Mitra Sembada	Soroquin tab 200 mg
3.	1/4/2025-31/4/2025	Methylegometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
4.	1/4/2025-31/4/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Maret 2025 = 0.34%					

3.2.1.12 Grafik Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Februari - April 2025



Analisis :

1. Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan masih sering terjadi kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok di distributor habis, kekosongan produk originator seperti Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg dan Itraconazole caps 100 mg sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
2. RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
2. Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
3. Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.
4. RS sudah mempunyai akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
5. Memberitahukan info kekosongan obat di distributor ke DPJP melalui surat edaran beserta saran substitusi.

3.2.1.13 Tabel Pemusnahan Obat, BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar), dan Recall Bulan April 2025

No	Kegiatan	Nama Obat/ BMHP/ Alat Kesehatan	Jumlah	Alasan	Keterangan
1.	Pemusnahan	-		-	Tidak ada pemusnahan obat
2.	BMHP/Alat Kesehatan Rusak (Substandar)	-	-	-	Tidak ada BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar)
3.	Recall	-	-	-	Tidak ada recall

3.2.1.14 Tabel Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Farmasi Pada Bulan April 2025

NO	MONITORING DAN EVALUASI	HASIL	TINDAK LANJUT															
1.	Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP	Perencanaan dilakukan dengan metode konsumsi dan rumus VEN-ABC. Evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP digudang farmasi menggunakan sistem ROP dan Non ROP farmasi di SIMRS, dikarenakan sistem ROP belum mendeteksi penjualan obat slow moving namun tetap harus disediakan jadi petugas mendata obat menipis secara manual kemudian diinput Non ROP farmasi	Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP menggunakan sistem ROP di gudang farmasi.															
2.	Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP ke distributor	Pengadaan sediaan farmasi dan BMHP dengan pembelian langsung, repacking dan donasi/hibah. Tersedia PKS dengan distributor; Semua pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, termasuk obat vaksin harus menjamin garansi keaslian yakni : a. Sediaan farmasi - No.Ijin Edar dari BPOM b. Alkes - No.Ijin Edar dari Dirjen Binar dan CoA c. BMHP - No ijin edar dari Binar d. B3 - MSDS; Kunjungan ke distributor; Surat Pesanan obat, alkes, dan BMHP di tandatangan oleh APJ	Monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP															
3.	Pemantauan suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin	Form monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin sudah tersedia namun petugas masih tidak rutin mengisi.	Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin di depo dan gudang farmasi oleh apoteker setiap hari.															
4.	Supervisi box emergency, trolley emergency, kit emergency, box HPP dan Eklamsi	Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali. Bedah box triwulan 2 pada Bulan April Tahun 2025 sudah dilakukan. Berikut temuan obat yang mendekati ED 6 bulan dan diganti dengan ED jauh yaitu : <table><tr><th>No</th><th>Temuan obat near ED < 6 bulan</th><th>Pergantian obat near ED</th></tr><tr><td>1.</td><td>Box emergency poli lantai 1: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.</td><td>Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Box emergency poli treadmill: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Gelafusal 9/25.</td><td>Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Gelafusal 4/27.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Box emergency poli lantai 2: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.</td><td>Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.</td></tr><tr><td>4.</td><td>Box emergency poli vaksin: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dexamethason inj 8/25, Dopamin inj 9/25, Epinephrin inj 8/25, Infus D5% 9/25,</td><td>Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dexamethason inj 6/26, Dopamin inj 9/26, Epinephrin inj 11/27, Infus D5% 11/26,</td></tr></table>	No	Temuan obat near ED < 6 bulan	Pergantian obat near ED	1.	Box emergency poli lantai 1: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.	2.	Box emergency poli treadmill: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Gelafusal 9/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Gelafusal 4/27.	3.	Box emergency poli lantai 2: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.	4.	Box emergency poli vaksin: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dexamethason inj 8/25, Dopamin inj 9/25, Epinephrin inj 8/25, Infus D5% 9/25,	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dexamethason inj 6/26, Dopamin inj 9/26, Epinephrin inj 11/27, Infus D5% 11/26,	Dilakukan supervisi oleh apoteker terhadap penyimpanan obat <i>emergency</i> dan segera diganti apabila dipakai, kedaluwarsa, atau rusak. Pelaksanaan supervisi dilakukan sebagai berikut : a. Pengecekan segel, pengecekan kedaluwarsa di list daftar obat dan pengecekan suhu penyimpanan dilakukan setiap hari. b. Pengecekan jumlah dan dipakai dilakukan saat segel terbuka. c. Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk mencegah kedaluwarsa saat dibutuhkan.
No	Temuan obat near ED < 6 bulan	Pergantian obat near ED																
1.	Box emergency poli lantai 1: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.																
2.	Box emergency poli treadmill: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Gelafusal 9/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Gelafusal 4/27.																
3.	Box emergency poli lantai 2: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.																
4.	Box emergency poli vaksin: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dexamethason inj 8/25, Dopamin inj 9/25, Epinephrin inj 8/25, Infus D5% 9/25,	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dexamethason inj 6/26, Dopamin inj 9/26, Epinephrin inj 11/27, Infus D5% 11/26,																

			Infus Manitol 8/25, Valisanbe inj 12/25.	Infus Manitol 1/26, Valisanbe inj 7/26.	
	5.	Trolley emergency IGD:			
		Aminophillylin inj 8/25, Inzana tab 9/25, Dexametason inj 12/25, Dopamin inj 8/25, Epinephrin inj 8/25, Furosemid inj 9/26, Infus D5% 8/25, Valisanbe inj 10/26.		Aminophillylin inj 2/26, Inzana tab 1/27, Dexametason inj 6/26, Dopamin inj 12/26, Epinephrin inj 11/27, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 8/26, Valisanbe inj 10/26.	
	6.	Box emergency infant Ponek IGD:			
		Aminophyllin inj 9/25, Dexamethason inj 8/25, Diazepam Rectal 8/25, Dobutamin inj 8/25, Epinephrin inj 8/25, Suction cath no. 8 10/25.		Aminophyllin inj 9/28, Dexamethason inj 6/26), Diazepam Rectal 8/26, Dobutamin inj 12/26, Epinephrin inj 11/27, Suction cath no. 8 12/28.	
	7.	Box HPP – Eklamsi IGD:			
		Eklampsi set : Infus RL 8/26, IV cannul no. 18 3/28. BE HPP SET : Infus RL 8/26, iv canul no. 18 9/28		Eklampsi set : Infus RL 8/26, IV cannul no. 18 3/28. BE HPP set : Infus RL 8/26, iv canul no. 18 9/28	
	8.	Kit emergency IGD 1:			
		Lidocain inj 9/25, Sduit 3 cc 12/25.		Lidocain inj 12/28, Sduit 3 cc 6/29.	
	9.	Kit emergency IGD 2:			
		Tidak ada obat near ED		-	
	10.	Box emergency ambulance:			
		Aminophillyne 8/25, Dobutamin inj 8/25, Dopamin inj 8/25, Infus D5% 8/26, Na-Phenytoin inj 1/28, Sduit 10 cc 9/29.		Aminophillyne 2/26, Dobutamin inj 12/26, Dopamin inj 12/26, Infus D5% 8/26, Na-Phenytoin inj 1/28, Sduit 10 cc 9/29.	
	11.	Trolley emergency IKO:			
		Infus D5% 1/26, Infus Gelafusal 8/25, Mannitol 1/26, IV 20 7/26, Amiodaron 2/26, Dopamin 10/25, Valisanbe 8/25, Inzana 11/25, Clopidogrel 3/26, Aminophillin 8/25, Dexametasone 3/26.		Infus D5% 6/26, Infus Gelafusal 4/27, Mannitol 4/26, IV 20 9/29, Amiodaron 1/27, Dopamin 12/26, Valisanbe 10/26, Inzana 02/27, Clopidogrel 12/26, Aminophillin 02/26, Dexametasone 2/27.	
	12.	Box emergency infant IKO:			
		Infus Gelafusal 10/25, Infus D10% 12/25, IV 24 11/25, Aminofilin 8/25, Dopamine 10/25, Sduit 1cc Terumo 8/25, Sduit 3cc Terumo 11/25, Sduit 5cc Terumo 3/26, Sduit 10cc Terumo 9/25		Infus gelafusal 4/27, Infus D10% 12/26, IV cannul no. 24 6/28, Aminophillin 2/26, Dexamethasone 2/27, Dopamine 12/26, Sduit 1 cc Terumo 5/29, Sduit 3 cc Terumo 9/29, Sduit 5 cc Terumo 8/29, Sduit 10 cc Terumo 9/29	
	13.	Box HPP-Eklampsi IKO:			
		Tidak ada obat near ED		-	
	14.	Box emergency 2C:			
		Mannitol 1/26, Clopidogrel 2/26, Aminophillin 8/25, Phenytoin 1/26, Sduit 1 cc-Terumo 8/25		Mannitol 6/26, Clopidogrel 6/26, Aminophilli 2/26, Phenytoin 1/28, Sduit 1 cc 6/26	
	15.	Box emergency ICU:			
		Mannitol 1/26, Aminophillin 8/25		Mannitol 6/26, Aminophillin 2/26	
	16.	Box emergency ICU ventilator:			
		Tidak ada obat near ED		-	
	17.	Box emergency HCU:			
		Aminophillin 8/25, Valisanbe injeksi 12/25, Phenytoin 1/26		Aminophillin 2/26, Valisanbe injeksi 11/26, Phenytoin 1/28	
	18.	Box emergency 3C anak:			
		Aminophillin 8/25, Aspilet 11/25,		Aminophillin 2/26, Aspilet 02/27,	

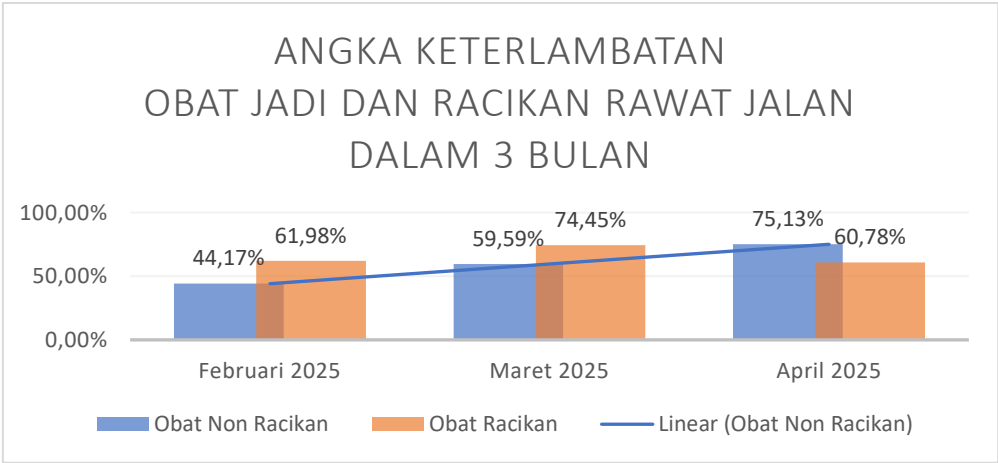
			Clopidogrel 01/26, Dobutamin 1/26, Dopamin 2/26, Mannitol 1/26, Na. Phenytoin 07/26, Furosemide 6/26, Valisanbe injeksi 1/26, Dexametasone 6/26	Clopidogrel 12/26, Dobutamin 01/26, Dopamin 09/26, Mannitol 01/26, Na. Phenytoin 01/28, Furosemide 11/26, Valisanbe Injeksi 10/26, Dexametasone 02/27	
		19.	Box emergency PICU Ventilator:		
			Amiodarone 5/26, Dopamin 2/26, Dexamethasone 2/26	Amiodarone 1/27, Dopamin 12/26, Dexamethasone 2/27	
		20.	Box emergency PICU:		
			Asam tranexamat 6/26, Amiodarone 5/26, Furosemide 5/26, Dexamethasone 6/26, Valisanbe 7/26, Infus D10 5/26	Asam tranexamat 12/26, Amiodarone 1/27, Furosemide 11/26, Dexamethasone 2/27, Valisanbe 10/26, Infus D10 12/26	
		21.	Box emergency 2A:		
			Aminophillin 2/26, Valisanbe injeksi 1/26, Aspilet 6/26, Clopidogrel 6/26	Aminophillin 2/26, Valisanbe injeksi 1/26, Aspilet 6/26, Clopidogrel 12/26	
		22.	Box emergency 3A:		
			Aminophillin 8/25, Amiodaron 6/26, Aspilet 11/25, Dexametasone 6/26, Mannitol 1/26, Valisanbe 10/25, Furosemide 6/26, Dopamine 2/26	Aminophillin 2/26, Amiodaron 1/27, Inzana 2/27, Dexametasone 2/27, Mannitol 6/26, Valisanbe 10/26, Furosemide 12/26, Dopamine 12/26	
		23.	Box emergency 4A:		
			Aminophillin 11/25, Amiodaron 6 /25, Aspilet 1/26	Aminophillin 2/26, Amiodaron 1/27, Aspilet 2/27	
		24.	Box emergency infant Maternitas:		
			Aminophillin 8/25, Dexametasone 10/25, Diazepam 9/25 Dopamin 9/25, Sduit 1cc 12/25, Suction Catheter 8 12/25	Aminophillin 2/26 Dexametasone 2/27 Diazepam 8/26 Dopamin 01/28 Sduit 1cc 02/28 Suction Catheter 8 05/29	
		25.	Trolley emergency Maternitas:		
			Infus D5 9/25, Sduit 5 cc terumo 12/25, Sduit 1 cc terumo 8/25, Aminophillin 8/25, Amiodaron 8/25, Miniaspi 11/25, Dexametasone 10/25, Dopamin 9/25, Na. Phenytoin 7/25, Valisanbe injeksi 12/25, Infus RL 8/25, Iv canule18 10/25, NS 0,9 % 6/25, Misoprostol 11/25	Infus D5 11/26, Sduit 5 cc terumo 09/29, Sduit 1 cc terumo 12/29, Aminophillin 02/26, Amiodaron 8/26, Miniaspi 07/26, Dexametasone 02/27, Dopamin 02/27, Na. Phenytoin 01/28, Valisanbe injeksi 11/26, Infus RL 8/26, Iv canule18 03/26, NS 0,9 % 1/27, Misoprostol 08/26	
		26.	Box emergency infant Perinatologi:		
			Aminophillin 8/25, Dexmetasone 6/25, Diazepam rectal 9/25, Dobutamin 7/25, Dopamin 9/25, Infus Gelafusal 6/25, Natrium Phenytoin 8/25, Suction Catheter 10/25	Aminophillin 02/26, Dexmetasone 2/27, Diazepam rectal 9/27, Dobutamin 12/26, Dopamin 09/26, Infus Gelafusal 2/26, Natrium Phenytoin 7/26, Suction Catheter 2/28	
		27.	Box emergency 5C:		
			Aminophillin 8/25 Dexametasone 6/26 Furosemide 6/26 Valisanbe 12/25	Aminophillin 2/26 Dexametasone 2/27 Furosemide 11/26 Valisanbe 10/26	
		28.	Box emergency 6A:		
			Aminophillin 11/25 Amiodaron 6 /25 Aspilet 1/26	Aminophillin 2/26 Amiodaron 1/27 Aspilet 2/27	

		29. Box emergency 7A: Aminophillin 11/25 Aminophillin 2/26 Amiodaron 6 /25 Amiodaron 1/27 Aspilet 1/26 Aspilet 2/27	
		30. Box emergency 8A: Aminophillin 8/25 Aminophillin 2/26 Amiodaron 6/26 Amiodaron 1/27 Aspilet 11/25 Inzana 2/27 Dexametasone 6/26 Dexametasone 2/27 Mannitol 1/26 Mannitol 6/26 Valisanbe 10/25 Valisanbe 10/26 Furosemide 6/26 Furosemide 12/26 Dopamine 2/26 Dopamine 12/26	
		31. Box emergency Radiologi: Aminophillin 8/25 Aminophillin 2/26	
5.	Kartu stok obat	Kepatuhan penulisan kartu stok 70% di depo farmasi, petugas masih merapel pengeluaran kartu stok dan belum menulis sisa stok. Kepatuhan penulisan kartu stok 100% di gudang farmasi.	1. Supervisi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap menuliskan pada kartu stok 2. Petugas lebih teliti ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran.
6.	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun di ruangan terpisah dan didalam lemari B3 tersedia APAR dan diberi label B3 sesuai sifat dan risiko bahan.	Monitoring dan evaluasi terhadap penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3).
7.	Penyimpanan produk steril di unit	Ditemukan perawat anestesi IKO melakukan sharing dose KTM inj dan sisanya digunakan kembali besok hari (lebih dari 1x24 jam) sehingga melewati batas BUD.	Supervisi secara berkala dan edukasi ke perawat BUD produk steril tidak boleh lebih dari 3 jam.
8.	Pelaksanaan double check untuk pemberian obat high alert	Bulan April 2025 terjadi perubahan sistem dari distribusi UDD (<i>Unit Dose Dispensing</i>) ke ODD (<i>One Daily Dose</i>) dimana double check obat high alert dengan mengisi daftar tilik serah terima obat farmasi - rawat inap sudah ditiadakan. Serah terima obat menggunakan lembar serah terima obat pasien, resep dan daftar pemberian obat (DPO) antar farmasi dan perawat. Double check dilakukan oleh farmasi sebelum distribusi obat.	Supervisi berkala

3.2.1.15 Tabel Angka Keterlambatan Obat Jadi dan Racikan Bulan Februari – April 2025

INDIKATOR	BULAN		
	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
Penyiapan Obat Jadi Rawat Jalan > 30 menit	44.17%	59.59%	75.13%
Penyiapan Obat Racikan > 60 menit	61.98%	74.45%	60.78%

3.2.1.16 Grafik Angka Keterlambatan Obat Jadi dan Racikan Bulan Februari - April 2025



Analisis :

Waktu tunggu obat rawat jalan pada Bulan April Tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2025. Namun prosentasi tersebut masih jauh dari target (0%) dikarenakan libur tanggal merah dan poli tutup sehingga menyebabkan penumpukan kunjungan pasien pada saat hari aktif, kunjungan pasien yang tidak dibatasi sehingga terjadi penumpukan resep di jam-jam tertentu.

Rencana Tindak Lanjut:

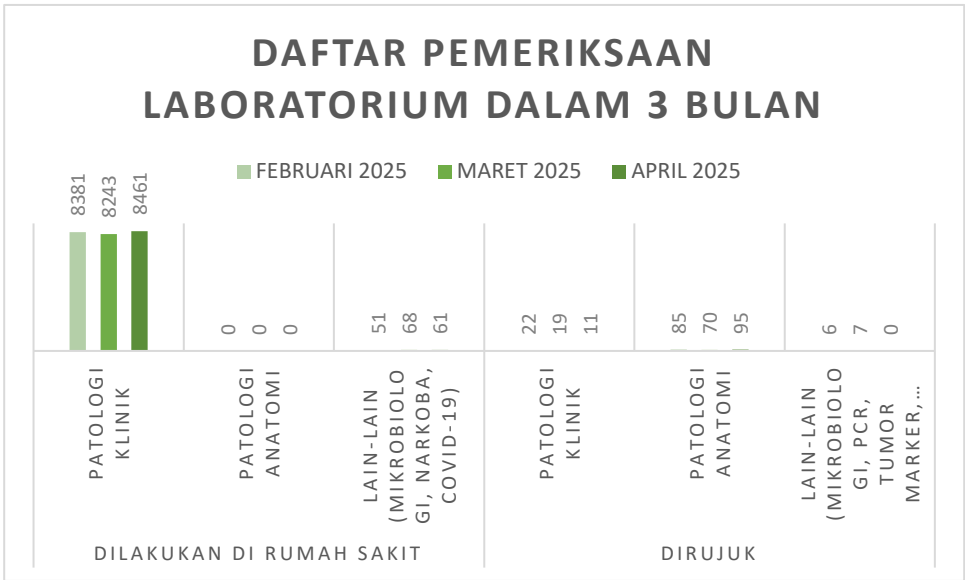
1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam klik obat selesai maupun ambil obat, sehingga petugas farmasi diharapkan *real time* dalam pelaksanaannya.
2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait alur pemberian obat kepada pasien, bahwa harus dihindari terjadi penumpukan obat yang telah siap diberikan.
3. Terdapat program pengantaran obat melalui Primantara sehingga mengurangi antrian pasien menunggu obat.
4. Petugas input dibagi menjadi resep kronis dan resep non kronis oleh TTK, resep iter dan PRB oleh Apoteker.
- 5.

5.2.1 Laboratorium

5.2.1.11Tabel Daftar Pemeriksaan Laboratorium yang Dilakukan Didalam dan Diluar Februari - April 2025

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BULAN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
Dilakukan di Rumah Sakit				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	4940	4789	4899
	Hematologi	2520	2583	2731
	Serologi dan Molekuler	533	508	592
	Urine	383	355	231
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	5	8	8
Total		8381	8243	8461
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	0	0	0
	Pemeriksaan Histopatologi	0	0	0
Total		0	0	0
3.	Lain-lain			
	Bakteriologi/Mikrobiologi	37	30	34
	Narkoba	11	35	26
	Covid-19	3	3	1
Total		51	68	61
Dilakukan di Luar Rumah Sakit (Dirujuk)				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	1	2	3
	Hematologi	7	0	4
	Serologi dan Molekuler	14	16	4
	Urine	0	1	0
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	0	0	0
Total		22	19	11
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	10	14	11
	Pemeriksaan Histopatologi	75	56	84
Total		85	70	95
3.	Lain-lain			
	Bakteriologi/Mikrobiologi	6	7	0
	PCR	0	0	0
	Tumor Marker	0	0	0
	Cholinesterase	0	0	0
Total		6	7	0

5.2.1.12 Grafik Pemeriksaan Didalam Rumah Sakit Bulan Februari - April 2025



Analisis :

1. Permintaan pemeriksaan laboratorium pada Bulan April 2025 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 8461 pemeriksaan. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kunjungan laboratorium, salah satunya adalah kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan juga mengalami peningkatan.
2. Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya dalam 3 bulan terakhir, yaitu :
 - a) Patologi Anatomi = 250 sampel
 - b) Patologi Klinik = 52 sampel
 - c) Lain-lain = 13 sampel
3. Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi pada dalam 3 bulan terakhir mencapai 250 pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena Rumah Sakit belum memiliki Laboratorium Patologi Anatomi, ditunjang dengan meningkatnya jumlah tindakan excise yang membutuhkan pemeriksaan penunjang (PA) untuk kebutuhan klaim.
4. Hasil pemeriksaan PA masih mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan karena adanya tindakan potong ulang dari hasil yang mengarah atau curiga keganasan dan cuti bersama lebaran pada awal Bulan April 2025.
5. Masih ditemukan pemeriksaan patologi klinik pada Bulan April 2025 sebesar 11 pemeriksaan, yaitu antara lain pemeriksaan ANA Test, Serum Iron, TIBC, HB Elektroforesis, Alkali Fosfatase, Hbs Ag (ELISA), VDRL.
Rumah Sakit tidak melakukan pengadaan alat dan reagen karena permintaan hanya sedikit.

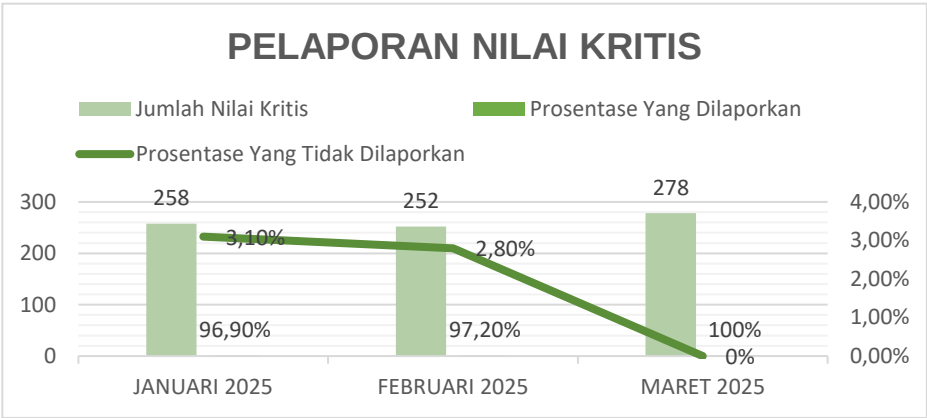
Rencana Tindak Lanjut :

1. Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.
2. Perbaikan serah terima hasil laboratorium menggunakan system digital.
3. Melakukan pencatatan keluar masuk stok reagen pada kartu stok dan dilakukan SO.
4. Follow up pengadaan reagen yang lama kosong.
5. Mengajukan pengadaan Laboratorium PA di RS Prima Husada Malang.
6. Membuat kesepakatan batas akhir bacaan hasil PA dan follow up secara berkala kepada Dokter Penanggungjawab Patologi Anatomi.
7. Mengajukan review tarif pemeriksaan laboratorium kepada Kepala Keuangan PT.

5.2.1.13 Pelaporan Nilai Kritis Februari – April 2025

NO	BULAN	JUMLAH NILAI KRITIS	PROSENTASE YANG DILAPORKAN	PROSENTASE YANG TIDAK DILAPORKAN
1.	Februari 2025	252	97,2%	2,8%
2.	Maret 2025	278	100%	0%
3.	April 2025	206	100%	0%

5.2.1.14 Grafik Pelaporan Nilai Kritis Februari – April 2025



Analisis :

- 1. Pelaporan nilai kritis pada Bulan Maret 2025 sudah mencapai 100%.
- 2. Petugas sudah disiplin dalam melakukan dokumentasi pelaporan nilai kritis.
- 3. Tidak ada complain yang masuk karena keterlambatan pelaporan nilai kritis ke unit.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Supervisi berkala dilakukan oleh Karu dan Kabid Penunjang Medis
- 2. Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan dan Kabid Pelayanan Medis terkait pelaporan complain DPJP terhadap keterlambatan pelaporan nilai kritis.
- 3. Kolaborasi dengan SDM terkait kedisiplinan petugas dalam melakukan pekerjaan.
- 4. Pertahankan kinerja yang sudah baik.

4.1.1.5 Tabel Pelaporan Kerusakan Sampel pada Bulan Februari – April 2025

No	Nama pasien	No RM	Tanggal Pengambilan Sampel	Unit Asal	Sampel yang diterima
Bulan Februari 2025					
Tidak ada					
Bulan Maret 2025					
Tidak ada					
Bulan April 2025					
1.	Abd Rohman	229923	18/04/2025	ICU	Sampel Vena BGA
2.	Aqilla Putri	160607	19/04/2025	IRNA 3C	Sampel Clotting
3.	Rochmad	102166	29/04/2025	IRNA 5C	Sampel Clotting

Analisis :

Masih ditemukan sampel rusak ketika diterima oleh petugas laboratorium pada Bulan April 2025 sebanyak 3 sampel. Namun tidak sebanyak sebelum dilakukan sosialisasi pada Bulan Januari 2025. Hal ini bisa disebabkan ketidaktelitian petugas saat melakukan sampling darah, tidak paham dengan kebutuhan dan prosedur penyimpanan sampai dengan pengiriman sampel ke laboratorium.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Monitoring dan Evaluasi.
- 2. Memberikan pemahaman bahwa pengambilan sampel sesuai dengan batas garis indicator.
- 3. Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan terkait training prosedur pengambilan darah, penyimpanan dan pengiriman sampel.
- 4. Supervisi ED reagen.

4.1.1.6 Tabel Pelayanan BDRS Bulan Februari – April 2025

Bulan	Permintaan Labu Darah				Total	Return Labu Darah				Total
	A	B	O	AB		A	B	O	AB	
Februari 2025	17	6	20	18	61	2	-	-	-	2
Maret 2025	33	17	40	25	115	3	7	-	12	22
April 2025	13	10	25	20	68	2	7	5	4	18

4.1.1.7 Tabel Hasil Incompatible pada Crossmatch pada Bulan Februari – April 2025

No	Nama Pasien	Jumlah pasien dan permintaan labu darah Incompatible				Total Permintaan Labu darah
		A	AB	O	B	
Bulan Februari 2025						
1.	Sukarno			√		1 Labu
2.	Luke Kurnia			√		3 Labu
Bulan Maret 2025						
1.	Nur Mujiati	√				2 Labu
Bulan April 2025						
Tidak ada						

Analisis :

- 1. Permintaan labu darah Pada Bulan April 2025 mengalami penurunan, hal ini disebabkan kasus dengan diagnosis kebutuhan labu darah menurun, dan semua permintaan terpakai, tidak ada return dari unit.
- 2. Masih ditemukan return labu darah ke PMI sebanyak 18 kantong darah.
- 3. Tidak ditemukan hasil incompatible pada crossmatch pada Bulan April 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengurangi stok maksimum labu darah dengan permintaan jarang.
- 2. Mengirimkan analis untuk magang di PMI selama 2 minggu secara bergantian, biaya free.
- 3. Melakukan penertiban penulisan kartu stok labu darah secara real time, pelaksanaan SO dilakukan setiap akhir bulan.
- 4. Mempertahankan ketelitian dalam melakukan *crossmatch*.

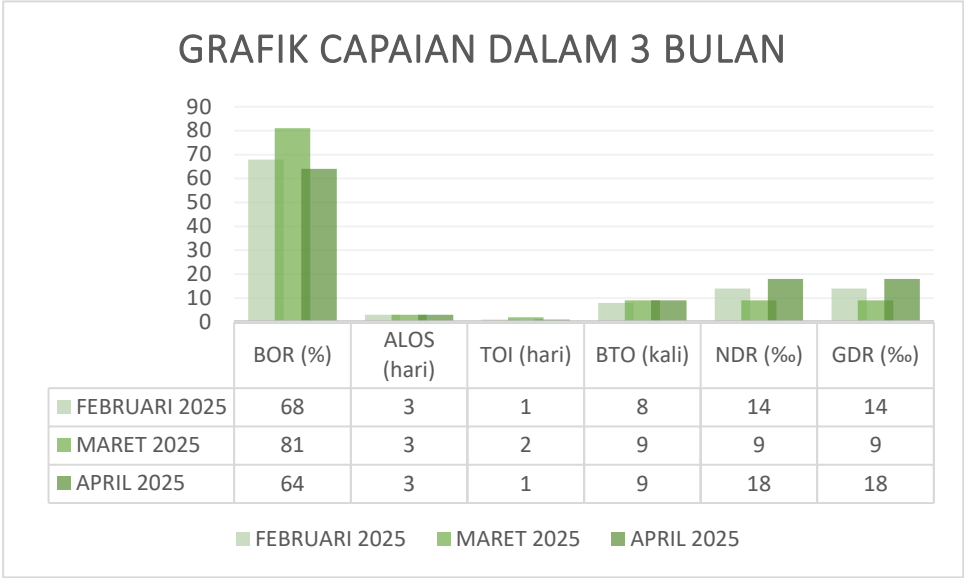
3.2.3 Rekam Medis – Pendaftaran

3.1.1.1 Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Februari – April 2025

Indikator	Rumus	Data	Standar Depkes	Bulan	Unit												Total
					2C	3A	3C	4Ab	5C	6A	7A	8A	MTS	NICU	HCU	ICU	
BOR (Bed Occupancy Rate) “Prosesntase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu”	$(\Sigma H P / (\Sigma T T \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60-80 %	Februari 2025	72	68	80	62	57	78	82	68	65	24	29	30	68%
				Maret 2025	68	57	61	83	60	62	71	65	66	31	24	17	81%
				April 2025	65	59	69	97	58	79	77	75	67	33	25	19	64%
ALOS (Average Length of Stay) “Rata-rata lama rawat seorang pasien”	$LD / \sum px \text{ keluar } (H+M)$	Jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar	6-9 hari	Februari 2025	4	2	3	3	3	4	3	3	3	2	0	2	3hari
				Maret 2025	4	3	3	3	4	3	3	1	3	3	2	2	3hari
				April 2025	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2	2	3hari
TOI (Turn Over Interval) “Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati”	$((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar } (H+M)$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1-3 hari	Februari 2025	1	1	1	1	2	1	1	1	1	5	3	4	1hari
				Maret 2025	1	1	1	0	2	1	1	1	1	4	4	5	2hari
				April 2025	1	1	1	1	2	1	1	1	1	4	2	5	1hari
BTO (Bed Turn Over) “Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode”	$\sum Px \text{ keluar } (H+M) / \sum TT$	Jumlah pasien, Jumlah TT	4-5 kali (dalam hitungan bulan)	Februari 2025	7	8	8	8	7	8	8	8	8	4	7	5	8kali
				Maret 2025	8	9	9	11	8	9	10	8	12	6	7	5	9kali
				April 2025	9	10	9	12	8	9	10	9	10	5	10	5	9kali
NDR (Net	$(\sum Px \text{ Mati } > 48 \text{ jm}) /$	Jumlah	<25 ‰	Februari	0	0	0	8	10	0	21	11	0	12	133	235	14‰

Death Rate) “Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit”	$\sum Px \text{ keluar (H+M)} \times 1000\text{‰}$	pasien meninggal >48jm, jumlah pasien keluar		2025													
				Maret 2025	0	0	0	7	0	9	9	21	0	16	77	91	9‰
				April 2025	14	0	0	0	42	19	17	19	0	0	158	209	18‰
GDR (Gross Death Rate) “Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit”	$(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar (H+M)}) \times 1000\text{‰}$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45‰	Februari 2025	0	0	0	8	10	0	21	11	0	12	133	235	14‰
				Maret 2025	0	0	0	7	0	9	9	21	0	16	77	91	9‰
				April 2025	14	0	0	0	42	19	17	19	0	0	158	209	18‰

3.1.1.2 Grafik Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Februari – April 2025 2025



Analisis :

Berdasarkan hasil perhitungan statistik rumah sakit pada Bulan April Tahun 2025, kinerja RSPHM didapatkan hasil nilai indikator:

- 5. BOR sebesar 64% (standar : 60-85%) sesuai standar.
- 6. LOS sebesar 3 hari sesuai dengan standard RSPHM terkait SE dari PT.DPM khusus pasien BPJS (standar pasien umum : 6-12 hari)
- 7. TOI sebesar 1 hari (standar : 1-3 hari)
- 8. BTO sebesar 9 kali (standar : 4-5 kali)

BOR Bulan April Tahun 2025 di bandingkan dengan Bulan Maret Tahun 2025 mengalami penurunan. BOR tersebut menjadi bukti bahwa penggunaan tempat tidur di Bulan April sudah standar. Hal tersebut menandakan bahwa penggunaan tempat tidur sudah efisien dari segi ekonomi menghasilkan pemasukan bagi rumah sakit.

Masalah :

Indikator LOS dan BTO belum memenuhi standar, terkait LOS yang belum memenuhi standar (standard lama belum berubah tidak sesuai peraturan baru). Standard saat ini sesuai dengan ketentuan BPJS yang mengacu juga pada PPK-CP masing-masing kasus/penyakit. Hal ini menunjukkan adanya kualitas pelayanan yang baik serta adanya kendali mutu dan kendali biaya sehingga lama perawatan pasien lebih cepat. Sedangkan BTO standar tersebut digunakan untuk satu tahun penuh, angka 9 mencerminkan bahwa 1 tempat tidur bisa digunakan 9 kali perawatan dalam sebulan.

Rencana Tindak Lanjut :

Meningkatkan kualitas pelayanan di rawat inap dan menjalankan sasaran keselamatan pasien agar mutu pelayanan tetap sesuai standar

3.1.1.3 Tabel Diagnosa Terbanyak Bulan April 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	E11.9	DM Tanpa komplikasi / Without complications	460
2.	I51.9	Decomp Cordis/Heart Disease, unspecified	330
3.	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	296
4.	I63.9	CVA Infark/Cerebral Infarction, unspecified	292
5.	E11.4	With neurological complications	282
6.	I25.9	Chronic ischemic heart disease, unspecified	263
7.	J47	Bronchiectasis	195
8.	J44.9	COPD / Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	184
9.	F41.2	Mixed anxiety and depressive disorder	163
10.	K80.8	Other cholelithiasis	163

3.1.1.4 Tabel Diagnosa Rawat Inap Bulan April 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	A01.0	Typhoid Fever (TF)	281
2.	P24.9	Neonatus Cukup Bulan	102
3.	A90	Dengue Fever	50
4.	E14.9	DM Hyperglikemia	48
5.	I63.9	CVA Infark	45
6.	M72.6	Necrotizing Fascitis	20
7.	J18.9	PNEUMONIA	16
8.	E11.5	Diabetes Melitus Type 2	14
9.	I50.1	Acute Decompensated Heart Failure	14
10.	N20.1	Batu Ureter	12

Analisis :

1. Diagnosa terbanyak di Rawat Jalan adalah DM tanpa komplikasi sebesar 460 kasus, sedangkan diagnose terbanyak di Rawat Inap adalah Typhoid Fever sebesar 281 kasus.
2. Tarikan data diagnose rawat inap diambil dari hasil analisa pada resume medis saat pasien pulang, yaitu pada diagnose utama yang ditulis oleh DPJP. Sedangkan tarikan data diagnose rawat jalan diambil dari SIMRS.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan analisa pada resume medis saat pasien pulang berdasarkan diagnose sekunder.

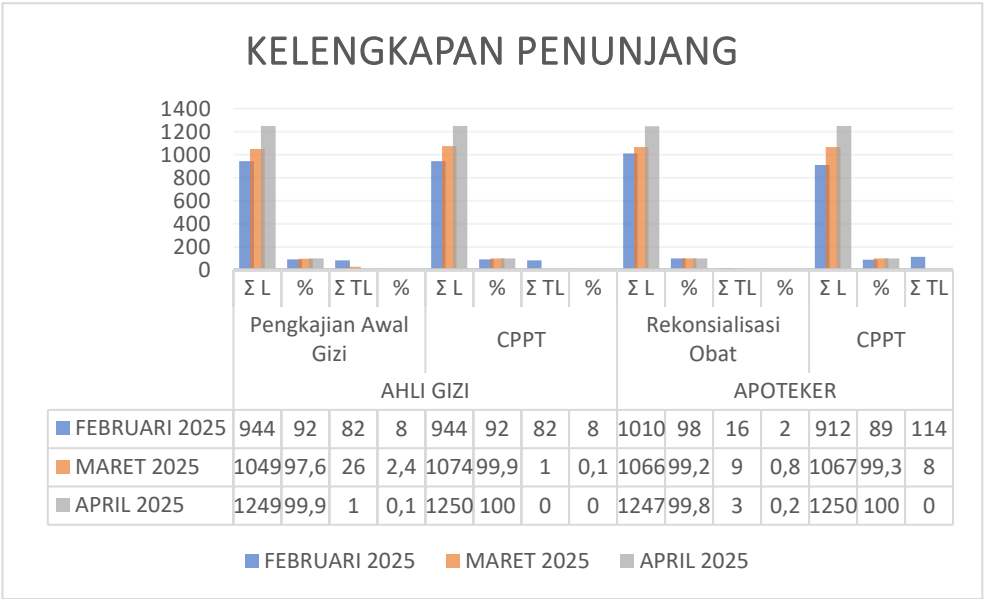
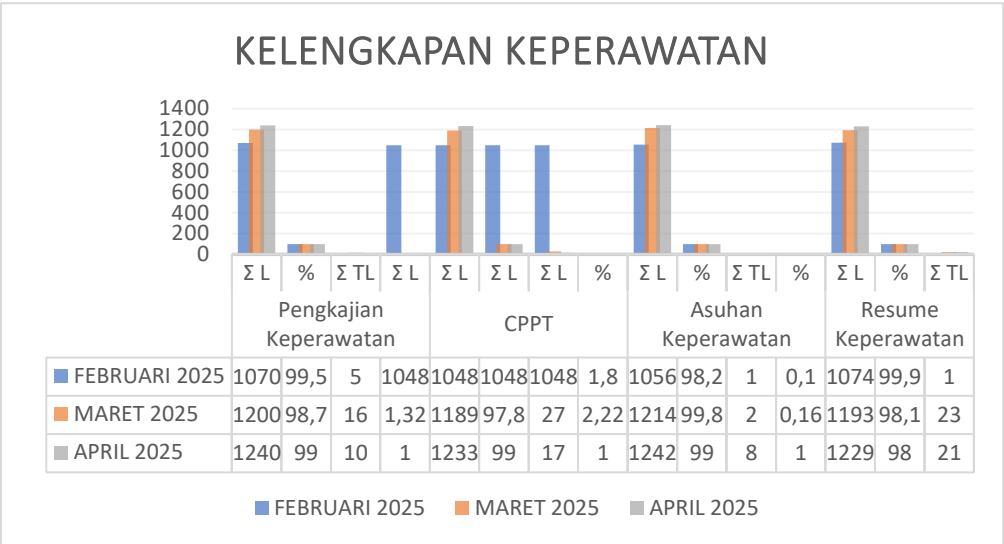
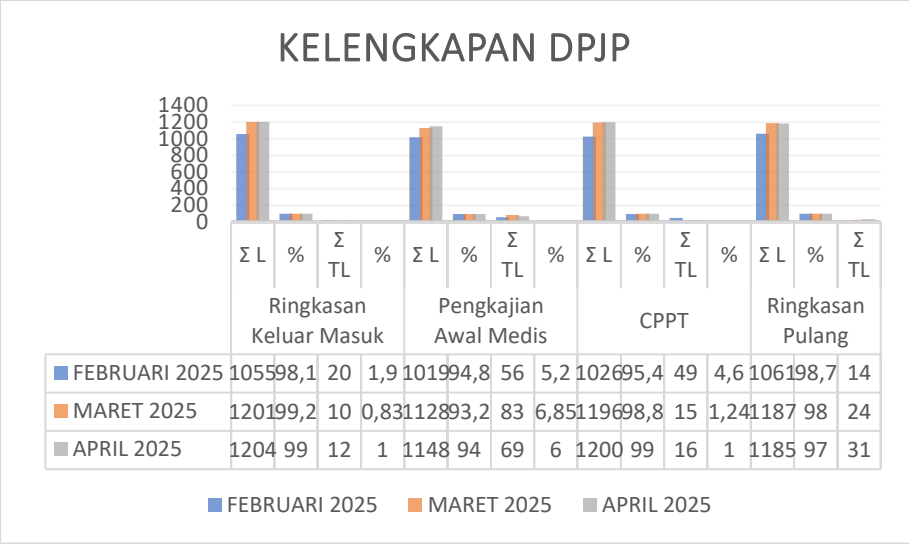
3.1.1.5 Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Februari - April 2025

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98
April	1204	99	12	1	1148	94	69	6	1200	99	16	1	1185	97	31	3

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan			
	Σ L	%	Σ TL	Σ L	Σ L	Σ L	Σ L	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89
April	1240	99	10	1	1233	99	17	1	1242	99	8	1	1229	98	21	2

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Maret	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
April	1249	99.9	1	0.1	1250	100	0	0	1247	99.8	3	0.2	1250	100	0	0

3.1.1.6 3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Februari - April 2025



Analisis :
Kelengkapan DRM rawat inap DPJP dan Perawat mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena perubahan alur analisa rekam medis, perawat melakukan setor terlebih dahulu ke petugas rekam medis sehingga data yang didapatkan valid.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
- 2. Melakukan supervise secara berkala.
- 3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
- 4. Membuat rapot ketidaklengkapan dan kolaborasi dengan Kabid Keperawatan.

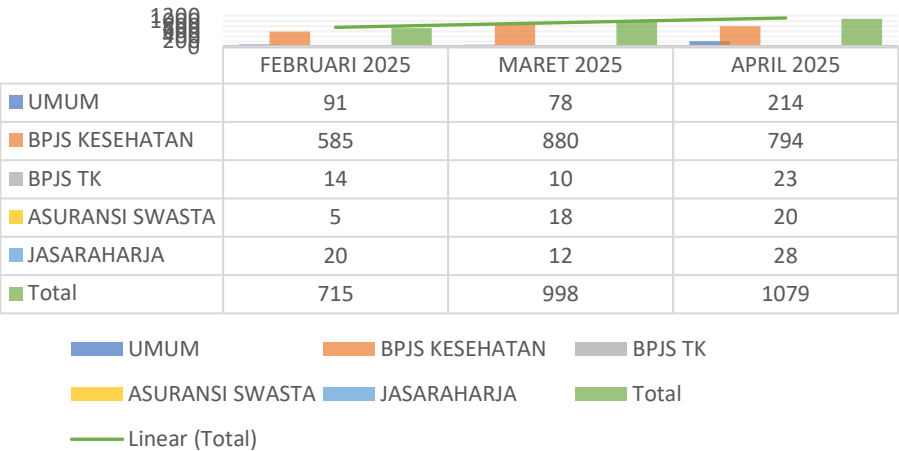
4.2.4 Radiologi

4.2.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Februari – April 2025

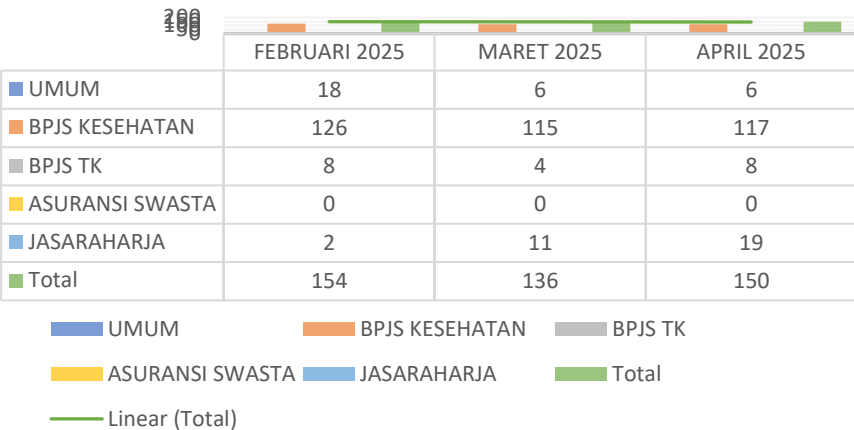
NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN		
			FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1.	RADIO DIAGNOSTIK	UMUM	91	78	214
		BPJS KESEHATAN	585	880	794
		BPJS TK	14	10	23
		ASURANSI SWASTA	5	18	20
		JASARAHARJA	20	12	28
	TOTAL		715	998	1079
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	18	6	6
		BPJS KESEHATAN	126	115	117
		BPJS TK	8	4	8
		ASURANSI SWASTA	0	0	0
		JASARAHARJA	2	11	19
	TOTAL		154	136	150
3.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	UMUM	0	0	2
		BPJS KESEHATAN	2	8	5
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	0	0	0
		JASARAHARJA	0	0	0
	TOTAL		2	8	7
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	39	23	14
		BPJS KESEHATAN	303	188	204
		BPJS TK	0	4	10
		ASURANSI SWASTA	24	11	2
		JASARAHARJA	0	4	8
	TOTAL		366	230	238
TOTAL KESELURUHAN			1237	1372	1474

4.2.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Februari - April 2025

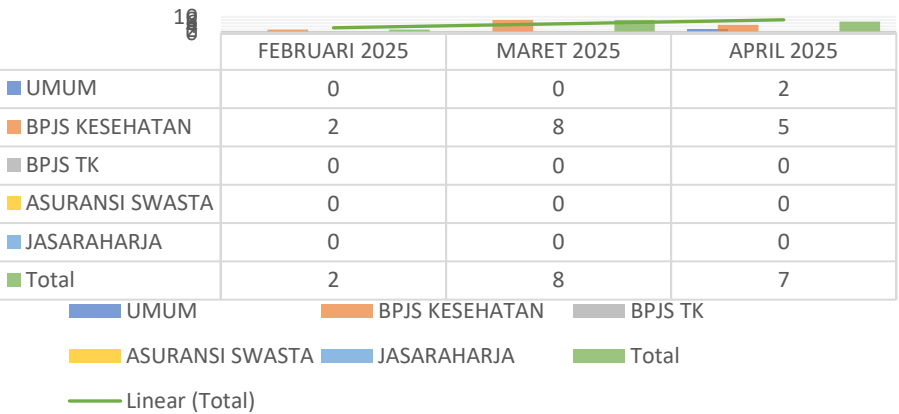
PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK



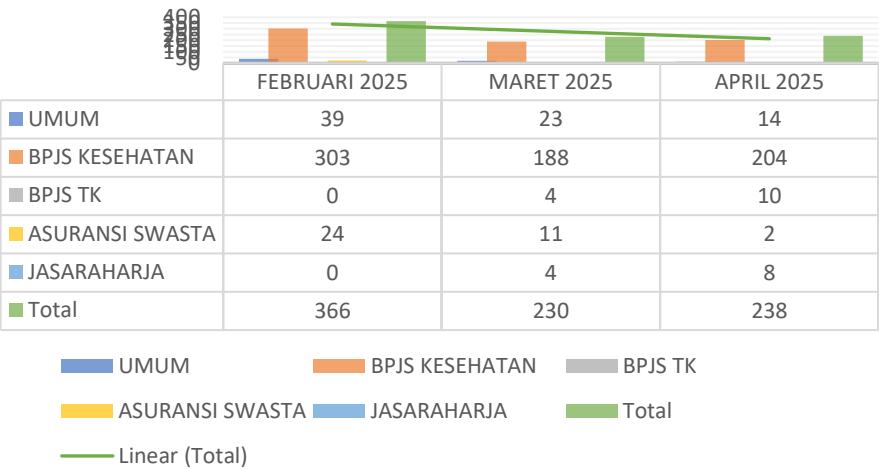
PEMERIKSAAN CT SCAN TANPA KONTRAS

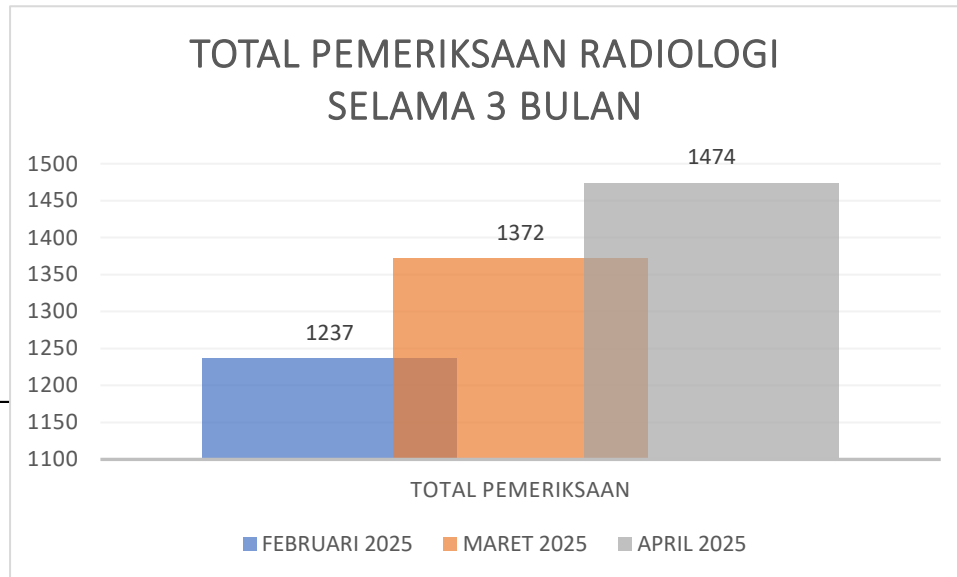


PEMERIKSAAN CT SCAN DENGAN KONTRAS



PEMERIKSAAN USG TANPA KONTRAS





Analisis :

1. Pelayanan pemeriksaan selama Bulan April 2025 meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.

Pada Bulan April 2025 pemeriksaan terbanyak, yaitu :

- a. Radiodiagnostik : 1079
- b. USG Tanpa Kontras : 238
- c. CT Scan Tanpa Kontras : 150

2. Produktivitas pemeriksaan radiodiagnostik mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya tambahan pasien MCU haji dan MCU Perusahaan/mandiri.
3. Jumlah total pemeriksaan selama Bulan April 2025 adalah sebanyak 1474 pemeriksaan.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk meningkatkan kunjungan di Radiologi dengan cara :
 - 1) Melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan.
 - 2) Mengajukan MCU kepada perusahaan-perusahaan besar di Kab/Kota Malang.
2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengawal Polisi LAKA supaya tetap melakukan rujukan LAKA LANTAS ke RS Prima Husada Malang.
3. Melakukan review tarif tindakan yang dibutuhkan DPJP atau bisa dilakukan di RS, namun belum ada di Billing. Contoh : Baby Gram.
4. Mendokumentasikan respon time pelayanan Radiologi menggunakan Google Spreadsheet, sambil menunggu waktu selesai hasil dimunculkan di Hasil Bacaan oleh Programmer PT.

4.2.4.3 Tabel Laporan Ulang Hasil Bulan Februari - April 2025

NO	NAMA DOKTER	NAMA PASIEN	BACAAN AWAL	BACAAN ULANG	TOTAL
Bulan Februari 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Dahniyar Afandi (227465)	Kongestif Pulmonum	Pneumonia	1
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	0	0	0	0
Bulan Maret 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	By Ny Zaimatus (227984)	Normal	Pneumonia	2
		Kasti (073280)	Normal	Infark Akut	
3.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Agus Wahyu (114824)	Spondylosis	Compresi Fractura	1
Bulan April 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Ny Sri Asnanik (224631)	CVA Infark	CVA Infark	2
		Dian Nihayatul (212732)	Normal	Normal	
3.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	0	0	0	0

Analisis :

Pada Bulan April terdapat pembacaan ulang pemeriksaan ke radiologi. Hal ini disebabkan karena klinis tidak ditulis secara lengkap pada surat permintaan radiologi.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.
2. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan untuk melengkapi pemeriksaan klinis pada surat pengantar supaya dapat menunjang hasil pemeriksaan.

4.2.4.4 Tabel Rata-Rata Respon Time Pembacaan Pemeriksaan Radiologi

NO	PEMERIKSAAN	RATA-RATA WAKTU (menit)			
		dr Agung, Sp.Rad (K)		dr Yudho, Sp.Rad	
		SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN	SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN
1.	Ro Thorax PA/AP	3	25-180	3	10-1440
2.	Ro Vertebrae	-	-	4	10-1440
3.	Ro Abdomen	4	25-60	10	10-1440
4.	Ro Extremitas	-	-	2	10-1440
5.	Ro Skull	-	-	2	10-1440
6.	USG Abdomen	8	5	15	10
7.	CT Scan Non Kontras	5	30-1440	-	-
8.	CT Scan Dengan Kontras	15	30-1440	-	-
9.	Radiologi CITO	-	-	-	-

Analisa :

1. Rata-rata pemeriksaan radiologi adalah 3 menit dengan rata-rata hasil pembacaan radiologi 25 menit untuk dr Agung, Sp.Rad (K), hal ini disebabkan karena hasil rontgen dapat dikonsultasikan via pesan whatsapp. (Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam).
2. Rata-rata pembacaan radiologi oleh dr Yudho, Sp.Rad adalah 1440menit/24 jam, tidak sesuai dengan target standar RS. Hal ini disebabkan karena adanya pembagian jobdesk konsulan, dr Yudho, Sp.Rad tidak berkenan dikonsuli via pesan whatsapp dan dibacakan saat praktik keesokan harinya.
3. Pembacaan elektif dilakukan oleh dr Yudho, Sp.Rad saat praktik. (Semua foto Vertebrae, Ekstremitas, Abdomen, dan Skull).
4. Tidak terdapat pemeriksaan CITO dan kasus kritis selama Bulan April 2025.
5. Semua pemeriksaan CT Scan dibacakan oleh dr Agung, Sp.Rad (K).
6. Terdapat kekosongan jam pelayanan radiologi pada siang hari.
7. Pembacaan hasil pemeriksaan radiologi oleh dr Agung, Sp.Rad, diatas target standar RS yakni 420-1440 menit dikarenakan hasil jadi diatas pukul 00.00 WIB dan DPJP meminta dibacakan oleh dr Agung, Sp.Rad.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menemui kedua DPJP Radiologi untuk menambah jam praktik.
2. Memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kolegium Radiografer bahwa RS membutuhkan tambahan DS Radiologi untuk mengisi jadwal praktik siang hari, sudah diterima oleh dr Agung, Sp.Rad.
3. Melakukan supervise pencatatan respon time pada Google Spreadsheet.
4. Membuat perjanjian dengan Kains Radiologi (dr Agung, Sp.Rad (K)) selama belum terpenuhi dokter untuk merespon konsulan secara cepat.

4.2.4.5 Tabel Angka Komplain DPJP Terhadap Keterlambatan Hasil Pembacaan Radiologi pada Bulan April 2025

NO	NAMA PASIEN	NAMA DPJP	PEMERIKSAAN	WAKTU	
				SELESAI PERIKSA	SELESAI HASIL
1.	-	-	-	-	-

Analisis :

Pada Bulan April tidak ada komplain DPJP dan Dokter Umum karena keterlambatan hasil pembacaan radiologi.

Hal ini disebabkan, selain waktu tunggu cito tidak melebihi standar, bisa disebabkan ketidakpahaman petugas pelayanan dalam melaporkan complain sehingga tidak terdokumentasikan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :

Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.

4.2.4.6 Tabel PMI dan PME di Radiologi

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Pemantapan Mutu Internal (PMI)			
1.	Mencatat waktu tunggu pelayanan foto	Mencatat waktu mulai pengerjaan hingga hasil diserahkan.	1. Respons time pelayanan radiologi terukur dan sesuai standar. 2. Pengendalian kegagalan foto dan meminimalkan pengulangan. 3. Mengendalikan penggunaan BMHP radiologi.
2.	Mencatat jumlah Reject Film	Mencatat kegagalan foto (review pembacaan dan review hasil radiograf)	
3.	Memonitor pemakaian BMHP	Memonitor penyimpanan, pemeliharaan dan pemakaian bmhp.	
Pemantapan Mutu Eksternal (PME)			
1.	Melakukan uji paparan radiasi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	1. Peralatan radiologi dalam kondisi siap pakai. 2. Standarisasi pelayanan radiologi rujukan.
2.	Melakukan uji akurasi tegangan	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
3.	Pengukuran TLD Badge	Kegiatan pengukuran dilakukan setiap 3 bulan sekali ke BPFFK (Balai Pengaman Fasilitas .Kesehatan)	
4.	Kalibrasi alat radiologi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali.	
5.	Uji kesesuaian	Pengujian kondisi alat dilakukan setiap 4 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
6.	Sertifikat kalibrasi	Memastikan sertifikat kalibrasi rs rujukan masih berlaku	

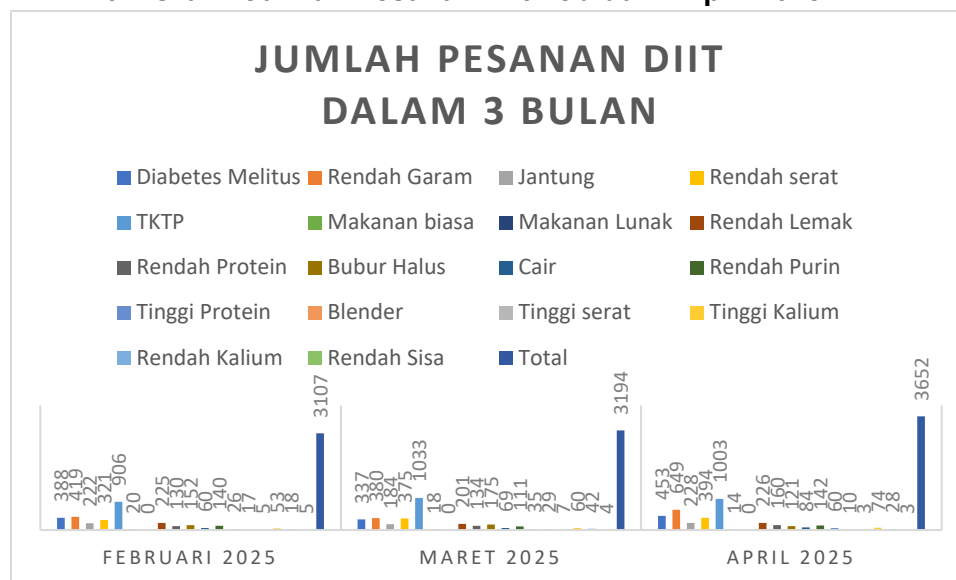
2.4.5 Gizi

2.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit Februari – April 2025

NO	NAMA DIIT	BULAN			PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025	
1.	Diabetes Melitus	388	337	453	134
2.	Rendah Garam	419	380	649	170
3.	Jantung	222	184	228	123
4.	Rendah serat	321	375	394	105
5.	TKTP	906	1033	1003	97
6.	Makanan biasa	20	18	14	77
7.	Makanan Lunak	0	0	0	0
8.	Rendah Lemak	225	201	226	112
9.	Rendah Protein	130	134	160	119
10.	Bubur Halus	152	175	121	69
11.	Cair	60	69	84	121

12.	Rendah Purin	140	111	142	127
13.	Tinggi Protein	26	35	60	171
14.	Blender	17	29	10	34
15.	Tinggi serat	5	7	3	42
16.	Tinggi Kalium	53	60	74	123
17.	Rendah Kalium	18	42	28	66
18.	Rendah Sisa	5	4	3	75
TOTAL		3107	3194	3652	117

2.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit Februari - April 2025



Analisis :

1. Jumlah pemberian diit pasien rawat inap pada Bulan April mengalami peningkatan, hal ini berbanding lurus dengan kenaikan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit.
2. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pemesanan diit terbanyak selama Bulan April 2025 adalah TKTP sebanyak 1003, berbanding lurus dengan diagnose terbanyak di rawat inap yaitu Thyphoid Fever dengan kebutuhan diit TKTP.
3. Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

Rencana Tindak Lanjut :

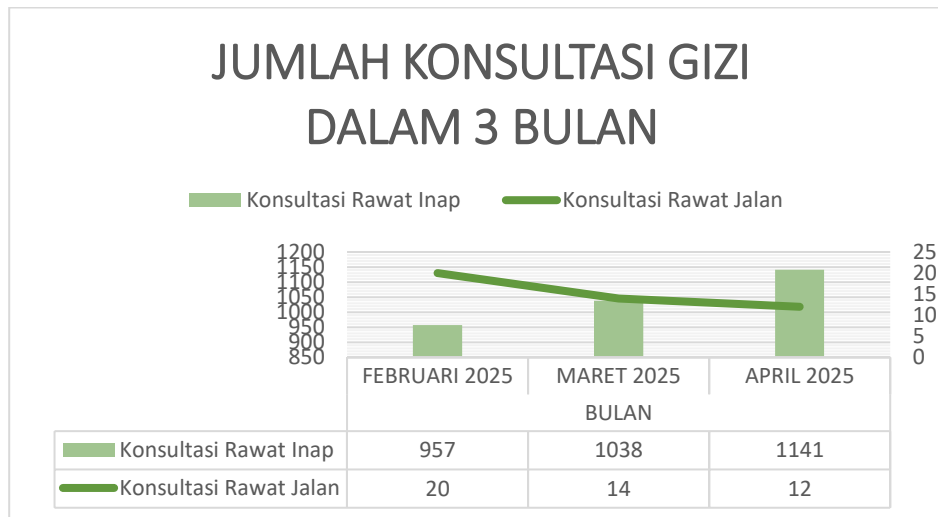
1. Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.
2. Mengajukan pelayanan catering makanan untuk pemulihan pasien saat pulang rawat inap.
3. Kolaborasi dengan layanan primantara (pengantaran obat) untuk MCU Gizi gratis sebagai reward.
4. Melakukan perbaikan menu makanan dan plating sesuai dengan kelas pasien.
5. Kolaborasi dengan PKRS untuk membuat leaflet menu makanan dan diupload di Sosial Media.

- Perbaikan pencatatan food waste dipisahkan setiap menu makanan untuk mengetahui menu makanan mana yang tidak diminati.

2.4.5.3 Tabel Jumlah Konsultasi Gizi Februari - April 2025

No	Indikasi	Jumlah Pasien		
		Februari 2025	Maret 2025	April 2025
1.	Konsultasi Rawat Inap	957	1038	1141
2.	Konsultasi Rawat Jalan	20	14	12

2.4.5.4 Jumlah Konsultasi Gizi



Analisis :

- Jumlah konsultasi gizi rawat inap pada Bulan April 2025 meningkat mengikuti jumlah pasien yang rawat inap.
- Jumlah konsultasi gizi rawat jalan pada Bulan April 2025 mengalami penurunan hal ini disebabkan pasien dan keluarga menunda datang dikarenakan liburan lebaran.
- Tidak semua DPJP memberikan rujukan ke Poli Gizi, rujukan diterima dari Poli Jantung dan Poli IPD saja ketika pasien bertanya terkait pantangan makan saat control ke Poli Spesialis.

Rencana Tindak Lanjut :

- Merancang pengembangan pelayanan MCU Konsultasi Gizi dengan perusahaan.
- Koordinasi dengan Humas Marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan.
- Koordinasi dengan Kabid Pelayanan agar DPJP merujuk pasien ke Poli Gizi.

2.4.5.5 Tabel Rekap Data Komplain Pasien Terhadap Gizi Bulan Februari - April 2025

No	Jenis Komplain	Nama Pasien	Analisis	Rencana Tindak Lanjut	Total
Bulan Februari 2025					
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	An Yuan (B3C-4 IRNA 3C Anak) Isi Komplain : Menu yang didapat tidak bervariasi dibandingkan dengan terakhir kali pasien rawat inap (siklus menu berulang)	1. Siklus menu yang berlaku di RS Prima Husada Malang adalah siklus menu 10 hari+1 hari 2. Pasien MRS pada hari dimana siklus menu yang sama dengan hari MRS sebelumnya.	Melakukan analisis asupan makan pasien selama rawat inap untuk melihat daya terima pasien tersebut terhadap menu yang disajikan	1
Bulan Maret 2025					
Tidak ada komplain					
Bulan April 2025					
Tidak ada komplain					

2.4.5.6 Tabel Rekap Food Waste (Sisa Makanan) bulan April 2025

No	Menu	Rincian Menu	Total Sisa Makanan (kg)		Keterangan
			Maret 2025	April 2025	
1.	Karbohidrat	Nasi	241,1	184,4	64% dari sisa makanan berasal dari karbohidrat. Sisa KH menurun 4% dibandingkan bulan Maret karena sisa KH sebesar 67%.
		Nasi Tim	374	282,7	
		Total	615,1	467,1	
2.	Snack	Roti Kukus	0	0	Menu yang kurang diminati : 1. Setup Pisang 2. Bubur Kacang Hijau
		Setup Pisang	0	0,6	
		Kacang Hijau	0	0,3	
		Kue Hongkong	0	0	
		Terang Bulan	0	0	
		Bubur Sagu	0,8	1	
		Kue Lumpur	0	0	
		Puding	0,4	0,2	
		Donat	0	0	

		Tahu Fantasi	0	0	3. Bubur Sagu
		Sagu Mutiara	0	0	
	Total		1,2	1,1	
1.	Menu 1				Menu 5 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 32.3 kg. Sisa makanan tersebut sudah menurun dibanding bulan sebelumnya dengan sisa makanan 41.1kg.
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	5,7	3,5	
		Rolade Ayam	3,9	3,1	
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	0,2	0,8	
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)	2,2	2,2	
		Ayam Kecap	5,1	3,3	
		Tahu Bumbu Tomat	1,5	2,1	
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	0,2	0,6	
	Sore	Rawon (Daging Slice, Manisah Dadu, Cambah Pendek)	2,4	3,1	
		Tempe Goreng	1,7	2,1	
	Tambahan VIP	Perkedel	0	0,4	
Total		22,9	21,2		
2.	Menu 2				
	Pagi	Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun)	7,8	4,4	
		Tahu Rempah (Remet)	3,1	3,5	
		Abon	0	0,7	
	Tambahan VIP	Telur Rebus	0	1	
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Wortel, Manisah)	5,7	2,8	
		Ayam Wijen	3,3	3,3	
		Bakwan Jagung	1,9	1,6	
	Tambahan VIP	Telur Gulung	0	0,5	
	Sore	Koloke (Ayam Goreng Fillet, Timun, Wortel)	4,7	2,5	
		Tempe Goreng	2,4	2,8	
Tambahan VIP	Bakso Goreng Mekar	0,4	0,3		
Total		29,3	23,4		
3.	Menu 3				
	Pagi	Sup (wortel, Sawi Putih, Ayam Dadu)	3,7	3,7	
		Tahu Krispy	2,7	2,2	
		Abon	0	0,4	
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	0,6	0,1	
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	4,7	3,1	
		Rolade Ayam	4	2,7	
Tahu Goreng		1,3	1,5		

	Tambahan VIP	Tempe Bacem	0,5	0,4
	Sore	Oseng (Jamur Kuping, Wortel, Bakso, Kacang Polong)	3,7	3,1
		Ayam Bombay	3,9	4,9
		Tempe Orek	1,6	2,3
	Tambahan VIP	Telur Dadar	0,3	0,2
	Total		26,4	24,6
4.	Menu 4			
	Pagi	Sayur Bobor (Selada Air, Manisah, Kemangi)	4,1	5,2
		Tahu Nugget	3,8	3,6
		Abon	0	0
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar	0	0
	Siang	Sup (Oyong, Wortel, Jagung)	4,3	5,3
		Ayam Kecap	6,5	3,6
		Jamur Krispy	2,7	1,6
	Tambahan VIP	Tahu Bacem	0	0,7
	Sore	Soto Ayam (Soun, Kubis, Seledri, Ayam Suwir)	4,2	3,3
		Telur Rebus	2,8	2,3
		Tempe Goreng	3,2	2,3
	Tambahan VIP	Keripik Kentang	0,2	0,5
	Total		31,8	28,4
5.	Menu 5			
	Pagi	Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso, Wortel)	5,3	3,2
		Opor Tahu	3,8	2,3
		Oper Telur	3,5	2,5
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	0,2	0,7
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah)	6,4	6,6
		Ayam Bombay	6,3	5,7
		Bakwan Jagung	4,5	4,1
	Tambahan VIP	Tahu Krispy	0	0,1
	Sore	Sup Merah (Bakso, Ayam Dadu, Polong, Wortel)	6,9	3,5
		Tempe Goreng	4,2	3,4
		Telur Dadar	0	0,2
	Total		41,1	32,3
6.	Menu 6			
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	2,9	3,0
		Orak Arik (Wortel, Kubis, Daun Bawang, Telur)	3,6	2,1
		Tempe Goreng	4,1	3,6

	Tambahan VIP	Ayam Goreng	1,6	1,7
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)	6,2	3,5
		Ayam Laos	5,4	4,7
		Tahu Bumbu Tomat	2,8	2,3
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	0,1	0,1
	Sore	Rawon (Daging Slice, Manisah Dadu, Cambah Pendek)	3	3,4
		Tahu Krispy	1,8	2,1
	Tambahan VIP	Perkedel	0,2	0,4
Total			31,7	26,9
7.	Menu 7			
	Pagi	Cah Sawi (Sawi Putih, Wortel Serut, Ayam Dadu)	4,9	3
		Telur Ceplok Bumbu Kuning	2,1	2,4
		Abon	0,5	1
	Tambahan VIP	Tempe Bacem	0,1	0,1
	Siang	Sup (Wortel Dadu, Jamur Es, Polong, Bakso)	4,4	4
		Ayam Ungkep	4,1	3,5
		Perkedel	1,3	2,3
	Tambahan VIP	Jamur Krispy	0,2	0,6
	Sore	Koloke (Ayam Goreng Fillet, Timun, Wortel)	5,5	3,7
		Tempe Goreng	4,2	2,3
	Tambahan VIP	Telur Dadar	0,1	0,5
Total			27,3	23,4
8.	Menu 8			
	Pagi	Sayur Bobor (Manisah, Sawi Hijau)	4,6	5,4
		Tahu Nugget	3,7	3,1
		Abon	0	1,2
	Tambahan VIP	Ayam Fillet Tepung	0,4	0
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Jagung, Manisah)	4,4	3,4
		Ayam Bakar	6,5	3,1
		Tahu Goreng	3,3	1,4
	Tambahan VIP	Nugget Ayam	0	0
	Sore	Semur (Ayam Fillet, Soun, Daun Bawang, Tomat)	4,7	3,6
		Botok Tahu	3,7	2,6
		Abon	0	0,8
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	0,7	0,2
Total			32	24,8
9.	Menu 9			

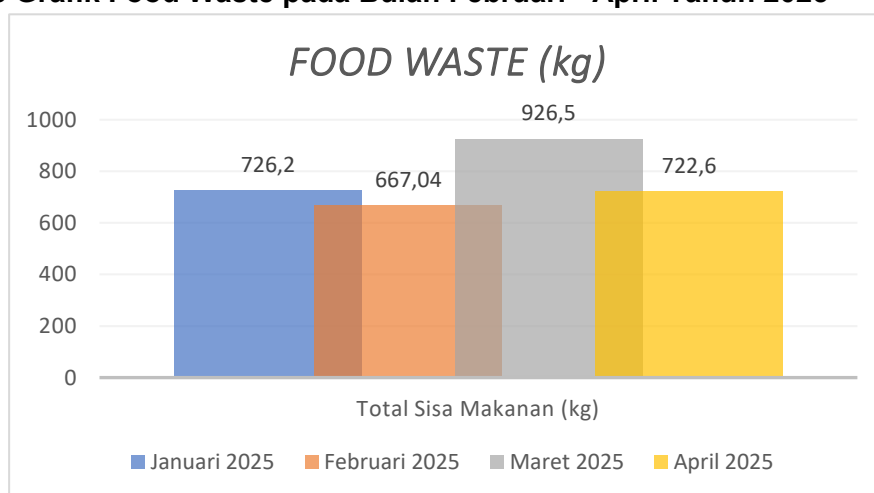
	Pagi	Tumis (Bakso, Wortel, Buncis)	4,8	4
		Tahu Rempah	4,6	1,5
		Abon	0	0,4
	Tambahan VIP	Telur Dadar	0,5	1
	Siang	Sup (Bihun, Wortel, Pokcoy)	6,1	3,4
		Ayam Kemangi	7,2	4,8
		Tahu Krispi	2,7	1,9
	Tambahan VIP	Bakso Goreng Mekar	0	0,4
	Sore	Soto Ayam (Soun, Kubis, Seledri, Ayam Suwir)	4,9	3,4
		Telur Rebus	2,2	1,8
		Tempe Goreng	2,3	1,4
	Tambahan VIP	Keripik Kentang	0,3	0
	Total		35,6	24
10.	Menu 10			
	Pagi	Sup (Wortel, Bakso, Sawi Putih)	4,5	6,3
		Telur Ceplok	3,3	2,8
		Abon	0	0,7
	Tambahan VIP	Tempe Bacem	0,9	0,5
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Wortel, Jagung, Manisah)	5,5	3,8
		Ayam Wijen	2,7	3,8
		Tahu Goreng	1,5	1,7
	Tambahan VIP	Telur Orak Arik	0,3	0,3
	Sore	Capjay (Wortel, Kembang Kol, Sawi, Bakso, Ayam Dadu)	6,6	3,5
		Tempe Goreng	3,1	2
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar	0,1	0
	Total		27,6	25,4
11.	Menu 11			
	Pagi	Sapo Tahu (Tahu, Wortel, Kembang Kol, Bakso)	2,4	0
		Tempe Goreng	0,2	0
		Abon	0	0
	Tambahan VIP	Telur Rebus	0,4	0
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	1	0
		Ayam Bakar	0,8	0
		Bakwan Jagung	0,2	0
	Tambahan VIP	Tahu Goreng	0	0
	Sore	Semur (Ayam Fillet, Soun, Daun Bawang, Tomat)	0,5	0
		Tahu Rempah	0,2	0

	Abon	0	0
	Tambahan VIP Jamur Krispy	0	0
	Total	5.7	0
	Total Food Waste Menu	311,4	254.4
	Total Keseluruhan	926,5	722.6

4.4.5.7 Tabel Rekap Food Waste pada Bulan Februari - April Tahun 2025

No	Bulan	Total Sisa Makanan (kg)
1.	Januari 2025	726.2
2.	Februari 2025	667.04
3.	Maret 2025	926.5
4.	April 2025	722.6

4.4.5.8 Grafik Food Waste pada Bulan Februari - April Tahun 2025



Analisis :

1. Terdapat perubahan perhitungan sisa makanan pada Bulan April 2025, dimana perhitungan dipisahkan per menu dengan tujuan mengetahui menu makanan yang kurang diminati.
2. Dari data diatas, dapat diketahui bahwa ada penurunan sisa makanan pada Bulan April 2025 setelah dilakukan tindaklanjut mengurangi porsi nasi pada setiap penyajian.
3. Masih ditemukan sisa makanan selain karbohidrat sebanyak 254.4 kg, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :
 - 1) Ada batasan diit yang dapat mempengaruhi rasa dan tampilan sehingga kurang menggugah selera.
 - 2) Tidak ada pantangan dari keluarga pasien, sehingga konsumsi makanan dari luar / dibawa dari rumah, komunikasi/edukasi Ahli Gizi kurang diperhatikan.
 - 3) Suasana lingkungan perawatan dan kondisi fisik pasien.
4. Tidak ada keterlambatan pengiriman makanan, jadwal makan sesuai.

2.4.5.8 Lampiran Rekap Dara Kehilangan Alat Makan

No	Tanggal	Nama Pasien	Ruangan	Nama Alat	Bukti Kuitansi	Dokumentasi	Keterangan
Januari 2025							
1.	19/01/2025	Suratman	D7A-9	Sendok			Kasir salah nama
2.	21/01/2025	Anissa Octaviafitri Widodo	B5C-2	Sendok			Pasien sudah KRS
3.	26/01/2025	Aqilla Rassi Susanto	B2	Mangkuk Kecil			Sudah kembali
4.	31/01/2025	Ilma Ayuningsi	T4C-3	Gelas			Sudah pembayaran
Februari 2025							
1.	01/02/2025	Abid Fadhul Abyan	B3C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	01/02/2025	Cholifah	B5C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	04/02/2025	Widya Dwi Anandita	D6A-11	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
4.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Makan			Sendok terbawa pulang
5.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Snack			Sendok terbawa pulang
6.	06/02/2025	Chabibatul Aziizah	B3C-1	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
7.	06/02/2025	Mimi Eka	D4C-7	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
8.	19/02/2025	Ni'matul Udhma Himza	D3B-3	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
Maret 2025							
1.	11/03/2025	Muhammad Syifa	V3 (VIP)				Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	24/03/2025	Pranata Dimas Ariansyah	C3C-10				Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	25/03/2025	Mistianingsih	C3A-4				Sendok hilang

							pasien sudah pulang
April 2025							
1.	17/04/2025	Achmad Yogie Septiansyah	B2-5C	Gelas			Sudah pembayaran

Analisis :

1. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa SPO sudah dijalankan, tidak ada laporan kehilangan.
2. Peralatan makan / gelas yang dipecahkan oleh pasien sudah diganti oleh pasien dan tercatat oleh sistem.
3. Telah dilakukan supervise dari Kepala Ruang terhadap SPO yang sudah dibuat.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Mencantumkan tata tertib menjaga fasilitas pada GC, sehingga petugas admisi dapat mengedukasi saat melakukan pendaftaran, jika pasien menghilangkan atau merusak fasilitas maka wajib mengganti. Sementara menggunakan catatan tertulis selama GC yang lama belum habis.
2. Melakukan supervisi “SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS”, sebagai panduan petugas dalam pelayanan dimana terdapat kolaborasi antara Instalasi Gizi, Perawat Ruang , CS Pantry dan Ruang, dan Kasir.

4.4.7 CSSD – Laundry

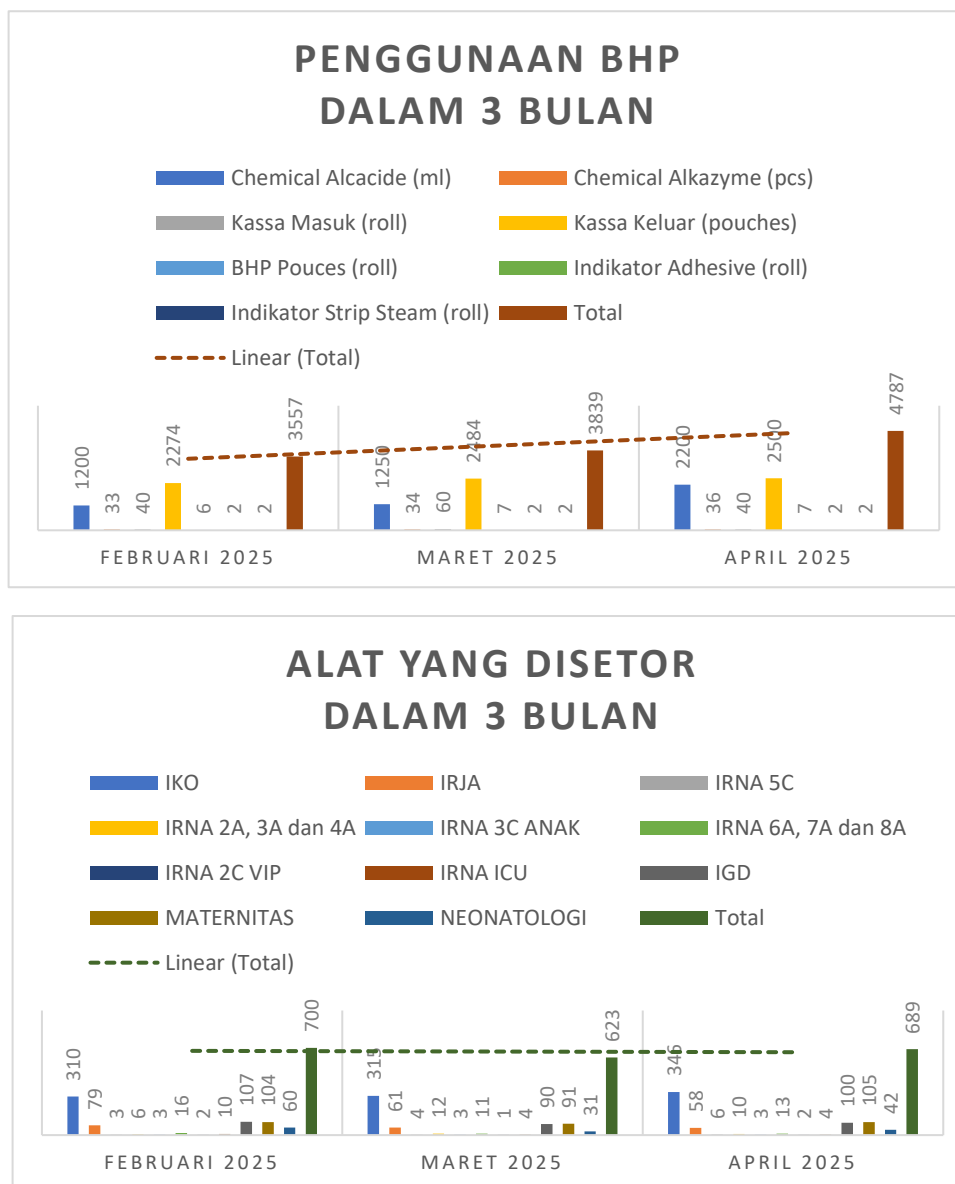
4.4.7.1 CSSD

4.4.7.2 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD Februari – April 2025

NO	HAL	BULAN TAHUN 2024		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
BHP				
1.	Chemical Alcacide (ml)	1200	1250	2200
2.	Chemical Alkazyme (pcs)	33	34	36
3.	Kassa Masuk (roll)	40	60	40
4.	Kassa Keluar (pouches)	2274	2484	2500
5.	BHP Pouces (roll)	6	7	7
6.	Indikator Adhesive (roll)	2	2	2
7.	Indikator Strip Steam (roll)	2	2	2
Alat Yang Disetor				
8.	IKO	310	315	346
9.	IRJA	79	61	58
10.	IRNA 5C	3	4	6
11.	IRNA 2A, 3A dan 4A	6	12	10
12.	IRNA 3C ANAK	3	3	3
13.	IRNA 6A, 7A dan 8A	16	11	13
14.	IRNA 2C VIP	2	1	2
15.	IRNA ICU	10	4	4

16.	IGD	107	90	100
17.	MATERNITAS	104	91	105
18.	NEONATOLOGI	60	31	42
Jumlah		700	623	689

4.4.7.3 Grafik Jumlah Alat Yang Disetor ke CSSD Bulan Februari – April 2025



Analisis :

1. Dari data diatas dapat diketahui bahwa, pengeluaran BHP dalam 3 bulan terakhir adalah stabil, ada peningkatan tetapi tidak signifikan. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kunjungan pasien baik rawat inap maupun rawat jalan dan produktivitas CSSD membuat kassa steril meningkat.

2. Jumlah alat yang disterilisasi paling banyak dari Unit IKO dengan jumlah setor alat pada Bulan April 2025 yaitu sejumlah 346 set, diikuti dari Unit Maternitas 105 set dan IGD 100 set. Dimana dari ketiga unit tersebut paling sering melakukan tindakan.
3. Unit IRJA mengalami penurunan hal ini disebabkan karena penurunan jumlah kunjungan pasien rawat jalan karena pegajian cuti Dokter Spesialis meningkat.
4. Dengan perbaikan pencatatan menggunakan google spreadsheet data yang diambil valid, namun penggolongan kategori alat tidak seragam, seperti gunting talpus terhitung 1 alat dan set partus juga terhitung 1 alat.
5. Penggunaan BHP meningkat tidak sebanding dengan jumlah alat yang disetor, hal ini disebabkan karena alat yang disetor terbanyak dari IKO dan Maternitas, dimana alat-alat tersebut kemungkinan besar terdapat noda membandel.
6. Terjadi peningkatan pengeluaran alcacide secara drastis, hal ini disebabkan karena unit IKO ada permintaan alcacide 1 jirigen untuk precleaning alat saat malam hari.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor per bulan dengan kesepakatan alat yang dihitung.
2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.
3. Monitoring dan Evaluasi pencatatan digital.
4. Melakukan orientasi petugas baru di CSSD.

4.4.7.4 Tabel Penggunaan Reuse Pada Bulan April Tahun 2025

Nama Alat	Reuse ke1
Junctionrees	-
Breathing circuit	-

Analisis :

Tidak ada permintaan alat reuse pada Bulan April 2025.

4.4.7.4 Tabel Hasil Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD

UNIT	BULAN			TOTAL 3 BULAN
	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025	
Kejadian instrument kurang				
IKO	0	1	1	2
IGD	2	0	0	2
IRNA	0	0	0	0
IRJA	0	0	0	0
Kejadian Instrumen Hilang				
IKO	0	0	0	0
IGD	0	2	2	4
IRNA	0	0	0	0
IRJA	0	0	0	0

Analisis :

1. Ditemukan kejadian instrument kurang di IKO, sebanyak 1 kali, yaitu sendok kuret. Hal ini ditemukan ketika perawat setor alat kotor dan langsung dicek oleh petugas CSSD, setelah ditelusur ditemukan di unit.
2. Ditemukan instrument hilang di IGD, sebanyak 2 kali, yaitu naldfulder dan pinset cirugis. Hal ini ditemukan ketika perawat setor alat kotor dan dicocokkan dengan serah terima alat bersih, setelah ditelusur instrument belum ditemukan.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan pencatatan saat ada penemuan.
2. Melaporkan temuan kepada Kabid Keperawatan untuk dilakukan pendisiplinan petugas.
3. Melakukan penggantian alat hilang oleh unit yang bersangkutan.

4.4.7.5 Tabel Rekap Data Permintaan Instrumen Cito Selama Bulan April 2025

UNIT	JUMLAH PERMINTAAN CITO			KETERANGAN
	Februari 2025	Maret 2025	April 2025	
IKO	0	0	0	
IGD	0	0	0	
IRNA	0	0	0	
IRJA	0	0	0	

Analisis :

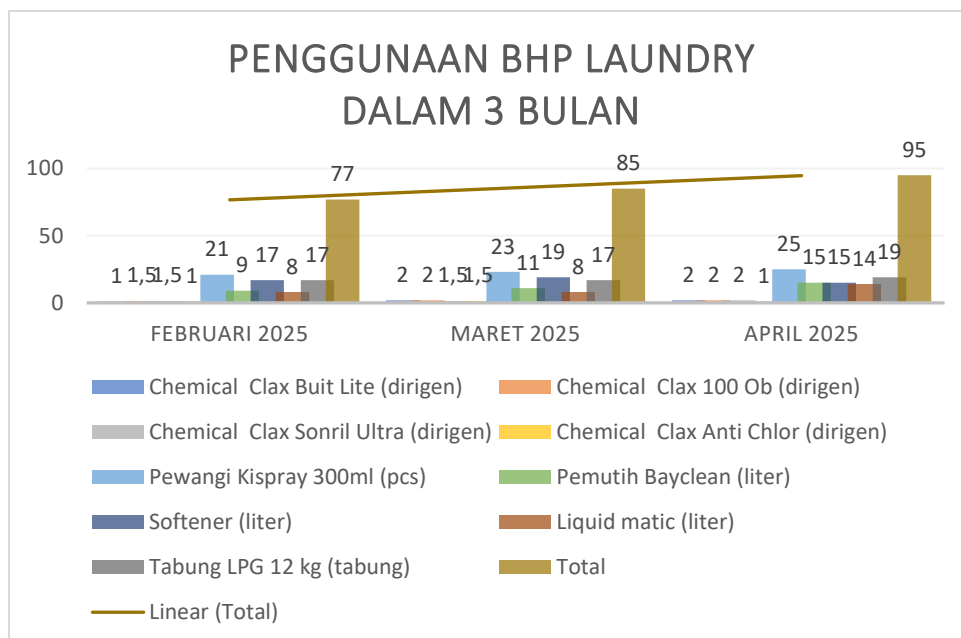
Tidak ada permintaan instrument cito selama 3 bulan terakhir, hal ini dipengaruhi ketertiban petugas dalam menyetorkan instrument kotor sehingga unit saat meminta alat selalu tersedia.

Rencana Tindak Lanjut : -**3.4.7.2 Laundry****3.4.7.2.1 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry pada Bulan Februari – April Tahun 2025**

NO	HAL	BULAN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
BHP				
1.	Chemical Clax Buit Lite (dirigen)	1	2	2
2.	Chemical Clax 100 Ob (dirigen)	1.5	2	2
3.	Chemical Clax Sonril Ultra (dirigen)	1.5	1.5	2
4.	Chemical Clax Anti Chlor (dirigen)	1	1.5	1
5.	Pewangi Kispray 300ml (pcs)	21	23	25
6.	Pemutih Bayclean (liter)	9	11	15
7.	Softener (liter)	17	19	15
8.	Liquid matic (liter)	8	8	14
9.	Tabung LPG 12 kg (tabung)	17	17	19
Total		77	85	95

LINEN (kg)				
1.	Linen Infeksius	2423	2347	2556
2.	Linen Non Infeksius	1759	2149	2076
3.	IRNA 2,3,4 A	434	417	523
4.	IRNA 6,7,8 A	634	598	648
5.	IRNA 2C/ICU/HCU	322	279	269
6.	IRNA 3C	324	343	289
7.	IRNA 4C/MATERNITAS	237	334	296
8.	IRNA 5C	237	259	321
9.	IKO	1650	1887	1964
10.	IRJA	78	78	41
11.	IGD	184	177	212
12.	LABORATORIUM	4	5	4
13.	RADIOLOGI	4	5	4
14.	DAPUR/GIZI	4	5	4
15.	CSSD	4	5	10
16.	Linen MS	30	44	34
17.	Umum	36	60	18
Total		4182	4496	4632

3.4.7.2.2 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Pada Bulan Februari - April Tahun 2025





Analisis :

1. Data diatas adalah jumlah pencucian linen pada Bulan April 2025 sebanyak 4632kg, mengalami peningkatan karena sebanding dengan peningkatan kunjungan pasien rawat inap.
2. Jumlah linen infeksius sebesar 2556kg, sebagian besar berasal dari IKO. Hal ini disebabkan produktivitas IKO pada Bulan April 2025 meningkat. Hal ini juga menyebabkan penggunaan BHP meningkat.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan breakdown pencatatan linen infeksius/non infeksiun per unit.
2. Dilakukan perubahan alur permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan, yang dilaksanakan mulai awal Tahun 2025.
3. Rencana akan dilakukan pencatatan keluar masuknya linen menggunakan google spreadsheet per hari nya.
4. Rencana akan dilakukan stok opname setiap bulan.
5. Pemampatan jadwal dinas malam untuk memaksimalkan pekerjaan.
6. Perubahan alur pengambilan linen yang perlu disterilisasi, dilakukan oleh petugas CSSD karena petugas laundry yang kurang.

4.4.7.2.3 Tabel Inventarisasi Linen Laundry Pada Bulan Februari – April 2025

No	Nama / Jenis Linen	Februari 2025	Maret 2025	April 2025
1.	Sprei	185	140	220
2.	Sarung bantal	275	250	325
3.	Selimut	216	209	201
4.	Baju tim IKO	118	117	114
5.	Baju ganti pasien	44	44	41
6.	Skort	160	154	151

7.	Perlak	19	35	31
8.	Baju ganti laundry	15	15	15
9.	Duk lubang besar	23	21	21
10.	Duk pembungkus	59	59	59
11.	Duk kecil 1 meter	58	58	55
12.	Duk ortho	20	18	16
13.	Duk lubang kecil	18	17	17
14.	Duk kaki	11	11	11
15.	Meja mayo	21	21	20
16.	Skort IKO	48	62	61
17.	Waslap	46	66	64
18.	Handuk CSSD	10	10	10
19.	Bantal	105	122	140

3.4.7.2.3 Tabel Rekap Kerusakan Linen dan Pemusnahan Pada Bulan Februari – April 2025

No	Nama / Jenis Linen	Februari 2025	Maret 2025	April 2025
1.	Sprei	10	45	20
2.	Sarung bantal	15	25	25
3.	Selimut	10	7	8
4.	Duk Pembungkus	0	0	0
5.	Duk Lubang Kecil	0	1	0
6.	Celana Tim IKO	0	0	3
7.	Baju Tim IKO	0	0	3
8.	Baju Pasien	0	0	0
9.	Skort	2	4	4
10.	Perlak	2	0	4
11.	Baju Ganti Laundry	0	0	0
12.	Duk Kecil	0	0	3
13.	Waslap	14	5	2
14.	Handuk CSSD	0	0	0
15.	Bantal	3	3	2
16.	Kerudung	0	0	0
17.	Kantung L	0	0	2
18.	Meja Mayo	0	0	1
Pemusnahan (+)		Tanggal 27/01/2025	Dijadwalkan 6 bulan sekali	Dijadwalkan 6 bulan sekali

Analisis :

Petugas melakukan sortir setiap hari, linen tidak layak dijadikan satu dan diajukan untuk dilakukan pemusnahan, BA sudah dikirim ke PT sebagai lampiran untuk penambahan linen pengganti.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Follow up Pengadaan PT
2. Jadwal pemusnahan linen selanjutnya pada Bulan Juli 2025

3.4.7.2.4 Tabel Pelaporan Limbah atau Benda Asing Tercampur Linen Pada Bulan Februari - April Tahun 2025

No	Nama Benda	Jumlah		
		Februari 2025	Maret 2025	April 2025
1.	Masker IKO	2	3	1
2.	Tissue	1	3	6
3.	Jarum	1	0	1
4.	Bumbu Dapur	0	0	0
5.	Uang	0	0	0
6.	Alat Tulis	0	0	1
7.	Benda lainnya	1	0	1 (selang oksigen)

Analisis :

1. Masih ditemukan benda asing tercampur dengan linen, karena pemilahan seharusnya dilakukan di Unit sebelum linen dimasukkan kedalam tong linen kotor.
2. Ketidakterdisiplinan paling banyak dari Unit IRNA.
3. Hal ini dapat menyebabkan kontaminasi terhadap linen lainnya dan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan sosialisasi kepada unit.
2. Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kemudian dilaporkan kepada Kabid Keperawatan dan SDM terkait hasil evaluasi.

4.4.7.5 Tabel Permintaan Linen Cito/Tidak Sesuai Jadwal Pada Bulan April 2025

UNIT	Tanggal	Jenis Linen	Jumlah	Alasan
-	-	-	-	-

Analisis :

Tidak ada permintaan linen cito dari unit, hal ini dikarenakan laundry memiliki jadwal permintaan linen sehari 2 kali, dan laundry standby 24 jam.

Rencana Tindak Lanjut : -

4.5 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan

4.5.7 SDM

4.5.7.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	39	13	6	7	0
		S1 Farmasi		1	0	1	0
		D3 Analisis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		20	12	8	0
		SMK		4	3	1	0
		S1 Akuntansi		0	0	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	1	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	6	6	0	0
		D3 Keperawatan		6	5	1	0
16	IGD	Profesi Ners	25	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		9	7	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	7	7	0	0

		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRs	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	27	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		14	13	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	8	6	5	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		13	7	6	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	15	6	4	0	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	9	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	25	12	6	6	0
		D3 Keperawatan		13	8	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		8	8	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	7	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	4	0	1
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		2	0	2	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	10	2	1	1	0
		D3 Analis Kesehatan		8	7	1	0
30	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	10	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	4	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		4	4	0	0

33	PIPP & MPP	Profesi Ners	5	2	1	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0
36	SDM	S1 Psikologi	2	1	0	1	0
		S1 Ilmu Sosial		1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	46	17	8	9	0
		SMA		24	20	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	4	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0

	Urologi						
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			460				

Keterangan :
 Terdapat penonaktifan sementara 2 staf TTK di unit farmasi dikarenakan magang pribadi, terdapat 1 penambahan dokter spesialis penyakit dalam.

3.5.1.1 Update STR / SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	Fahmi Shohibul Mubarak, A.Md.Rad	Radiografer	07 Maret 2025	SIP Perpanjangan
2	Fifi Wahyuningsih, A.Md.Kep	Perawat	21 Maret 2025	Perpanjangan SIP
3	Defi Isniriyati, A.Md.Farm	Tenaga Teknis Kefarmasian	10 April 2025	SIP Baru
4	dr. Gusti Gandha Pandya	Dokter Umum	11 April 2025	SIP Baru
5	Dyah Palupi, A.Md.Kep	Perawat	11 April 2025	SIP Perpanjangan
6	Lusianah Nurul Islamiyah, A.Md.Kep	Perawat	11 April 2025	SIP Perpanjangan
7	Kurnia Setyawan Syah, S.Kep.,Ns	Perawat	11 April 2025	SIP Perpanjangan
8	Muhammad Iqbal Maulana, A.Md.Rad	Radiografer	11 April 2025	SIP Perpanjangan
9	Renaldi Salsabila, A.Md.Rad	Radiografer	11 April 2025	SIP Baru
10	Anjani Kusumawati, A.Md.Farm	Tenaga Teknis Kefarmasian	26 April 2025	SIP Baru

Keterangan : Pada bulan April 2025 terdapat 4 SIP baru dan 6 SIP perpanjangan.

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Menguhubungi kampus dengan jurusan tersebut
3	Dokter Gigi Spesialis Konservasi	1	0	1	Sulit mencari Dokter Gigi Spesialis	Menguhubungi kampus dengan jurusan tersebut

	Gigi				Konservasi Gigi	
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang Perempuan
5	Fisioterapis	5	4	1	Belum mendapatkan kandidat yang cocok	Sedang proses pemenuhan
6	Perawat Gigi	2	1	1	Sudah ACC dari PT DPM	Open recruitment setelah hari raya
7	Terapis Wicara	2	1	1	On proses pengajuan ke PT DPM	On proses pengajuan ke PT DPM

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN
1	5 Desember 2024	Orientasi Khusus	Renaldi Salsabila, A.Md.Rad	D3 Radiologi	Radiografer	5 Desember 2024	Bulan ke-3 orientasi khusus
2	16 Desember 2024	Orientasi Khusus	Miftakhul Khoiriyah, S.Ft	Profesi Fisioterapi	Fisioterapis	16 Desember 2024	Bulan ke-3 orientasi khusus
3	01 Maret 2025	Orientasi Khusus	dr. Annishafira Widyawardhani	Profesi Kedokteran	Dokter Umum	01 Maret 2025	Nulan ke-1 orientasi khusus

Keterangan :

Pada bulan Maret 2025 terdapat 3 staf yang menjalani orientasi khusus

3.5.1.4 Diklat

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS DIKLAT	JUDUL DIKLAT	SASARAN	KETERANGAN	RTL
1	09 April 2025	Diklat Internal	Diklat Indokator Mutu Prioritas	All Staf	Diklat dihadiri oleh 97 peserta	Proses sertifikat online
2	10 April 2025	Diklat Internal	Diklat Indokator Mutu Prioritas	All Staf	Diklat dihadiri oleh 96 peserta	Proses sertifikat online
3	15 & 16 April 2025	Company Visit Otsuka	Company Visit	Direksi RS, SDM, PIPP	Dilaksanakan di PHS dan di PT Amerta Indah Otsuka	-
4	23 & 26 April 2025	Diklat Internal	Diklat Manajemen Risiko Rumah Sakit	All Staf	Diklat dihadiri oleh	

Keterangan:

Pada bulan Maret 2025 terdapat pelaksanaan diklat yang dilaksanakan di RS Prima Husada Malang.

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

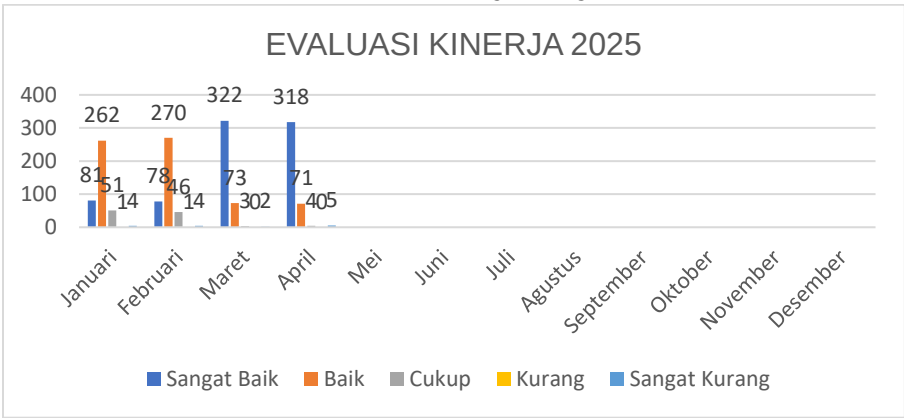
NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
1	Direktur	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Direktur secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Kabid Pelayanan Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Pelayana Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
3	Kabid Penunjang Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit KABid Penunjang Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
4	Kabid Keperawatan	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Keperawatan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	Kabid Umum & Keuangan	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Umum & Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	Satuan Pengawas	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Satuan Pengawas Internal secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
	Internal								penilaian kinerja umum.
7	Farmasi	Umum	40	2	22	18	2	0	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Asuransi Center	Umum	10	0	10	0	0	0	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
9	CSSD	Umum	5	0	5	0	0	0	Unit CSSD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	Fisioterapi	Umum	5	0	3	2	0	0	Unit Fisioterapi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	Gizi	Umum	17	0	15	2	0	0	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	Humas & Marketing & PKRS	Umum	2	0	2	0	0	0	Unit Humas Markrting & PKRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	ICU dan HCU	Umum	12	0	10	2	0	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	IGD	Umum	25	0	21	4	0	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	IKO	Umum	12	0	11	1	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	IPCN	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IPCNsecara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
17	IPSRS	Umum	6	0	5	1	0	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRJA	Umum	27	0	23	4	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRNA 2C	Umum	8	0	7	1	0	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	IRNA 2A, 3A, & 4A	Umum	18	0	15	3	0	0	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	IRNA 3C Anak	Umum	15	0	13	2	0	0	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	IRNA 5C	Umum	9	0	7	2	0	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IRNA 6A, 7A, & 8A	Umum	24	0	21	3	0	0	Unit IRNA 6A, 7A & 8A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	Maternitas	Umum	12	0	9	3	0	0	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Neonatologi	Umum	9	0	8	1	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Keuangan & Akuntansi	Umum	10	0	6	4	0	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Laboratorium	Umum	10	0	9	1	0	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	Laundry	Umum	5	0	5	0	0	0	Unit Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
28	Rekam Medis	Umum	9	0	9	0	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
29	Pendaftaran	Umum	18	0	16	2	0	0	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
30	PIPP & MPP	Umum	5	0	4	1	0	0	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
31	PMKP	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Mutu & PMKP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
32	Radiologi	Umum	7	0	7	0	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
33	SDM	Umum	2	0	2	0	0	0	Unit SDM secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
34	Sekretaris	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Sekretaris secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
35	SIMRS & IT	Umum	3	0	2	1	0	0	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
36	Umum & Rumah Tangga	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
37	Cleaning Service	Umum	45	1	32	12	1		Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
38	Security	Umum	12	0	12	0	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
39	Driver	Umum	5	0	4	1	0	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
40	Gudang Umum	Umum	1	1	0	0	1	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis :
Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode April 2025.

3.5.1.5.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



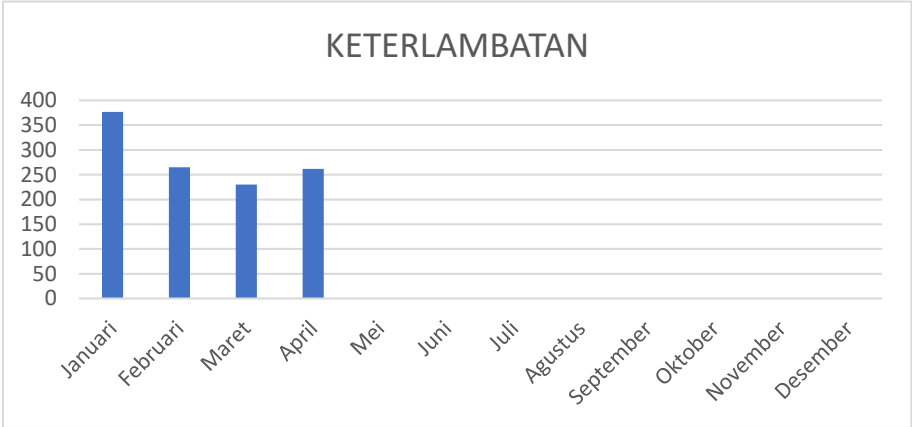
Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sangat Baik	81	78	322	318								
Baik	262	270	73	71								
Cukup	51	46	3	4								
Kurang	1	1	0	0								
Sangat Kurang	4	4	2	5								
TOTAL	399	399	400									

Analisa :
Secara umum terdapat peningkatan kinerja dari staf dilihat dari jumlah kategori cukup yang naik menjadi kategori diatasnya.

Rencana Tindaklanjut :

- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
- 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
- 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
KETERLAMBATAN	377	265	230	262								



Analisa :

Secara umum terdapat peningkatan keterlambatan karyawan. Hal ini dikarenakan keputusan terkait teguran tertulis atau tindakan setelah 3 bulan terakhir terlambat.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
- 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
- 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2025

NO	JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Konseling	0	0	3	3							

Analisis :

Terdapat konseling terkait karir sejumlah 3 karyawan terkait kontrak kerja.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

Jenis	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Supervisi (2x/bulan)	0	100%	50%	100%								

3.5.2 IPSRS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintenance Alat Medis

	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Capaian Maintenance Ruangan	90%	84.61	66.6	92.3	76,92								

BULAN	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Januari	268	154	57.46%
Februari	270	135	50.00%
Maret	276	153	55.43%
April	276	150	54.34%

TOTAL ALAT (PERBAIKAN)	TOTAL ALAT
Januari	21
Februari	22
Maret	21
April	17

Analisa :

Pada bulan ini, capaian maintenance alat berdasarkan ruangan 76,92% dan jumlah alat 54.34%. Beberapa factor yang menyebabkan fluktuatif antara lain : alat medis masih dipakai oleh pasien, ruangan atau unit masih ada tindakan pasien, perbantuan perbaikan alat medis klinik Mutiara sehat serta beberapa kondisi alat servis yang membutuhkan waktu lebih lama.

Rencana Tindak Lanjut :

Koordinasi dengan PT untuk ATEM sesuai ABK

3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

BULAN	MAINTENANCE / 1 BULAN	MAINTENANCE / 2 BULAN	MAINTENANCE / 3 BULAN	TOTAL	CAPAIAN
TARGET/BULAN	42	30	23	95	
JANUARI	11	6	16	33	35%
FEBRUARI	23	17	11	51	53.6%
MARET	14	41	6	61	64.21%
APRIL	7	30	6	43	45.26%
MEI					
JUNI					

JULI					
AGUSTUS					
SEPTEMBER					
OKTOBER					
NOVEMBER					
DESEMBER					

Analisa :

Pada awal januari digunakan metode baru pencatatan kinerja terutama terkait system pencatatan dan target perbulan. Sudah dilakukan pencatatan metode baru, hasil evaluasi lebih baik dari tahun 2024. Capaian bulan ini menurun 45.26 %.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :

Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.5.2.2.4.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :

Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D,E dan LVMDP dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan dokumentasi. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

April 2025							
Tanggal	Stok Liquid	Sebelum pengisian	Penggunaan	Satuan	Keterangan	Pengiriman	Satuan
01/04/2025	1773	1469	304	MMHG			MMHG
02/04/2025	1469	3465	0	MMHG	sesudah pengisian	1996	MMHG
02/04/2025	3465	3380	85	MMHG			MMHG
03/04/2025	3380	3185	195	MMHG			MMHG
04/04/2025	3185	2957	228	MMHG			MMHG
05/04/2025	2957	2769	188	MMHG			MMHG
06/04/2025	2769	2544	225	MMHG			MMHG
07/04/2025	2544	2334	210	MMHG			MMHG
08/04/2025	2334	2116	218	MMHG			MMHG
09/04/2025	2116	1875	241	MMHG			MMHG
10/04/2025	1875	1718	157	MMHG			MMHG
11/04/2025	1718	1464	254	MMHG			MMHG
12/04/2025	1464	1246	218	MMHG			MMHG
13/04/2025	1246	858	388	MMHG			MMHG
14/04/2025	858	3464	0	MMHG	sesudah pengisian	2606	MMHG
14/04/2025	3464	3408	56	MMHG			MMHG
15/04/2025	3408	3224	184	MMHG			MMHG
16/04/2025	3224	2998	226	MMHG			MMHG
17/04/2025	2998	2579	419	MMHG			MMHG
18/04/2025	2579	2322	257	MMHG			MMHG
19/04/2025	2322	2000	322	MMHG			MMHG
20/04/2025	2000	1653	347	MMHG			MMHG
21/04/2025	1653	1415	238	MMHG			MMHG
22/04/2025	1415	1153	262	MMHG			MMHG
23/04/2025	1153	885	268	MMHG			MMHG
24/04/2025	885	2976	0	MMHG	sesudah pengisian	2091	MMHG
24/04/2025	2976	2811	165	MMHG			MMHG
25/04/2025	2811	2597	214	MMHG			MMHG
26/04/2025	2597	2352	245	MMHG			MMHG
27/04/2025	2352	2152	200	MMHG			MMHG
28/04/2025	2152	1915	237	MMHG			MMHG
29/04/2025	1915	1680	235	MMHG			MMHG
30/04/2025	1680	1435	245	MMHG			MMHG
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			7031	MMHG			MMHG
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						4697	MMHG
Rata-rata penggunaan okisgen per hari			466,5	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						3131,333333	MMHG

Analisis :

Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.7 Filter Air

3.5.2.2.7.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.9 UPS

1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

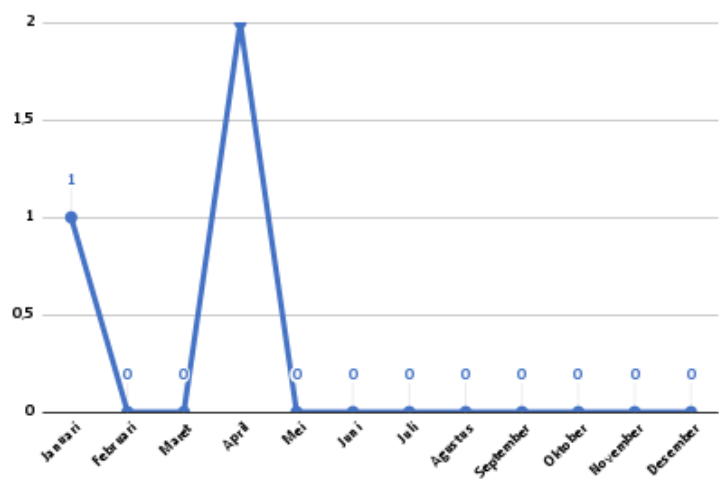
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	1	0	0	2							

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



Analisa :

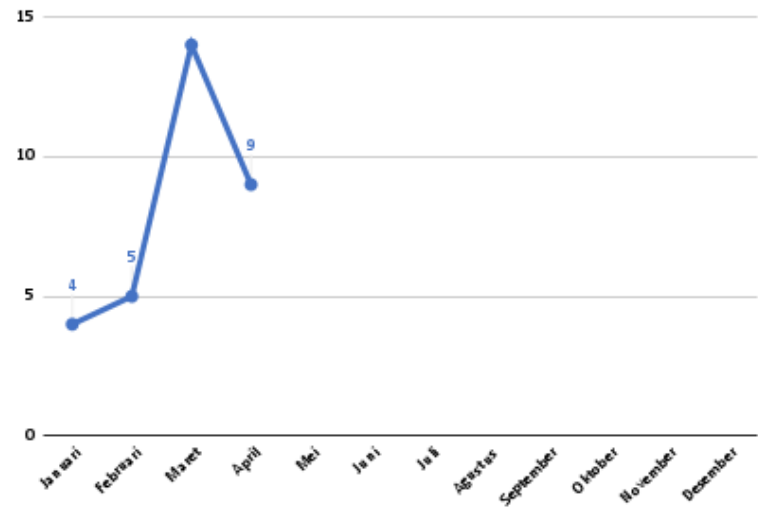
TANGGAL	KETERANGAN	RTL
11 – 04 – 2025	Telah terjadi kehilangan barang pribadi milik pasien (karyawan rsph) berupa hp , posisi rawat inap di lantai 3a ruang cempaka , untuk penelusuran cctv selasar irna nihil dikarenakan cctv dalam kondisi off & error	Koordinasi dengan team IT perihal perbaikan dan pemantauan cctv , untuk cctv sudah diperbaiki on dan pantauan normal
26 – 04 - 2025	Telah ditemukan uang dilantai 1 disekitar iko sampai lift Gedung c ,untuk uang diamankan di lantai 3c	Diamankan di lantai 3c

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	4	5	14	9							

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



ANGKA KEJADIAN BARANG BERPOTENSI HILANG		
TANGGAL	KETERANGAN	RTL
05 – 04 – 2025	Telah ditemukan sim milik pengunjung di area cso ,diamankan di CSO	Sudah diambil pemiliknya
07 – 04 – 2025	Telah ditemukan berkas pasien tertinggal dibawah lantai depan PIPP diamankan di pos IGD	Sudah diambil pemiliknya
12 – 04 – 2025	Telah ditemukan kunci beat putih diparkiran karyawan diamankan di CSO	Sudah diambil pemilik
14 – 04 – 2025	Telah ditemukan tas milik pasien tertinggal diarea poli pendaftaran , diamankan di pendaftaran central	Sudah diambil pemilik
15 – 04 – 2025	Telah ditemukan dompet milik pasien tertinggal di area poli pendaftaran diamankan di pos poli	Sudah diambil pemilik
16 – 04 – 2025	Telah ditemukan dompet milik pasien tertinggal di area poli pendaftaran diamankan di pos poli	Sudah diambil pemilik
21 – 04 - 2025	Telah ditemukan kartu bpjs pasien diamankan di admisi 6 pendaftaran central	Sudah diambil pemilik
23 – 04 – 2025	Telah ditemukan kunci motor karyawan di parkiran karyawan diamankan di pos igd	Sudah diambil pemilik
29 – 04 - 2025	Ditemukan berkas dan obat beserta kartu identitas pasien di kamar mandi KR2 blok C sementara diamankan di pos IGD	Sudah diambil pemilik

Analisis :

Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

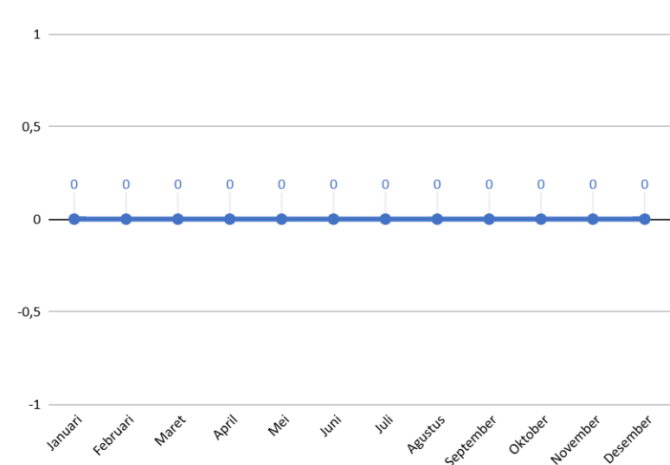
Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0							

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan

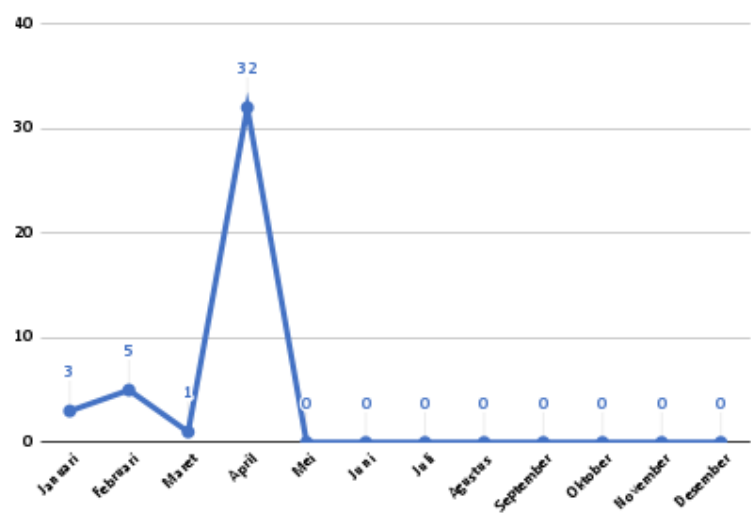


Analisis :
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusuhan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	3	5	1	32								

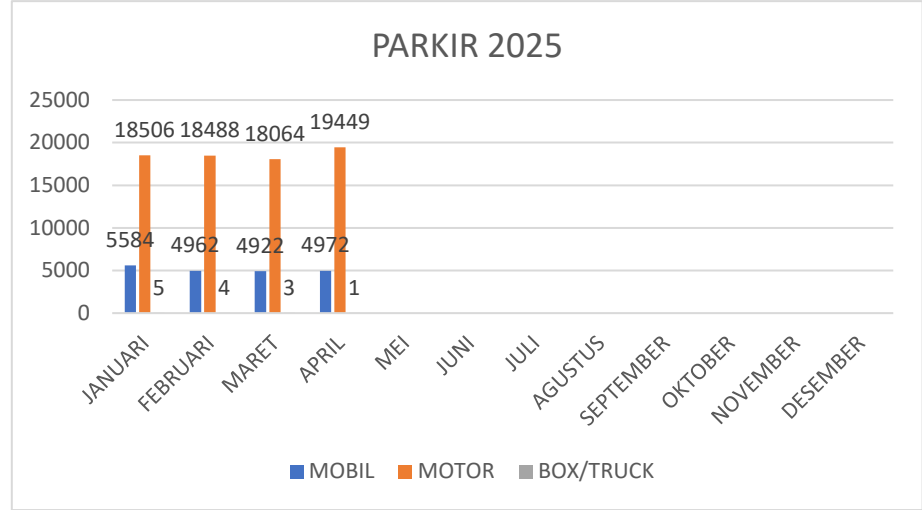


Analisis :
Angka ini relative kecil. Belum sepenuhnya tercatat. Yang tercatat adalah laporan security saat keliling saja.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.4 Parkir

3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member



Analisis :
Progres parkir bulan ini menurun akibat jumlah hari aktif yang lebih sedikit serta fluktuatif kunjungan pasien.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.5.5.1.1 Pencapaian Kinerja PKS – IKS April 2025

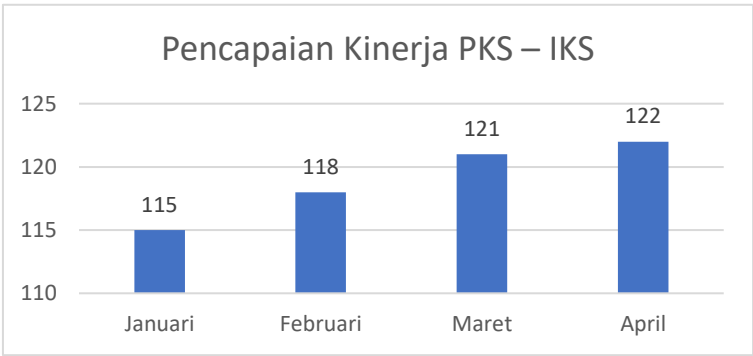
No	Bulan	Target	Jumlah				Progres	Total Kurang
			Berlaku	ED	Baru	Kurang Baru		
1	Januari 2025	1 IKS baru	115	6	0	0	2 (review pihak kedua) 1 (progres evaluasi) 1 (tdk diperpanjang)	4
2	Februari 2025	1 IKS baru	118	1	1	0	3 (Proses Tanda Tangan Pihak kedua)	3
3	Maret 2025	1 IKS baru	121	1	1	0	1 (Proses review)	1
4	April 2025	1 IKS baru	122	1	1	0	1 (Proses Review Pihak ke 2)	1

Analisis ;
1. Pada bulan April 2025, PKS dengan instansi lain masih dalam progres. Pembuatan Addendum untuk PKS BNI dan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Draft yang dikirim ke Pihak kedua masih dalam tahap Review
Rencana Tindak Lanjut :
1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua

3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru April 2025

NO	NAMA PKS	PROGRES PENGURUSAN	KENDALA
1	PT Nayaka Era Husada	Review pihak kedua	Selesai
2	Klinik Brawijaya Lawang	Review pihak kedua	Selesai
3	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Review pihak kedua	Selesai
4	PT. Kasoem Hearing	Proses TTD	Proses kirim dari Jakarta

5	PT Global Excel	Review	Perbedaan template draft PKS
6	PT Malang Intermedia Pers	Review	Proses Perpanjangan
7	PT BNI Life Insurance	Penambahan Addendum	Selesai
8	Dispenduk Kab. Malang Ketan Ireng	Review (konfirmasi terakhir bulan April masih menunggu pihak sekda)	Proses pihak Dispenduk



3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

3.5.5.2.1 Pencapaian Hasil Kinerja MCU dan Vaksin April 2025

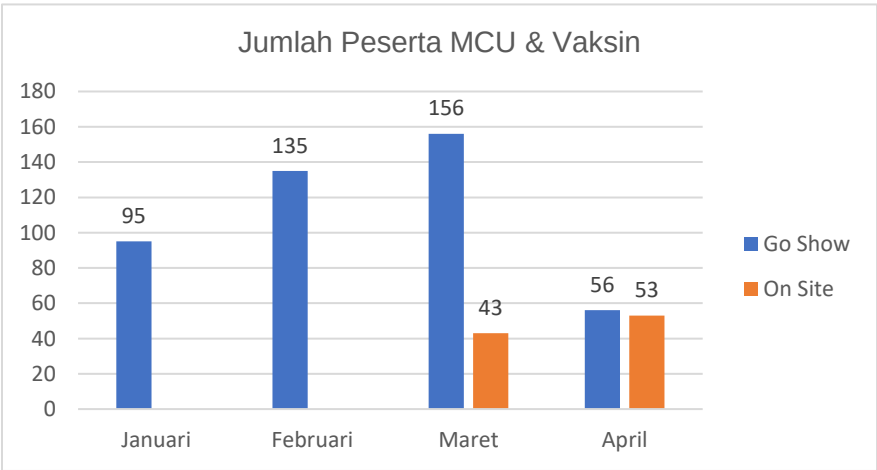
NO	BULAN	TARGET	JUMLAH PASIEN GOSHOW	ON SITE
1	Januari	25	95	-
2	Februari	25	135	-
3	MARET	150	156	43
4	APRIL	150	56	53
5	MEI	150		
6	JUNI	150		
7	JULI	150		
8	AGUSTUS	150		
9	SEPTEMBER	150		
10	OKTOBER	150		
11	NOVEMBER	150		
12	DESEMBER	150		

Analisis ;

- Jumlah peserta MCU dan Vaksin bulan April Menurun 0.56 % dari bulan Maret

Rencana Tindak Lanjut :

- Melakukan Promosi melalui Social Media
- Kunjungan ke Universitas, SMA dan SMK untuk menawarkan program MCU Pelajar



3.5.5.2.2 Tabel Evaluasi Hasil Penawaran MCU Tahun 2025

NO	BULAN	INSTANSI	HASIL
1	Januari	PT Berca Kawan Sejati Cab. Malang Official	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
2	Februari	PT Pesta Pora	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Peserta 106 orang
3	Maret	Meteor Cell Singosari	Sudah terlaksana
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Perubahan Peserta menjadi 53 orang dan pengajuan dengan Bus MCU
4	April	PT Green Mountains Natural Food	Sudah terlaksana

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Jumlah Kunjungan	5	10	2								

Analisa :

Kunjungan eksternal mulai dilakukan Kembali untuk sosialisasi kebijakan yang berhubungan dengan rujukan pasien dan pengenalan staf baru. Terdapat peningkatan kunjungan pada bulan Februari karena telah direncanakand dan terjadwal.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala.

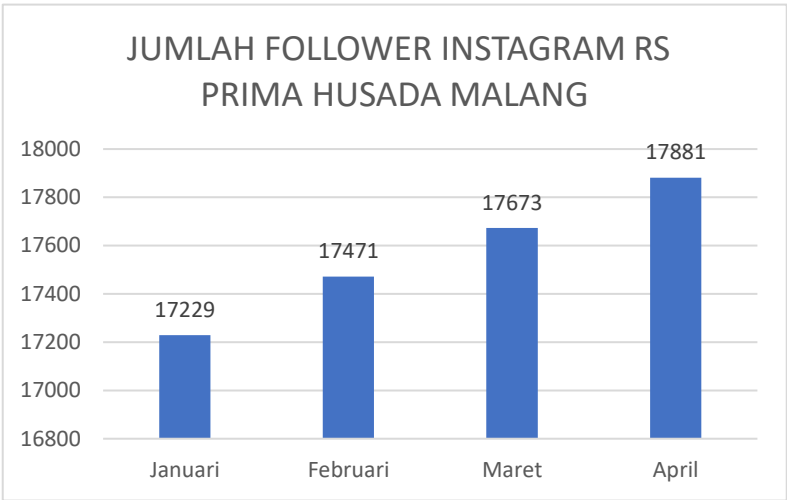
2.5.5.2.4 Digital Marketing

2.5.5.2.4.1 Daftar Kegiatan Digital Marketing

Platform Instagram

JUMLAH KONTEN BARU	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	3	7	9	10								
REELS	5	5	11	5								
STORY	6	10	14	8								
TOTAL	14	22	34	28	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL POSTINGAN (BARU + LAMA)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	6	11	16	19								
FEED VIDEO	0	0	0	0								
REELS	3	4	5	7								
STORY	29	33	28	38								
TOTAL	38	48	49	64	0	0	0	0	0	0	0	0
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER	17,229	17,471	17.673	17.88								

(CUT OFF TANGGAL 1)												
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	496	242	202	208	0	0	0	0	0	0	0	0
TARGET	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

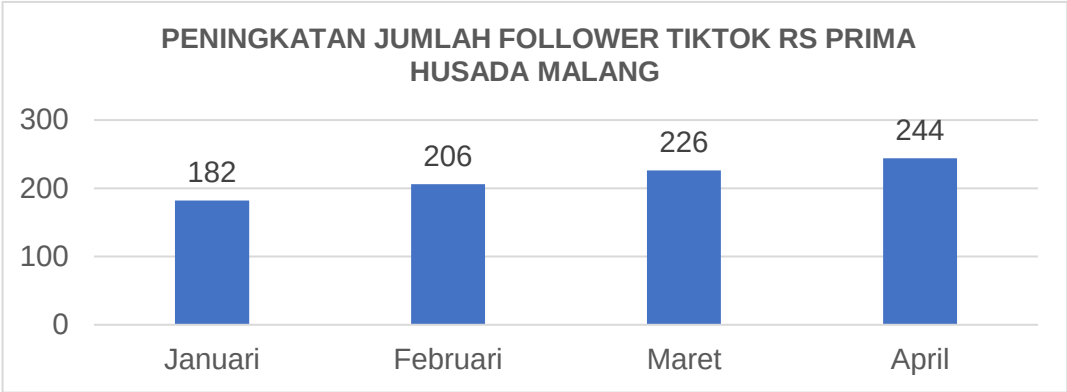


Analisa :
 Jumlah Follower Instagram RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 1% dari bulan April

- Rencana Tindal Lanjut :**
1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS setiap harinya
 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Tik Tok

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	2	3	4	0								
TARGET	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	182	206	226	244								
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	16	24	20	18	0	0	0	0	0	0	0	0
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH LIKE	45	72	1023	1085								



Analisa :
Jumlah Follower Tiktok RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 1.1% dari bulan Februari

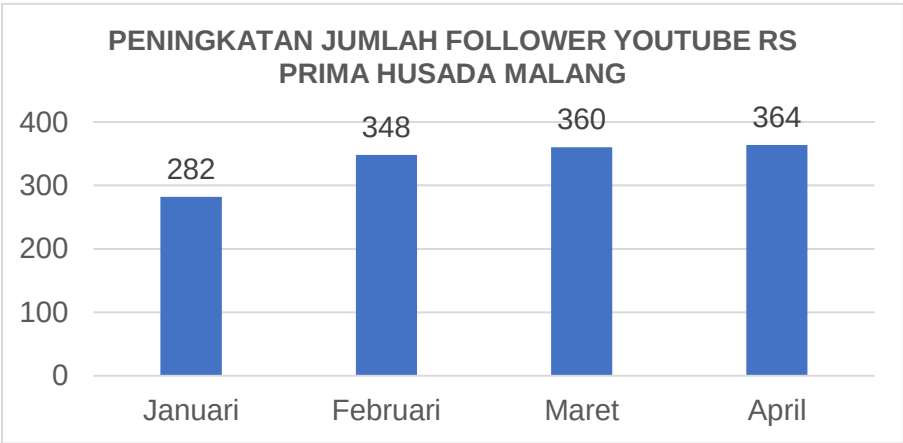
- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Youtube

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	0	2	0	0								
TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH SUBS	282	348	360	364								

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN SUBS	4	66	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0
TARGET	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



Analisa :
Jumlah Follower Youtube RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 1.01% dari bulan Maret

Rencana Tindal Lanjut :

- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
- 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
- 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Google Review

PROGRESS	JAN	FEB	MAR	AP	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH RATING	4.2	4.2	4.2	4.2								

Analisa :

Progres untuk Rating Google Review RS Prima Husada Malang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari bulan Maret

Rencana Tindal Lanjut :

Meningkatkan Survei kepuasan pasien dengan melakukan pengisian Google Review

3.5.5 Penjaminan

3.5.5.1 Piutang

3.5.5.1.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PIUTANG RS PRIMA HUSADA MALANG PERIODE 2025																	
									Y	Z	AA	AB	AC				
NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG						JUMLAH PIUTANG
5	6	a	b	c	(a-b-c-d)	e	f	g	(e-f-g)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total	
20	PERIODE MARET 2025 :								Total Saldo	2.026.286.312	1.810.834.393	107.092.068	5.778.521	57.526.812	46.157.467	2.026.286.312	
21	Asuransi	372.121.499	148.268.405	4.315.445	219.537.649	269.056.447	41.722.389	1.482.081	216.851.258	436.388.967	495.049.395	6.677.663	1.899.475	-	22.852.374	436.388.967	
22	Penusahan	317.283.425	150.789.978	126.876	166.367.571	88.905.852	6.181.886	0	81.823.966	248.191.537	125.763.100	935.000	42.760.383	3.403.421	75.329.572	248.191.536	
23	Mandiri Inheath	54.648.608	-	-	54.648.608	48.713.383	-	-	48.713.383	95.361.991	94.989.952	-	-	-	372.639	95.361.991	
24	Jasa Raharja	230.528.595	229.607.676	2	920.917	124.795.356	-	-	124.795.356	125.716.273	124.795.356	-	-	-	920.917	125.716.273	
25	BPJS Ketenagakerjaan	1.853.591.487	1.040.744.420	694.896	12.242.891	648.446.733	-	-	648.446.733	652.689.624	645.228.193	538.803	338.100	2.375.150	4.268.377	652.689.624	
26									Total Saldo	1.658.348.312	1.396.277.858	8.157.486	46.987.958	6.778.921	103.683.280	1.658.348.312	
27	PERIODE APRIL 2025 :																
29	Asuransi	436.388.967	233.073.610	2.823.466	200.491.831	99.371.545	17.719.696	802.628	88.848.912	281.340.743	223.431.114	31.839.920	3.417.334	-	22.852.374	281.340.743	
30	Penusahan	247.499.536	121.942.752	642.172	125.014.612	89.549.932	-	-	89.549.932	214.564.544	144.803.681	7.861.000	935.000	39.062.759	21.872.105	214.564.543	
31	Mandiri Inheath	95.361.991	13.989.429	1.443.759	79.528.803	44.799.413	-	-	44.799.413	124.728.210	93.562.791	36.793.385	-	-	372.639	124.728.210	
32	Jasa Raharja	125.716.273	124.795.354	1	920.918	105.627.548	-	-	105.627.548	106.548.466	105.627.548	-	-	-	920.917	106.548.466	
33	BPJS Ketenagakerjaan	652.689.624	232.205.080	115	420.484.659	392.881.789	-	-	392.881.789	813.366.448	811.470.464	1.031.460	-	-	864.524	813.366.448	
34									Total Saldo	1.540.548.416	1.378.896.698	71.325.785	4.362.734	39.062.759	46.881.960	1.540.548.416	

Keterangan :

Cut Off Piutang per 30 April 2025 saldo akhir Rp 1.540.548.416

3.5.5.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
RAWAT INAP			
1.	Rujuk dihari yang sama	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Penolong persalinan bidan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Indikasi rawat inap	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Pterygium los 2 hari	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	Reseleksi diagnosa aki N17. 9 menjadi N19 karena tidak sesuai dengan syarat BA	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
6	Pasien hamil tidak ada riwayat kunjungan ke fktg	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
RAWAT JALAN			
1	Kriteria gawat darurat IGD	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Kontrol di hari yg sama di Rumah Sakit yang berbeda	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Tidak ada Surat keterangan approval penerbitan SEP	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Pasien rehab lebih dari 6 bulan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi

	tidak sesuai dengan standarisasi pelayanan perdosri dan rekomendasi TKMKB		Pending
--	---	--	---------

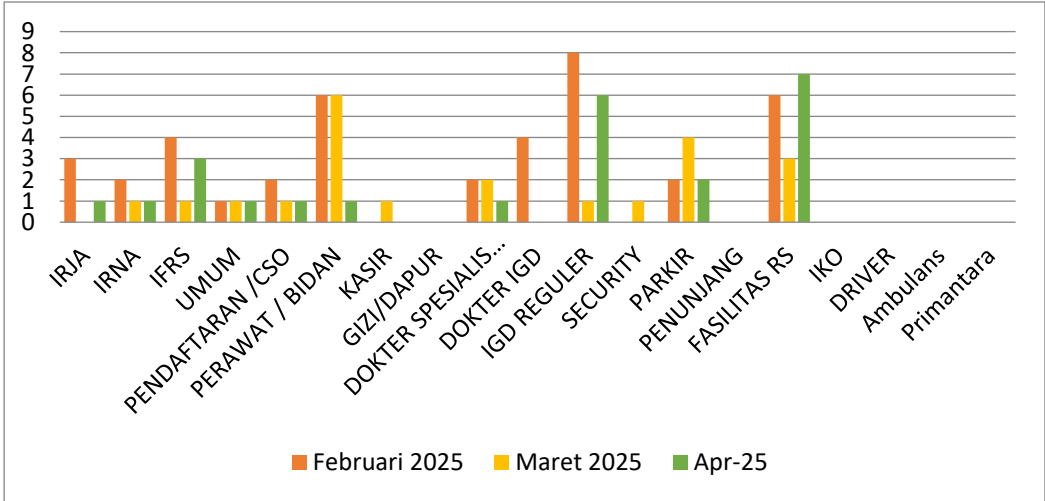
3.5.6 PIPP – MOD – MPP

3.5.6.1 Laporan Komplain Pasien

1.5.6.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan April 2025

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	Februari 2025	Maret 2025	April 2025
1.	IRJA	3	0	1
2.	IRNA	2	1	1
3.	IFRS	4	1	3
4.	UMUM	1	1	1
5.	PENDAFTARAN /CSO	2	1	1
6.	PERAWAT / BIDAN	6	6	1
7.	KASIR	0	1	0
8.	GIZI/DAPUR	0	0	0
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	2	2	1
10.	DOKTER IGD	4	0	0
11.	IGD REGULER	8	1	6
12.	SECURITY	0	1	0
13.	PARKIR	2	4	2
14.	PENUNJANG	0	0	0
15.	FASILITAS RS	6	3	7
16.	IKO	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0
18.	Ambulans	0	0	0
19.	Primantara	0	0	0
Total		40	22	24

3.5.7.1.1 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit April 2025



Analisis :

Jumlah pasien complain selama Bulan April 2025 mengacu pada complain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

1. Jumlah complain Pada bulan April 2025 Meningkat dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan februari 2025 sebanyak 40 kasus. pada bulan maret 2025 sebanyak 22 pasien Sedangkan pada bulan April 2025 sebanyak 24 pasien
2. Komplain terbanyak pada bulan April 2025 yaitu dari bagian fasilitas RS sebanyak 7 kasus, IGD 6 kasus, farmasi 3 kasus, parkir 2 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
3. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 11 kasus complain dengan rincian :
 1. Fasilitas RS sebanyak 5 kasus yaitu disediakanya fasilitas fotokopi agar tidak keluar RS untuk melakukan FC dokumen ketan ireng, tempat bermain anak untuk menunggu saat berkunjung, disediakan tempat ariari bayi, saluran TV banyak yang tidak bisa, disediakan kebutuhan air minum untuk pasien
 2. Parkir sebanyak 3 kasus yaitu terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap,
 3. Farmasi RS sebanyak 3 kasus yaitu lama pengambilan obat di farmasi

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan April 2025

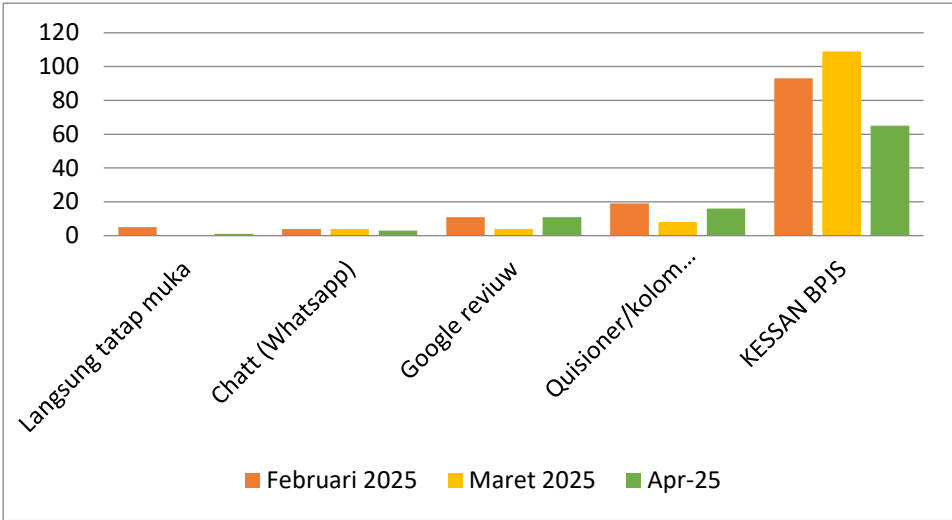
NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1.	Langsung tatap muka	5	0	1
2.	Tidak Langsung :			
a	Chatt (Whatsapp)	4	4	3
b	Google reviuw	11	4	11
3.	Quisioner/kolom kritik saran	19	8	16
4.	KESSAN BPJS	93	109	65

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

NO	KETERANGAN	BINTANG 1	BINTANG 2	BINTANG 3	BINTANG 4	BINTANG 5
1.	KESSAN BPJS	0	0	3	7	55

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan April 2025



Analisis :
Pada bulan April 2025 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 16 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari google review 11 kasus.

Rencana Tindak Lanjut :
Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan April 2025

No	Jenis Pasien Komplain	Waktu tanggap		Waktu Penyelesaian		< 3 hr Manajerial RS	7 hr ke PT
		Standard < 5 ‘	Pencapaian (dari waktu total dibagi jml komplain atau rata2 waktu tanggap)	Standard < 60 ‘	Pencapaian		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	100%	0	0
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	100%	0	0
3.	Google reviuw	100%	100%	100%	8	3	0
					70%	30%	
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	8	8	0
					50%	50%	
5.	KESSAN	100%	0	100%	100%	0	0

Analisis :
Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan April 2025 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Quisioner dengan capaian 50% dan dari google revium sebayak 30% hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak

bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 4 kasus complain dengan rincian :

- 1) Fasilitas RS sebanyak 5 kasus yaitu disediakanya fasilitas fotokopi agar tidak keluar RS untuk melakukan FC dokumen ketan ireng, tempat bermain anak untuk menunggu saat berkunjung, disediakan tempat ariari bayi, saluran TV banyak yang tidak bisa, disediakan kebutuhan air minum untuk pasien
- 2) Parkir sebanyak 3 kasus yaitu terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap,
- 3) Farmasi RS sebanyak 3 kasus yaitu lama pengambilan obat di farmasi

Rencana Tindak Lanjut :

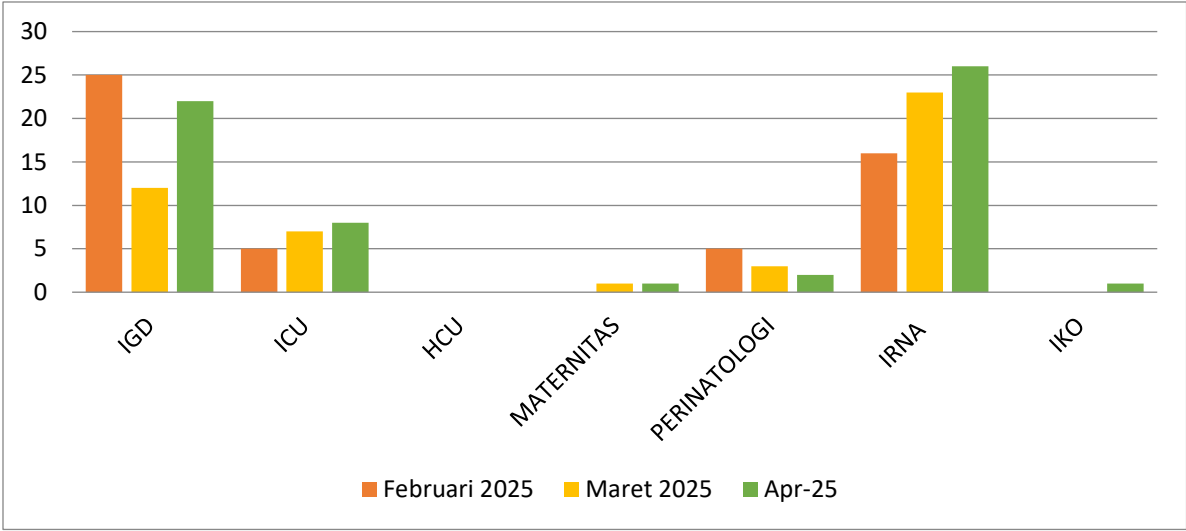
Penyelesaian complain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk

3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan April 2025

NO	UNIT PERUJUK	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1.	IGD	25	12	22
2.	ICU	5	7	8
3.	HCU	0	0	0
4.	MATERNITAS	0	1	1
5.	NEONATOLOGI	5	3	2
6	IRNA	16	23	26
7	IKO	0	0	1
Total		48	46	46

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan April 2025



3.5.7.5.3 Tabel Rincian Pasien Rujuk April 2025

NO	Nama Pasien	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	LAMA RAWAT	PLAVON HABIS
1	KETIANA GANDAIMU	IGD	G2p1Ab0 uk18-20 mnggu	dr.Humairah Sp,OG	RSSA	Pro curet	2	Tidak

2	Ny. Jumani	IRNA	CVA ICH Serebelum	dr. Syahrir, Sp.N	RST	Tatalaksana lanjut (perawatan fase akut) hari rawat ke-3	3	Tidak
3	Tn. Riduwan	IRNA	1. Peritonitis ec perforasi gaster + post repair gaster + jejunostomy feeding	dr. Zaki, Sp.B	RSSA	Tatalaksana lanjut (perawatan fase akut) hari rawat ke-2	2	Tidak
4	Tn. Adi Susanto	IRNA	UGIB variceal dt rupture VE dd nonvariceal	dr. Aji Sp.PD	RST	pro endoskopi	2	Tidak
5	Tn. Gisan	IRNA	Decreased of BW+ Chronic diarhea dt IBD dd IBS dd Colorectal malignancy	dr. Aji Sp.PD	RSSA	pro colonoscopy	2	Tidak
6	Tn. SUHERMAN	IRNA	DOC susp Hepatic Encephalopathy + Sirosis Hepatis + Riw. Aritmia + Hepatitis B reaktif	dr Ardhi Sp PD	RSSA	tatalaksana lanjut	2	Tidak
7	Ny. Ella Rizka Hibattulloh	IRNA	Tetraparase ec Multiple Sclerosis	dr. Farid, Sp.N	RSSA	Tatalaksana lebih lanjut (plasma patesis, IVIG)	5	Ya
8	Tn. Deny Candra Siswanto	IRNA	Anemia HM + Splenomegali + History recurrent transfusion dt thalassemia dd anemia def fe dd sideroblastik	dr. Aji Sp. PD	RSSA	Perawatan lebih lanjut, penegakan diagnosis	2	Tidak
9	Ny. Sanya fatchi riska	IRNA	HL, Hipokalemi, Bronkopneumonia	dr. Aji Sp. PD	RSSA	Tatalaksana lebih lanjut	2	Tidak
10	Tn. Takrib	IRNA	Hematemesi Melena, syok Condition, AKI	dr. Adhya aji, Sp. PD	RSSA	Tatalaksana lebih lanjut	3	Tidak
11	Tn. KARIM	IRNA	AKI dd HDD + ADHF+ HDD+ anemia Renal +LVH	dr. Adhya aji, Sp. PD	RSSA	PRO HD dan Perawatan lebih lanjut	2	Tidak
12	TN. DWI WIDODO	IGD	ALO Non-cardiogenik, ACKD	dr Heri, Sp.PD	RST	PRO HD dan Perawatan lebih lanjut	1	Tidak
13	TN. ALI MUSTOFA	IGD	B24, syok sepsis	dr Elvi, Sp.P	RSUD Lawang	Pro Ruang isolasi HIV	1	Tidak
14	TN. KASTANI	IGD	prolaps recti	dr. Zaki Sp. B	RSSA	Pro Tatalaksana lebih lanjut dan backup HD	2	Tidak
15	Tn. Tulus	IRNA	Hidrocephalus non comunicans ec susp SOP	dr. Farid, Sp. N	RSUD Lawang	Pro VP Shunt	2	Tidak
16	Ny. Marinem	IGD	COS susp fracture kompresi temporal D, Vulnus Appertum regio Parieto-occipita	dr. Anton, Sp. B	RS Karsa Husada	Pro trepanasi	2	Tidak
17	Ny Srianah	IGD	DOC dd CVA ICH + IVH, HT emergency	dr Farid Sp S	Rs Unisma	pro Evakuasi dan pasang VP shunt	1	Tidak
18	Tn Marsan	ICU	STEMI INFARO LATERAL, RV INFARK ONSET <12 jam post FIBRINOLITIK	dr Mira SP JP	RS UMM	pro PCI	1	Tidak
19	An. Zaina Aqila Yasmine	IGD	CKR 456, Fraktur kompresi os frontalis, CF os humerus dextra	dr Sigit Sp BS	RS Karsa Husada	pro penanganan lebih lanjut	1	Tidak
20	Tn. Sumarlan	IRNA	SAH, IVH, Hematemesis, bacterial Infection, Post DOC	dr. Farid, Sp. N, Raber dr. Ard hany, Sp. PD	RST dr. Soepraoen	Pro VP Shunt	3	Tidak
21	Sdr. RADITYA ARSYA AKMAL PUTRA	IGD	COS, EDH	dr. Andi, Sp. B	RSSA	Penangan lebih lanjut (Bedah Saraf)	2	Tidak
22	TN.	IRNA	Colic Abdomen dt	dr. Ard hany,	RSSA	Penangan lebih	2	Tidak

	SOEWARNO		Hepatoma, Liver Failure	Sp. PD		lanjut		
23	MUHAMMAD BAQIR	IGD	COS 345 + Open Fracture Os Nasale, Maxilla, Zygomaticum Dextra et Sinistra + Susp. Blowout Fracture + Susp. Fraktur Basis Cranii Fossa Anterior, Vulnus Laceratum Brachii Sinistra	dr. Sigit, Sp. BP	RS Wava Husada	Penangan lebih lanjut (Bedah Saraf)	2	Tidak
24	PRAPTIANI	ICU	DOC, Hiperglikemia dt DM type 2, AKI dd A CKD, mild ARDS, HT emergency	dr. Aji, Sp. PD	RSUD Lawang	PRO HD	2	Tidak
25	Ny. TJONG SUI LAN	IRNA	, abses perirenalfistel uretrokutan	dr. Pradana,Sp. U	RSSA	Tatalaksana lebih lanjut pro RPG Dextra + DJ Stent Dextra + Drainage Abses	2	Tidak
26	*HAFIDZ *	IGD	COB susp EDH	dr. Andi, Sp. B	RST dr. Soepraoen	Penangan lebih lanjut	2	Tidak
27	Mega Intanadias Calista	ICU	KAD, DM type 1	dr. Ardhi, Sp. PD	RSSA	pro penanganan lebih lanjut	2	Tidak
28	Tn. Bambang Hariono	IRNA	DM HIPOGLIKEMIA, HIPONATREMIA	dr. Ardhany, SP. PD	RSJ Lawang	Pro perawatan SpPD- KGEH	8	Tidak
29	WINNI ARTI	IRNA	ACUTE ON CKD ST V, UREMIC GASTROPATY	dr. Ardhi, Sp. PD	RSSa	pro HD	2	Tidak
30	Netty Tjatur Rini	ICU	AVM, ARDS, Pneumonia Aspirasi, pneumonia VAP, Transaminitis, Anemia Post koreksi, Hipokalemi post koreksi	dr. Heru, Sp. An	RSSA	PRO DSA	10	Tidak
31	Nanik	IGD	G2 P1001 Ab0 UK 26-28 Mg T/ H dg Eklamsi, BSC	dr. Aida, Sp. OG	RSSA	PRO penatalaksanaan Eklamsi lebih lanjut	1	Tidak
32	DIAN NIHAYATTUL	MTS	Post SC Hari ke - 9, Asites, Dipsneu, Anemia	dr. Humaira, Sp. OG	RSSA	PRO penatalaksanaan lebih lanjut	2	Tidak
33	TN. SUJITNO	IGD	STEMI INFERIOR, Junctional rhythm	dr. Yoga, Sp. JP	RSI AISYAH	Pro PCI	2	Tidak
34	ny. Miftahul jannah	IRNA	DM hiperglikemia + abses perirenal Dextra dd ca Renal	dr. pradana sp.u konsul dr.ardhani sp.pd	RSSA	Pro CT- Scand + Drainage abses	3	Tidak
35	Sdr. Muhammad Fawwas Rega Madani	IRNA	Ileus Obstruktif	dr. Zaki, Sp.B	RSUD. Dr. Soetomo	PRO Penatalaksanaan lanjutan	1	Tidak
36	Tn. Parto	ICU	CKD st V, Pneumonia	dr. Ardhany, Sp. PD	RS Lavalette	Pro HD	3	Tidak
37	Tn. SUBANDI	IRNA	Acute on CKD	dr. Ardhi, Sp. PD	RS Lavalette	Pro HD	2	Tidak
38	Tn. DARMAJI	ICU	CVA ICH	dr Dewi, Sp.S	RS Karsa Batu	Pro Evakuasi ICH	1	Tidak
39	Ny ROBANAH	IGD	Syok kardiogenik	dr. Mira Sp,JP	RS UMM	Pro PCI	2	Tidak
40	Ny UMUL HAYATI	IRNA	Abdominal mass + Decreased of BW + Multiple nodul hepar + Suspect metastatic process dt intraluminal mass dd ekstraluminal mass dd cholangiocarcinoma	dr. Aji Sp pd	RSSA	perawatan lebih lanjut dan evaluasi kondisi keganasan (perlu khom)	4	Tidak
41	Ny SOLIKATIN	IGD	STEMI anterior Luar	dr. Yoga, Sp. JP	RSSA	pro PCI	1	Tidak

42	Ny. Suramah	IRNA	Colangitis, DM Jaundice, CKD st III	dr. Ardhany, Sp. PD	RSSA	Pro explore CBD	6	Tidak
43	Tn Solikin	ICU	DOC dt Uremic Ensohalopati ,AKI, DM	dr. Aji, Sp. PD	RSSA	Pro HD	5	Tidak
44	By. Ny. Rusda Fauziah	NEO	RDS, Pneumonia, NEC, Prematur, BBLR	dr Fiona Sp A	RS Lavalette	Pro Ventilator	3	Tidak
45	Ny Sumarni	IGD	CKD, ADHF, DM Hiperglikemia	dr Aji Sp PD	RSSA	Pro HD	2	Tidak
46	An. Octavia Kartika Chandra	IGD	SDH Frontal D	dr. Anton, Sp. B	RS Karsa Husada Batu	Perawatan lebih lanjut	2	Tidak
47	Tn Paimin	IRNA	tumor cerebellum + hidrocephalus non communicans	dr. Farid, Sp.N	RSUD Lawang	PRO VP SHUNT	2	Tidak
48	Tn. Achmad Rifai	IGD	DOC ec CVA IVH+ICH	dr. Farid, Sp.N	Rs Unisma	Pro evakuasi hematome	2	Tidak
49	Nadia Marinka Oktavani	IKO	Abdominal pregnancy	dr. Aida, Sp. OG	RSSA	pro penanganan lebih lanjut	1	Tidak
50	WIJI SANTOSO	IGD	STEMI anterior extensive, Sup. Acute Stent Thrombosis	dr. Yoga, Sp. JP	RSSA	Pro PCI	1	Tidak
51	Ny. MUDAYANAH	IGD	Doc dd susp Stroke ICH	dr. Farid, Sp.N	RSSA	Pro Evakuasi Hematome	1	Tidak
52	Sdr. Yoga Kurniawan	IRNA	Susp fistula enterovesica impending fistula enterocutan/vesicocutan, Urosepsos	dr. Pradana, Sp.U konsul dr. Anton, Sp.B	RSSA	Pro tatalaksana lebih lanjut	3	Tidak
53	By ny siti ulifah	NEO	Atresia ani tanpa fistel, undesensus testis	dr. Fiona, Sp. A	RSSA	Pro tindakan bedah	1	Tidak
54	Ny. Kasiyati	IRNA	DM type 2 hiperglikemi, 2. Jaundice + AKI+ Trombositopeni + leukositosis dt probable weils disease	dr Aji Sp PD	RSSA	Pro Penatalaksanaan lebih lanjut (Pertimbangan HD)	5	Ya
55	Tn. Bashori	IRNA	Anemia NN related malignancy	dr. Aji, Sp.PD	dr. Aji, Sp.PD	Pro Penatalaksanaan lebih lanjut	2	Tidak
56	Tn. PUJI LESTARI	IGD	STEMI	dr Yoga Sp JP	RS UMM	Pro PCI	1	Tidak
57	ny. YUNI SUGIASTUTI	ICU	AKI dd Akut, HHD, DM Tipe 2	dr Aji Sp PD	RS Lavalette	Pro HD	2	Tidak
58	Tn. SARTO	IGD	Necrotizing facitis pedisdextra, syok sepsis, AKI dd ACKD, Krisis Hiperglikemia	dr Andi Sp B	RSSA	pro penanganan lebih lanjut	1	Tidak
59	Tn. REZA	IGD	PCP, B20, TB Paru, ADHF, HT	dr Elvi Sp P	RSSA	Pro pengobatan ARV	2	Tidak
60	Tn. TONDO SUTRISNO	IRNA	CVA Infark, Hemiparese Dextra, Pneumonia	dr Farid Sp S	RS Karsa Husada	Pro Backup Venti	6	YA

Analisis :

- Terjadi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan April 2025.
 Pada bulan februari 2025 sebanyak 46 pasien pada bulan Maret 2025 yaitu 46 pasien Sedangkan pada bulan April 2025 sebanyak 60 pasien
- Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - Pro PCI
 - Pro CVCU
 - Pro stroke unit
 - Pro HD
 - Pro Bedah digestif
 - MRI
 - Pro bedah saraf lanjutan

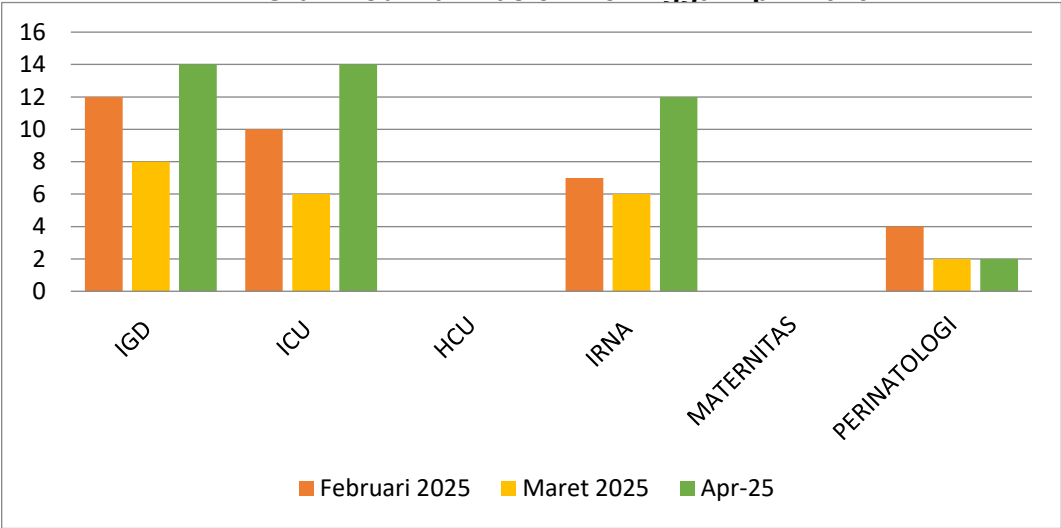
- h) Membutuhkan alat khusus
- i) Membutuhkan pengobatan ARV
3. Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya.
Pada bulan Maret 2025 sebanyak Rp. 963.726 sedangkan pada bulan April 2025

- Rencana Tindak Lanjut:
1. Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
2. Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan April 2025

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1.	IGD	12	8	14
2.	ICU	10	6	14
3	HCU	0	0	0
4.	IRNA	7	6	12
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	NEONATOLOGI	4	2	2
Total		17	33	22

Grafik Jumlah Pasien Meninggal April 2025



Tabel Rincian Pasien Meninggal April 2025

NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP
1	Ny. Mudjiati	IGD	Dyspneu ec ALO	dr Mira, Sp.JP
2	By. Ny. Ketiana Gandaimu	NEO	G2P1000Ab0 uk 18-20 mgg dengan abortus inkomplet	dr. Humaira, Sp. OG
3	Tn RAMAT	IGD	DOC susp CVA Hemoragic	Dr.San
4	Sdr.Agustinus Wuri Wardana	ICU	STEMI anteroseptal New Onset + TF	Dr.andy,Sp.P
5	Tn. Kristian Cahya Susilo	IRNA	UAP, Hipokalemia berat, Electrolit inbalance, ADHF, selulitis pedis dextra	dr. Ira, Sp. JP
6	Ny Siti urifah	ICU	CVA Infark, Respiratory failure, DM Tp 2	dr Farid Sp S
7	Ny. SUPRIYATIN	IGD	PEA	dr Endra
8	Tn Sugiono	IRNA	Peritonitis susp Perforasi Gaster dengan	dr. Anton, Sp. B

			Pengotoran Lien post Laparatomy, Repair Gaster	
9	Tn HERU SUHENDRO	IGD	DOA	dr. Yeni
10	Ny. SUKEMI	IGD	DOC	dr. Yeni
11	Ny Sri Asnanik	ICU	CVA Emboli, AF RVR, CAD, ISK, DM	dr Yoga SP JP
12	Tn SUHUD ABDUL MAJID	IGD	DOA	dr. Isrotul
13	Tn. Laminto	IRNA	Ileus Obstruktif, CHF, AKI	dr. Mira, Sp. JP
14	Ny. Samini	IRNA	Post Laparatomy Peritonitis ec perforasi	dr. Anton, Sp. B
15	N. MOCH NOVI ARINSA	IGD	COB, Multiple fracture	dr. Endra
16	TN. ERVAN WAHYU BUDIARTO	IGD	COB, SUSP CF FEMUR D ET S	dr. Shafira`
17	Ny. Dianita	ICU	CVA ICH , HT	dr. Farid, Sp. N
18	Tn. Moh. Khisbul Maulana	ICU	Tumor Otak	dr. Dewi, Sp. N
19	Tn. Chotimah	ICU	DOC dd HHS dd HHD, DM hiperglikemia	dr. Aji, Sp. PD
20	NN. AHMADA ANANDIRA MATIN	IGD	SYOK HIPOVOLEMIK DD SYOK CARDIOGENIK	dr. Ardhi, Sp. PD konsul dr. Yoga,Sp. PD
21	Ny Tumik Asih	IRNA	Dm gastropati	dr. Heri sp PD
22	Tn Fariyadi	IRNA	ckd st 4	dr. ardhani, Sp.PD
23	Tn. Abd Rohman	ICU	AKI	dr.Aji.,Sp.PD raber dr. ira Sp.JP
24	TN. NGATARI	IGD	ADHF	DR. YOGA, JP
25	an. MUHAMMAD SYIFA	IRNA	Anemia	dr Dicky Sp A
26	Ny.UMI SUCIATI	IGD	DOC dt Extracranial dd Intracranial	dr. ardhani, Sp.PD
27	Tn. Mansur Yusuf	IRNA	Ileus paralitik	dr. Zaky, Sp. B
28	Tn. Hadi Suklisno	ICU	Post Op debridement, CKD	dr. Anton, Sp. B
29	Tn. Sumali	ICU	CVA Infark, ARDS	dr. Dewi, Sp. N
30	Ny. Senah	IRNA	Melena	dr. Aji, Sp. PD
31	Tn. soebroto	ICU	Respiratory failure, ARDS, CVA Infark	dr. Dewi, Sp. N, dr. Robby, Sp. An - TI
32	Ny. Endang Sukemi	IGD	Cardiogenik Shock	dr Ira Sp JP
33	Tn. Sujiono	ICU	SOP Cerebri Supratentorial dt susp Tumor Cerebri Primer	dr Fahimma, Sp.N
34	Ny. ANNA YASMIN	IGD	Doc, CVA ICH	dr. Farid Sp.S
35	Tn. Sariman	IRNA	ILEUS OBSTRUTIF POST LAPARATOMY	dr. Anton, Sp. B
36	Ny. Suryanita	ICU	DOC, DM	dr. Heri sp PD, raber dr. Dewi,. Sp. S
37	NY. SITI RAHAYU	ICU	RF, HT Urgency	dr. Ardhany Sp. pd raber dr. Robby Sp.An
38	By. Ny. Luluk Nur Khanifah	NEO	Imatur, BBLASR, Gemeli	dr Humaira Sp OG
39	Ny. Sulikah	ICU	Doc, Uremi encephalopati	dr. Aji, Sp. PD
40	Ny. Nur Mujiati	IRNA	ANEMIA	dr. Ardhany Sp. pd raber dr. Robby Sp.An
41	By. Graciela Elora	IGD	DOA	
42	TN. ALI BAWON	IRNA	ckd hiperkalemia	dr. Ardhany Sp. pd raber dr. Robby Sp.An

Analisa :

1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan April 2025 sebanyak 42 pasien

- 2. Jumlah terbanyak yaitu dari IGD : 14 pasien, ICU : 14 pasien, IRNA 12 pasien, dan Neonatologi sebanyak 2 pasien.
- 3. Pada bulan April 2025 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 3 kasus.
- 4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.6 Laporan MPP

3.5.7.6.1 Tabel Rekap Berdasarkan Skrining Pasien

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN	BULAN / JUMLAH		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	Usia lanjut	-	-	-
2	Kasus penyakit kronis / terminal katastropik	-	-	-
3	Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll)	-	-	-
4	Perkiraan biaya tinggi	-	-	-
5	Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi)	-	-	-
6	Pasien dengan fungsi kognitif rendah	-	-	-
7	Potensial komplain tinggi	-	-	-
8	Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat	-	-	-
9	Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya	-	-	-
10	Berisiko membutuhkan kontinuitas pelayanan	-	-	-
11	Berpotensi masalah hukum	-	-	-
12	Naik kelas pelayanan	-	-	-
13	Lain - lain	-	-	-

3.5.7.6.2 Tabel Jumlah Lain-Lain (Permasalahan Cara Bayar)

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN LAIN-LAIN (PERMASALAHAN CARA BAYAR)	BULAN / JUMLAH		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	Habis PKS	-	-	-
2	BPJS status Denda	-	-	-
3	BPJS status Premi	-	-	-
4	BPJS status Denda dan Premi	-	-	-
5	BPJS staus Usia lebih dari 21 tahun	-	-	-
6	BPJS status keluar atas kemauan sendiri	-	-	-
7	BPJS status penangguhan pembayaran	-	-	-
8	Rencana pengurusan BPJS	-	-	-
9	BPJS status tidak ditanggung	-	-	-
10	BPJS tidak aktif akhir bulan	-	-	-
11	BPJS peralihan Mandiri ke PBI	-	-	-

3.5.8 Cleaning Service

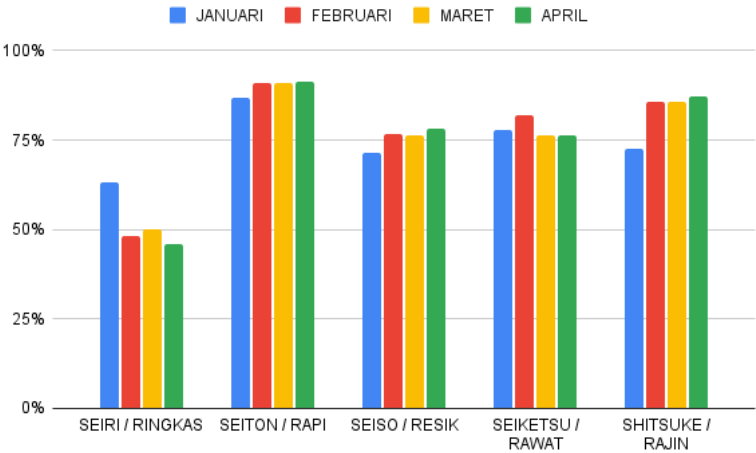
3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

KATEGORI	DESKRIPSI
Seiri	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
Seiton	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas Cs
	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas CS
Seiso	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
Seiketsu	Mematuhi Sop Kebersihan

	Mematuhi SOP Kebersihan
Shiketsu	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan

3.5.8.2 Tabel Produktifitas *Cleaning Service*

NO	JENIS SPV	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
1	SEIRI / RINGKAS	63%	48%	50%	50%
2	SEITON / RAPI	87%	91%	91%	91%
3	SEISO / RESIK	71%	77%	76%	76%
4	SEIKETSU / RAWAT	78%	82%	76%	76%
5	SHITSUKE / RAJIN	72%	86%	86%	86%



Analisa :
 Produktifitas Unit CS dalam penilaian ini masih dalam moneyv karena memakai instrument supervise yang baru. Hasil masih fluktiatif dan salam relative baik.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

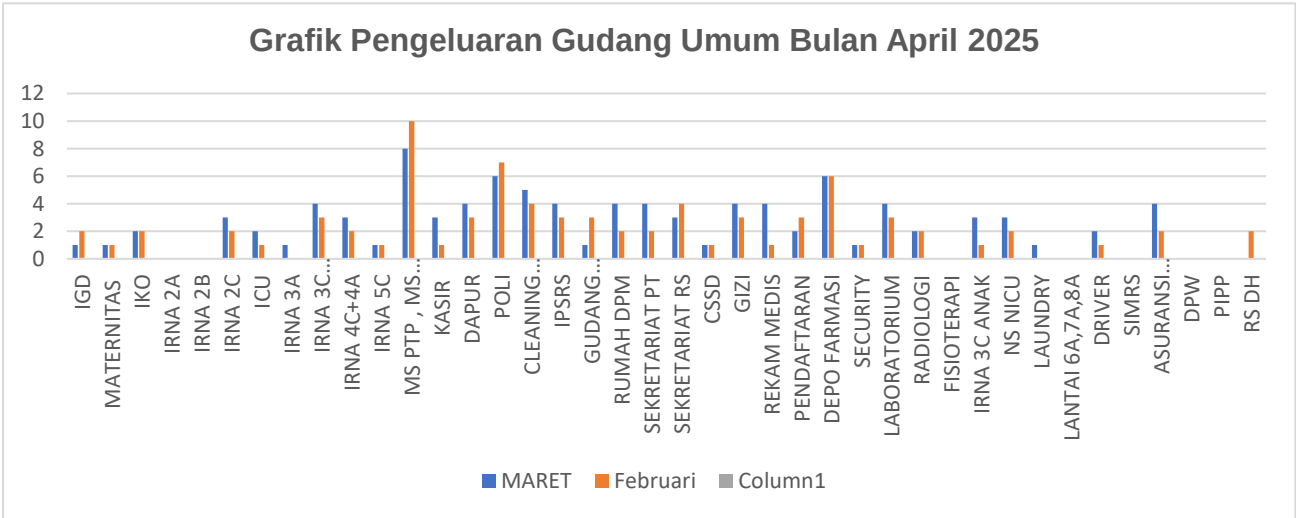
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT ASAL	JUMLAH BARANG		PERSENTASE
		MARET	APRIL	
1	IGD	1	2	↑50%
2	MATERNITAS	1	1	↓0%
3	IKO	2	2	↑0%
4	IRNA 2A	0	0	↓0%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	3	2	↓-50%
7	ICU	2	1	↓-100%
8	IRNA 3A	1	0	↓0%
9	IRNA 3C DEWASA	4	3	↓-33,33%
10	IRNA 4C+4A	3	2	↑-50%
11	IRNA 5C	1	1	↓0%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	8	10	↑20%
13	KASIR	3	1	↓-100%

14	DAPUR	4	3	↓ -33,33%
15	POLI	6	7	↑14,28%
16	CLEANING SERVICE	5	4	↓-25%
17	IPSRs	4	3	↓-33,33%
18	GUDANG FARMASI	1	3	↑66,66%
19	RUMAH DPM	4	2	↓-100%
20	SEKRETARIAT PT	4	2	↓-100%
21	SEKRETARIAT RS	3	4	↑25%
22	CSSD	1	1	↓0%
23	GIZI	4	3	↓-33,33%
24	REKAM MEDIS	4	1	↓-100%
25	PENDAFTARAN	2	3	↑33,33%
26	DEPO FARMASI	6	6	↓0%
27	SECURITY	1	1	↑0%
28	LABORATORIUM	4	3	↓-33,33%
29	RADIOLOGI	2	2	↑0%
30	FISIOTERAPI	0	0	↓0%
31	IRNA 3C ANAK	3	1	↓-100%
32	NS NICU	3	2	↓-100%
33	LAUNDRY	1	0	↑0%
34	LANTAI 6A,7A,8A	0	0	↓0%
35	DRIVER	2	1	↓-100%
36	SIMRS	0	0	↓0%
37	ASURANSI CENTER	4	2	↓-100%
38	DPW	0	0	↓0%
39	PIPP	0	0	↑0%
40	RS DH	0	2	↑100%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang Berdasarkan Asal Unit



Analisis :

Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara sehat dan,Depo Farmasi

Rencana Tindak Lanjut :

1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.6 Komite dan Tim

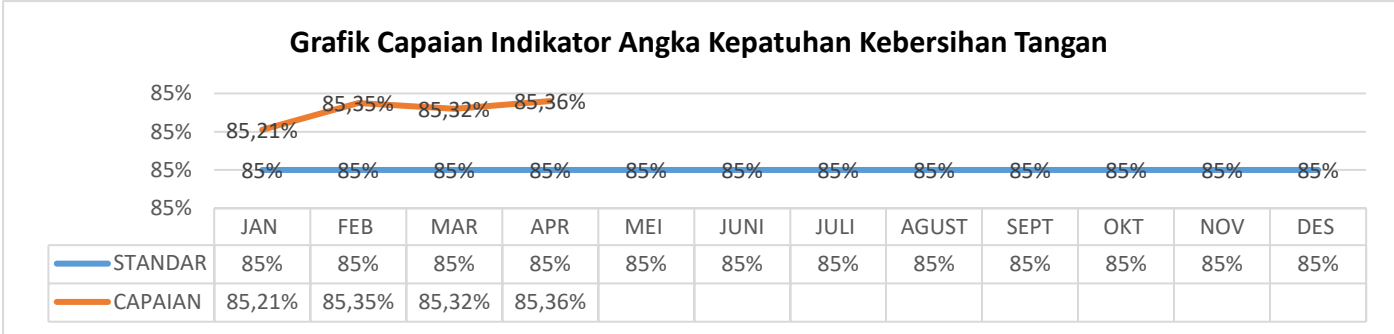
3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%									85,29%
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,22%									93,05%
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%									99,74%
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%									100%
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	89,16%	89,38%	99,1%	98,21%									92,54%
6.	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%									0%
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	75,9%	76,21%	74,93%	74,19%									75,68%
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%									98,07%
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%	100%									100%
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	100%	100%	100%	100%									100%
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	99,75%	98,64%	99,1%	99,44%									99,16%
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	99,92%	100%	100%									99,97%
13.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%	99,88%									99,86%

3.6.1.1Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



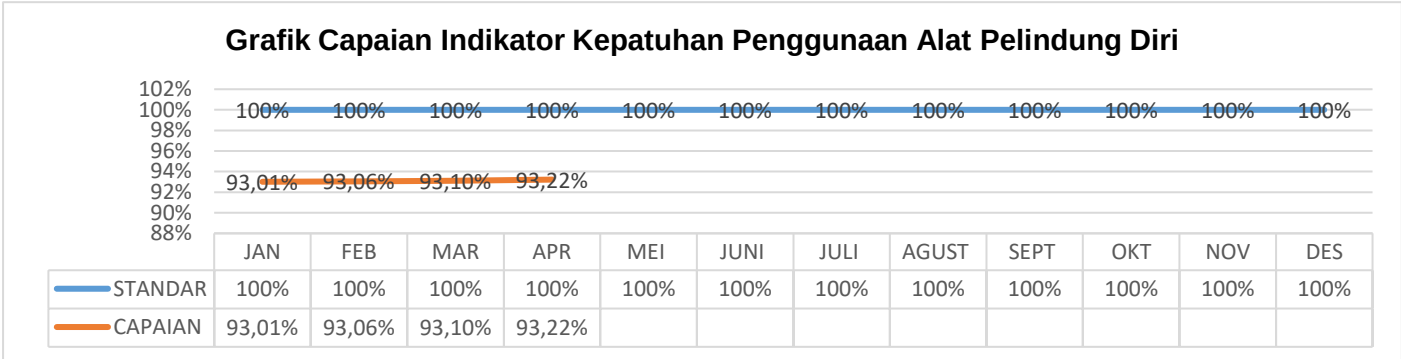
Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capian di bulan Maret yaitu 85,32% dan capaian di bulan April yaitu 85,36%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin hingga 100%.				
DO	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.				
STUDY	Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35% dan capian di bulan Maret yaitu 85,32%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu	Satu bulan

			3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	4. IPCLN/PCN	
--	--	--	--	--------------	--

3.6.1.1.1 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

3.6.1.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



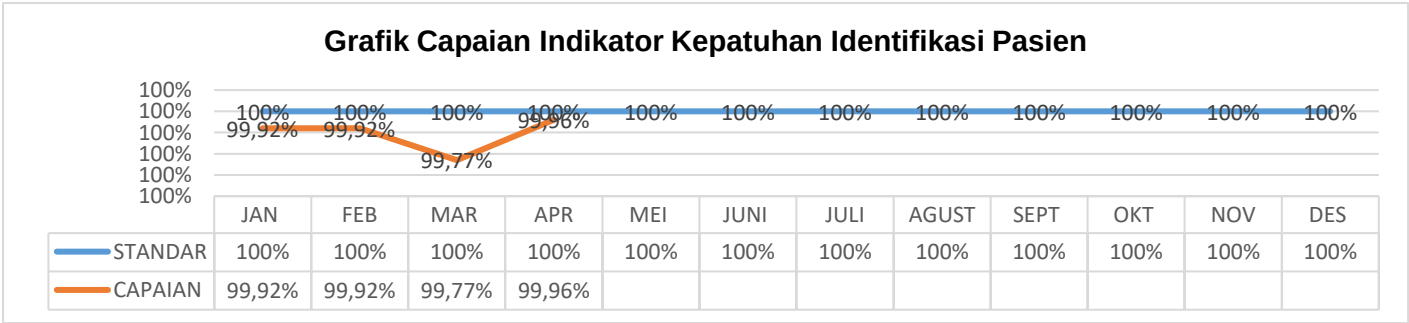
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung alat pelindung diri pada bulan Januari hingga April Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin hingga 100%.
DO	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter. 6. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart. Capaian di bulan Januari tahun 2025 yaitu 93,01%, bulan Februari sebesar 93,06%, bulan Maret sebesar 93,1% dan capaian di bulan April 93,22% dengan rata-rata 93,09%. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas perawat yang memakai APD tidak sesuai dengan jenis tindakan dan transmisi penyakit, misalnya

	seperti injeksi lewat selang infus / hanya TTV ke pasien non infeksi namun menggunakan handscoon. Kepatuhan APD petugas dapur terutama pengolah makanan masih sangat kurang terutama penggunaan masker. Untuk petugas medis, masih ditemukan DPJP yang masih menggunakan handscoon meskipun hanya visite tidak melakukan tindakan. Untuk petugas CS ditemukan masih menggunakan handscon medis untuk mengepel yang seharusnya menggunakan handscoon kerja.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	1. Berkolaborasi dengan IPCD untuk melakukan edukasi terhadap para DPJP. 2. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 3. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 4. Berikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 5. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 6. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

3.6.1.1.2 Kepatuhan Identifikasi Pasien

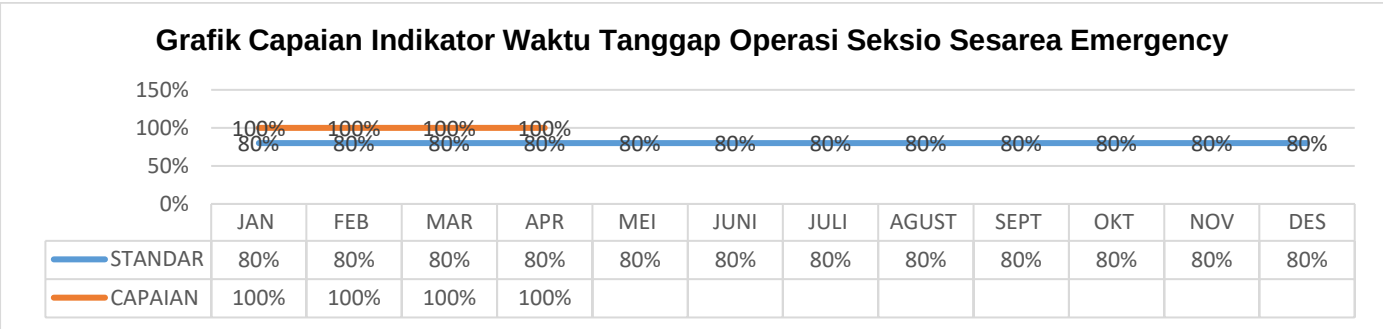
3.6.1.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pas



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari hingga April Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart dengan capaian bulan Januari tahun 2025 yaitu 99,92 %, bulan Februari sebesar 99,92%, bulan Maret sebesar 99,77% dan capaian di bulan April yaitu 99,96%. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

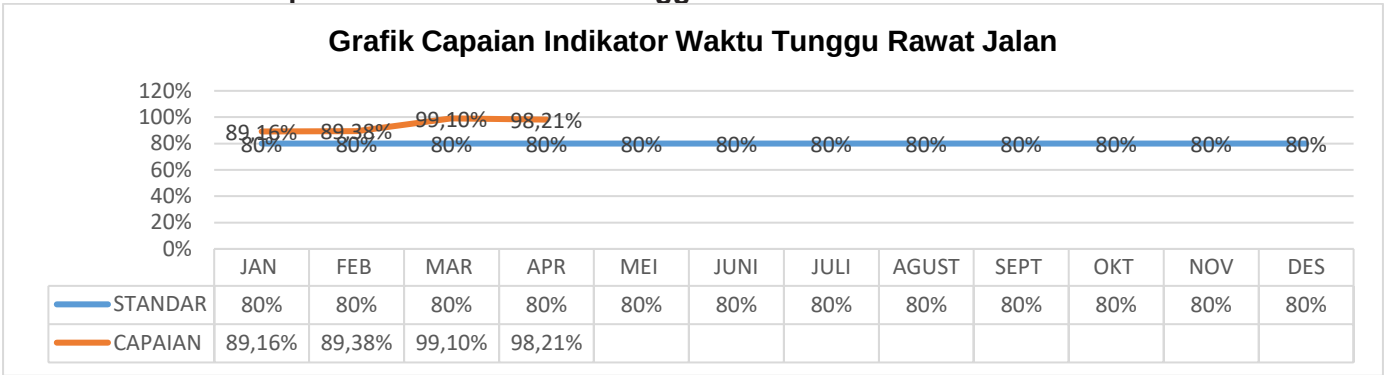
3.6.1.1.3 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Dari grafik indikator waktu tanggap SC emergency bulan Januari hingga April tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergency. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Waktu Tunggu Rawat Jalan

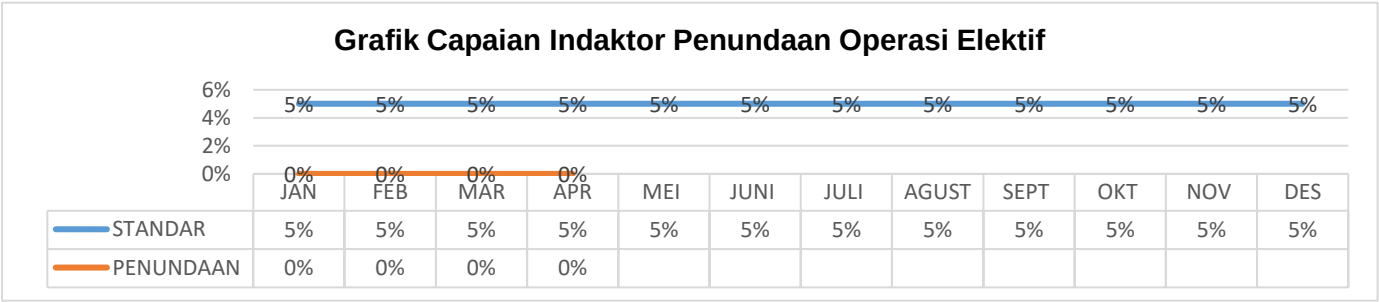
3.6.1.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Berdasarkan grafik capaian indikator waktu tunggu rawat jalan pada bulan Januari Tahun 2025 capaian telah mencapai standart dengan capaian 98,16%, capaian di bulan Februari 89,38%, capaian di bulan Maret 99,1% dan capaian di bulan April 98,22%. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara manajemen dan juga DPJP yang sudah berusaha datang tepat waktu dan evaluasi berkelanjutan yang telah dilakukan manajemen terhadap keterlambatan DPJP. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dibulan berikutnya.

3.6.1.1.2 Penundaan Operasi Elektif

3.6.1.1.6.1 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

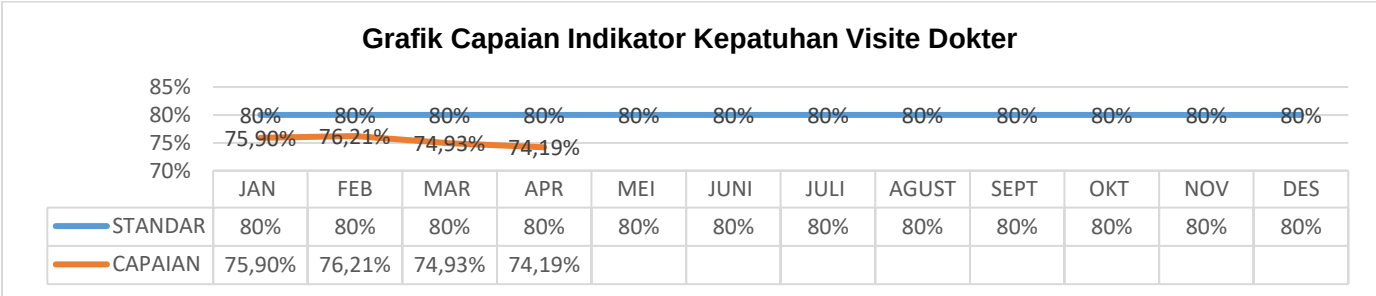


Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Januari hingga April tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 0%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

3.6.1.1.3 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

3.6.1.1.7.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter

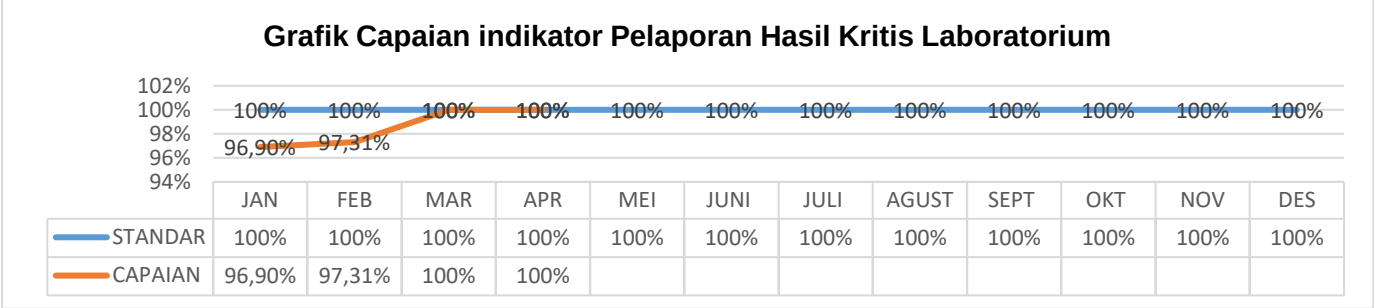


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite Dokter pada bulan Januari hingga AprilTahun 2025 belum mencapai standart, hal ini disebabkan karena Seluruh dokter Klinisi di Rumah Sakit Prima Husada adalah dokter tamu dari luar, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan masukan pada SDM dan Kabid pelayanan untuk melakukan rekrutmen home dokter lebih banyak				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 75,9%, capaian di bulan february yaitu 76,21%, capaian di bulan Maret yaitu 74,93% dan capaian di bulan April yaitu 74,19%. Dari hasil supervisi didapatkan nya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS asal karena RS Prima Husada belum memiliki dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr. dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og, dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr. dr. Aji, Sp.PD. Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu), dr. Ardani, Sp.DP (tidak menentu)				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Melakukan KIE dan komunikasi dengan DPJP terkait waktu visite dokter, hal ini menjadi PR yang cukup besar bagi tim mutu dan manajemen karena sebagian besar DPJP tidak hanya bertugas di RS Prima Husada.	Manajemen RS	Satu Tahun

3.6.1.1.7.2 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

3.6.1.1.8.1 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

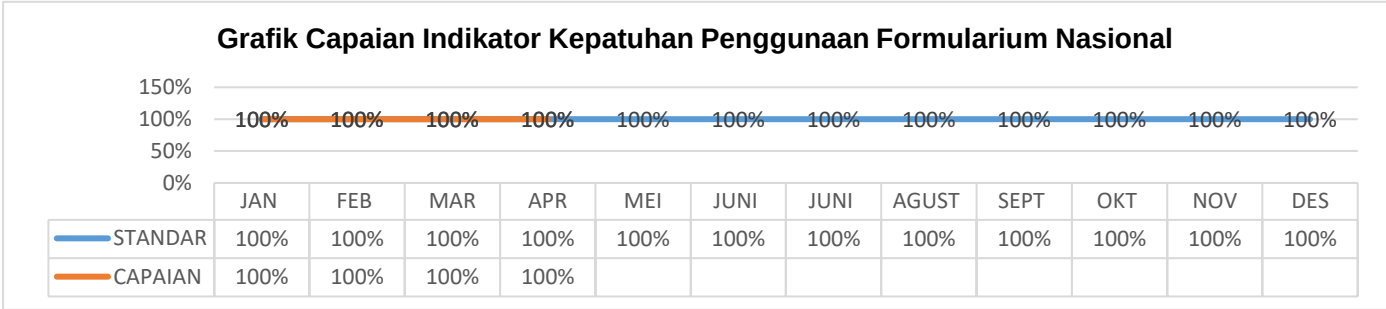


Berdasarkan grafik capaian indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium pada bulan Januari dan Februari Tahun 2025 diketahui capaian belum mencapai standart dan capaian meningkat hingga 100% di bilan Maret dan April. Capaian meningkat pada bulan Maret yang telah mencapai standart 100%.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 96,9% dan bulan Februari 97,31%. Capaian meningkat pada bulan Maret dan April yang telah mencapai standart 100%. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	1. Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor 2. Memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	1. Komite mutu 2. Kepala instalasi laboratorium	Satu Tahun

3.6.1.1.4 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

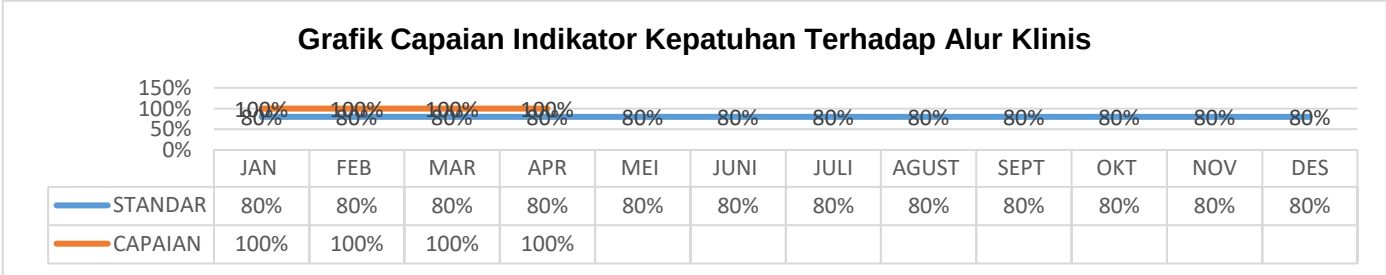
3.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Dari grafik indikator Formularium Nasional bulan Januari hingga April tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.6.1.1.5 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

3.6.1.1.10.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



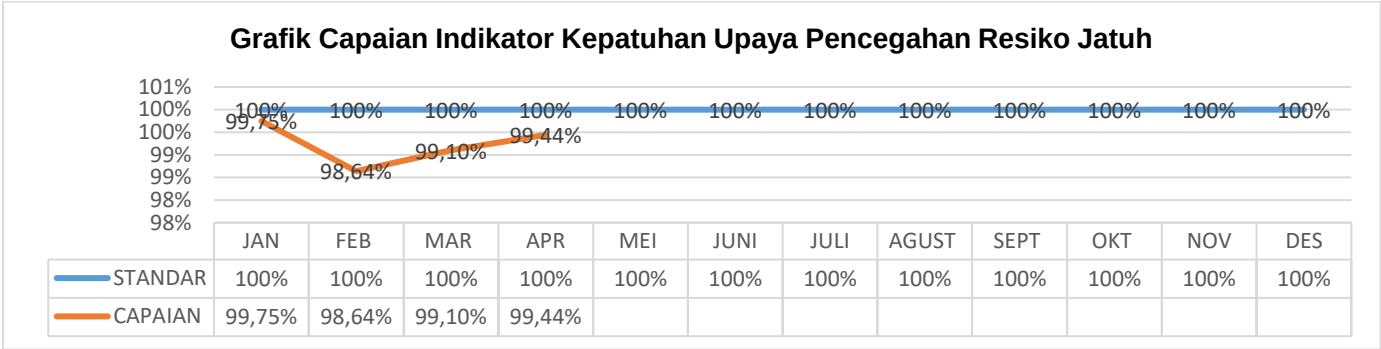
Dari grafik indikator kepatuhan terhadap alur klinis bulan Januari hingga April tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

Daftar Clinical Pathway Bulan April 2025

Diagnosa	Jumlah	Patuh	Tidak Patuh
DF			
CVA Infark			
Gastritis			
Batu Ureter			
DM			
GEA			
CHF			
FAM			
TB Paru			
HT			
CA Mammae			
HIV			
STEMI			
NSTEMI/UAP			
Pneumonia			
Sectio Caesarea	29		
Partus Normal	32		
Jumlah	61	61	

3.6.1.1.6 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.6.1.1.11.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

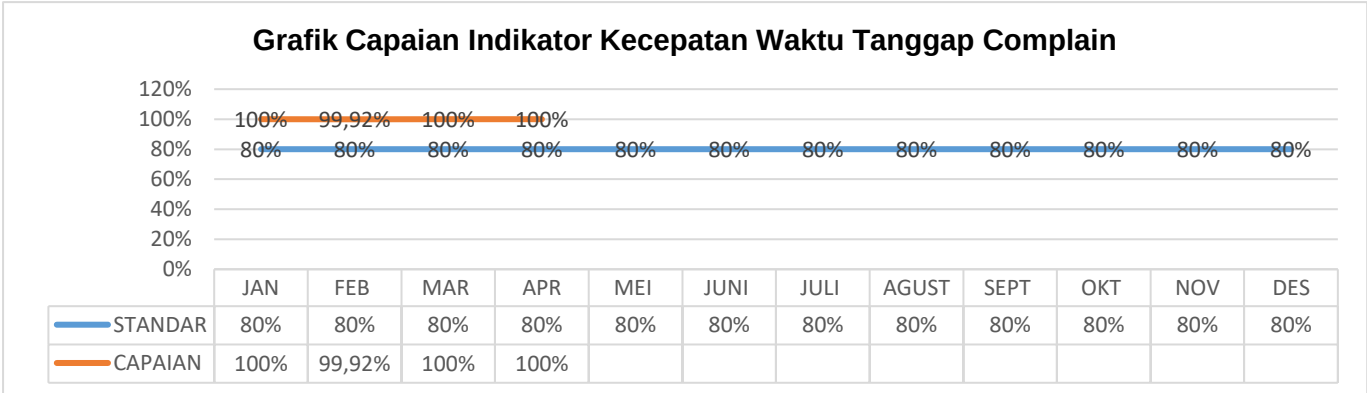


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Maret Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian yaitu 99,75%, capaian di bulan Februari yaitu 98,64%, capaian di bulan Maret yaitu 99,1% dan capaian di bulan April yaitu 99,44%. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	Melakukan supervisi berjenjang mulai dari PJ shift, kepala ruangan, kepala bidang keperawatan dan tim mutu guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu Bulan

3.6.1.1.7 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

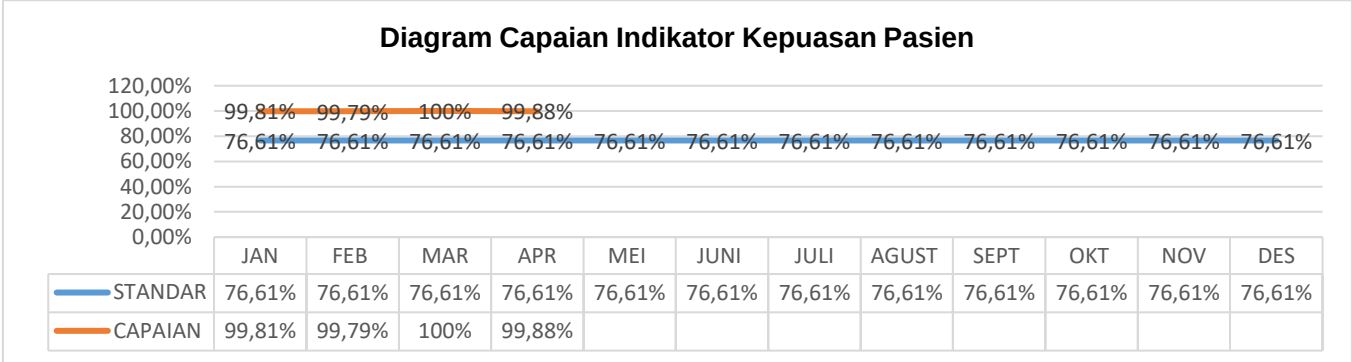
3.6.1.1.12.1 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Dari grafik indikator waktu tanggap komplain bulan Januari hingga April tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 80% dengan rata-rata 99,98%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait komplain yang diterima. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.12.2 Kepuasan Pasien

3.6.1.1.12.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Januari hingga April tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 76,61% dengan rata-rata 99.87%, meskipun belum mencapai nilai sempurna 100% tetapi capaian ini telah melebihi standart. Hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepuasan pasien . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%									99,74%
2.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	100%	99,55%	99,92%	99,73%	99,51%									99,73%
3.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi (IRNA,IGD,IKO)	100%	100%	100%	100%	100%									100%
4.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%									100%
5.	Kejadian Ketidaklengkapan Lembar Operan Pasien (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	0	0	0	0	0									0
6.	Angka Kelengkapan Penyiapan Dan Pengelolaan Obat Yang Perlu di Waspadai / High Alert (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%									100%
7.	Kepatuhan penyiapan, pengelolaan, pemberian sesuai standar obat elektrolit pekat (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%									100%
8.	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi Sesuai Prosedur (IGD,IRNA,IKO)	100%	100%	100%	99,57%	99,77%									99,85%
9.	Kepatuhan Pengisian Daftar Tilik Keselamatan Pasien Operasi (IKO)	100%	100%	100%	100%	100%									100%
10.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan) (IRNA,IRJA,IGD,IKO)	100%	98,64%	98,64%	99,32%	99,63%									98,86%
11.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh	100%	98,64%	98,65%	98%	99,44%									98,43
12.	Kepatuhan kebersihan tangan	85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%									85,29%

3.6.1.1.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis akut	100%	100%	100%	100%	100%									100%
2.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%	100%									100%

3.6.1.1.3 Tujuan Strategis

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%	99,98%									

3.6.1.14 Perbaikan Sistem

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kesesuaiaan Penarikan Data SIMRS Dengan Data Manual Pada Laporan Unit	100%	80,39%	81,69%	82,73%	87,5%									

1.6.1.2.5 Mutu Unit

1.6.1.2.5.1 Instalasi Gawat Darurat

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Batas waktu pasien menunggu tempat tidur kurang dari 6 jam (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	99,71%	99,7%									
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,2%	98,36%	98,37%	98,44%									
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%									
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
5.	Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%									
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%									
7.	Kepuasan pasien	85%	97,36%	97,29%	100%	98,2									
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%									
9.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%									
10.	Kepatuhan pelaporan pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%									
11.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%									
12.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis di IGD	100%	100%	100%	100%	95,43%									
13.	Angka tindak lanjut screening nyeri pasien di IGD	100%	100%	100%	100%	100%									
14.	Angka kepatuhan triage untuk penyakit menular di IGD	100%	100%	100%	100%	100%									
15.	Respon time IGD kurang dari 5 menit	100%	100%	100%	100%	100%									
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	4,65%	3,7%	2,38%	1,9%									
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%									

18.	Kepatuhan pemasangan gelang identitas pasien kurang dari 30 menit setelah pasien terdaftar rawat inap	100%	73,21%	73,32%	75,11%	100%									
19.	Kejadian merujuk pasien berdasarkan aspek pilihan pasien	0	0	0	0	0									
20.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%									
21.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, anak, remaja, risiko bunuh diri)	100%	100%	100%	100%	100%									
22.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%									
23.	Kegiatan merujuk pasien (horizontal)	0	1	4	3	2									

1.6.1.2.5.2 IRNA 2A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	-	-	-	-							
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	-	-	-	-							
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	5.	-	-	-							
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	-										
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	-	-	-	-							
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-							
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	-	-	-	-							
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	-	-	-	-							
9.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-							

10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	-	-	-	-							
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	-	-	-	-							
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	-	-	-	-							
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	-	-	-	-							
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	-	-	-	-							
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	-	-	-	-							
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	-	-	-	-							
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	-	-	-	-							
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	-	-	-	-							
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-							
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-							
21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	-	-	-	-							
22.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	-	-	-	-							

3.6.1.2.6.3 IRNA 3A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%									
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	92,8%	94,7%	95,23%	95,31%									
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	93,7%	94,5%	94,61%	95,22%									
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	90,6%	89,82%	92,22%	93,33%									
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-									
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	88,98%	100%	100%	100%									
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	88,98%	100%	100%	100%									
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%									
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	96,04%	100%									
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%									
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%									
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	97,93%									
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	95,48%									
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajenen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%									

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%									
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%									
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	0	-									
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	0	-									
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%									
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	95,31%	100%									
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0									
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%									
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	97,75%									

3.6.1.2.6.4 IRNA 4A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25		
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	98,74%									
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,72%	96,88%	97,12%	97,22%									
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,6%	96,9%	96,7%	97,8%									
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	88,98%	95,17%	96,38%	99,46%									
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-									

7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	97,14%	100%	89,11%	89,19%									
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	97,14%	100%	100%	95,15%									
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%									
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%									
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%									
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%									
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	95,38%									
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	90,75%									
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%									
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%									
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%									
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-									
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-									
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%									
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	98,06%	84,21%									

22.	Kejadian merujuk pasien (Hirizontal)	0	0	0	0	0								
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%								
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	96,32%								

3.6.1.2.6.5 IRNA 2C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%									
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,9%	97,5%	99,2%	99,31%									
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	95,8%	97,3%	97,8%	98,2%									
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	82,47%	80,15%									
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-									
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	94,07%	94,92%									
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	100%	100%									
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%									
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%									
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%									
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%									

13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	93,75%									
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%									
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%									
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%									
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-									
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-									
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%									
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%									
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0									
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%									
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%									

3.6.1.2.6.6 IRNA 3C ANAK

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%									
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,7%	97,1%	97,54%	97,57%									
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	94,8%	96,1%	96,19%	96,34%									
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	80,72%	100%	100%									
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-									
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	88,1%	100%	100%									
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	88,1%	100%	100%									
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%									
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%									
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%									
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%									
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%									
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajenen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%									

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%									
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%									
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0,43%									
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	100%									
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%									
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%									
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0									
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%									
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%									

3.6.1.2.6.7 IRNA 5C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	92,11%	98,95%									
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,6%	99,8%	99,7%	99,78%									
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,7%	99,1%	99,5%	99,62%									
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	99,61%									
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	80,68%	81,44%									

6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-									
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	100%	100%									
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	97,27%	99,51%									
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%									
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	98,71%	92,24%									
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%									
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	88,24%	100%									
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	97,47%									
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	75%	95,12%									
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	92,64%	98,88%									
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%									
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0,97%	1,06%	0,43%	0%									
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	-									
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%									

21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%									
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0									
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%									
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%									

3.6.1.2.6.8 IRNA 6A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%									
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,2%	90,3%	93,3%	93,7%									
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,1%	97,3%	97,1%	97,31%									
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	82,14%	78,72%	82,02%	68,31%									
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-									
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%									
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%									
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%									
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%									
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%									

12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%									
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%									
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%									
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%									
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%									
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,75%	0%	0,32%	0%									
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-									
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%									
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%									
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0									
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%									
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%									

3.6.1.2.6.9 IRNA 7A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%									
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,98%	93,4%	96,12%	96,16%									
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	87,24%	89,22%	92,33%	92,41%									
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	80,58%	63,95%	67,13%									
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-									
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%									
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%									
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%									
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%									
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%									
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%									
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%									
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajenen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%									

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%									
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%									
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,23%	0%	0,64%	0%									
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-									
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%									
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%									
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	1	1	0									
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%									
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%									

3.6.1.2.6. 10 IRNA 8A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agt'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%									
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	97,8%	99,8%	99,62%	99,64%									
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	92,1%	95,6%	95,71%	95,82%									
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	72,79%	82,52%	73,6%									
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-									

7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%									
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%									
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%									
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%									
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%									
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%									
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%									
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%									
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%									
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%									
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%									
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%									
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%									
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%									

22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0									
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%									
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%									

3.6.1.2.6.11 ICU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%									
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89.9%	95,5%	97,7%	97,8%									
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,2%	99,8%	99,6%	99,8%									
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,64%	97,81%	100%	100%									
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,72%	96,89%	100%	100%									
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	92%	93,2%	88,2%	100%									
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%									
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-									
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%									
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%									
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%									

12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%									
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%									
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0	0									
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-									
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%									
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	93,33%	100%									
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%									
21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	92,37%	100%									
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%									
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0									
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%									

3.6.1.2.6.12. HCU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%									
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	88,99%	96,22%	97,61%	98,17%									
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,5%	99,2%	99,36%	99,42%									
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,71%	98,92%	100%	100%									
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,21%	96,71%	95,32%	100%									
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	94%	97,1%	82,18%	100%									
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%									
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-									
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%									
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%									
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%									
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%									
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%									
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%									

16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0	0									
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-									
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%									
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	100%	100%									
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%									
21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%									
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%									
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0									
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%									

3.6.1.2.6.13 IRJA

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian medis rawat jalan (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	S									
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,2%	98,72%	99,02%	99,32%									
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,35	98,71%	99,24%	99,44%									
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	99,11%	100%									

5.	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%	89,16%	89,3%	99,11%	99,02%									
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%									
7.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%									
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%									
9.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%									
10.	Angka kelengkapan pengkajian keperawatan rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%									
11.	Ketepatan waktu jam praktek dokter	100%	78,92%	77,8%	72,59%	79,58%									
12.	Kejadian merujuk pasien	0	0	0	48										
13.	Angka kelengkapan inform concent	100%	100%	100%	100%	100%									
14.	Angka kelengkapan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%									
15.	Kelengkapan profil pasien rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%									

3.6.1.2.6.14 MATERNITAS

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kematian ibu (mutu prioritas unit)	0%	0%	0%	0%	0%									
2.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
3.	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%	100%									

4.	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	25,95%	24,56%	34,51%	39,04%									
5.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%	100%									
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%									
7.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%									
8.	Kejadian keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%	0%									
9.	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%	57,14%									
10.	Kejadian perdarahan post partum	0	0	2	5	4									
11.	Kejadian partus macet	0	0	0	13	8									
12.	Kejadian eklamsi	0	1	0	0	0									
13.	Kejadian pre eklamsi	0	5	2	4	4									
14.	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0	1									
15.	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%									
16.	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%									
17.	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	108	77	86	102									
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%									
19.	Kepuasan pasien	≥ 76,61	100%	100%	100%	100%									
20.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%									
21.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%									

22.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%									
23.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
24.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%									
25.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%									
26.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%									
27.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
28.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%									
29.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%									
30.	Angka kelengkapan pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%									
31.	Kejadian tidak dilakukan edukasi RSSIB pada pasien post partum dan post SC	0	0	0	0	0									
32.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%									
33.	Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir	0	0	0	0	0									

3.6.1.2.6.15 NICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian kematian bayi (mutu prioritas unit)	0	0	1	2	0									
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	98,31%	99,02%	99,45%	99,57%									
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,98%	99,79%	99,71%	99,74%									

4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	85,11%	85,51%	81,18%	84,09%									
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%									
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%									
8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%									
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%									
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%									
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%									
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%									
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%									
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%									
16.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%									
17.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%									
18.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%									

20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-									
21.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%									
22.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk NICU	100%	100%	100%	100%	100%									
23.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%									
24.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%									
25.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (neonatus)	100%	100%	100%	100%	100%									
26.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0									

6.6.1.2.6.16 PICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (Anak) (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%									
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,23%	99,44%	99,44%	99,61%									
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,11%	98,79%	98,79%	98,82%									
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	100%	100%	100%	100%									
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%									
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%									

8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%									
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%									
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%									
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%									
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%									
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%									
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%									
16.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
17.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%									
18.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-									
19.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%									
20.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk PICU	100%	100%	100%	100%	100%									
21.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	0%	-	-	-	-									
22.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%									
23.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0									

3.6.1.2.6.17 IKO

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian tidak dilakukannya skiren pada pasien operasi yg seharusnya diskiren (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0									
2.	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%	100%									
3.	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%									
4.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%									
5.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%									
6.	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	0	0	0									
7.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0	0									
8.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0	0									
9.	Kejadian tidak dilaksanakannya pengkajian pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0	0									
10.	Kejadian diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0	0									
11.	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0	0									
12.	Kejadian tidak lengkapnya pengkajian pra bedah	0	0	0	0	0									
13.	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0									
14.	Kejadian ketidaklengkapan form daftar tilik pasien operasi	0	0	0	0	0									
15.	Kejadian Ketidakpatuhan Prosedur Pasien Yang Menggunakan Implan	0	0	0	0	0									

16.	Kejadian ketidaklengkapan formular penandaan pasien operasi	0	0	00	0	0									
17.	Ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC	0	0	0	81,98%	19,84%									
18.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan inform consent	100%	100%	100%	100%	98,37%									
19.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis	100%	100%	100%	100%	100%									
20.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%	100%									
21.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%									
22.	Kepatuhan pencatatan pesan lewat telepon	100%	100%	100%	100%	100%									
23.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%									
24.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
25.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%									
26.	Kepatuhan pelaksanaan asesmen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%									
27.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%									

28.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%									
29.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
30.	Kelengkapan Asesmen pra sedasi dan pra anastesi	100%	100%	100%	100%	100%									

3.6.1.2.6.18 Laboratorium

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian ketidaktersediaan Reagen esensial di laboratorium (mutu prioritas unit)	0	0	0	3	0									
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
3.	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%									
4.	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan	100%	100%	100%	100%	100%									
5.	Survilen harian hemofiglen	100%	100%	100%	100%	100%									
6.	Angka kepatuhan Prosedur penggunaan produk darah	100%	100%	100%	100%	100%									
7.	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0	0									
8.	Waktu tunggu hasil laboratorium >140 menit	0%	0%	0%	0%	0%									
9.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%									
10.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%									
11.	Kepatuhan Pelaporan Kritis Gula Darah	100%	100%	100%	100%	100%									

12.	Angka kepatuhan pengelolaan POCT (proses pelaporan nilai kritis, kualifikasi)	100%	100%	100%	100%	100%									
13.	Waktu tunggu hasil laborat cito <30 menit	100%	100%	100%	100%	100%									

3.6.1.2.6.19 Radiologi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	97,88%	100%	100%	98,74%									
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	2,12%	3,54	5,5%	6,99%									
3	Kepatuhan pelaporan nilai kritis hasil radiologi <30 menit	0	0	0	0%	100%									
4.	Kepatuhan edukasi pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	99,49%									
5.	Angka kelengkapan inform consen pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	100%									
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%									
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%									

3.6.1.2.6.20 Gizi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian pasien baru tidak mendapatkan makan (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0									
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
3.	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	0	0	4	1									
4.	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0									
5.	Kelengkapan pengkajian gizi (awal dam lanjut)	100%	100%	100%	100%	100%									

6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,44%	99,67%	99,21&	99,42%									
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,01%	99,23%	98,92%	99,22%									

3.6.1.2.6.21 Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketersediaan obat obatan emergency (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%									
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%									
3.	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%									
4.	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	0	0	1	0									
5.	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0									
6.	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,85%	61,98%	74,45%	75,13%									
7.	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	48,68%	44,17%	59,59%	60,78%									
8.	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	1	0									
9.	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	2	0									
10.	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0									
11.	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	2	0									
12.	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0									
13.	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	20	13									
14.	Kejadian obat pasien rawat jalan yang tidak diambil	0	0	0	29	22									

15.	Kepatuhan penggunaan panduan antibiotik dan efektivitas jangka panjang dan jangka pendek	100%	100%	100%	100%	100%									
16.	Kepatuhan penyimpanan obat obatan emergency disimpan secara seragam	100%	100%	100%	100%	100%									
17.	Kepatuhan proses pengelolaan obat recal hingga pengembalian atau pemusnahan	100%	100%	100%	100%	100%									
18.	Angka Kepatuhan pengelolaan obat kedaluwarsa	100%	100%	100%	100%	100%									
19.	Angka Kepatuhan penyimpanan dan pengelolaan obat yang perlu di waspadi	100%	100%	100%	100%	100%									
20.	Kepatuhan penyimpanan, pengelolaan dan pemberian obat elektrolit pekat	100%	100%	100%	100%	100%									
21.	Angka Kepatuhan peresepan dan interuksi medis	100%	100%	100%	100%	100%									
22.	Angka kepatuhan dispensing	100%	100%	100%	100%	100%									
23.	Angka kepatuhan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%									
24.	Angka kelengkapan pencatatan efek samping obat	100%	100%	100%	100%	100%									
25.	Angka Kepatuhan Pelaporan Medication Error	100%	100%	100%	100%	100%									
26.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%									
27.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	93,10%	97,66%									
28.	Kepatuhan pelaksanaan panduan penggunaan single dose vial	100%	100%	100%	100%	100%									
29.	Kepatuhan penggunaan risk based approach monitoring penggunaan obat	100%	100%	100%	100%	100%									

30.	Angka kepatuhan pengkajian risiko penggunaan obat yang dibawa pasien dari rumah	100%	100%	100%	100%	100%									
-----	---	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.6.1.2.6.22 Pengadaan Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0%	0%	0,42%	0,24%									
2	Angka kepatuhan kolaborasi tim pengadaan obat	0%	0%	0%	100%	100%									

3.6.1.2.6.23 PPI

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,27%	0,29%	0,29%	0,48%									
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰									
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 %	0‰	0‰	0‰	0‰									
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 %	0‰	0‰	0‰	0‰									
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,21%	0,23%	0,23%	0,1%									
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%									
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%									
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,39%									
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	93,44%	93,21%	93,27%	93,42%									
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0									

3.6.1.2.6.24 PIPP

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%									

2.	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%									
3.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%									
4.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	1005	100%	100%									
5.	Kepuasan Pasien	76,61%	99,81%	99,79%	100%	99,88%									
6.	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	14,12	18,94%	16,09%%	16,89%									
7.	Angka Kepuasan Pasien BPJS	100%	99,9%	99,89	100%	100%									
8.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%									
9.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%									

3.6.1.2.6.25 SDM

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	0	0									
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	78%	98,51%	98,69%	98,79%									
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	37%	2,39%	1,91%	2,31%									
4.	Angka pemenuhan kompetensi sesuai dengan unit	100%	100%	100%	100%	100%									
5.	Angka kelengkapan file kepegawaian dimasing masing unit	100%	100%	100%	100%	100%									

3.6.1.2.6.26 Rekam Medis

No .	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap (mutu prioritas unit)	100%	91,86%	29,3%	35,83%	51,74%									
2.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda	0%	0,14%	0,23%	0,35%	0,47%									

3.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat jalan	100%	91,86%	70,8% %	98,04%	1,57%									
4.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien IGD	100%	100%	100%	90,25%	88,2%									
5.	Kejadian Kendala Pada SIMRS Dalam Upaya Menunjang Pelayanan Rekam Medis Elektronik	0	0	0	0	0									
6.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien Di SIMRS	100%	100%	100%	100%	100%									
7.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	7,56%	7,89%	9,56%	15,3%									
8.	Angka keterbacaan dokumen rekam medis	100%	100%	100%	98,17%	95,87%									

3.6.1.2.6.27 K3RS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%	100%	100%									
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	0	0	0									
3	Kejadian tenaga Kesehatan sakit akibat kerja	0	0	0	0	0									

3.6.1.2.6.28 Asuransi Center

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian dokumen rawat jalan tidak layak klaim	0	0	0	0	0									
2.	Angka pending klaim BPJS	0%	3,05%	2,54%	3,23%	3,23%									
3.	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	0,91%	1,9%	2,22%	2,18%									
4.	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	100%	98,99%	98,96%	99,26%	98,89%									
5.	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	1	2	0	0									

3.6.1.2.6.29 IPSRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	46%	65%	78%	61%									
2.	Angka keterlambatan respon dan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam (alat medis)	0%	97%	92%	94%	95%									

3.6.1.2.6.30 UMUM

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	7	8	7	2									
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	10	8	2	2									

3.6.1.2.6.31 Cleaning Service

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	47,5%	59,26%	23,53%	45%									
2.	Kejadian komplain Kebersihan Kamar Mandi	0%	0	0	0	0									
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	88,72%	91,33%	92,47	94,21%									
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	92%	94,07%	94,28	96,82%									

3.6.1.2.6.32 KESEKRETARIATAN

	No	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 4 setiap bulannya	0%	50%	40,48%	56,52%	50%									
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	27,27%	23,08%	31,82%	27,78%									
3	Angka tindak lanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	29,41%	29,41%	34,88%	34,78%									

3.6.1.2.6.33 Laundry

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	2,14%	1,78%	2,23%	1,32%									
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0	0									
3.	Kejadian Tercampur Benda Asing	0	0	0	1	1									
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	98,82%	99,32%	99,04%	99,22%									
5.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	97,23%	96,22%	96,48%	96,92%									

3.6.1.2.6.34 CSSD

No	Judul	Stan	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	0	0	0	0									
2	Kejadian instrument kurang	0	0	1	1	1									
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%									
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	96,77%	97,11%	97,88%	98,22%									

3.6.1.2.6.35 Humas dan Pemasaran

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kunjungan rawat inap >90 pasien perhari	100%	98,71%	98,71%	99,86%	79,78%									
2	Angka kunjungan rawat jalan >350 pasien perhari	100%	86,69%	93,82%	93,82%	79,81%									
3.	Angka kunjungan pasien rencana operasi 15 pasien perhari	100%	92,34%	91,22%	92,46%	76,14%									
4.	Angka kunjungan MCU dan vaksin 150 perbulan	100%	100%	98,82%	97,92%	72,67%									

1.6.1.2.6.36 IT

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian downtime	0	0	0	0	0									
2	Respon time penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%	100%	100%									
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%									

3.6.1.2.6.37 Kamar Jenazah

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%	100%	100%	0									
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	-	-	-	100%									
3.	Kepatuhan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	1005	1005	100%									

3.6.1.2.6.38 PKRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan pelaksanaan edukasi kelompok	100	53,26%	68,38%	78,88%	82,44%									

3.6.1.2.6.38 DRIVER

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Resptime Panggilan Driver < 10 menit On Side	100%	99,2%	99,68%	99,88%	100%									
2	Resptime Panggilan Driver < 30 menit On Call	100%	100%	99,92%	99,82%	98,88%									
3	Kepatuhan pemeliharaan alat transportasi	100%	100%	100%	100%	100%									
4	Angka kelengkapan alat emergency untuk ambulance emergency	100%	100%	100%	100%	100%									
5	Kepatuhan pelaksanaan decontaminasi pasca transport pasien menular pada ambulance	100%	100%	100%	100%	100%									

3.6.1.2.6.39 SECURITY

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya merokok, puntung rokok di lingkungan RS (mutu prioritas unit)	0	6	11	7	14									
2	Kejadian Barang Hilang Di Area Rumah Sakit	0	0	0	0	0									
3	Kejadian potensial barang hilang	0	7	9	13	9									
4	Kejadian kekerasan di lingkungan RS	0	0	0	0	0									

1.6.2 Komite PPI

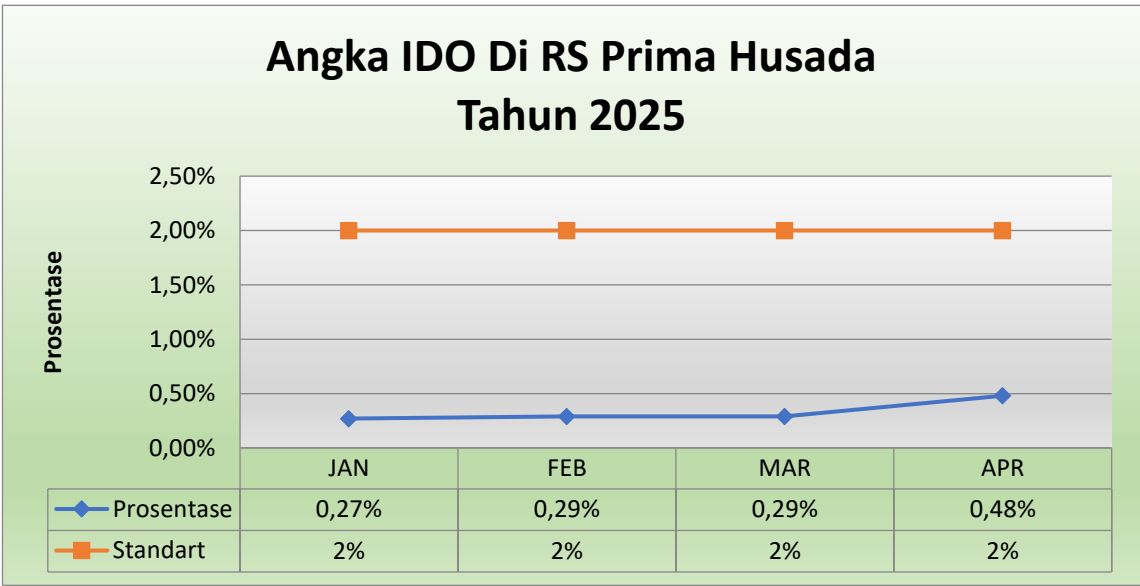
1.6.2.2 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

1.6.2.2.5 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

1.6.3.5.1 Tabel Data IDO berdasarkan Jenis Tindakan Operasi Sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Jenis Tindakan Operasi di RS	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Tindakan Operasi	Insiden (%)
Bedah Orthopedi	0	77	0%
Seksio Sesaria	2	74	2,7%
Apendiktomi	0	3	0%
Herniotomi	0	15	0%
Katarak	0	38	0%
CABG	-	-	-
Tumor Payudara	0	16	0%
Semua Operasi	2	417	0,48%

1.6.3.5.2 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)



Analisa	Dari grafik diatas diperoleh data terdapat kejadian IDO pada 2 orang pasien yang menjalani operasi SC. Dari hasil assesmen pasien diperoleh data bahwa pasien berusia 23 dan 28 tahun. Saat kontrol hari 1, ditemukan kondisi luka terbuka dan keluar darah bercampur puss. Pasien belum sempat melakukan perawatan luka sebelumnya dan luka tidak dibuka sama sekali setelah operasi. Dari hasil assesmen diperoleh data bahwa pasien tidak melakukan mandi sebelum operasi. Selain itu, dari hasil laboratorium kedua pasien menunjukkan adanya kondisi leukositosis, yaitu 13.980 dan 14.000. Namun pada salah satu pasien justru leukosit membaik dari yang awalnya 13.980 menjadi 8.960. Namun kedua pasien harus dilakukan reheating ulang karena luka yang terbuka. Jumlah pasien operasi secara keseluruhan memang mengalami peningkatan. Dari hasil assesmen pasien juga diperoleh data bahwa salah satu pasien terek makan dan hanya sedikit memakan makanan yang tinggi protein.				
Masalah saat ini	1. Masih belum berjalannya secara rutin terkait anjuran pasien untuk melakukan mandi sebelum operasi baik itu operasi elektif maupun cyto. 2. Belum adekuatnya edukasi perawatan pasien pasca operasi terutama perawatan saat dirumah termasuk nutrisi yang harus dipenuhi untuk mempercepat penyembuhan luka. 3. Belum maksimalnya proses pembersihan ruang operasi pada operasi estafet dimana terjadi peningkatan jumlah pasien operasi.				
Permasalahan sebelumnya	4. Belum adekuatnya edukasi perawatan pasien pasca operasi terutama perawatan saat dirumah termasuk nutrisi yang harus dipenuhi untuk mempercepat penyembuhan luka.				
Tindakan yang dilakukan	1. Mengingatkan kembali perawat/bidan yang melakukan perawatan pasien untuk mengedukasi pasien untuk mandi terlebih dahulu sebelum dilakukan operasi baik elektif maupun cyto, jika cyto bisa dengan diseka air sabun antiseptik. 2. Monitoring proses edukasi pasien pasca operasi terutama pemahaman pasien dan keluarga terhadap nutrisi tubuh yang harus dipenuhi. 3. Koordinasi dengan ahli gizi untuk memastikan pasien dan keluarga paham terkait diet pasien operasi dan tidak menghiraukan pernyataan-pernyataan mitos diluar terkait terek makan. 4. Monitoring proses edukasi tambahan pada pasien yang terjadi IDO, untuk tidak khawatir jika terdapat penyakit penyerta dan konsultasi dengan DPJP untuk mendapatkan terapi yang sesuai untuk membantu mempercepat pemulihan. 5. Mengajukan petugas IKO untuk menjadwalkan penggunaan kamar operasi dan mendahulukan pasien dengan kategori operasi bersih terlebih dahulu dan memperhatikan jeda waktunya. 6. Mengamati kembali proses pembersihan ruang operasi terutama jika terdapat operasi estafet. 7. Monitoring pelaksanaan audit bundle IDO sesuai di ruang perawatan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Memastikan bundle IDO berjalan dengan baik.	Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	Pasien operasi	1. Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi resiko infeksi. 2. Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

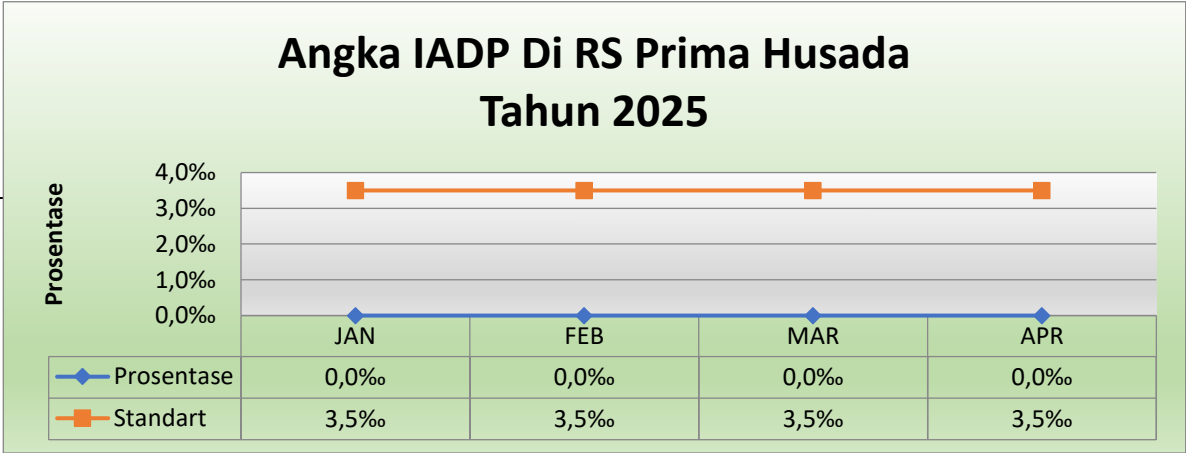
			3. Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik) 4. Pastikan proses pembersihan kamar operasi diantara jeda operasi dilakukan dengan benar sesuai prosedur. 5. Koordinasi dengan MOD terkait penjadwalan pasien operasi elektif lebih ditingkatkan. 6. Penggunaan alat tetap diperhatikan proses sterilisasi central di CSSD terutama jika dilakukan operasi estafet dengan kasus yang sama (SC).		
Lanjutkan evaluasi pemahaman pemberian edukasi perawatan pasien di rumah	Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi perawatan pasien post operasi.	Pasien post operasi.	1. Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. 2. Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-komunikasikan-pesan-media-feed back) 3. Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. 4. Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama terkait pantangan yang tidak perlu dipercaya di masyarakat.	1. Perawat /Bidan 2. Karu 3. IPCLN/PCN	Satu bulan

3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Tabel Data IDP Berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes

Ruang	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian CVC	Insiden (%)
ICU	0	42	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.6.1.1.2.2 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



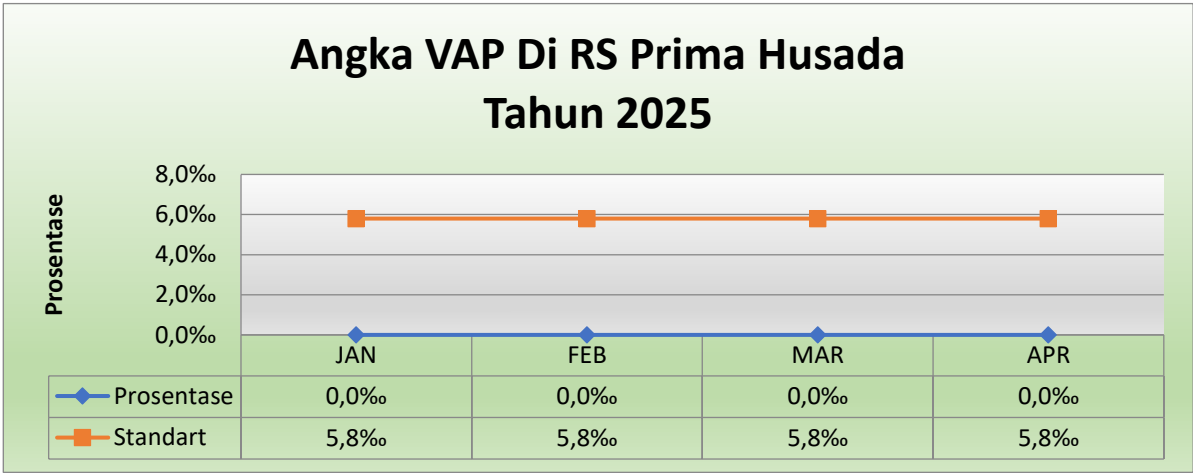
Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP pada 42 hari total lama pemasangan CVC pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi IADP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi IADP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. 2. Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Melakukan monitoring 5. perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Pasien dengan pemakaian CVC.	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.3 VAP

3.6.1.1.3.1 Tabel Data VAP berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	VAP		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (%)
ICU	0	52	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.6.1.1.3.2 Grafik Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



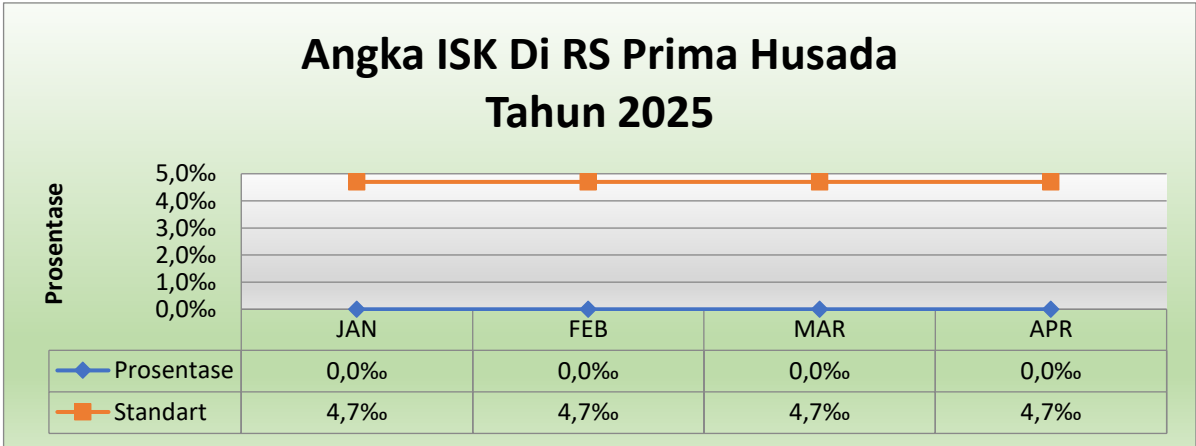
Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 52 hari total lama pemasangan ventilator pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi VAP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. 2. Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. 3. Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. 4. Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan lendir / suction. 5. Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	Pasien yang terpasang ventilator mekanik	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. 3. Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. 4. Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator. 5. Monitoring kegiatan oral hygiene dan pendokumentasian di RM. 6. Pemberian tindakan oral hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCPN	Satu bulan

3.6.1.1.4 ISK

3.6.1.1.4.1 Tabel Data berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR
((Pelaporan INM dan HAI^s Kemenkes)

Ruang	ISK		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (‰)
ICU	0	157	0‰
HCU	0	22	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

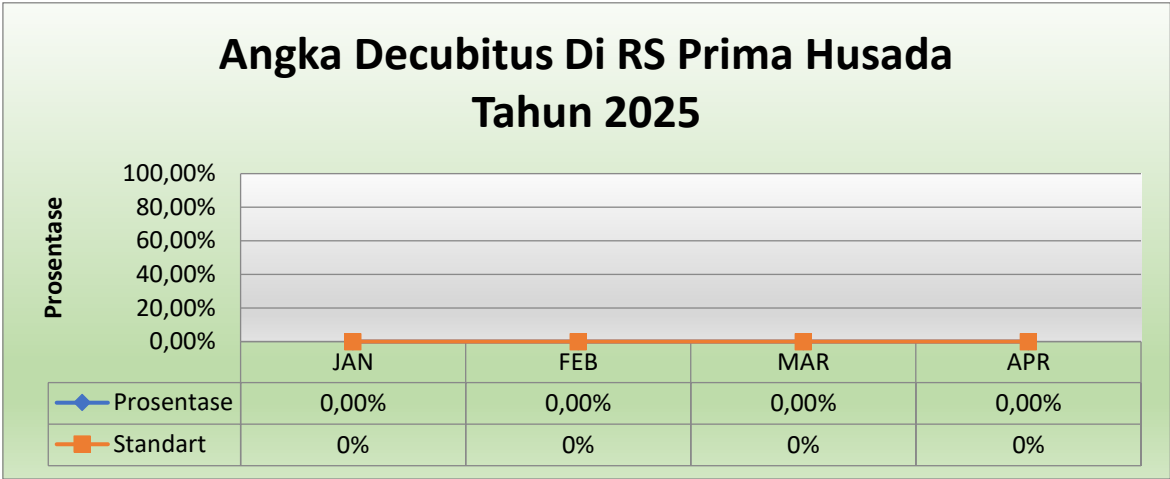
3.6.1.1.4.2 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1252 hari lama pemakaian kateter pasien.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi ISK				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi ISK				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Pasien yang terpasang kateter	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.5 Decubitus

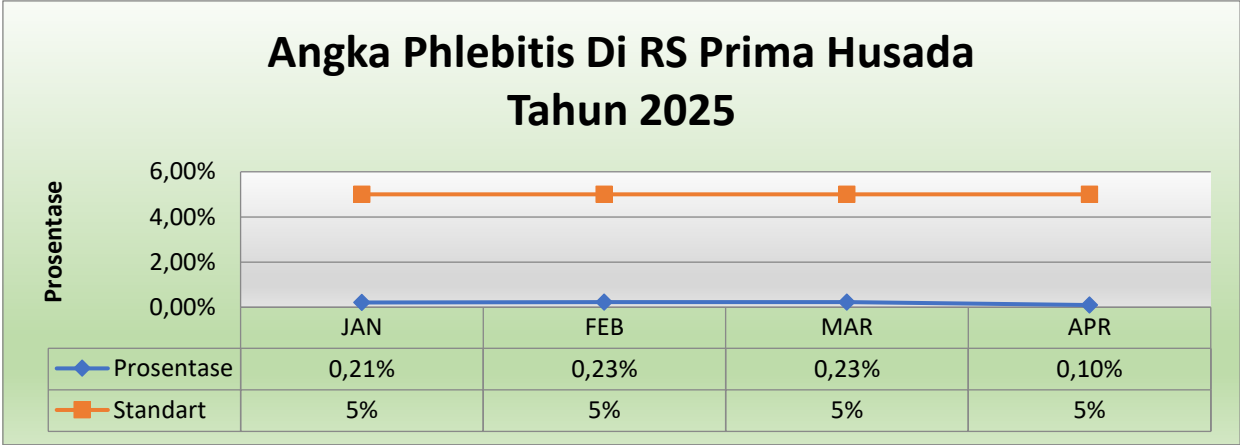
1.1.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 40 pasien tirah baring lama.				
Masalah saat ini	idak terjadi decubitus				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi decubitus				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 4. Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus atau alternatif lain 4. Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 5. Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.6 Phlebitis

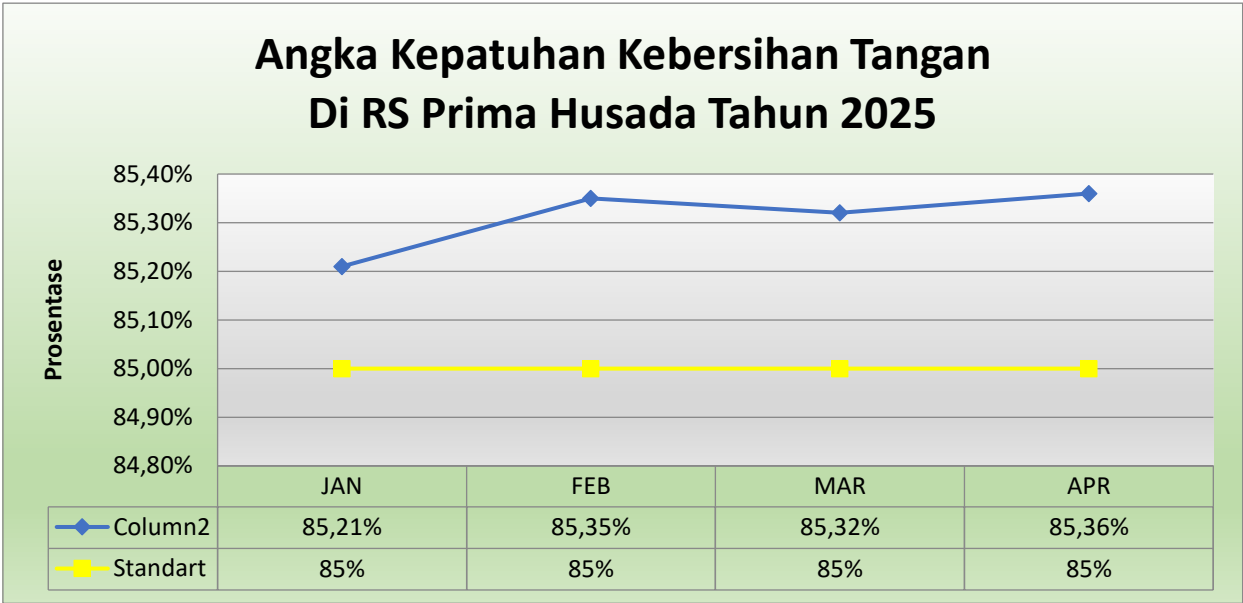
3.6.1.1.6.1 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)



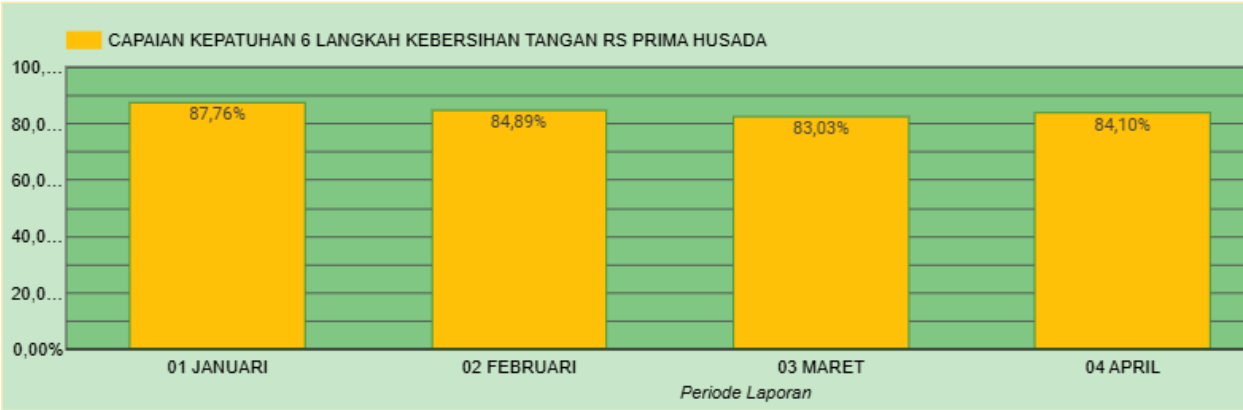
Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2974 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,10%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh, 3 pasien yang mengalami phlebitis, 1 diantaranya merupakan pasien berusia 60 tahun lebih dan 1 pasien batita dengan kondisi pembuluh darah sangat beresiko pecah. 1 diantara ketiga pasien tersebut mengalami phlebitis karena mendapatkan cairan pekat KCL dan 2 pasien lainnya mendapatkan banyak injeksi obat termasuk antibiotik pada 1 jalur infus saja. Kebanyakan kejadian phlebitis terjadi di ruang perawatan 1 hari setelah pemasangan (OB) dari IGD dan setelah mendapatkan cairan pekat tersebut. Dari 5 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).				
Masalah saat ini	Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, seperti KCL meskipun sudah diberikan dengan pengencer cairan infus				
Permasalahan sebelumnya	Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian produk darah.				
Tindakan yang dilakukan	1. Menganjurkan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat setiap hari setelah melakukan injeksi. 2. Menyarankan petugas untuk memberikan kompres hangat pada pasien yang mendapatkan cairan pekat pada area tangan yang terpasang infus untuk merilekskan pembuluh darah dan cairan pekat/darah tidak gampang menggumpal. 3. Menganjurkan perawat untuk memilih iv canula yang sesuai dengan kebutuhan pasien (lihat besarnya pembuluh darah & rencana pengobatan yang akan diberikan, usahakan menggunakan iv canula ukuran besar). 4. Mengkoordinasikan dengan kabit dan komite keperawatan terkait banyaknya kasus phlebitis untuk saran dilakukan pelatihan pemasangan dan perawatan luka infus.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Pasien yang terpasang infus	1. Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. 2. Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. 3. Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. 4. Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. 5. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. 6. Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. 7. Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. 8. Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

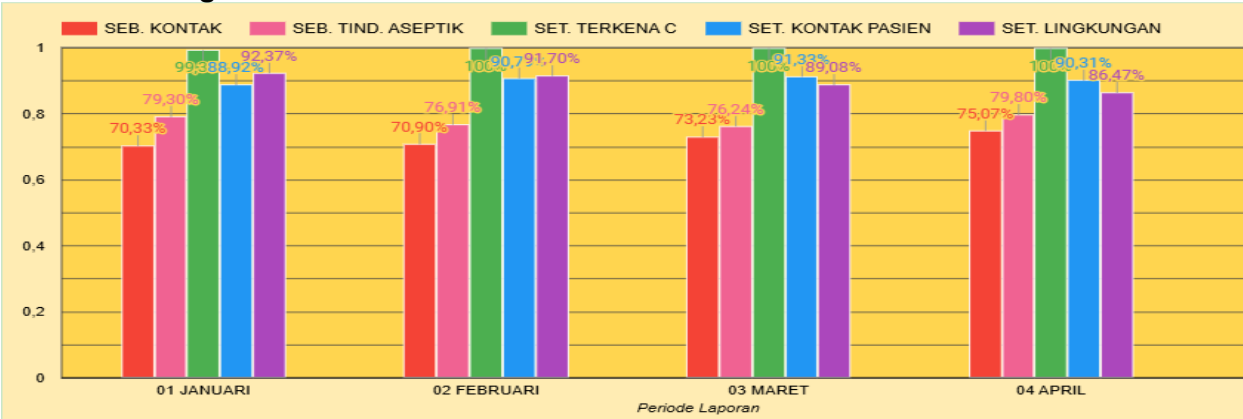
3.6.1.1.7.1 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



3.6.1.1.7.2 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan (Hand Hygiene)



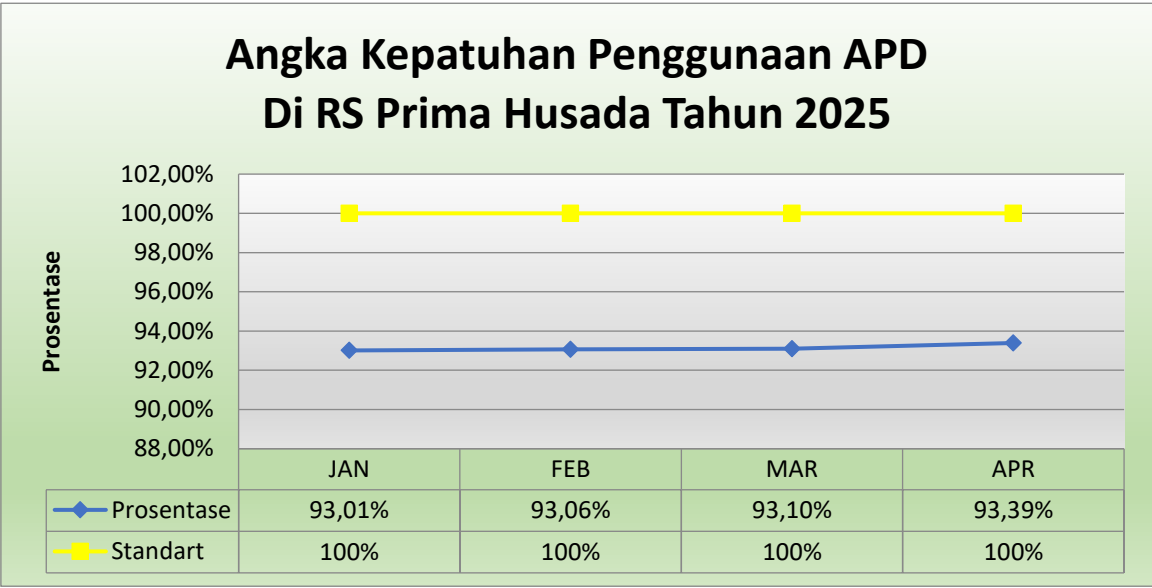
3.6.1.1.7.3 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan



Analisa	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,36%. Masih belum bisa mencapai target 100% karena memang masih ditemukan petugas yang tidak melakukan cuci tangan terutama pada momen sebelum kontak pasien (75,07%) dan sebelum melakukan tindakan aseptik (79,80%). Terdapat sedikit peningkatan prosentase pada bulan ini, termasuk juga pada penerapan 6 langkah cuci tangan dikarenakan pada bulan depan akan dilakukan survey perbaikan standar akreditasi dan kebanyakan dari petugas mempersiapkan diri dengan mulai membiasakan agar pada saat harinya tidak lupa atau bingung saat diharuskan praktek 6 langkah cuci tangan. Namun masih banyak juga petugas yang beranggapan jika tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Dilihat dari segi kepatuhan 6 langkah cuci tangan, 84,10% dari petugas dapat melakukan 6 langkah cuci tangan dengan baik. Namun memang karena belum menjadi kebiasaan dari petugas sehingga masih ada yang tidak urut melaksanakan 6 langkah cuci tangannya.				
Masalah saat ini	Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya saat pelayanan ke pasien (belum terbiasa), hanya pada saat ada event saja terjadi peningkatan, belum menjadikan suatu kebiasaan petugas.				
Permasalahan sebelumnya	Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya saat pelayanan ke pasien (belum terbiasa).				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. 3. Memberikan proses pembelajaran dengan membuat video pendek edukasi cuci tangan supaya lebih mudah untuk mengingat. 4. Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik. 6. Lakukan sosialisasi ke petugas langsung pada saat melakukan supervisi untuk mengingatkan kebiasaan petugas dalam kebersihan tangan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPC�	Satu bulan

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

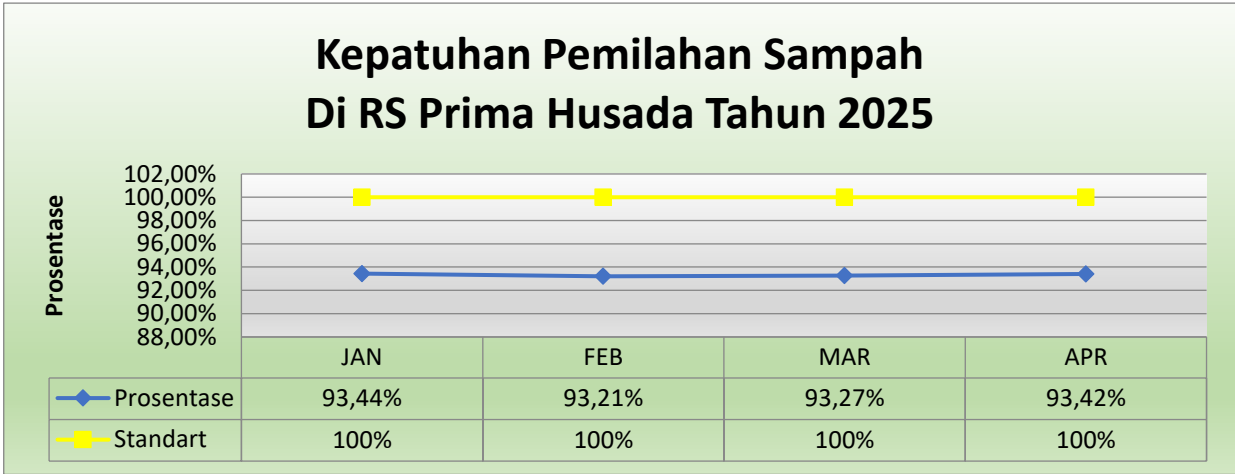
3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas



Analisa	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,39%. Dari hasil monitoring dan supervise, terjadi sedikit peningkatan kepatuhan pemakaian APD, kepatuhan petugas nakes dalam pemakaian APD sudah baik, namun masih tetap tidak pada dokter DPJP yang sering berlebihan memakai APD, seperti visite saja namun memakai APD lengkap mulai skort masker, nurse cap, dan sarung tangan. Selain itu, Penggunaan APD pada petugas penjamah makanan juga mengalami peningkatan semenjak dilakukannya resosialisasi terkait hygiene penjamah makanan. Dan karena adanya event survey akreditasi menyebabkan peningkatan pada kebiasaan petugas dalam memakai APD meskipun tidak banyak.				
Masalah saat ini	Kesadaran petugas sedikit meningkat terkait pemakaian APD dikarenakan adanya event tertentu saja, belum tertanam dan belum menjadikan kebiasaan sehari-hari jika tidak ada event.				
Permasalahan sebelumnya	Kurangnya kesadaran petugas terhadap penggunaan APD yang sesuai untuk menghindari penyebaran infeksi dengan mementingkan keuntungan pemakaian APD pribadi dan tidak melihat kerugiannya pada orang lain.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). 5. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. 6. Melarang perawat untuk memberikan handscoon jika ada CS yang meminta untuk membersihkan ruangan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Tingkatkan sosialisasi pada petugas langsung saat melakukan supervisi unit. 2. Koordinasi dengan IPCD untuk membantu meningkatkan pemahaman terkait APD pada para DPJP. 3. Berkolaborasi dengan SDM terkait ketidak disiplin petugas dalam pemakaian APD. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 5. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 6. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 7. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.9
Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius

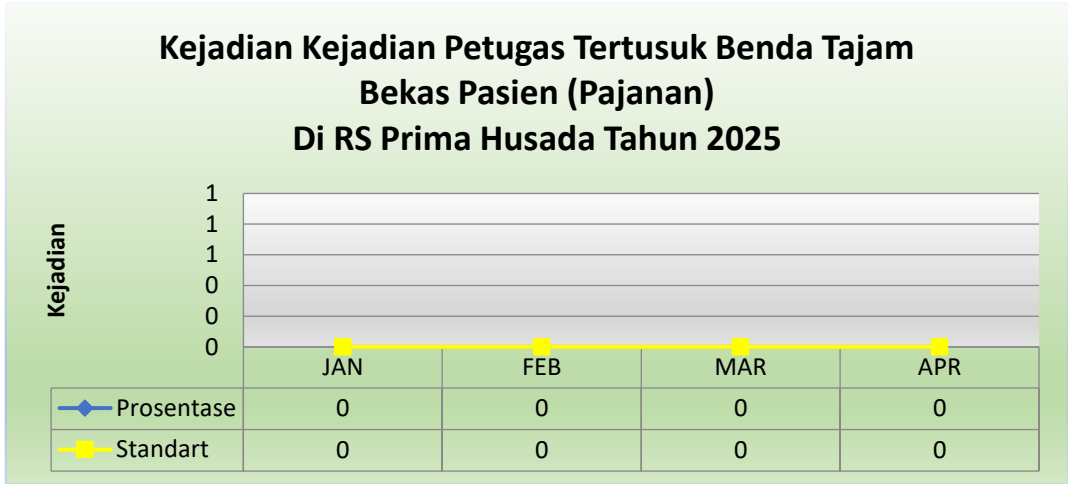
3.6.1.1.9.1
Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan



Analisa	Prosentase kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,42%. Dari hasil monitoring dan supervise, memang masih ditemukan petugas yang tidak melakukan pemilahan dengan baik saat melakukan tindakan terutama pembuangan bungkus spuit yang sering dibuang juga jadi satu dengan spuitnya di safety box dan yang paling sering adalah bungkus alkes seperti alcohol swab di sapah infeksius, beberapa unit seperti IRJA juga sering didapatkan tissue pada safety box.				
Masalah saat ini	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius.				
Permasalahan sebelumnya	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius.				
Tindakan yang dilakukan	1. Menganjurkan menyiapkan kresek hitam dan kresek kuning pada saat akan melakukan tindakan yang sekiranya akan menghasilkan banyak sampah non infeksius dan infeksius atau bengkok. 2. Memberikan proses pembelajaran langsung petugas unit dan Karu/PJ saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan dan memberitahukan pemilahan sampah yang benar. 3. Melakukan monitoring pemilahan sampah saat melakukan tindakan. 4. Melakukan supervisi pada tempat sampah yang ada di unit-unit. 5. Menjelaskan terkait proses pembayaran saat membuang sampah infeksius pada pihak ke-3 tergantung dari berat timbangan sampah, untuk menyadarkan bahwa kesalahan pembuangan sampahnya dapat merugikan rumah sakit.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Peletakkan tempat sampah baik infeksius dan non infeksius harus ditata dengan benar. 2. Lakukan edukasi ulang pada staf tentang pemilahan sampah. 3. Berikan proses pembelajaran pada petugas unit saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan. 4. Sampaikan kesalahan pembuangan unit pada kepala unit dan IPCLN unit dalam forum rapat PPI maupun grup WA (untuk menciptakan efek jera).	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.10 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam

3.6.1.1.10.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



Analisa	Tidak ditemukan kejadian pajanan.				
Masalah saat ini	Tidak ada kejadian pajanan.				
Permasalahan sebelumnya	Safety box tidak standar, tembus tusukan jarum.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring pemilahan sampah khususnya benda tajam pada saat melakukan tindakan. 2. Melakukan monitoring kerapian dan kebersihan troli tindakan untuk segera dibersihkan setelah tindakan dan tidak meninggalkan jarum/benda tajam terbuka di troli tindakan. 3. Melakukan monitoring teknik recapping saat menutup jarum saat menyiapkan obat pasien. 4. Sudah diajukan telaah penggantian safety box, dengan melampirkan kejadian pajanan namun tidak ada penggantian safety box.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan proses pemilahan sampah yang benar dan pengelolaan benda tajam yang baik.	Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar 0 kejadian.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. 2. Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. 3. Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. 5. Monitoring teknik recapping tutup jarum.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

UNIT	TARGET	FEB	MAR	APR	%	MANDOK	KETERANGAN
IRNA 2C	4x/Bulan	100%	100%	50%	Menurun	Ada	
ICU HCU	4x/Bulan	0%	0%	50%	Meningkat	Ada	
IRNA 3C	4x/Bulan	100%	50%	100%	Tercapai	Ada	
MATERNITAS	4x/Bulan	100%	75%	0%	Menurun	Ada	
PERINATOLOGI	4x/Bulan	100%	75%	100%	Tercapai	Ada	
IRNA 5C	4x/Bulan	100%	50%	100%	Tercapai	Ada	
IRNA 2A,3A,4A	4x/Bulan	75%	25%	0%	Menurun	Ada	
IRNA 6A,7A,8A	4x/Bulan	100%	75%	0%	Menurun	Ada	
IGD	4x/Bulan	0%	100%	0%	Menurun	Ada	
FARMASI	4x/Bulan	100%	25%	0%	Menurun	Ada	
GIZI	4x/Bulan	50%	100%	100%	Tercapai	Ada	
IRJA	4x/Bulan	100%	50%	100%	Tercapai	Ada	
PPI	4x/Bulan	100%	100%	50%	Menurun	Ada	
Total							

ANALISIS : Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan April Petugas PKRS tiap unit tidak terlaksana dengan baik, dari data tersebut Unit MATERNITAS, IRNA 2A,3A,4A, IRNA 6A,7A,8A FARMASI, DAN IGD belum melaksanakan Edukasi Kelompok dengan maksimal sehingga peresentasi sangat kurang dimana masih 0%, untuk Unit IRNA 2C dan PPI mengalami penurunan dengan presetase diawal 100% menjadi 50% dari bulan Maret 2025.

RTL : Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai kinerjanya untuk mengejar ketertinggalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan Maret.

3.6.3.2 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

UNIT	TARGET	KEGIATAN	FEB	MAR	APR	%	MANDOK	KET
Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	100%	100%	50%	Tidak Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	50%	50%	50%	Tidatk Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	50%	Tidak Tercapai	Ada	
		Karya wisata						
Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		0%	100%	0%	Tidak Tercapai	Terlaksana	
Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.3 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

NO	UNIT	TARGET	FEB	MAR	APR	%	MANDOK	KETERANGAN
1	PONEK	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
2	HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
3	STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	0%	0%	25%	0%	-	

4	KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
5	TB DOTS	4X/Bulan	0%	25%	0%	0%	-	

Analisis : Bulan April PROGNAS belum tercapai.

Rencana Tindak Lanjut : Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat Meningkatkan produktivitas Tim Prognas.

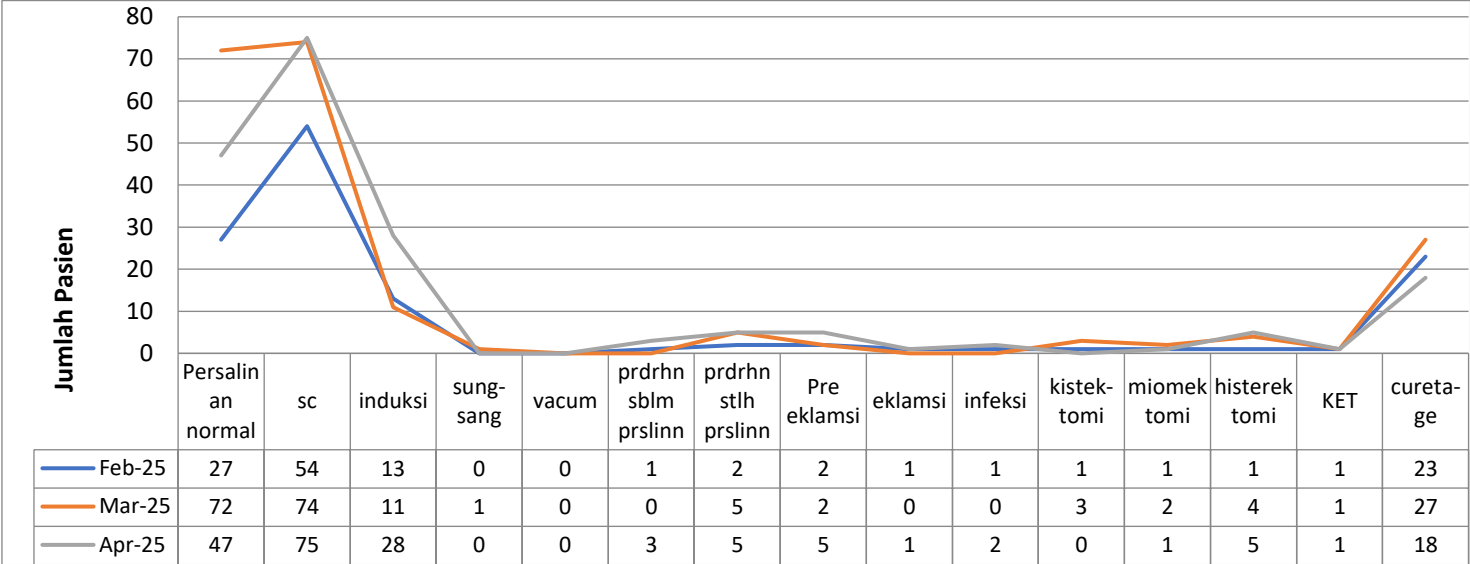
3.6.4 Tim Prognas

3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek April 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	27	72	47
	b. <i>SectioCaesaria</i>	54	74	75
2				
	a. Induksi / Drip	13	11	28
	b. Sungsang	0	1	0
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	1	0	3
	b. Perdarahan setelah Persalinan	2	5	4
	c. Pre Eklamsi	2	2	5
	d. Eklamsi	1	0	1
	e. Infeksi	1	0	2
4				
	a. Curretage	23	27	18
	b. Kistektomi	1	3	0
	c. Miomektomi	1	2	1
	d. Histerectomy	1	4	5
	e. KET	1	1	1

3.6.4.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan April 2025



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan April 2025 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 75 pasien. Dan untuk persalinan normal pada bulan April 2025 mengalami penurunan yang cukup banyak jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 47 persalinan. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu.
2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
3. Tidak ada persalinan dengan sungsang pada bulan April dan Februari 2025, sedangkan pada bulan Maret sebanyak 1 pasien. Dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan April 2025 dan 2 bulan sebelumnya.
4. Induksi Persalinan pada bulan April mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 28 pasien
5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan April 2025 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 4 pasien. Dan ada 1 kejadian eklamsi pada bulan April dan Februari 2025, sedangkan pada bulan Maret tidak ada kejadian.
6. Jenis pelayanan curretage di bulan April 2025 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 18 pasien. Curetage dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hiperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.

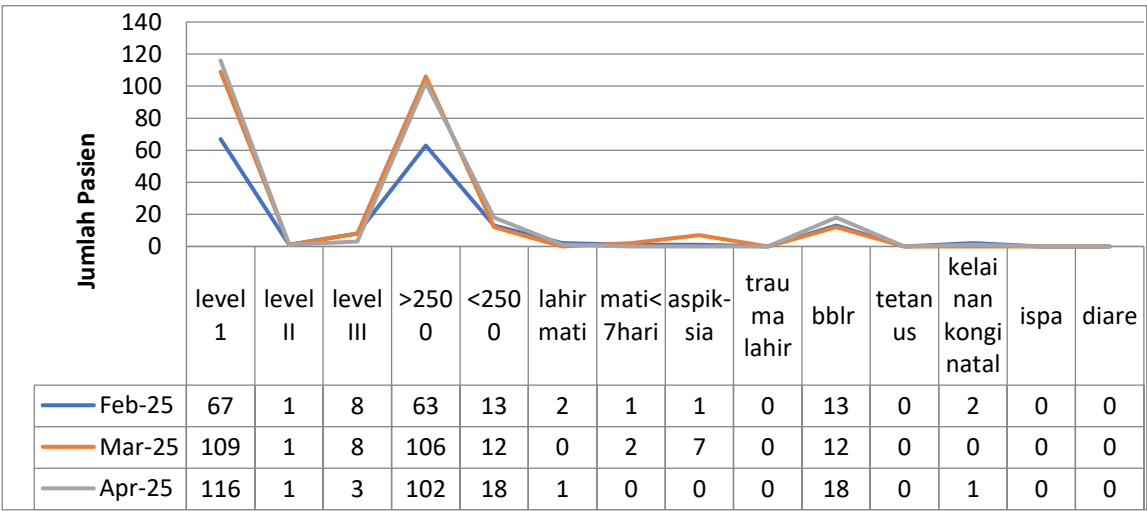
- Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.6.4.1.3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.3.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponek April 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1				
	a. Level 1	67	109	116
	b. Level II	1	1	1
	c. Level III	8	8	3
2				
	a. ≥ 2500 gram	63	106	102
	b. ≤ 2500 gram	13	12	18
3				
	a. Kelahiran Mati	2	0	1
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	1	2	0
4				
	a. Asphyxia	1	7	0
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	13	12	18
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	2	0	1
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.6.4.1.3.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada April 2025



Analisis :

- Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan April 2025 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 116 bayi. Dan pada level 2 sama dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 1 bayi. Dan pada level 3 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 3 bayi.

- 2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan April 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 102 bayi.
- 3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan April 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 18 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
- 4. Kasus BBLR pada bulan April 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 18 bayi.
- 5. Ada 1 kasus kelahiran mati pada bulan April 2025, sedangkan pada bulan Maret tidak ada, dan 2 kelahiran mati pada bulan Februari
- 6. Tidak ada kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan April 2025, sedangkan pada bulan Maret ada 2 kasus, dan Februari sebanyak 1 kasus

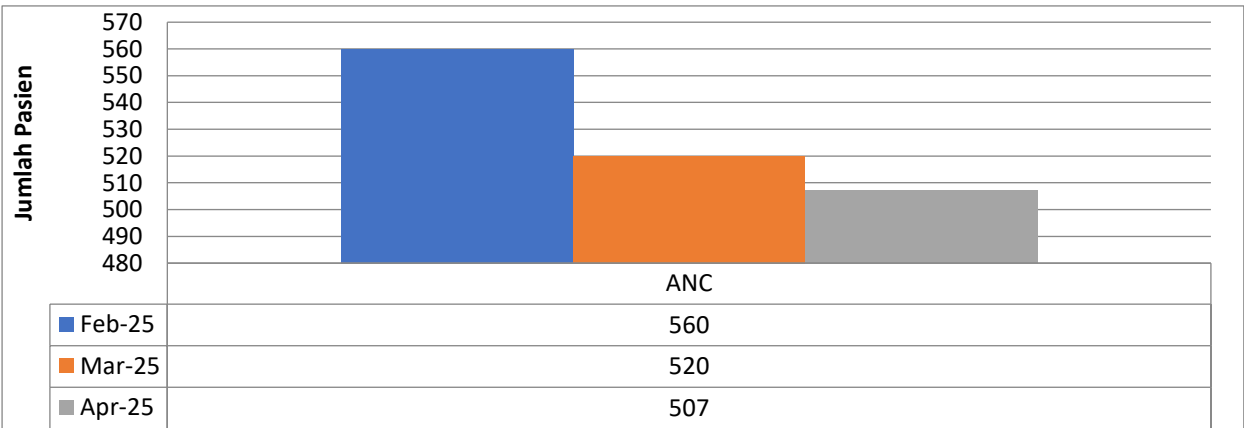
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.

3.6.2.1.2.3 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek April 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	ANC	560	520	507

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada April 2025



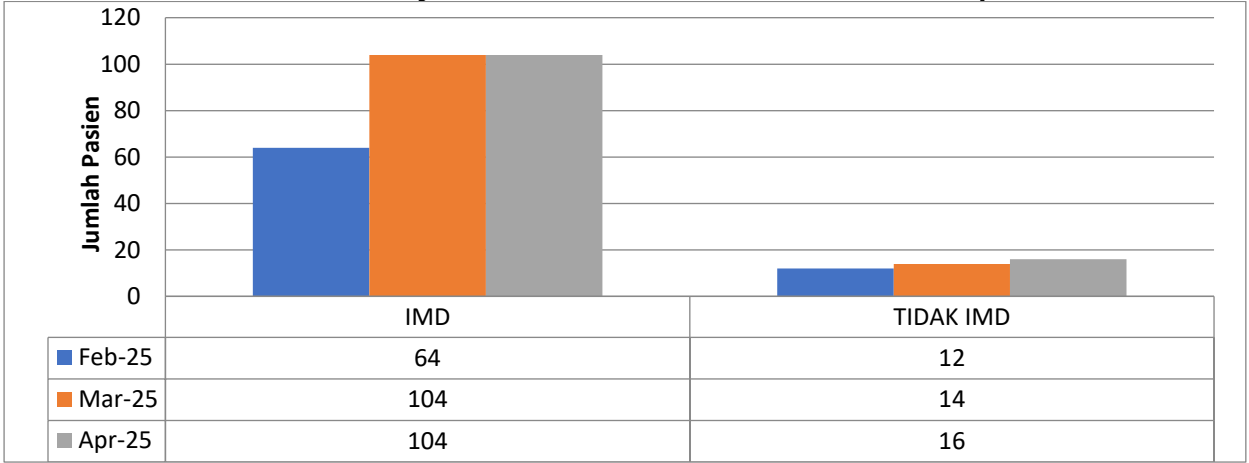
Analisis :
Pelayanan ANC pada bulan April 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 507 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.6.1.2.4 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) April 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	IMD	64	104	104
2	Tidak IMD	12	14	16

Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan April 2025



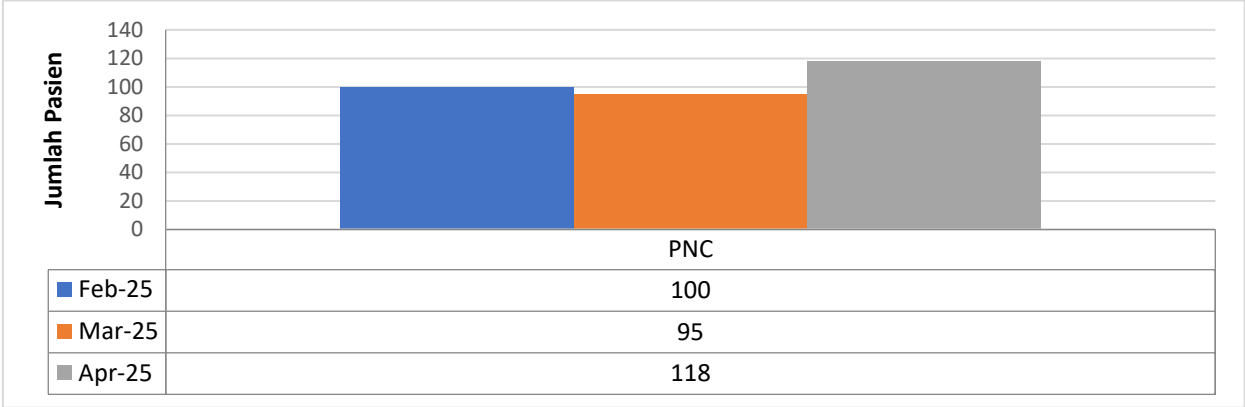
- Analisis :**
- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan April 2025 sama dengan bulan sebelumnya, yaitu 104 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
 - 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan April sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 16 bayi, Sedangkan pada bulan Maret sebanyak 14 bayi, dan Februari 12 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
 - 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat atau tidak.

3.6.1.2.5 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek April 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	PNC	100	95	118

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan April 2025



Analisis :
Pelayanan PNC pada bulan April 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 118 kunjungan.

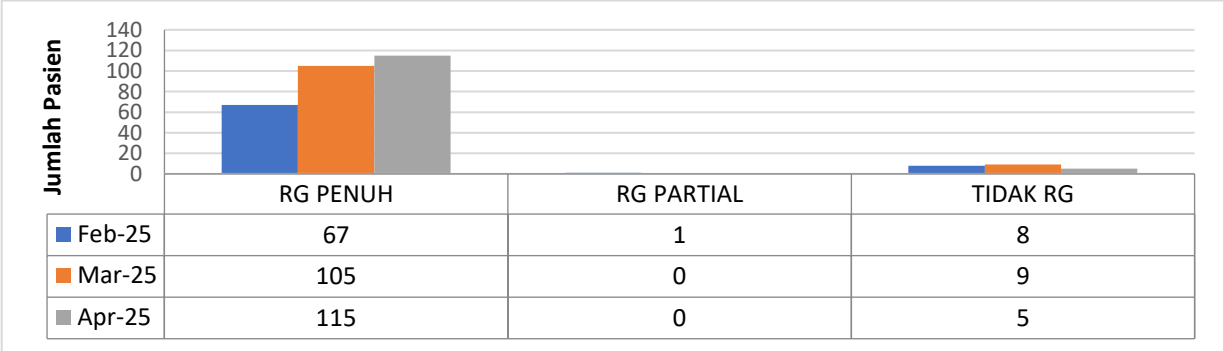
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek April 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	Rawat gabung penuh	67	105	115
2	Rawat gabung partial	1	0	0
3	Tidak Rawat gabung	8	9	5

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan April 2025



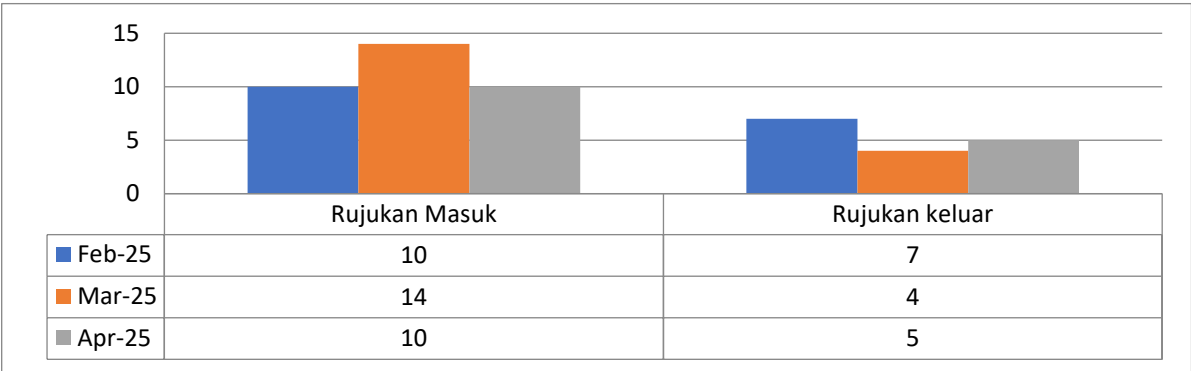
- Analisis :**
- Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan April 2025 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 115 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
 - Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan April 2025 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 5 bayi.
Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram dan masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponpek April 2025

NO	RUJUKAN	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	Rujukan Masuk	10	14	10
2	Rujukan keluar	7	4	5

Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan April 2025

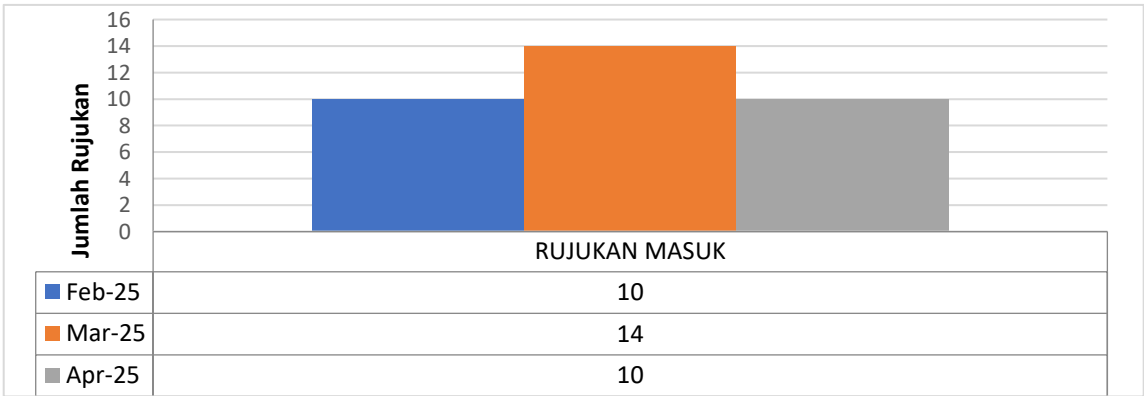


3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponpek April 2025

Bulan Februari 2025		
1	G2 P1001 Ab000 uk 30-32 mgg dg PPI	BPS Lilik Agustina
2	G3 p0201 Ab000 uk 32-34 mgg dg KIFA	Klinik Putra Husada
3	G1 P0000 Ab000 uk 37-38 mgg dg KPD	BPS Subaedah I
4	G1 P0000 Ab000 uk 39-40 mgg dg Prolong KIFA	BPM Titik Sunaryati
5	G1 P0000 Ab000 uk 39-40 mgg dg IUFD + Letli + High miopi	Klinik Kartini
6	G2 P1001 Ab000 uk 10-12 mgg dg Abortus Inkomplit	Klinik Putra Husada
7	P2002 Ab000 dg kala 3 + Retensio Plasenta	PKM Singosari
8	G2 P1001 Ab000 uk 30-32 mgg dg PPI	BPM Tri
9	Anemia Grafis + Massa IntraAbdominal susp CA Ovari + Prolaps Uteri grade 4	PKM Pakis
10	Anemia +Susp CA Serviks	Klinik Nayaka
Bulan Maret 2025		
1	G2 P1001 Ab000 UK 6-8 dg abortus inkomplit + Syok Hipovolemik	PMB Tri Widiyawati
2	G1 P0000 Ab000 UK 2-4 Mgg dg KET	KRI Idaman Hati
3	G2 P0101 Ab000 UK 28-30 mgg dg PPI	PMB Tri Widiyawati
4	G3 P2002 Ab000 UK 8-10 mgg dg abortus Inkomplit dan Anemia	PKM Ardimulyo
5	G3 P2002 Ab000 UK 36-37 mgg dg KPD + KIFL	PMB Nuri Afanti
6	Anemia Grafis + Kista Endometriosis	Klinik Tirto Husada

7	G2 P1001 Ab000 UK 38-39 mgg dg KIFL + Autoimum + HT	PKM Singosari
8	G1 P0000 Ab000 UK 40 mgg dg KIFL + KPD	PMB Titik
9	G1 P0000 Ab000 UK 39 – 40 mgg dg prolong kala 1 fase aktif	PKM Ardimulyo
10	G3 P2002 Ab000 UK 38 - 39 mgg dg letak lintang + HT gestasional	PMB titik
11	P1001 Ab000 dg post partum normal dan rupture perineum D3	PMB Heni Budiasih
12	G1 P0000 Ab000 UK 32-34 mgg dg Gemeli, letsu, anemia grafis	RS Sahabat
13	G3 P1001 AB100 UK 39-40 mgg dg KIFA	PMB Titik Sunaryati
14	Asfiksia berat + BBLR + NKB	RSUD Lawang
Bulan April 2025		
1	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 MGG DG HT + FH	Klinik Mutiara Sehat
2	G2P1001AB000 UK 37-38 MG KPD + Prolong K1FA	PMB Tri Widiyawati
3	G2 P1001 AB000 UK 37-38 MGG dgn KIFA	PMB Munawaroh
4	G3P2AB0 UK 34-36 MGG dg PPI	PMB Tri Widiyawati
5	G2P1001AB000 UK 10-12 MG dg susp.KET	RSUD lawang
6	G 2 P1001 AB0 UK 42-43 MGG dgn KIFL + Post date	RSUD lawang
7	G1P000 ABOO UK 40- 41 mgg dg prolong KIFL	PMB Titik Sunaryati
8	G1 P0 AB 0 UK 41-42 MGG dgn KIFA + OF hari ke 3	PKM Ardimulyo
9	Convulsion of Newborn	RSAU Munir
10	Sust TTNB	BPM Tri Widiyawati

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan April 2025



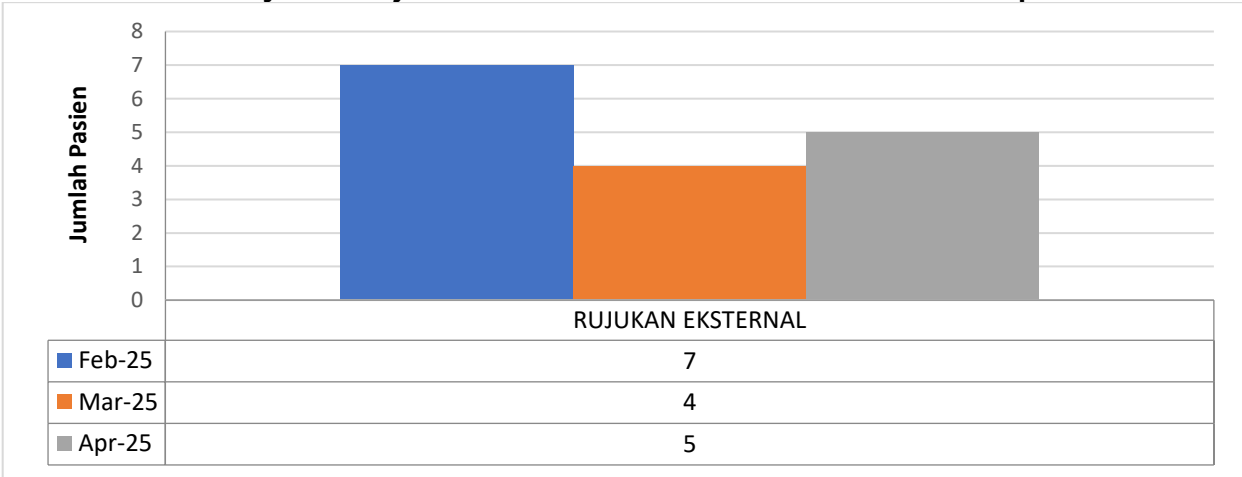
Analisis :
 Jumlah rujukan masuk pada bulan April 2025 menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 rujukan, sedangkan pada bulan Maret sebanyak 10 rujukan, dan Februari sebanyak 10rujukan masuk

Rencana dan Tindak Lanjut
 Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
Tabel Rujukan Keluar Ponpek April 2025

BULAN FEBRUARI 2025		
1	P1001 Ab000 dg Eklamsia	RS saiful Anwar
2	P1001 Ab000 dg post SC h+9 dg late HPP ec Sub Involusi Uteri	RS Saiful Anwar
3	RDS +NKB	RS Saiful Anwar
4	RDS + BBLSR	RS Soepraoen
5	RDS + NKB + BBLSR	RS Soepraoen
6	RDS + BBLR	RS Soepraoen
7	RDS + BBLR	RS Saiful Anwar
BULAN MARET 2025		
1	NKB + RDS + Susp NEC, Pneumonia	RS Saiful Anwar
2	NKB + BBLSR + RDS	RS Saiful Anwar
3	RDS ok Neonatal	RS Lavalette
4	G1 P0000 Ab000 UK 28-30 mgg dg PEB + ALO	RS Saiful Anwar
BULAN APRIL 2025		
1	Atresia Ani tanpa fistel undesensus testis	RS Saiful Anwar
2	RDS, Prematur, NEC	RS Lavalette
3	Post SC h-9, asites, dipsneu, anemia, anuria	RS Saiful Anwar
4	Abdominal Pregnancy	RS Saiful Anwar
5	G2 P1001 Ab000 Uk 26-28 mgg dg Eklamsia + BSC	RS Saiful Anwar

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan April 2025



Analisis :
Pada bulan April 2025 jumlah rujukan eksternal sedikit meningkat, yaitu 5 pasien dirujuk, sedangkan pada bulan Maret ada 4 pasien, dan Februari 2025 ada 7 pasien

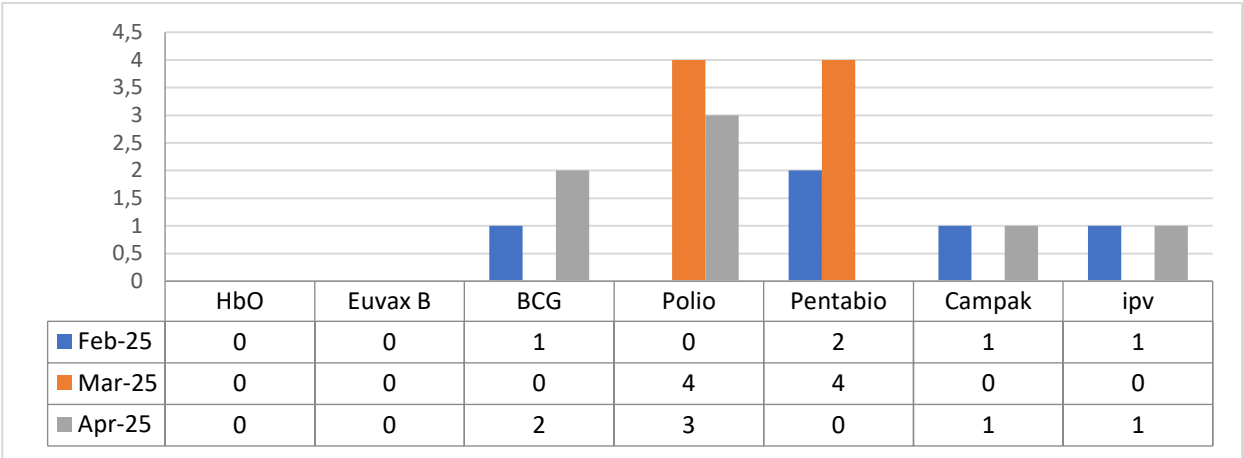
Rencana dan Tindak Lanjut :
Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponpek April 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	HbO	0	0	0
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	1	0	2
3	Polio	0	4	3

4	Pentabio	2	4	0
5	Campak	1	0	1
6	IPV	1	0	1

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan April 2025



Analisis :

1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode April 2025 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga tidak menggunakan vaksin euvax B
2. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan April dan 2 bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan ketidakterseidanya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas belum bisa memeberikan ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
3. Ada 1 bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan April dan Februari 2025, sedangkan pada bulan Maret tidak ada
4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan April sebanyak 2 bayi, sedangkan pada bulan Maret tidak ada, dan 1 bayi pada bulan Februari 2025
5. Bayi yang melakukan Imunisasi campak pada bulan April dan Februari 2025 sebanyak 1 bayi, sedangkan pada bulan Maret 2025 tidak ada
6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan April 2025 sebanyak 3 bayi, sedangkan pada bulan Februari 2025 tidak ada, dan pada bulan Januari 2025 sebanyak 2 bayi.
7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Maret sebanyak 4 bayi, sedangkan pada bulan Januari dan Februari 2025 sama, yaitu 2 bayi, imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

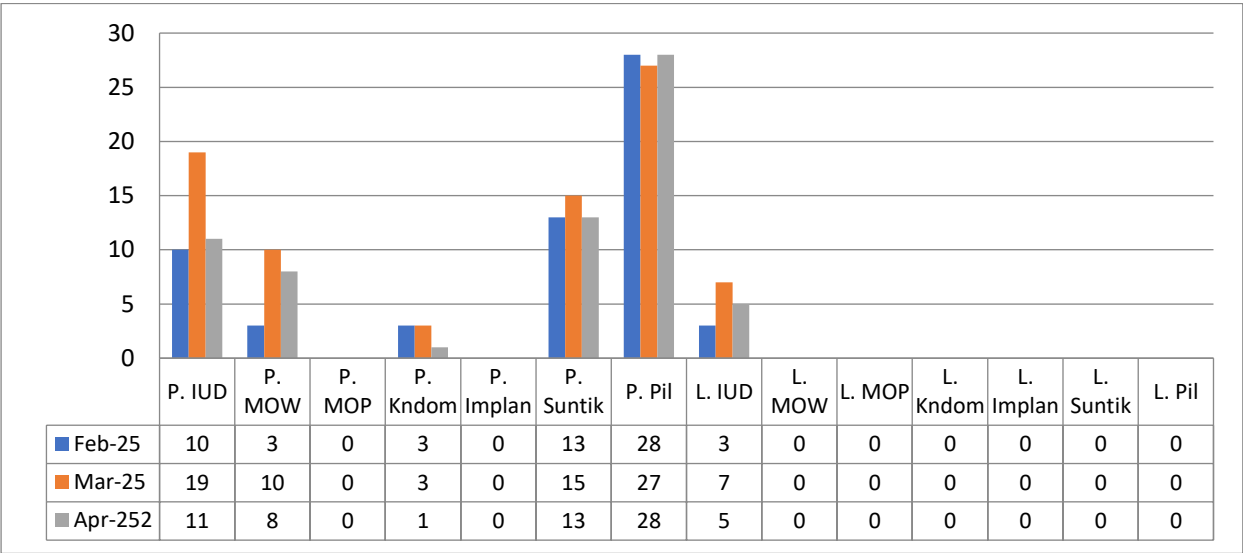
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponpek April 2025

NO	JENIS	JUMLAH PASANG			JUMLAH LEPAS		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	IUD	10	19	11	3	7	5
2	MOW	3	10	8	0	0	0
3	MOP	0	0	0	0	0	0
4	Kondom	3	3	1	0	0	0
5	Implant	0	0	0	0	0	0
6	Suntikan	13	15	13	0	0	0
7	Pil	28	24	28	0	0	0

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan April 2025



Aanalisis :

- 1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan April 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 11 akseptor yang terdiri dari 1 akseptor IUD Nova T dan 10 akseptor IUD copper T, pemakaian KB belum maksimal dikarenakan KB IUD coper T pasca salin ada biaya jasa dokter Rp. 400.000, biaya gratis jika dipasang oleh bidan tetapi pasien tidak berkenan, memilih KB di faskes tingkat 1
- 2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan April 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 8 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
- 3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulanApril menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 1 pengguna. Sedangkan pada bulan Maret dan Februari sama yaitu 3 pengguna
- 4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan April sama dengan Februari, yaitu 28 pengguna, sedangkan bulan maret 2025 sebanyak 27 pengguna
- 5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan April juga sama dengan Februari, yaitu 13 pengguna, sedangkan Maret 2025 sebanyak 15 pengguna.

Rencana dan Tindak Lanjut :

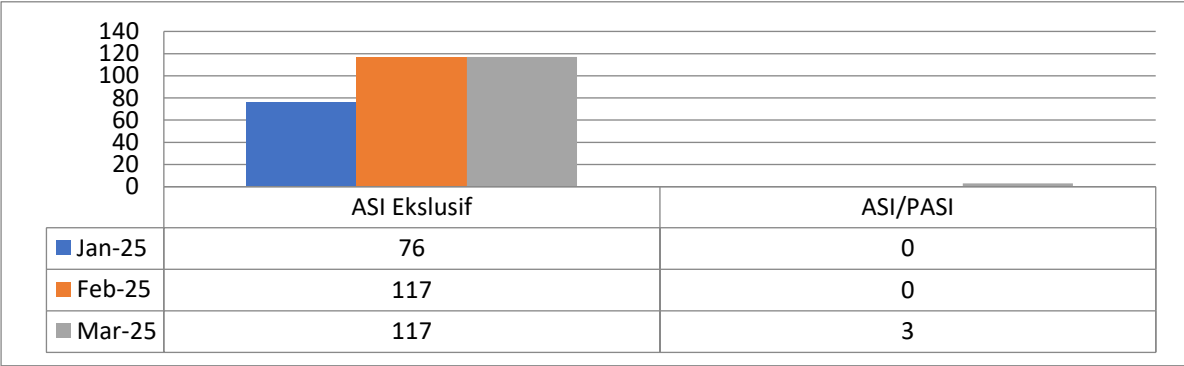
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif April 2025

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	Asi eksklusif	76	117	117
2	Asi /PASI	0	0	3

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan April 2025



- Analisis :**
1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan April dan Maret 2025 sama, yaitu 117 bayi, sedangkan pada bulan Februari sebanyak 76 Bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
 2. Bayi yang mendapat PASi pada bulan April sebanyak 3 bayi. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

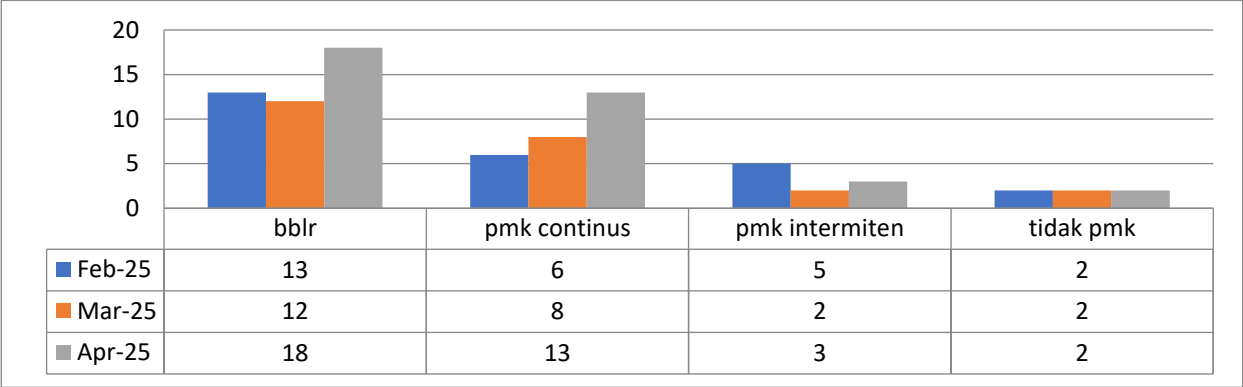
Rencana dan Tindak Lanjut :
 Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR

Tabel Pelayanan Perawatan metode kanguru (PMK) Pada BBLR di Ponek April 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	Bayi BBLR	13	12	18
2	PMK continuos	6	8	13
3	PMK Intermiten	5	2	3
4	Tidak PMK	2	2	2

Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada April 2025



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
- 2. Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan April 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 3 bayi, sedangkan pada bulan Maret sebanyak 2 bayi, dan Februari 2025 sebanyak 5 bayi
- 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan April 2025 meningkat sebanyak 13 bayi, sedangkan pada bulan Maret sebanyak 8 bayi, dan Februari 2025 sebanyak 6 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
- 4. Ada 2 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan April dan 2 bulan sebelumnya, dan tidak ada yang tidak PMK pada bulan Januari 2025. Hal ini dikarenakan kondisi bayi yg tidak mendukung untuk dilakukan PMK karena terpasang alat C-pep dan bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut

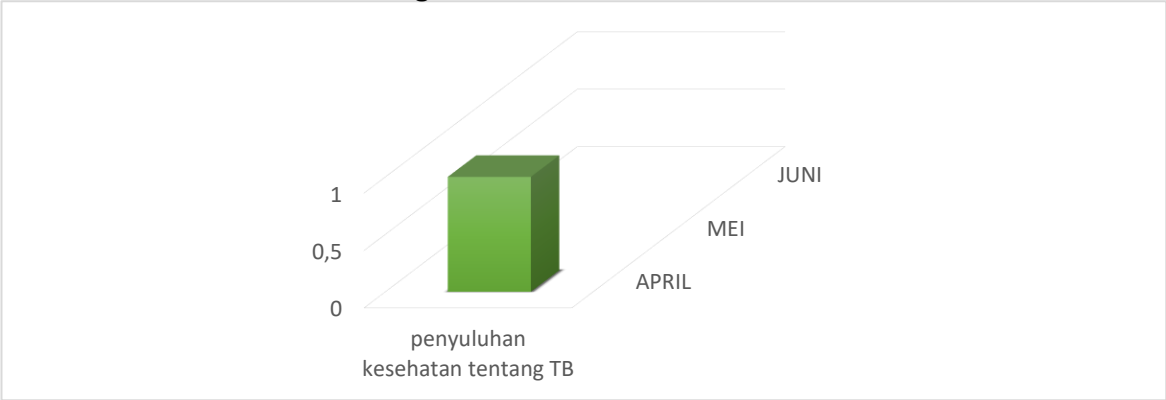
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

1.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.1 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		APRIL	MEI	JUNI
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1		

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada



Analisis:

Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

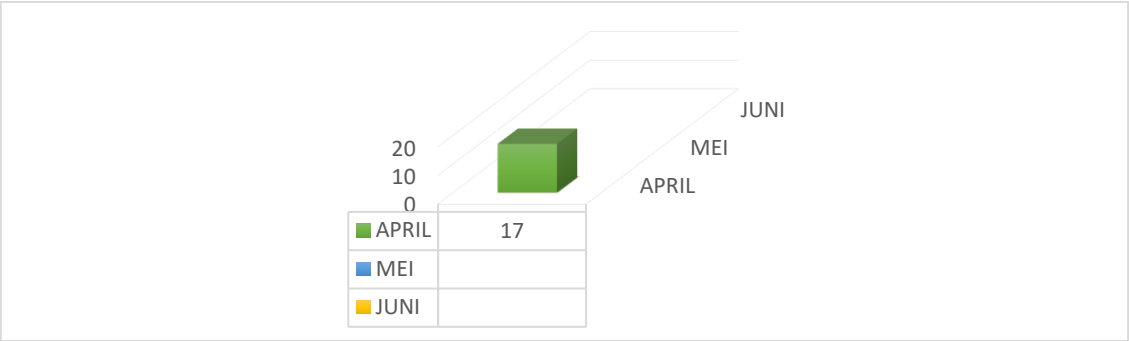
Rencana dan Tindak Lanjut:

Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dlls.

3.1.2.2.2 Skringing Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pemberian Masker	17		

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skringing Awal Pemberian Masker di RS Prima Husada



Analisis :

Pada bulan April 2025 terdapat 17 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

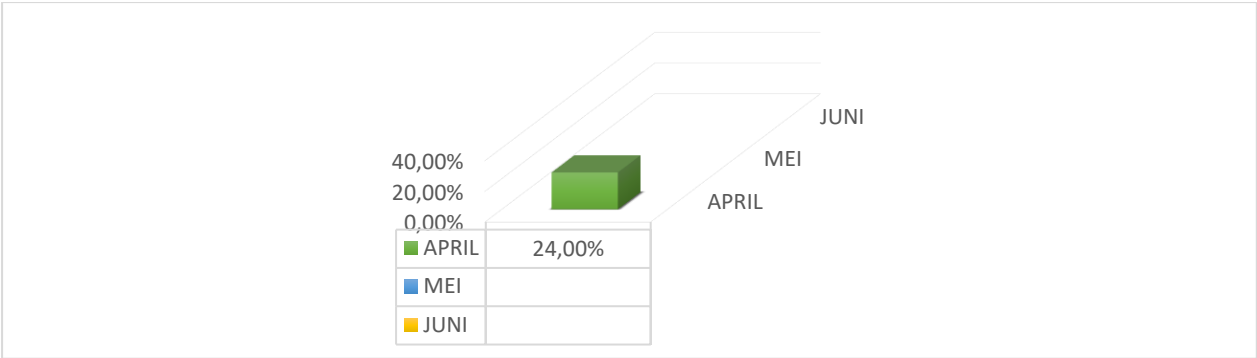
Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	24		

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis di RS Prima Husada



Analisis :

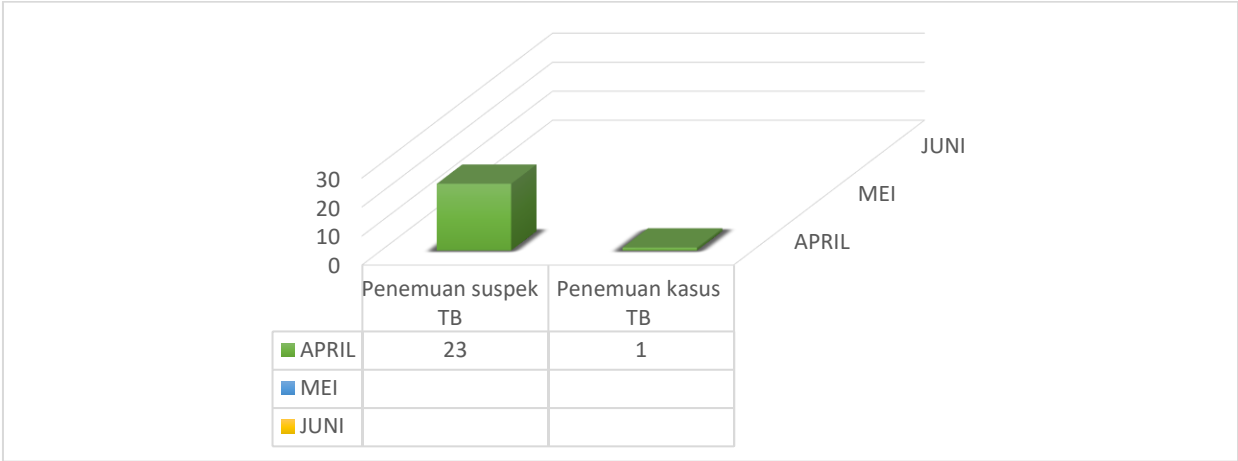
Pada bulan April 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 24

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Penemuan suspek TB	23		
2	Penemuan kasus TB	1		

Grafik Penemuan Kasus TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



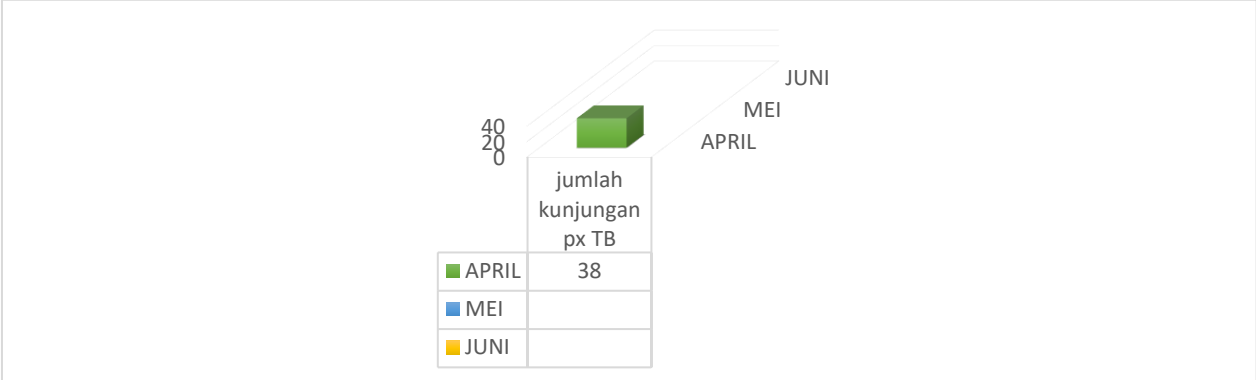
Analisis :
Pada bulan April 2025 terdapat 40 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 1 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut:
Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB

3.1.2.2.5 Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pasien TB Kunjungan Keseluruhan	38		

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



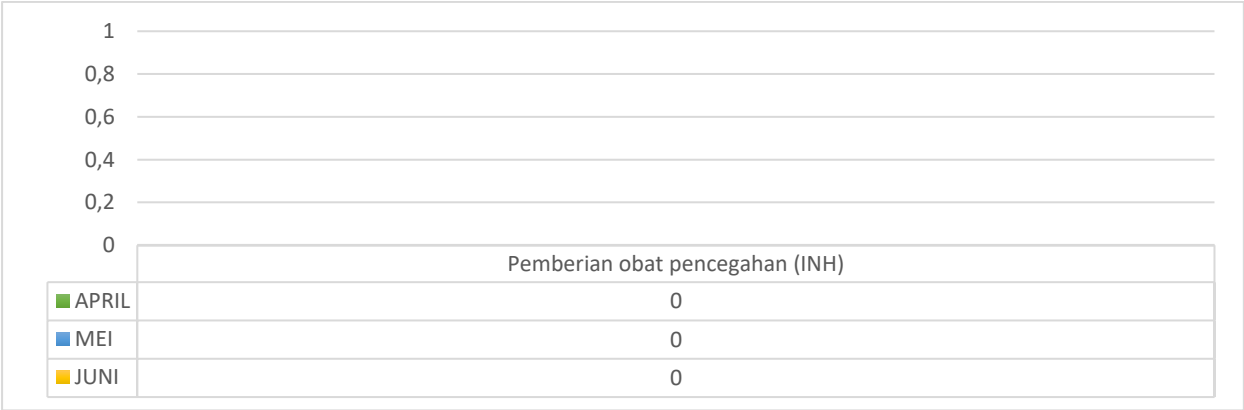
Analisis:
Jumlah keseluruhan kunjungan bulan April 2025 di poli pasien TBC mencapai 38 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	0

Grafik Pemberian Obat Pencegahan di Rumah Sakit Prima



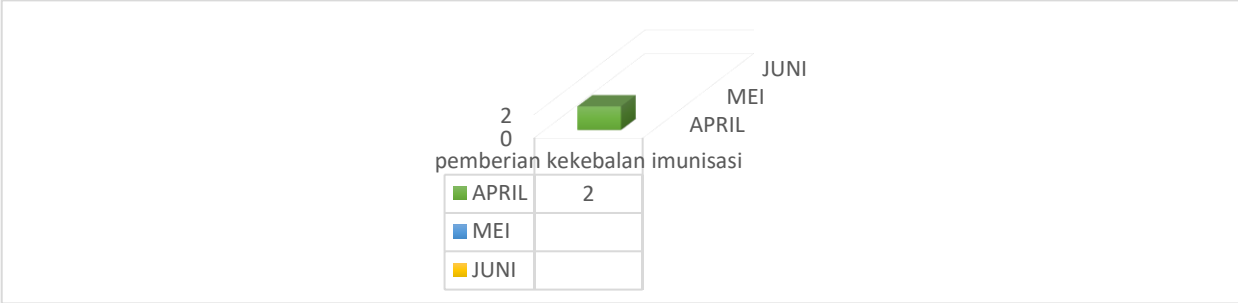
Analisis :
Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

- Rencana dan Tindak Lanjut**
- 1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
 - 2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pemberian imunisasi BCG	2		

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi Di RS Prima Husada



Analisis :
 Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan April

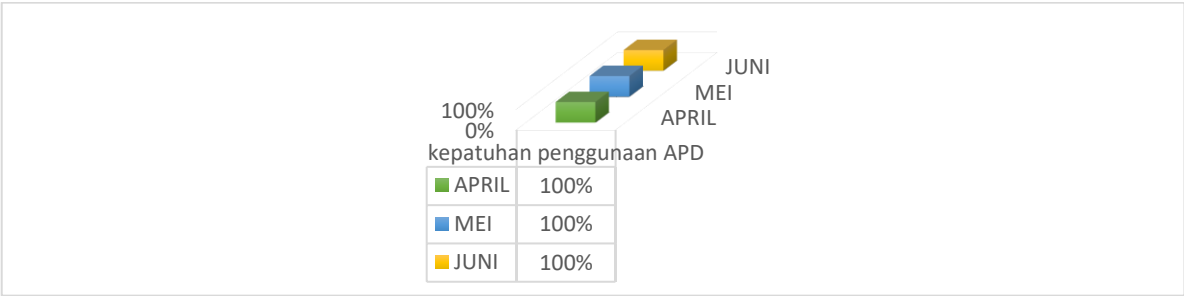
Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%		

Grafik Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APDRS Prima Husada



Analisis :
 Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

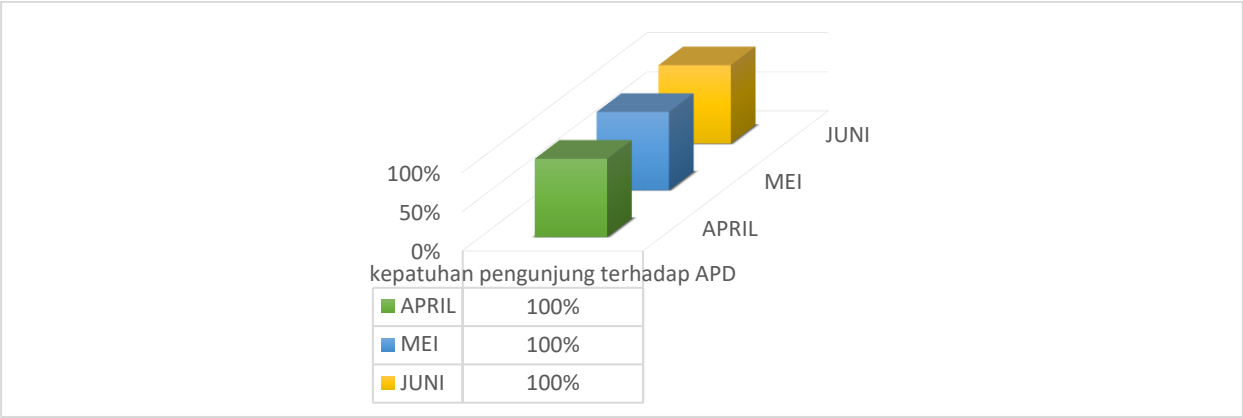
Rencana dan Tindak Lanjut :
 Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9 Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN
----	----------	---------------

		APRIL	MEI	JUNI
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%		

Grafik Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD di RS Prima Husada



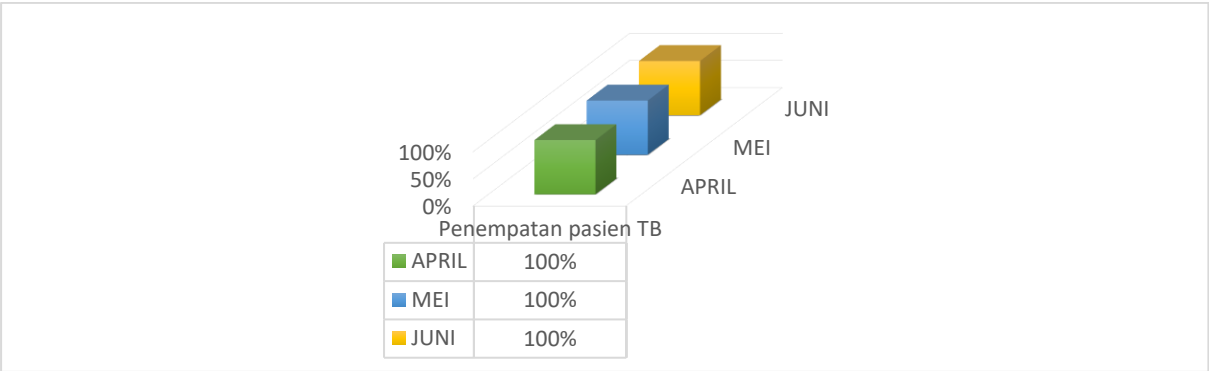
Analisis:
 Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Penempatan pasien TB	100%		

Grafik Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan April 2025



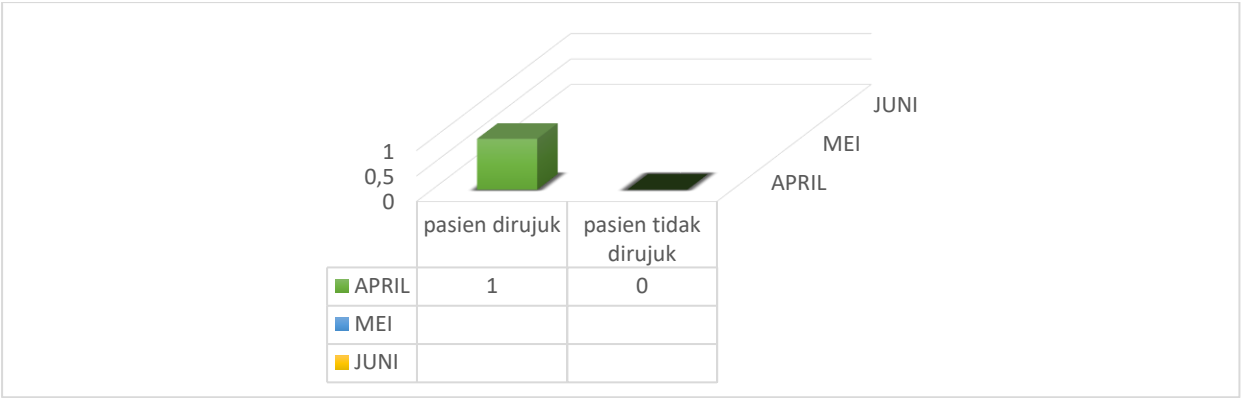
Analisis:
 Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pasien TB yang dirujuk	1		
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	0		

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



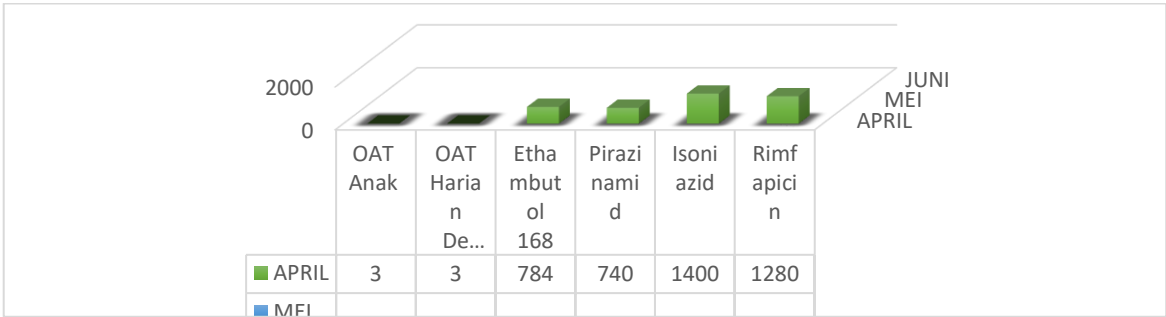
Analisis :
Pada bulan Januari 2025 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	OAT Anak	3		
2.	OAT Harian Dewasa	3		
3.	Ethambutol	784		
4.	Pirazinamid	740		
5.	Isoniazid	1400		
6.	Rimfapicin	1280		

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



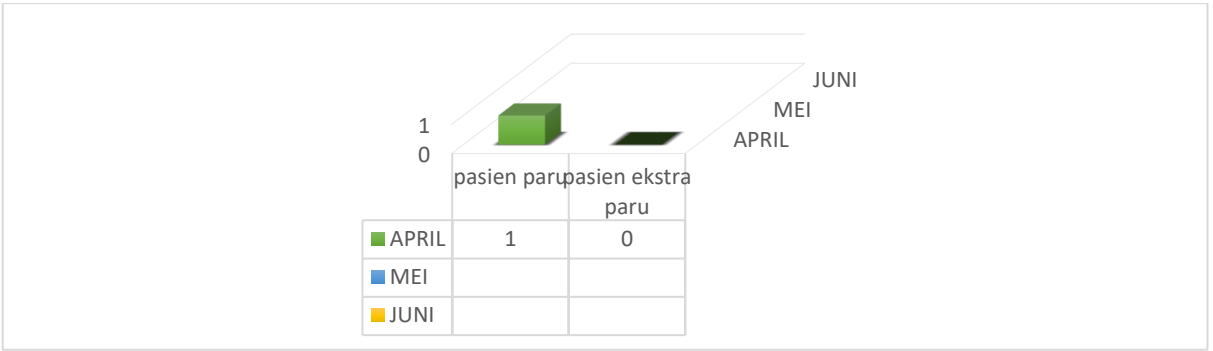
Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pasien paru	1		
2.	Pasien Ekstra paru	0		

Grafik Pasien Paru dan Ekstra Paru di Rumah Sakit Prima Husada



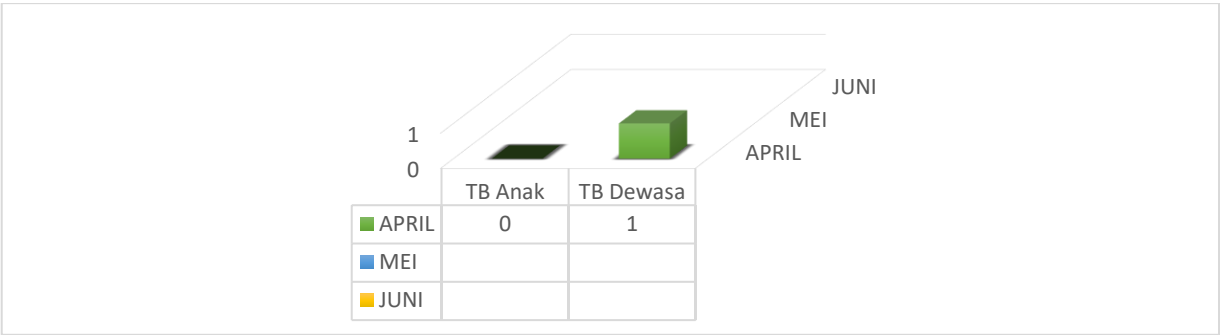
Evaluasi :
Pada bulan April 2025 terdapat 0 pasien ekstra paru

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama

3.1.2.2.14 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pasien Anak	0		
2.	Pasien Dewasa	1		

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa di Rumah Sakit Prima



Analisis :
Pada bulan April terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 1 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.1.2.2.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Ny. S	V		
		Ny. I	V		
		Ny. S	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P				
3.	Dr. Yunita, Sp. P	Tn. P	V		
		Ny. S	V		

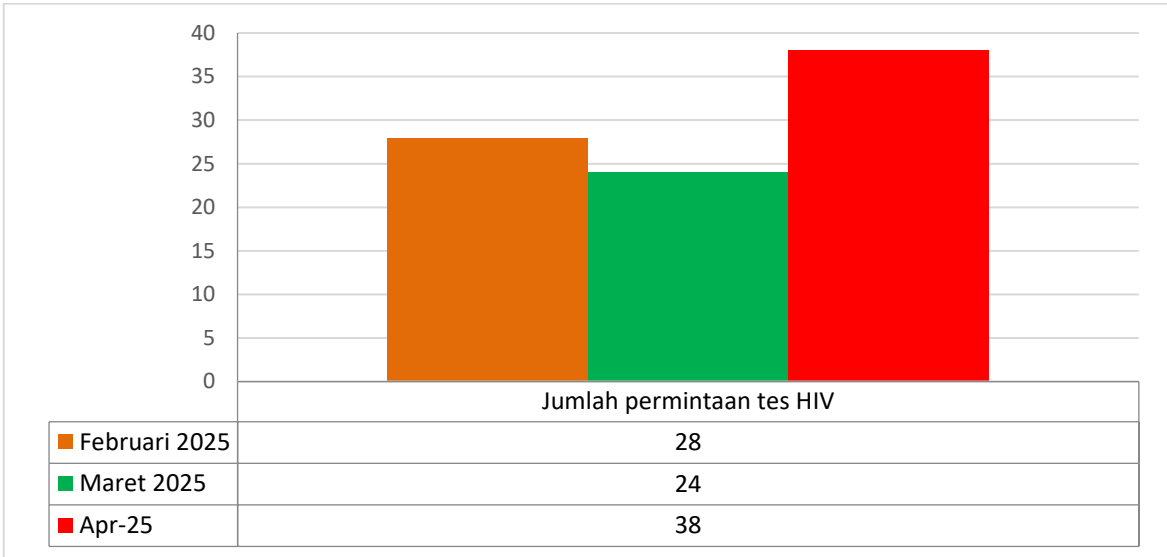
Analisis :
Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV				
NO	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	Permintaan Test HIV	28	24	38

**Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan April 2025**



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan februari 2025 sebanyak 28 pemeriksaan, pada bulan maret 2025 turun menjadi 24 pemeriksaan. Sedangkan pada bulan April 2025 sebanyak 38 pemeriksaan. Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

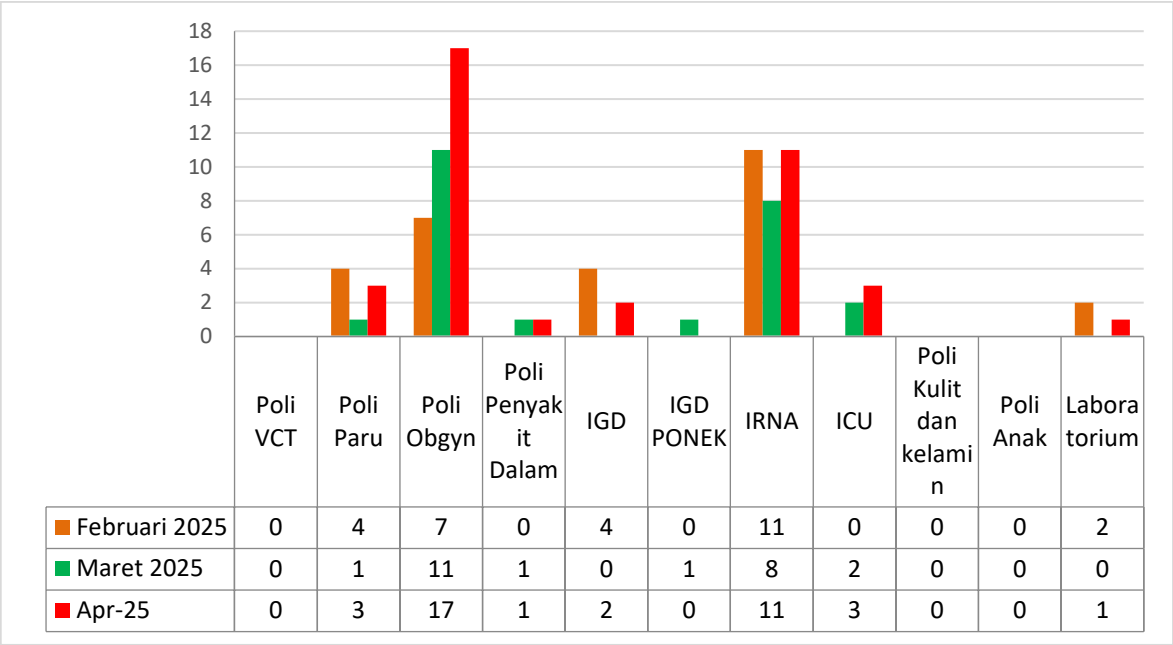
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.1.2.3.1. Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	4	1	3
3	Poli Obgyn	7	11	17
4	Poli Penyakit Dalam	0	1	1
5	IGD	4	0	2
6	IGD PONEK	0	1	0
7	IRNA	11	8	11
8	ICU	0	2	3
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	2	0	1

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV April 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain pada february 2025 sebanyak 7 pasien pada bulan Maret 2025 sebanyak 11 pasien. Sedangkan pada bulan April 2025 sebanyak 17 pasien

Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

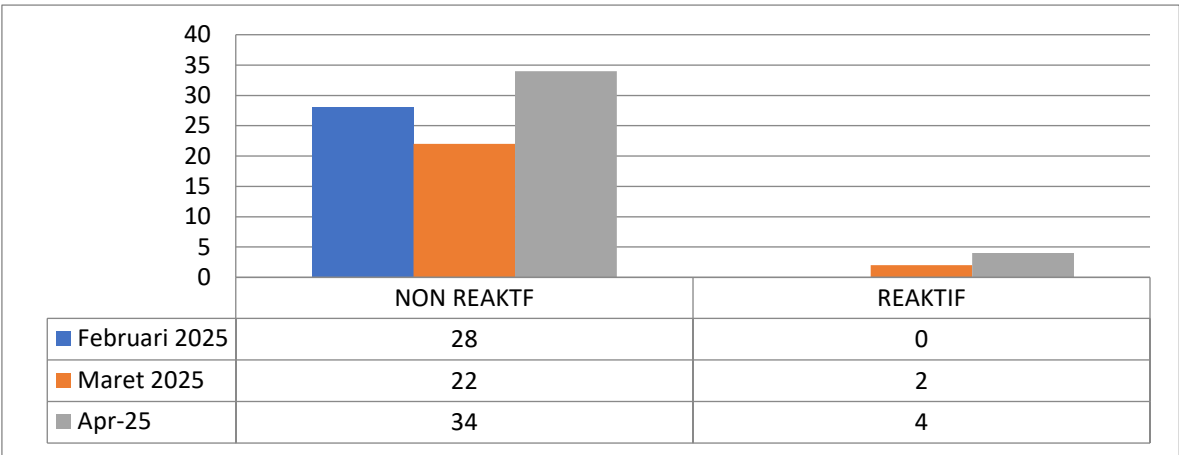
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	Non Reaktif	28	22	34
2	Reaktif	0	2	4

Grafik Status HIV April 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan Maret 2025 sebanyak 2 pasien sedangkan pada bulan April 2025 sebanyak 4 pasien.

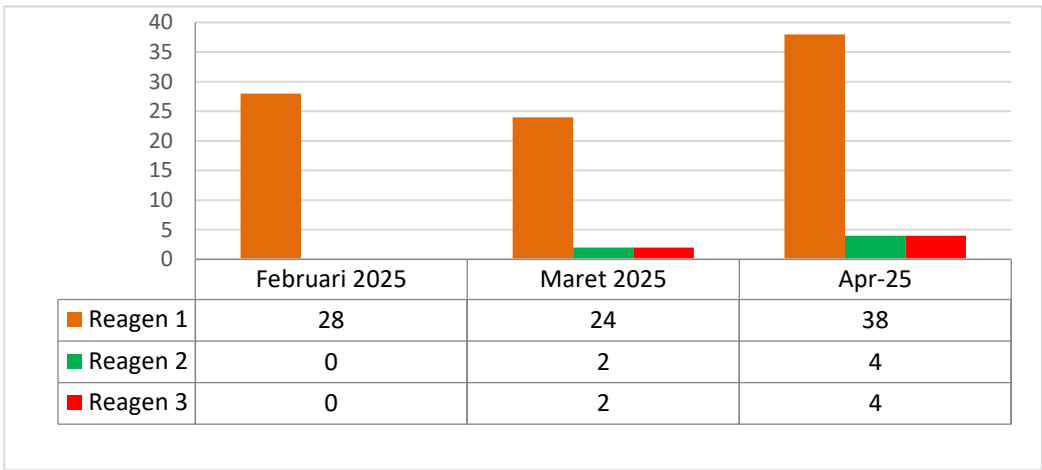
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.1.2.3.3 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	Reagen 1	28	24	38
2	Reagen 2	0	2	4
3	Reagen 3	0	2	4

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen April 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan Februari 2025 hanya memakai reagen 1 karena tidak ada pasien dengan hasil positif. Pada bulan Maret 2025 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 2 pasien. Sedangkan pada bulan April memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 4 pasien.

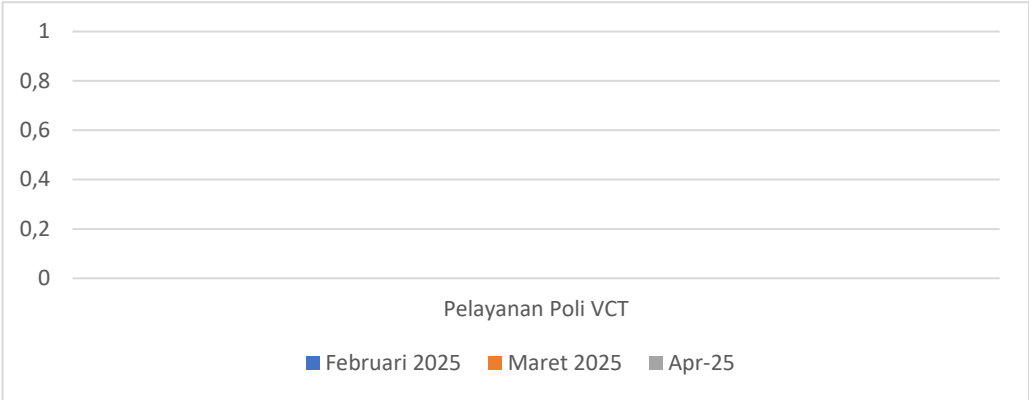
Rencana Tindak Lanjut :

Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3. Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.1.2.3.4 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT April 2025



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

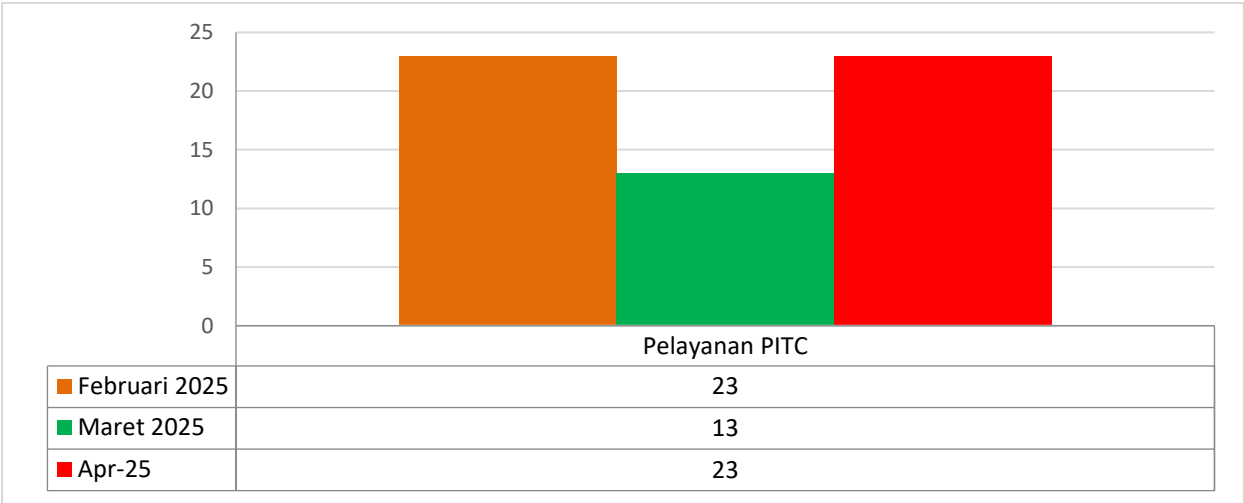
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.1.2.3.5 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	Pelayanan PITC	23	13	23

Grafik Pelayanan PITC April 2025



Analisis :

Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan februari sebanyak 23 pasien. pada bulan Maret 2025 turun menjadi 13 pasien. Sedangkan pada bulan maret sebanyak 23 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

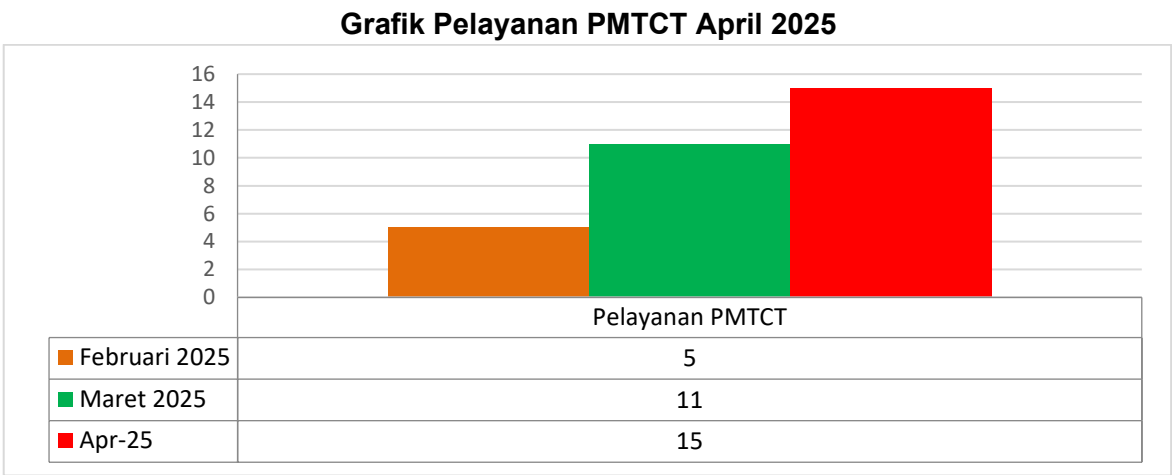
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan peningkatan terkait penjangrian pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang

pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.1.2.3.6 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	Pelayanan PMTCT	5	11	15



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada february 2025 sebanyak 5 pasien. pada bulan maret 2025 sebanyak 11 pasien. Sedangkan pada bulan April 2025 sebanyak 15 pasien.

Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

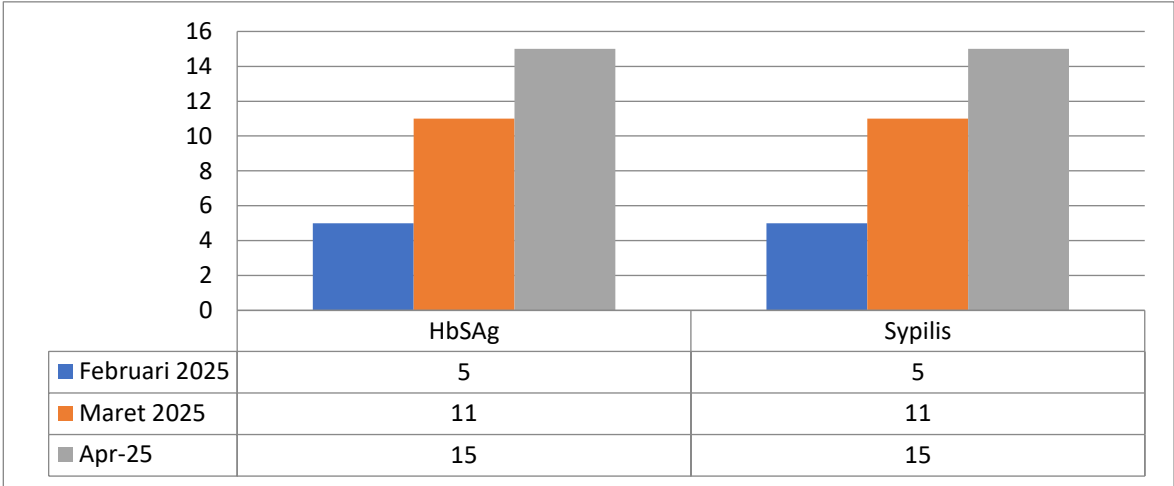
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.1.2.3.7 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	HbSAg	5	11	15
2	Sypilis	5	11	15

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
April 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Syphilis pada bulan pada bulan Februari 2025 sebanyak 5 pasien pada bulan maret 2025 sebanyak 11 pasien Sedangkan pada bulan April 2025 sebanyak 15 pasien. Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Syphilis bisa dilakukan.

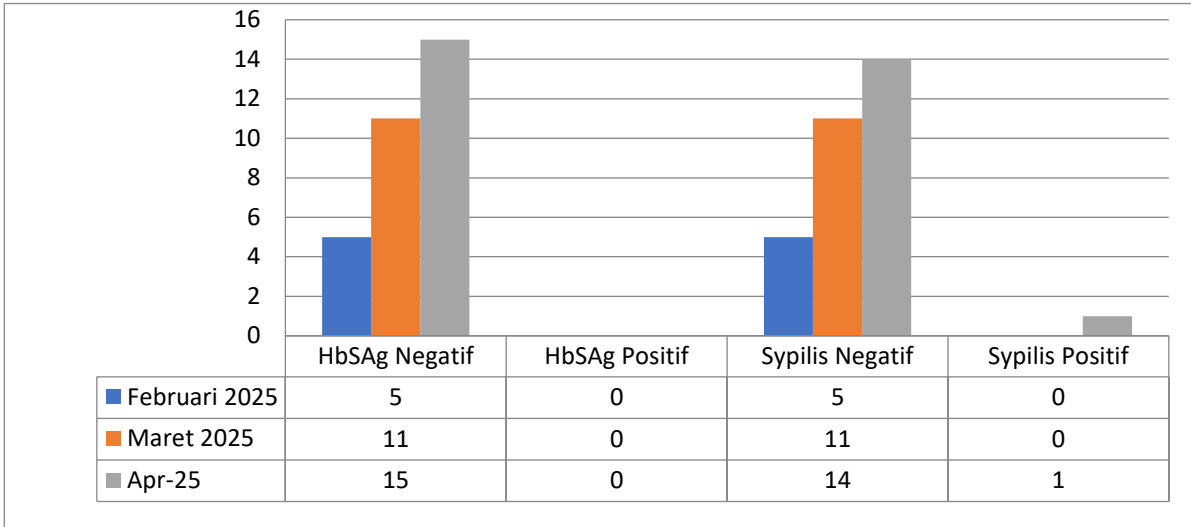
Rencana Tindak lanjut :

Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.1.2.3.8 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	HbSAg			
	Negatif	5	11	15
	Positif	0	0	0
2	Syphilis			
	Negatif	5	11	14
	Positif	0	0	1

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
April 2025



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan februari dan Maret 2025 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif. Sedangkan pada bulan april 2025 ditemukan 1 pasien positif Syphilis.

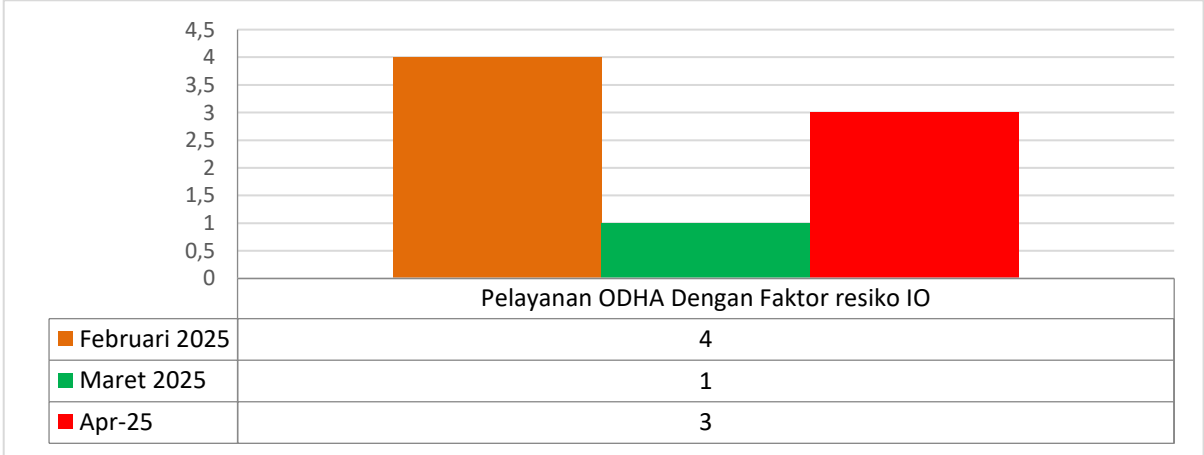
Rencana Tindak Lanjut :

1. Pada pasien HbSAg
Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
2. Pada pasien Syphilis
Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.1.2.3.9 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	4	1	3

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO April 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada bulan february 2025 sebanyak 4 pasien, pada bulan Maret 2025 didapatkan 1 pasien. Sedangkan pada bulan april 2025 sebanyak 3 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

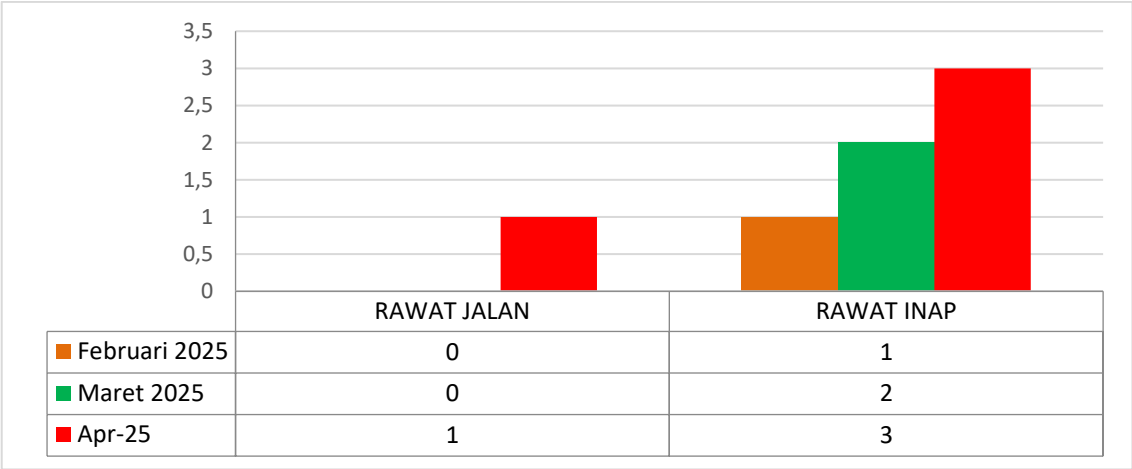
Rencana Tindak Lanjut :

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO.
Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.1.2.3.10 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	Rawat Jalan	0	0	1
2	Rawat Inap	1	2	3

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS April 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Pada bulan february 2025 tidak ada pasien dengan HIV yang dirujuk, pada bulan maret 2025 terdapat 2 pasien yang dirujuk dari rawat inap Sedangkan pada bulan April 2025 terdapat 4 pasien yang dilakuka rujuk, 3 dari rawat inap dan 1 rawat jalan.
Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV .

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

3.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting April 2025

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah sakit.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas
Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	0	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita	IRNA Anak	IRJA	1	1	1

	2. Pembagian PMBA					
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	1	1	1
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

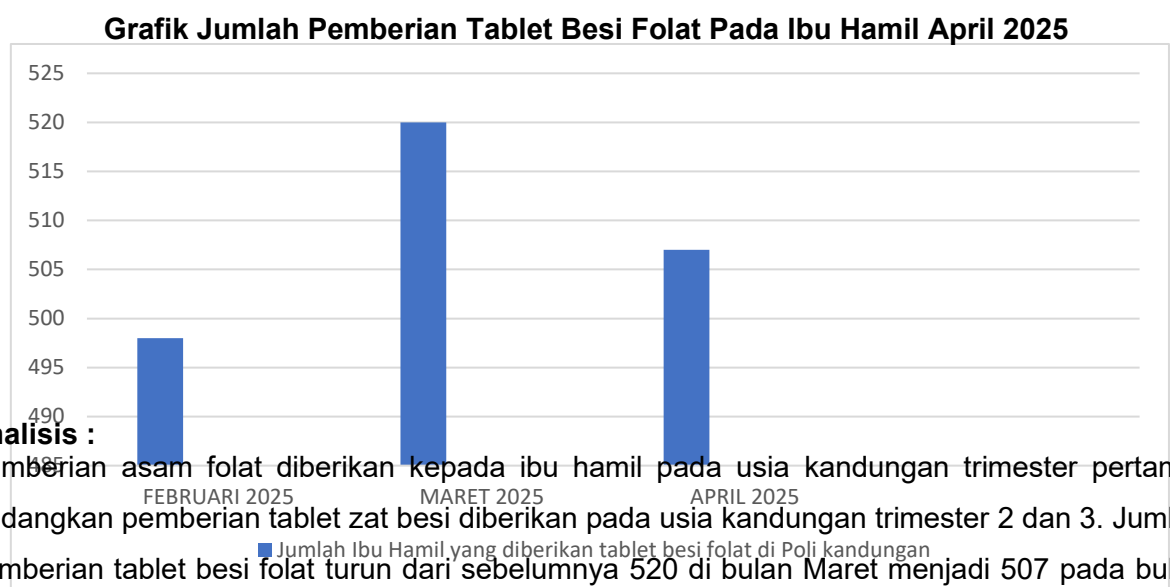
	mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia					
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

Analisis :
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

Rencana Tindak Lanjut :
 Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	498	520	507

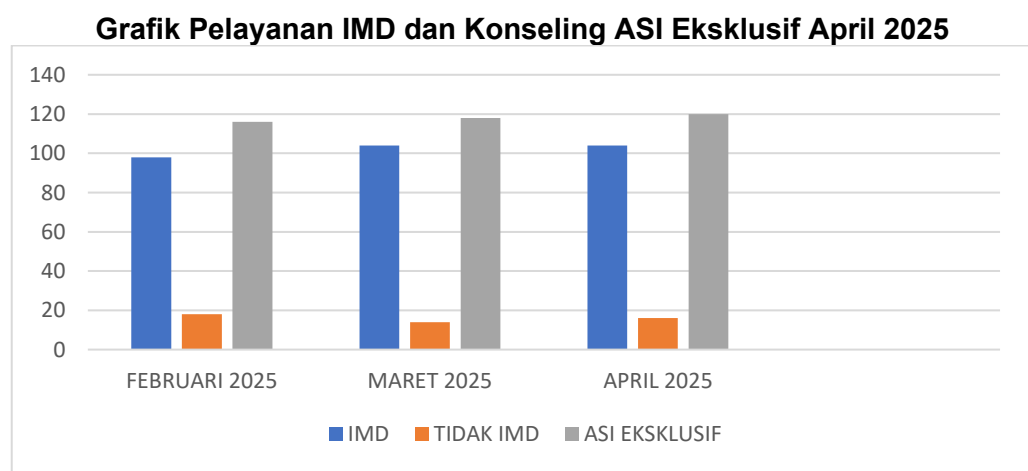


- Rencana Tindak Lanjut:**
1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	IMD	98	104	104
2	Tidak IMD	18	14	16
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	116	118	120



- Analisis :**
1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan April sebanyak 104 bayi.
 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan April 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 16 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.

- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan April 2025 yaitu sebanyak 120 pasien.

Rencana Tindak Lanjut:

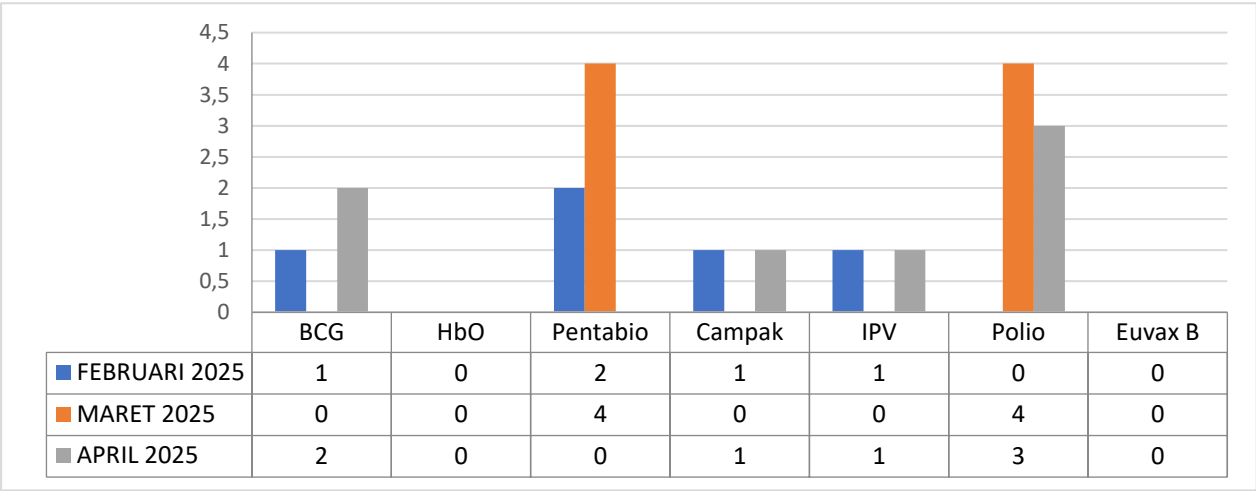
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	BCG	1	0	2
2	DPT 1	0	0	0
3	DPT 2	2	4	0
3	DPT 3	1	0	1
4	DPT 4	1	0	1
5	Campak	0	4	3
6	IPV	0	0	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada April 2025



Analisis:

- 1. Terdapat 2 balita yang melakukan imunisasi BCG di bulan April 2025.
- 2. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Pentabio, HbO, dan euvax B pada bulan April 2025.
- 3. Pada periode April 2025 terdapat 3 bayi yang melakukan Imunisasi Polio.
- 4. Terdapat 1 balita yang melakukan imunisasi campak dan IPV di RS. Prima Husada Malang.

Rencana Tindak Lanjut :

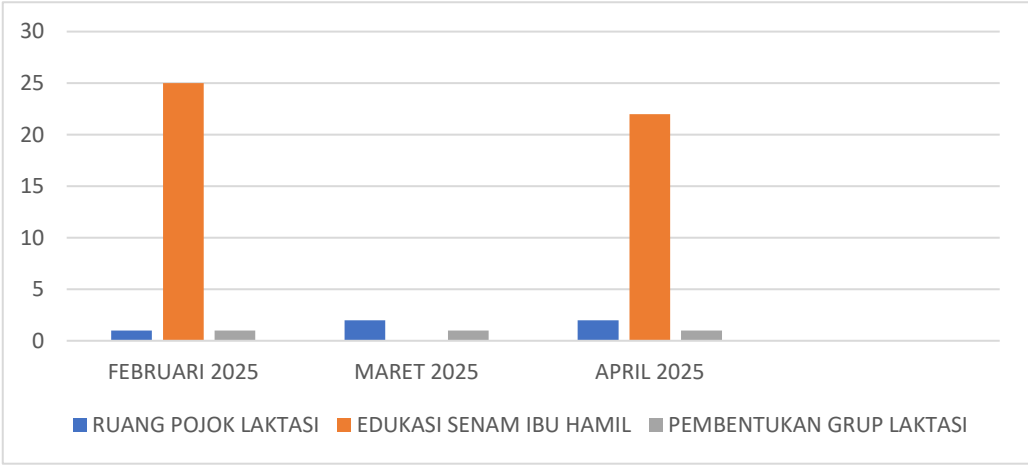
Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit. Bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk keersediaan vaksin di RS.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi

Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
Ruang Pojok Laktasi	1	2	2
Senam Hamil	25	0	22
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada April 2025



Analisis :

- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada malang.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Pada bulan April edukasi pada senam ibu hamil dilakukan dengan memberikan penyuluhan 100 HPK sebanyak 12 peserta senam ibu hamil dan 10 peserta pasien rawat jalan di poli obgyn.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting

Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

RUJUKAN MASUK				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
	-	-	-	-
RUJUKAN KELUAR				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
	-	-	-	-



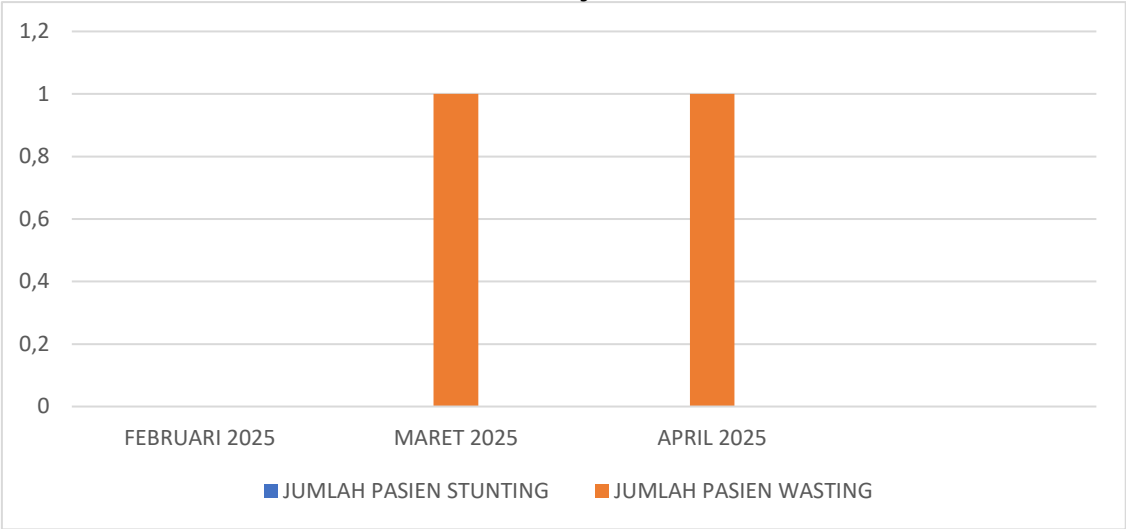
Analisis :
Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS

Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjangir pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan
Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
Jumlah Pasien Stunting	0	0	0
Jumlah Pasien Wasting	0	1	1

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :

Terdapat 1 pasien *stunting wating* pada bulan April 2025. Hal tersebut berkaitan dengan kebiasaan makan yang salah pada pasien. Ibu pasien mengatakan anak hanya makan sehari 1 kali, sulit makan meskipun sudah dipaksa, dan tidak suka menyemil makanan, makanan yang disukai berupa ice cream orang lewat depan rumah. Di mana kebutuhan energi anak defisit tingkat berat, makanan yang dimakan tidak dapat memenuhi kebutuhan energinya. Sehingga berdasarkan berat badan menurut umur dan berat badan menurut tinggi badan pasien termasuk *wasting*.

Rencana Tindak Lanjut :

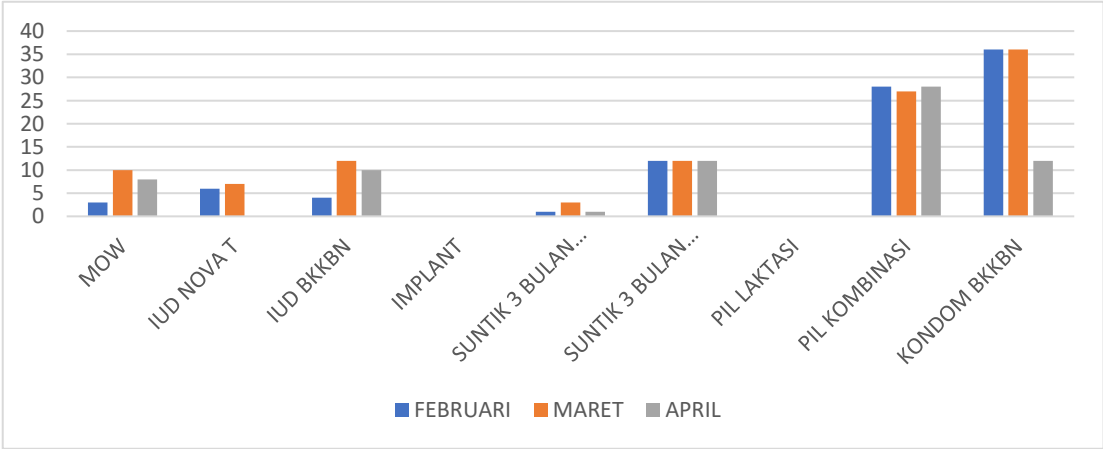
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan dokter spesialis anak untuk memberikan vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita wasting tersebut pada bulan April.

3.1.2.5 KBRs

3.1.2.6 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		Februari 2025	Maret 2025	April 2025
1	MOW	3	10	8
2	IUD Nova T	6	7	0
3	IUD BKKBN	4	12	10
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI	1	3	1
6	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN	12	12	12
7	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
8	PIL KOMBINASI	28	27	28
9	PIL LAKTASI	0	0	0
10	KONDOM BKKBN	36	36	12

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



Evaluasi :

- 1. Peserta MOW pada bulan Februari (3) naik Maret (10) April turun (8)
- 2. Peserta IUD Nova T pada bulan Februari (6) Maret (7) April turun (0)
- 3. Peserta IUD BKKBN Februari (4) Maret (12) April turun (10)
- 4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Februari (1) naik Maret (3) April turun (1)
- 5. Peserta KB suntik progestin Februari (12) Maret tetap (12) April tetap (12)
- 6. Peserta KB pil kombinasi pada bulan Februari (28) Maret (27) April (28)
- 7. Peserta KB Kondom pada bulan Februari (36) Maret tetap (36) April turun (12)

Analisis :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

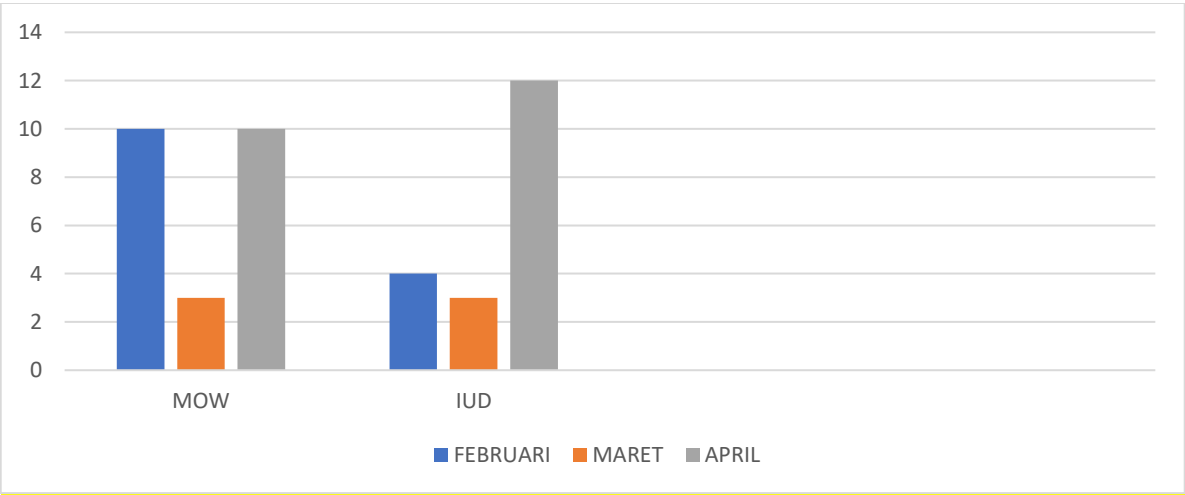
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Persalinan

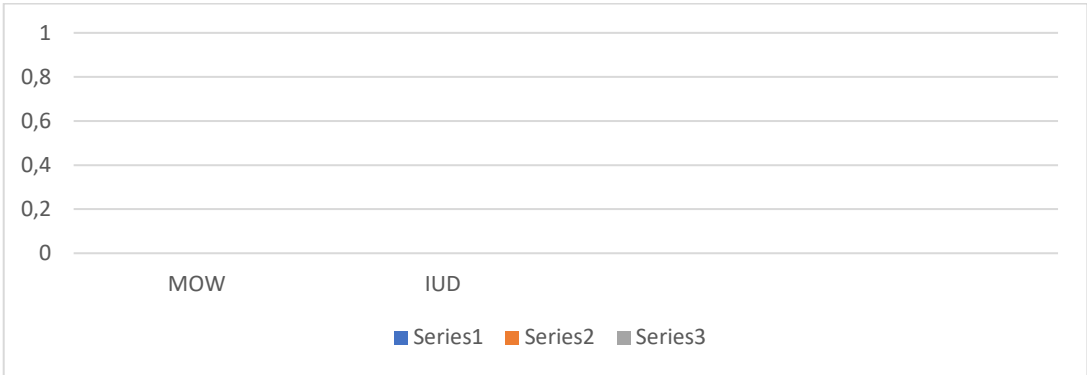
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		Februari 2025	Maret 2025	Bulan April 2025
1	MOW	3	10	8
2	IUD	3	12	11

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Februari-Maret-April menurun
2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Februari-Maret-April menetap.

Analisis :

1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan III Tahun 2025

1.2.3.1.1 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Februari 2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Santoso	L/59	dr. Yoga, Sp.JP	226229	Syok Kardiogenik	27/01/2025	02/02/2025	7	Ceftriaxone	2	2x1	14	2	7
									Levofloxacin po		1x0,5	3,5	0,5	7
2	Muslica	P/64	dr. Zaki, Sp. B	226256	Necrotizing facitis	28/01/2025	02/02/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Metronidazole inf		3x0,5	7,5	1,5	5
3	M Ifham C	L/66	dr. Anton, Sp.B	226468	Ganggren Diabetic	01/02/2025	03/02/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,75	2	0,875
4	Mudjayanah	P/61	dr. Heri, Sp.Pd	226249	DM type 2	01/02/2025	05/02/2025	5	Ceftiaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2,4	0,8	3
5	Ani Ati	P/63	dr. Heri, Sp.Pd	217025	OF	02/02/2025	05/02/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Metronidazole inf		2x0,5	3,5	1,5	2,33
6	Munjiono	L/45	dr. Anton, Sp.B	226500	Necrotizing fasciitis	03/02/2025	05/02/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	6	2	3
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
7	Tasu'in	L/67	dr. Ardhany, Sp. Pd	226683	Malaise and fatigue	05/02/2025	07/02/2025	3	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	0,5	3
8	Ponimi	P/68	dr. Zaki, Sp.Pd	226831	Post of Amputasi	07/02/2025	10/02/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Metronidazole inf		3x0,5	4,5	1,5	3
9	Nabilla I	P/25	dr. Ardhany, Sp.Pd	221471	Diarrhoea	07/02/2025	10/02/2025	4	Asam Pipemidat	2	2x0,4	2	8	2,5
									Metronidazole po		3x0,5	3	1,5	2

10	Sukardi	L/74	dr. Andy, Sp. P	200612	COPD, HT	08/02/2025	13/02/2025	6	Azitromycin po	1	1x0,5	2,5	0,3	8,3
11	Wahyu Saskya	P/23	dr. Aida, Sp.OG	227002	SC	10/02/2025	12/02/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
12	Shofi'i K	L/64	dr. Zaki, Sp.B	227077	Gangrene	11/02/2025	13/02/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
13	Chrismi Ismawati	P/24	dr. Humaira, Sp.OG	227058	Preamture repture	11/02/2025	13/02/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
14	Wiwik Indrayani	P/32	dr. Andi, Sp.B	226390	Abses Mamae Dextra	13/02/2025	16/02/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Metronidazole inf		3x0,5	4,5	1,5	3
15	Wartani	L/65	dr. Anton, Sp.B	186975	Appendicitis pedis	19/02/2025	22/02/2025	4	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
16	Sri Mardiana	P/59	dr. Ira, Sp. Jp	113462	ADHF, Susp Pneumoni	20/02/2025	24/02/2025	5	Azitromycin po	1	1x0,5	1,5	0,3	5
17	Yossy Dwi	P/28	dr. Heri, Sp.Pd	227564	TF	22/02/2025	28/02/2025	7	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2,4	0,8	3
18	Ratnawati	P/40	dr. Humaira, Sp.OG	227676	PEB	24/02/2025	26/02/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
19	Tumiasih	P/46	dr. Zaki, Sp.B	211797	Hemoroid	24/02/2025	27/02/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
20	Rosati	P/51	dr. Pradana, Sp. U	067107	Observation for susp malignant	25/02/2025	28/02/2025	4	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5

1.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Maret 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	M Sueb	L/57	dr. Heri, Sp.Pd	227934	OF H-8	01/03/2025	07/03/2025	7	Levofloxacin po	2	1x0,75	5,25	0,5	10,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
2	Sanusi	L/72	dr. Andy, Sp.P	197323	Dyspnea	03/03/2025	07/03/2025	3	Azitromycin po	3	1x0,5	1	0,3	3,33
									Meropenem		2x1	6	3	2
									Levofloxacin inf		3x0,25	1,5	0,5	3
3	Anam Jumadi	L/44	dr. Aji, Sp.Pd	123986	Enchelophathy	09/03/2025	10/03/2025	2	Metronidazole inf	2	4x0,5	3,5	1,5	2,33
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
4	David Adi	L/23	dr. Zaki, Sp.B	093671	COS 345	10/03/2025	13/03/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
5	Friska Mey	P/27	dr. Humaira, Sp.OG	225378	Gravida SC	11/03/2025	13/03/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
6	Edis Adelia	P/16	dr. Aida, Sp.OG	228456	SC	11/03/2025	13/03/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
7	Revalino T	L/26	dr. Arianto, Sp.OT	103388	CF Patela	11/03/2025	14/03/2025	4	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
8	Muhammad Noer	L/21	dr. Farid, Sp. N	049242	Chronic intractable pain	11/03/2025	15/03/2025	5	Clindamycin	1	4x0,6	7,2	1,2	6
9	Siti Mukhayana	P/55	dr. Ardhany, Sp. Pd	222081	Vomiting ec urenia	12/03/2025	15/03/2025	4	Levofloxacin	1	1x0,5	0,5	0,5	1
10	Silviana C	P/29	dr. Humaira, Sp.OG	228119	Floating Head	14/03/2025	16/03/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
11	Yohana S	P/46	dr. Ardhany, Sp. Pd	228595	CKD stage 2	14/03/2025	16/03/2025	3	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	0,5	3
12	Irwan Rahman	L/38	dr. Anton, Sp.B	150624	Hidrocel testis	14/03/2025	16/03/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5

									Ceftriaxone		3x1	7	2	3,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
13	Kasnawi	L/70	dr. Ardhi, Sp.Pd	024214	DM + Hidronefrosis renal	15/03/2025	19/03/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Asam Pipemidat		2x0.4	1,6	0,8	2,5
14	Nisviyatul Amri	P/46	dr. Oka, Sp.OT	093688	Flexor Tenosynovitis	16/03/2025	18/03/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Ruminah	P/64	dr. Arianto, Sp.OT	228665	Ruptur tendon flexor	16/03/2025	18/03/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
16	M Mukhlis	L/62	dr. Aji, Sp. Pd	228666	Chronic diarrhea	16/03/2025	20/03/2025	5	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	3,5	1	3,5
17	M Firmansyah	L/25	dr. Pradana, Sp. U	045530	Strictur Uretra	18/03/2025	20/03/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
18	Sudarsih	L/75	dr. Pradana, Sp. U	088276	Susp Nefroliasis	26/03/2025	29/03/2025	4	Gentamycin	1	2x0,04	0,28	0,24	1,167
19	Nurul Yaqin	L/58	dr. Anton, Sp.B	166085	Gangren anogenital	28/03/2025	30/03/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
20	Anggelina K	P/20	dr. Sigit, Sp. BP	229132	Injury of unspecified	28/03/2025	30/03/2025	3	Cefazolin	1	2x1	6	3	2

1.2.3.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan April 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Nadiya F	P/27	dr.Aji, Sp.Pd	212900	TF	01/04/2025	03/04/2025	3	Azitromycin po	1	1x0,5	1,5	0,3	5
2	Titik Rustanti	P/60	dr. Zora, Sp.BP	159231	DM Hiperglikemi	03/04/2025	06/04/2025	4	Ciprofloxacin inf	2	2x0,2	0,8	0,8	1
									Ciprofloxacin po		2x0,5	2	1	2
3	Kunainah	P/44	dr. Ardhi, Sp.Pd	212694	General Weaknes + DM	05/04/2025	09/04/2025	5	Asam Pipemidate	2	2x0,4	3,2	0,8	4
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
4	Indy Belva A	P/18	dr. Sigit, Sp.BP	229437	CKR 456	06/04/2025	09/04/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
5	Sri Asnanik	P/68	dr. Yoga, Sp.JP	224631	Chest pain	07/04/2025	11/04/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Ciprofloxacin inf		1x0,4	1,6	0,8	2
6	Isman Hadi	L/42	dr. Zaky, Sp.B	228110	Hernia Ingunalis (S)	08/04/2025	10/04/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
7	Askur	L/72	dr. Heri, Sp. Pd	229547	DM Hiperglikemi	09/04/2025	11/04/2025	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
8	Moch Dja'far	L/49	dr. Elvi, Sp. P	229771	Hemaptoe	13/04/2025	15/04/2025	3	Ceftriaxone	1	2x1	3	2	1,5
9	Ninik Farida	P/53	dr. Anton, Sp.B	087303	CKR 456	13/04/2025	15/04/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
10	Chindi M	P/30	dr. Aida, Sp.OG	075162	SC Eracs	14/04/2025	16/04/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
11	Parto	L/65	dr.Ardhany, Sp. Pd	229814	CKD st V + Pneumoni	14/04/2025	17/04/2025	4	Levofloxacin inj	1	1x0,5	1,5	0,5	3
12	Purnomo Edi	L/73	dr. Anton, Sp.B	162566	Gangren necrotic diabeticum	15/04/2025	17/04/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		3x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
13	Faizatul K	P/27	dr. Aida, Sp.OG	065799	SC	15/04/2025	18/04/2025	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
14	Hadi Mulyo	L/43	dr. Arianto, Sp.B	056807	Fracture of other parts	15/04/2025	17/04/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1

									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Suramah	P/64	dr.Ardhany, Sp. Pd	229894	DM Type 2	16/04/2025	20/04/2025	5	Levofloxacin inj	1	1x0,5	2,5	0,5	5
16	Sutiani	P/57	dr.Zora, Sp. Pd	178669	Gatroenteritis	17/04/2025	20/04/2025	4	Ciprofloxacin inf	1	2x0,2	1,4	0,8	1,75
17	Nofi C	P/42	dr. Zora, Sp.Pd	172291	TF	20/04/2025	24/04/2025	4	Levofloxacin po	2	1x0,5	1,5	0,5	3
									Levofloxacin inj		1x0,5	1	0,5	2
18	Anggi Annur	P/24	dr. Anton, Sp.B	230259	Necrotizing facitis coli	23/04/2025	25/04/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		3x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
19	Moch Ridwan	L/60	dr. Yoga, Sp.JP	182365	DM krisis hiperglikemi, ALO	23/04/2025	28/04/2025	6	Levofloxacin po	2	1x0,5	2	0,5	4
									Ceftriaxone		2x1	11	2	5,5
20	Jumanah	P/71	dr. Ardhany, Sp.Pd	230369	CHF	25/04/2025	28/04/2025	4	Levofloxacin inj	1	1x0,5	1,5	0,5	3

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

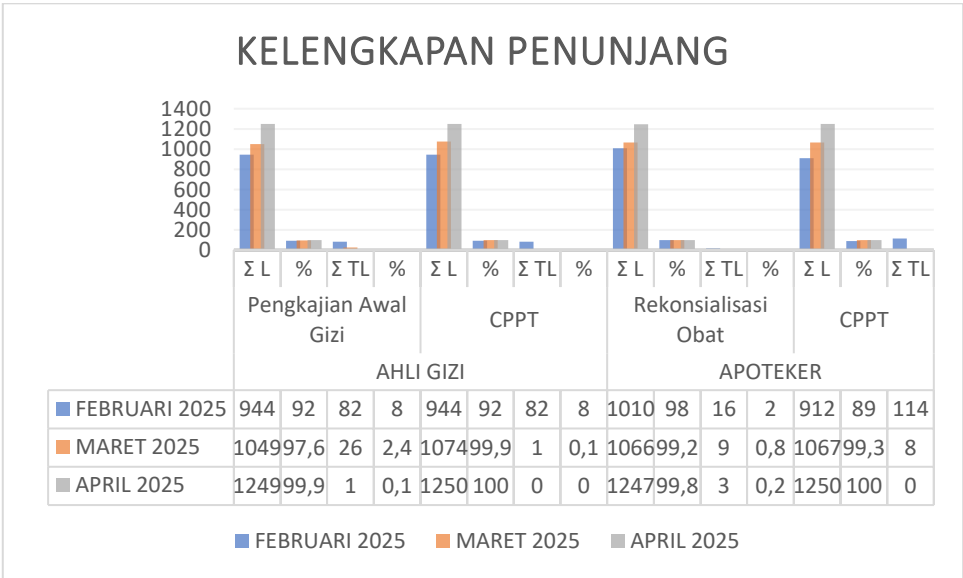
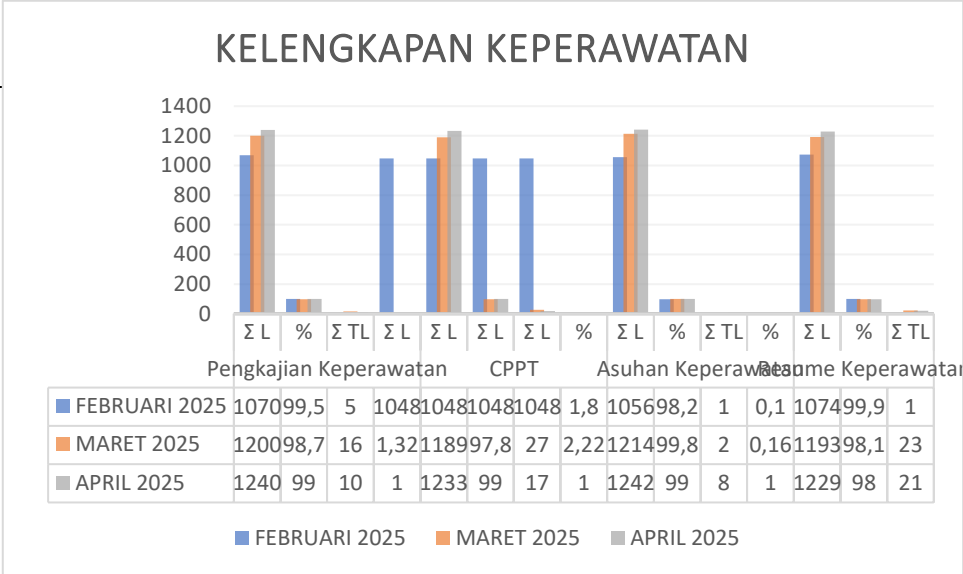
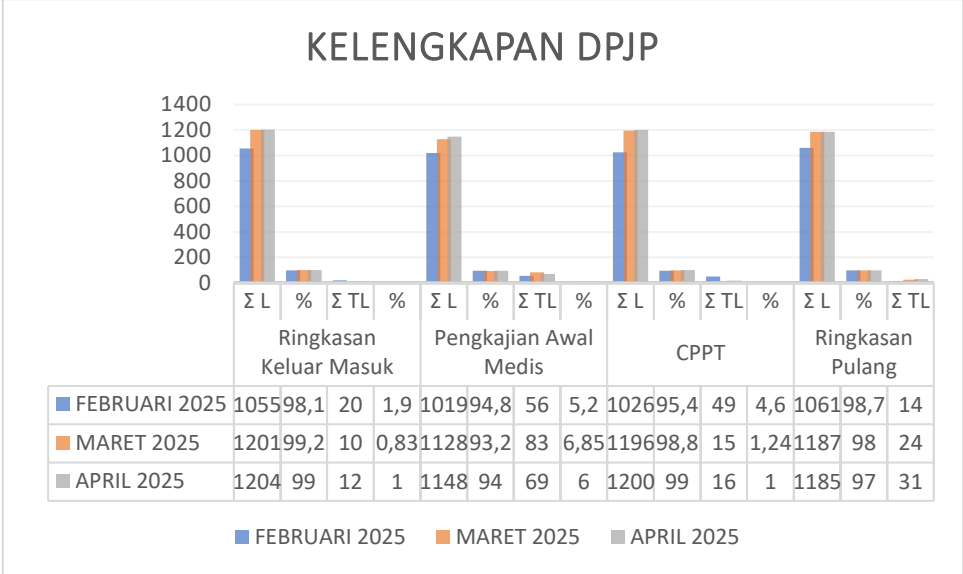
3.6.6.1 Tabel Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Februari - April Tahun 2025

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98
April	1204	99	12	1	1148	94	69	6	1200	99	16	1	1185	97	31	3

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan			
	Σ L	%	Σ TL	Σ L	Σ L	Σ L	Σ L	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89
April	1240	99	10	1	1233	99	17	1	1242	99	8	1	1229	98	21	2

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Maret	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
April	1249	99.9	1	0.1	1250	100	0	0	1247	99.8	3	0.2	1250	100	0	0

3.6.6.2 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Februari – April 2025



Analisis :
Kelengkapan DRM rawat inap DPJP dan Perawat mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena perubahan alur analisa rekam medis, perawat melakukan setor terlebih dahulu ke petugas rekam medis sehingga data yang didapatkan valid.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
2. Melakukan supervise secara berkala.
3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
4. Membuat rapot ketidaklengkapan dan kolaborasi dengan Kabid Keperawatan.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit**3.7.1 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)**

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Kurang disiplinnya penginputan BMHP /obat di IKO membuat selisih SO positif	P	Memberikan sosialisasi kepada petugas IKO tentang pentingnya penginputan obat yang akurat dan disiplin Memantau dan mengevaluasi penginputan obat di IKO untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan standart
		D	Melakukan sosialisasi penginputan obat kepada petugas IKO
		S	Mengevaluasi penginputan obat di IKO untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan standart
		A	Mengambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan analisa data
2	Fasilitas ruang OK dalam 1 bulan beberapa kali bocor	P	Kumpulkan data waktu dan lokasi kebocoran Mengidentifikasi sumber air: atap,pipa AC,saluran air Lakukan inspeksi rutin
		D	Lakukan inspeksi oleh tim teknis pada semua titik potensi kebocoran Lakukan perbaikan ringan area yang terlihat rusak
		S	Evaluasi hasil dalam 2 minggu pertama Bandingkan kondisi sebelum dan sesudah tindakan awal
		A	Jika perbaikan awal efektif,lanjutkan inspeksi dan pemeliharaan rutin Terapkan pelatihan bagi petugas kebersihan dan teknisi agar responsif terhadap tanda awal kebocoran
3	Kurang komunikasi yang baik antara Dokter DPJP dan petugas IKO	P	Membuat SOP atau panduan komunikasi standart anatara DPJP dan petugas IKO
		D	Terapkan metode komunikasi yang sudah disepakati (laporan rencana operasi)
		S	Evaluasi pelaksanaan uji coba Kumpulkan umpan balik dari petugas IKO dan DPJP
		A	Jika hasil positif, terapkan SOP komunikasi baru secara menyeluruh di seluruh unit

3.7.2 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Harga di IGD rawat jalan tetap 150 seharusnya di SIMRS harus 70 sehingga perawat harus konfirmasi kasir membuat pasien harus menunggu	P	Koordinasi dengan tim IT dan programmer dan bagian keuangan/biling rumah sakit untuk mengidentifikasi penyebab tarif
		D	Implementasi rencana: Meningkatkan jumlah petugas penerimaan pasien dan pengkajian Pemantauan waktu tunggu pasien
		S	Analisis data: Menganalisis data waktu tunggu pasien sebelum dan setelah implementasi rencana. Identifikasi kesulitan: Mengidentifikasi kesulitan yang di hadapi dalam implementasi rencana
		A	Tindakan: Mengambil tindakan dengan merubah alur yang sekarang Evaluasi: Mengevaluasi efektivitas dengan alur yang baru
2	Pelayanan di IGD yang masih sering ada komplain terkait komunikasi pasien	P	1. Identifikasi Masalah: Mengidentifikasi kebutuhan komunikasi pasien dan keluarga pasien di IGD 2.Pelatihan petugas:Memberikan pelatihan kepada petugas IGD tentang teknik komunikasi 3.Pengembangan protokol komunikasi: Mengembangkan protokol komunikasi yang jelas dan standart untuk digunakan di IGD
		D	1.Implementasi pelatihan: Melakukan pelatihan kepada petugas IGD tentang teknik komunikasi yang efektif 2.Penggunaan protokol komunikasi: Menggunakan protokol komunikasi yang telah dikembangkan di IGD
		S	1.Evaluasi kualitas komunikasi: Mengevaluasi kualitas komunikasi di IGD melalui survei pasien dan keluarga pasien 2.Analisa Data: Menganalisis data yang diperoleh dari survei untuk mengetahui apakah kualitas komunikasi di IGD telah meningkat
		A	1.Mengambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan analisa data
3	Dokter IGD masih tergantung bidan jika ada masalah obgyn di IGD	P	1.Memberikan pelatihan kepada dokter IGD tentang penanganan pasien OBGYN 2.Meningkatkan kerja sama antara dokter IGD dan bidan dalam menangani pasien OBGYN
		D	Melakukan pelatihan kepada dokter IGD tentang penanganan pasien OBGYN Melakukan pelatihan menggunakan alat bantu diagnostik seperti USG dan laboratorium di IGD
		S	1. Mengevaluasi kemampuan dokter IGD dalam menangani pasien OBGYN sebelum dan sesudah pelatihan
		A	1.Mengambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan analisi data 2.Meningkatkan kerja sama anatara dokter IGD

			dan bidan dalam menangani pasien OBGYN
4	Kurang patuhnya pengisian rigester di IGD terutama jam transfer pasien	P	1. Edukasi ulang tentang pentingnya jam transfer 2. Supervisi harian oleh kepala jaga untuk memeriksa rigester 3. Buat sistem pelaporan kepatuhan harian/mingguan
		D	1. Lakukan edukasi dalam 3 shif (pagi,sore,malam) 2.Kepala shift atau koordinator perawat IGD menegecek rigester setiap akhir shif 3.Membuat table monitoring mingguan untuk tracking kepatuhan pengisian
		S	1. 2 dari 5 shift masih menunjukkan kelalaian, terutama saat IGD ramai 2. Petugas merasa terbantu dengan checklist dan pengingat visual
		A	1.Revisi SOP: sebelum pasien di pindahkan ,pengisian rigester wajib-verifikasi oleh kepala jaga 2.Buat sistem penanggung jawab pencatatan per shif

3.7.3 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Operan keliling di unit rawat inap tidak berjalan dengan baik	P	Membuat checklist operan yang harus di bahas di unit
		D	Gunakan ceklist selama operan dan dokumentasikan secara konsisten Ambil catatan kendala atau resistensi dari staf
		S	1.Kumpulkan feedbacj dari staf 2.Lihat dokumentasi operan 3.Observasi langsung bebrapa operan untuk menilai kualitas komunikasi 4.Bandingkan data kepuasan pasien dan staf sebelum dan sesudah
		A	1.Jadikan checklist bagian dari sop operan keliling
2	Kurang pekanya petugas perawat ke pasien	P	1.Terapkan program 5 S 2. Supervisor melakukan observasi pendek harian ke pasien
		D	1.Implementasikan program 5S dan umpan balik harian selama 2 minggu 2. Supervisor mencatat observasi perilaku empatik
		S	1.Tingkat kepuasan pasien akan meningkat 2.Jumlah komplain akan menurun 3.Kedekatan pasien dan perawat akan lebih dekat
		A	1. Mengintegrasikan program empati ke dalam alur kerja, contoh mengganti infus 2. Lanjutkan observasi supervisor dan rotasi pelatihan untuk staf baru
3	Menemukan staf yang berpasangan kurang profesional bekerja saat di rumah sakit	P	1.Menyusun ulang kebijakan atau kode etik profesional, khususnya soal hubungann personal di lingkungan kerja 2.Sosialisasi melalui zoom dengan SDM

			3.Tingkatkan pengawasan oleh kepala ruangan/supervisor 4.Lakukan pendekatan personal jika ada pasangan yang sudah teridentifikasi, dengan pendekatan coaching 5.Siapkan mekanisme pelaporan anonim jika ada pelanggaran berulang
		D	1.Sosialisasi kebijakan “batas profesionalisme”kepada semua staf dalam waktu 1 minggu 2.Supervisi lebih rutin di area kerja 3.Kepala ruangan mengamati langsung pasangan staf yang diduga kurang profesional 4.Lakukan sesi sosialisasi satu per satu (privat) dengan staf yang terkait,tanpa mempermalukan 5.Pasang pengingat visual tentang” integritas & profesionalisme kerja”diarea staf
		S	1.Evaluasi selama 2 minggu di unit 2.Supervisor melaporkan peningkatan fokus kerja dan penurunan interaksi pribadi berlebihan saat jam kerja
		A	1.Integrasikan kode etik profesional ini ke dalam peilaian kinerja bulanan
4	Kurang patuhnya perawat dalam menjalankan advice dpjp untuk dikonsulkan ke verifikator	P	1.Kurang pemahaman perawat tentang pentingnya advice DPJP untuk verifikasi klaim 2.Sosialisasi kembali ke staf perawat untuk selalu melaporkan advice DPJP ke verifikator 3.Supervisi ruangan memantau dan memberi umpan balik harian/mingguan
		D	1.Sosialisasi kembali sop yang sudah ada 2.Kepala ruangan /supervisor menegecek setiap hari apakah advice sudah di jalankan
		S	DPJP mulai merasa lebih didukung oleh tim perawat
		A	Terapkan komunikasi antar-shif berbasis handover dengan item’pending advice Evaluasi mingguan oleh kepala ruangan-lapor tim mutu bila ditemukan kelalaian

3.7.4 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Pasien batal kunjungan di ERM sudah bersih tidak ada datanya tetapi di non ERM masih muncul	P	1.Identifikasi sistem non- ERM mana saja yang masih menyimpan data pasien batal. 2.Koordinasi dengan TIM programer dan rekam medis untuk meninjau alur sinkronisasi 3.Buatkan SOP penghapusan data terintegrasi dari semua sistem
		D	1.Tim programer menandai semua transaksi pembatalan kunjungan -dicatat dan di telusur 2.Lakukan sosialisasi kepada petugas pendaftaran untuk menggunakan “pembatalan resmi”
		S	Evaluasi 1 minggu auntuk mengetahui masalah yang ada di unit

		A	1.Membuat sistem terintegrasi agar ketika kunjungan dibatalkan di ERM,semua sistem lain ikut terintegrasi 2.Membuat penanggungjawab harian untuk validasi pasien batal
2	Kurangnya sosialisasi dari pihak farmasi ke DPJP terkait kekosongan obat	P	1.Membuat sistem early warning list obat kosong/terbatas yang di update harian oleh farmasi 2.Menunjuk PIC farmasi yang bertanggungjawab menyampaikan update
		D	Farmasi membuat list obat kosong/kritis tiap pagi jam 08.00 PIC farmasi mencatat siapa saja yang sudah menerima informasi Uji coba sistem ini selama 2 minggu
		S	Jumlah resep kosong teratasi DPJP merasa lebih mudah mengantisipasi pergantian obat
		A	Terapkan sistem digital Evaluasi mingguan oleh tim farmasi
3	Kurangnya service excellent dari petugas terkait keramahan petugas	P	Mengadakan pelatihan singkat terkait service excellent dan komunikasi empatik Supervisi harian diam-diam oleh kepala unit
		D	Laksanakan pelatihan di semua shift Supervisi melakukan pengamatan diam-diam terhadap minimal 3 interaksi petugas/hari
		S	Hasil evaluasi 1-2 minggu awal Ditemukan bahwa beberapa area (contoh:IGD) lebih sulit menerapkan service excellent saat over load
		A	Melanjutkan pelatihan jika evaluasi berhasil

3.7.5
Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Retur barang dari rawat inap : 3) Obat tak bertuan → gudang retur (secara sistem), namun fisiknya dikembalikan ke rak barang retur di depo farmasi → setelah diretur ke gudang, kains akan order obat dengan jumlah sesuai yang ada di gudang retur agar dapat dimasukkan kembali menjadi stok depo. 4) Obat bertuan → depo farmasi melalui fitur Retur Penjualan. Retur barang dari rawat jalan → Depo Farmasi melalui fitur Retur Penjualan .	P	Pelaksanaan retur obat tidak bertuan dan obat bertuan berjalan rutin.
		D	Sosialisasi alur retur obat untuk meminimalkan selisih stok.
		S	Tidak perlu ada gudang retur karena menambah rantai proses retur yang tidak diperlukan. Untuk efisiensi, seluruh obat dari unit baik bertuan atau tidak harus dikembalikan melalui depo farmasi.
		A	1. Obat bertuan dikembalikan melalui fitur Retur Penjualan. 2. Obat tidak bertuan dikembalikan melalui fitur sesuai dengan kondisinya yaitu : 5) Penerimaan Barang Konsinyasi 6) Penerimaan Obat yang Dibeli Antar RS 7) Penerimaan Obat Tidak Bertuan 3. Fitur penerimaan farmasi lainnya dibuat berjenjang : diajukan oleh Kains Farmasi (dengan adanya fitur keterangan untuk menjelaskan alasan penerimaan obat lainnya) → diapprove oleh PT → baru bisa

			menambah ke stok depo. Berita Acara tetap dilampirkan sebagai arsip RS. 4. Buat PJ retur tiap shift di depo yang bertanggung jawab terhadap proses retur mulai dari penerimaan barang fisik, penginputan ke sistem, penilaian obat layak/tidak, pengembalian obat retur di rak obat depo.
2.	Perubahan alur iter resep BPJS Kesehatan karena adanya fitur surat kontrol di SIMRS	P	Sosialisasi dan pemahaman petugas terkait SPO Alur Iter Resep BPJS Kesehatan
		D	Sosialisasi SPO
		S	Kitir iter yang ditulis manual menimbulkan kesalahan resep tidak di centang iter oleh DPJP karena kurangnya double check antara perawat dan farmasi.
		A	Perubahan di Poli : 1. DPJP input e-resep ITER 1x atau 2x di Billing SIMRS sesuai dengan kondisi pasien 2. Input rencana lanjutan pasien dan pilih menu iterasi obat. 3. Poli input sesuai advice DPJP. 4. Cetak Surat Iterasi Obat (Kitir manual iter dihilangkan). Perubahan di Farmasi : 1. Menerima Surat Iterasi Obat dan KPO dari pasien. 2. Menyerahkan Copy Resep-KPO yang dijepret jadi satu kepada pasien untuk kunjungan selanjutnya. Perubahan di CSO : 1. Beri paraf dan nama pada Surat Iterasi Obat
3.	Penertiban pasien yang mengambil obat diluar jam pelayanan rawat jalan	P	Sosialisasi dan pemahaman petugas agar tidak menolak pasien yang mengambil obat tertinggal di hari Sabtu dan Minggu di atas pukul 14.00 WIB.
		D	Sosialisasi ke Apoteker dan TTK
		S	Komplain pasien terkait penolakan dari farmasi untuk ambil obat tertinggal di hari sabtu dan minggu di atas pukul 14.00 WIB.
		A	Jika ada pasien yang sudah datang ke RS untuk mengambil obat tertinggal rawat jalan tetap dilayani walau diluar jam pelayanan rawat jalan, dan tetap di kie berulang untuk waktu pengambilan obat.
4.	Perubahan alur permintaan SPB (Surat Permintaan Barang) ke gudang farmasi menjadi 3 kali dalam seminggu.	P	Permintaan SPB (Surat Permintaan Barang) ke gudang farmasi menjadi 3 kali dalam seminggu
		D	Koordinasi dengan petugas Gudang farmasi
		S	Semua komposisi Gudang hari minggu setelah SO diliburkan karena telah melakukan kegiatan input SO malam. Evaluasi kegiatan serah terima setelah stok opname jika sertim selasa, Kamis sabtu, minggu habis so tidak ada sertim. Barang yang diserahkan terimakan tidak terlalu banyak.

		A	1. Perubahan alur input SPB pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari serah terima barang tiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. 2. Gudang tetap libur semua di hari minggu, senin dilakukan SPB untuk tambahan permintaan untuk setelah SO. 3. Komposisi jaga Gudang farmasi pada hari serah terima tidak ada yang libur agar waktu sertim tidak mundur sampai pukul 13.00 WIB.
5.	Alur permintaan Breathing Circuit Bubble Cpap; Breating Circuit Double Heated Wire Neonatal; Breathing Circuit Ventilator Adult; Breathing Circuit Ventilator Child untuk pasien umum diinput BMHP ke gudang farmasi. Hal ini menyebabkan sering selisih stok dikarenakan perawat tidak ada stok breathing di ruangan. Jika ada permintaan pada malam hari dan gudang tutup jadi perawat ambil barangnya ke depo dan utang barang ke depo namun operan farmasi tidak jalan sehingga lupa tidak follow up ke perawat.	P	Perubahan alur permintaan bmhp breathing CPAP dan bmhp breathing ventilator untuk pasien umum
		D	Melakukan koordinasi dengan Kabid Penunjang Medis, Kabid Keperawatan, dan Karu
		S	Breathing Circuit Bubble Cpap; Breating Circuit Double Heated Wire Neonatal; Breathing Circuit Ventilator Adult; Breathing Circuit Ventilator Child tarif BMHP sudah termasuk jasa tindakan CPAP dan Ventilator.
		A	Perubahan alur permintaan Breathing Circuit Bubble Cpap; Breating Circuit Double Heated Wire Neonatal; Breathing Circuit Ventilator Adult; Breathing Circuit Ventilator Child khusus penjamin UMUM : 1. Perawat input Breathing Circuit CPAP atau Breathing Ventilator pada fitur resep "Tambah Paket" di biling perawat artinya input resep tanpa tarif. 2. Farmasi cek resep sudah tercentang obat paket dan simpan resep. Tujuan : tidak ada tambahan tarif. 3. Perawat ambil barang ke depo farmasi 4. Permintaan BMHP ke Gudang Farmasi khusus Breathing Circuit Bubble Cpap; Breating Circuit Double Heated Wire Neonatal; Breathing Circuit Ventilator Adult; Breathing Circuit Ventilator Child ditiadakan.
6.	Alur paket kuret ODC di Rawat Jalan yang semula diinput perawat rawat jalan namun salah input resep di Tambah Paket sehingga tarif tidak muncul di keuangan.	P	Evaluasi alur peresepan paket kuret ODC Rawat Jalan.
		D	Melakukan koordinasi dengan Kabid Pelayanan Medis dan Verifikator.
		S	Resep paket kuret ODC rawat jalan tarif harus muncul di keuangan untuk di klaim.
		A	Alur peresepan paket kuret ODC RJ disepakati diinput oleh bidan maternitas. Alurnya: 1. Apabila pasien berkunjung ke poli → advice tindakan kuret → paket di ambil oleh maternitas → bidan input resep paket kuret sesuai yg terpakai. 2. Apabila pasien dijadwalkan kuret → pasien ke igd → paket diambil bidan ponek igd → bidan input resep paket kuret sesuai yg terpakai.

			3. Farmasi mengambil paket kuret dan menyiapkan tambahan sesuai list. 4. Farmasi cek inputan resep sesuai yg terpakai dan cek resep tanpa centang obat paket (agar tagihan tetap masuk dikeuangan).
7.	Hasil stok opname farmasi yang sudah stabil pada akhir tahun 2024 dan belum mencapai target selisih 0.	P D S A	Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname Berdasarkan Surat Edaran dari RS Nomor 218/I-SE/DIR/III/2025 tentang Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname Farmasi disampaikan beberapa kebijakan Evaluasi hasil stok opname belum mencapai target 0 1. Penyesuaian / Adjustment stock (akibat dari adanya selisih hasil stock opname) dengan acuan selisih wajar sebesar 1% dari total persediaan TIDAK LAGI DIBERLAKUKAN per 1 Januari 2025. 2. Acuan selisih hasil SO sesuai dengan BA (Berita Acara) hasil SO. 3. Selisih Kurang (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO < jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu dan menentukan unit yang terlibat kemudian hitung beban 60% kepada Manajemen Rumah Sakit (Direktur Rumah Sakit, Kabid Penunjang, Kabid Pelayanan Medis, Kabid Keperawatan, Kabid Umum & keuangan, Kains. Farmasi). Penanggung jawab rak dan unit terlibat sebesar 40% dari jumlah selisih SO. Pembebanan langsung pada periode berjalan. 4. Selisih Lebih (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO > jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu, jika selisih lebih masih dalam selisih wajar tidak dibebankan, jika terdapat selisih lebih yang mengalami peningkatan ekstrim, maka diberlakukan pembebanan selisih lebih hasil SO berupa teguran tertulis dari direktur rumah sakit kepada unit penyebab selisih SO dan penanggung jawab rak. 5. Hasil dari perhitungan selisih akan disesuaikan dalam penggajian setiap bulan
8.	Terdapat selisih stok opname yang fluktuatif. Februari 2025 : +5.439.289 Maret 2025 : +1.009.675 April 2025 : + 5.327.247 Belum berjalan scan barcode menunggu antrian Programmer PT	P D S	Perencanaan scan barcode. 1. Mengajukan proposal scan barcode dan mengajukan kebutuhan alat yang menunjang pelayanan. 2. Melakukan presentasi perencanaan scan barcode beserta tujuan dan manfaatnya. Scan barcode dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data,

			pengendalian stok yang lebih baik, kepatuhan terhadap regulasi, pengurangan biaya operasional, tindak lanjut yang lebih efisien, integrasi sistem yang lebih baik, peningkatan pelayanan pasien.
		A	Pengajuan software aplikasi barcode ke progamer dan pengajuan alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper ke Pengadaan Umum PT. DPM.
9.	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual dan membuat waktu obat jadi lama. Prosentase waktu tunggu obat non racikan 75.13% dan waktu tunggu obat racikan 60.78%	P	Menggunakan KPO digital dalam pelayanan resep.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk membuat fitur KPO digital di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker.
		S	Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO.
		A	1. Follow up ke Programmer. 2. Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang. 3. KPO tertinggal ada 126 KPO.
10.	Obat tertinggal 2x24 jam	P	Perbaikan kebijakan obat tertinggal.
		D	Membuat rekapan pasien yang sudah mendapat pengantaran gratis.
		S	1. Obat tertinggal bulan April sudah mengalami penurunan namun masih ditemukan pasien mengambil obat lebih 2x24 jam. 2. Primantara sudah menghubungi pasien agar obat tertinggal dikirim oleh primantara namun banyak pasien menolak karna obat diambil sendiri ke farmasi.
		A	1. Pasien yang obatnya tertinggal dimintai data agar mudah diidentifikasi. 2. Pengantaran gratis membantu farmasi agar tidak terjadi penumpukan obat tertinggal, terkadang pasien memang ada yang tidak mau tapi tetap di edukasi untuk obat diantar.
11.	Penambahan daftar obat near ED	P	Mempercepat pengeluaran barang near ED.
		D	Membuat surat edaran untuk DPJP supaya membantu mengeluarkan barang near ED dari Depo Farmasi maupun Gudang Farmasi.
		S	Obat near ED yang tidak segera dikeluarkan akan mejadi deathmoving dan menyebabkan kerugian terhadap rumah sakit.
		A	1. Kolaborasi dengan Komite Medik untuk membantu pengeluaran barang near ED. 2. Melakukan negoisasi dengan DPJP untuk menggunakan barang near ED sesuai dengan kebutuhan.

			3. Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk melakukan retur obat near ED kepada distributor.
12.	Tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai dengan standar, ditemukan indikator vaksin pemerintah yang berubah warna sehingga tidak layak digunakan.	P	Mengadakan VR di Depo Farmasi sesuai dengan standar penyimpanan vaksin.
		D	Memperbaiki VR yang ada supaya bisa digunakan kembali. Menedukasi perawat dan petugas farmasi terkait penyimpanan yang benar.
		S	Vaksin yang tidak layak diberikan kepada pasien bisa dikembalikan ke Puskesmas Wilayah, tetapi RS harus memikirkan bagaimana vaksin tidak sampai diretur.
		A	1. Vaksin pemerintah disimpan di VR Gudang Farmasi. 2. Perubahan alur pengambilan vaksin oleh perawat poli.
13.	Fitur retur barang rusak tidak bisa mengeluarkan stok di monitoring stok.	P	Perbaikan fitur retur barang rusak.
		D	Koordinasi dengan Programmer PT.
		S	1. Barang expired date perlu dikeluarkan stoknya dari SIMRS menggunakan fitur retur barang rusak kemudian dilalukan pemusnahan obat namun fitur tersebut tidak dapat mengeluarkan stok dari sistem. 2. Sudah dilakukan receive retur namun stok masih muncul di monitoring stok, tapi di pengeluaran barang dan mutasi barang sudah 0.
		A	Follow up progamer.
14.	Floorstok IKO	P	Mendisiplinkan perawat untuk menjalankan SPO.
		D	Koordinasi dengan Kabid Keperawatan.
		S	Kendala di FS IKO dimana perawat anestesi belum menjalankan inputan resep terlebih dahulu kemudian disiapkan oleh farmasi dikarenakan tidak menyanggupi jika operasi berlangsung berturut-turut. Dan informasi SPO sudah diedarkan dan dijelaskan namun perawat belum menjalankan sesuai SPO.
		A	Monitoring dan evaluasi.
15.	Ditemukan resep IU (Ketidaksesuaian surat kontrol poli dengan jadwal ambil obat apotek online BPJS Kesehatan 30 hari). Februari 2025 = 31 resep Maret 2025 = 116 resep April 2025 = 47 resep	P	Koordinasi dengan Karu poli dan Kabid Keperawatan
		D	1. Sosialisasi fitur edit no apol. Koordinasi dengan Karu poli dan Kabid Keperawatan untuk edukasi ke perawat perhitungan obat 30 hari agar surat kontrol sesuai.
		S	1. Perawat salah perhitungan obat 30 hari sehingga surat kontrol tidak sesuai 30 hari. 2. Farmasi banyak pendingan resep di SIMRS karena belum bisa input no apol. 3. Farmasi utang input obat di apol. 4. Jika sudah waktunya input apol farmasi telpon verifikator bahwa resep sudah dikerjakan.
		A	1. Alur fitur "Edit No APOL" : a. Input resep IU di apol b. Copy no apol

			c. Klik kanan sesuai resep yang telah dikerjakan di apol d. Klik "Edit No APOL" e. Paste no apol f. Klik OK 2. Alur perubahan surat kontrol ; a. Farmasi menemukan IU di apol b. Konfirmasi ke grup whatsapp c. Surat Kontrol jika merubah surat kontrol pakai HP IFRS dengan format : Form Order Perubahan Tanggal Kontrol Nama pasien : No. RM : DPJP : Tanggal perubahan : Alasan perubahan : IU/TK tanggal berapa d. Pendaftaran mengubah di V-Claim e. Apoteker KIE pasien menuju CSO untuk mengambil surat kontrol, jika obat di primantara maka farmasi mencetak surat kontrol dan di steples ke obatnya. f. Pasien mengambil obat ke farmasi jika sudah ke CSO.
--	--	--	---

3.7.6 Permasalahan Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	LIS belum berjalan karena menunggu bridging SIMRS	P	Membuat target pelaksanaan LIS di Labortorium RSPH Malang.
		D	Mengingatkan programmer untuk segera menyelesaikan bridging.
		S	LIS belum bisa diaplikasikam dikarenakan belum bridging dengan SIMRS.
		A	Follow up berkala ke Programmer.
2.	Petugas belum kompeten dalam pelaksanaan crossmatch labu darah	P	Mendaftarkan pelatihan/magang secara bergilir.
		D	1) Melakukan pendampingan terhadap petugas yang melakukan crossmatch. 2) Melakukan pelatihan dengan vendor.
		S	Hasil crossmatch menentukan apakah labu darah bisa diberika kepada pasien atau tidak, jika hasil aglutinasi positif maka tidak bisa diberikan.
		A	1) Melakukan pencatatan pengulangan kegiatan crossmatch. 2) Permintaan labu darah cito ketika malam hari sementara permintaan ke PMI Lawang terlebih dulu. 3) Petugas magang secara bergilir setiap 2 minggu sekali.
3.	Tidak ada fitur nilai normal pada Billing SIMRS sehingga petugas melakukan klik manual.	P	Mengajukan fitur pengisian nilai normal kepada Programmer PT.
		D	Membuat surat pengajuan fitur batas atas dan batas bawah nilai normal untuk

			dilakukan pengisian oleh petugas laboratorium.
		S	Dengan adanya batas atas dan batas bawah yang ditentukan, system akan membaca hasil laboratorium setiap pasien apakah berada pada nilai normal atau tidak.
		A	Follow up ke Programmer PT.
4.	Reagen kadaluarsa dan datang terlambat.	P	Memperbaiki pengadaan reagen di Laboratorium.
		D	Melakukan analisa keterlambatan. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan..
		S	Terdapat reagen yang kosong nasional seperti CKMB, DPJP memutuskan untuk menggunakan pemeriksaan Troponin.
		A	1. Melakukan perbaikan penataan FIFO FEFO pada kulkas Laboratorium. 2. Menjalankan kartu stok dan perencanaan SO. 3. Menentukan stok minimal untuk order reagen.
5.	Pengadaan rectal swab di Lab RS Prima Husada Malang	P	Mengajukan TOR pelayanan rectal swab.
		D	Diskusi dengan Kains Laboratorium RS, dr Ari Putri, Sp.PA
		S	Utilitas jarang tidak direkomendasikan, kecuali jika bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk MCU.
		A	Proses perhitungan unit cost, jika sudah maka akan diajukan TOR.

3.7.7 Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Layanan Poli yang belum masuk kedalam E-RM -Poli KIA -Poli Gizi	P	Melakukan permintaan fitur kepada Programmer PT.
		D	Membuat flow chart alur pelayanan pada Poli KIA dan Poli Gizi untuk diterapkan pada E-RM.
		S	Kekurangan jika kunjungan Poli KIA dan Poli Gizi dilakukan pencatatan secara manual maka hasil konseling tidak terekap dengan baik dan tidak bisa diakses oleh DPJP, sehingga tidak bisa dilakukan tindakan lanjutan yang terintegrasi. Pencatatan manual resiko hilangnya sangat tinggi.
		A	Follow up ke Programmer PT. Hasil konseling disampaikan kepada asisten setiap DPJP.
2.	Kebijakan baru dari BPJS Kesehatan tentang Kunjungan Kontrol Poli Rawat Jalan	P	Menjalankan kebijakan baru dengan meminimalisir complain.
		D	Melakukan pemberitahuan melalui social media sebelum kebijakan dijalankan. Kolaborasi dengan Programmer PT untuk menambahkan fitur surat control fisioterapi.
		S	Perawat fisioterapi masih belum bisa menginput surat kontrol pasien bpjs yg berasal dari surat rujukan utama, sehingga masih pasien masih diarahkan ke pendaftaran

			untuk mencetak surat kontrol
		A	1. Menertibkan pasien control sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 2. Follow up ke Programmer PT.
3.	Pendaftaran masih mendaftar pasien pada waktu jam praktik dokter sudah selesai.	P	Membuat kebijakan terkait pendaftaran pasien.
		D	Mendisplinkan petugas menjalankan SPO.
		S	Dokter spesialis Gigi Anak drg. Ajeng, Sp.KGA komplain karena ada 1 pasien yang didaftar oleh pendaftaran pada waktu jam prakteknya sudah selesai.
		A	1. Menutup pendaftaran poli spesialis di H-10menit sebelum jam praktik selesai. 2. Konfirmasi DPJP jika ada tambahan pasien yang mendekati jam praktik selesai.
4.	ERM Rawat Inap belum terlaksana, ERM rawat jalan masih ditemukan kendala.	P	Merealisasikan pelaksanaan ERM rawat Inap dan rawat Jalan pada tahun 2025.
		D	Kolaborasi dengan Programmer PT.
		S	ERM Rawat jalan sudah terlaksana, tetapi masih banyak ketidaklengkapan dalam penginputan ERM.
		A	1. Follow up terus menerus ke programmer dengan cara screenshoot permasalahan dan dikirimkan via whatsapp guna menindaklanjuti permasalahan tersebut agar proses validasi ERM berjalan lancar. 2. Trial ERM Rawat Inap Bulan Maret 2025.
5.	Pasien BPJS TK dari IGD tidak diberikan pengantar rujukan ke Poli Spesialis.	P	Perbaikan alur rujukan pasien.
		D	Mendisplinkan petugas menjalankan SPO.
		S	Ada 1 pasien dari IGD yg tidak diberikan pengantar rujukan untuk ke poli spesialis bedah plastik dan tidak diarahkan ke pendaftaran untuk informasi jadwal praktek dokter tersebut. Pasien ke pendaftaran pada hari H tidak membawa surat rujukan dan datang pada hari yang tidak ada jadwal dokter tersebut.
		A	Mengingatkan ke KARU IGD terkait alur pasien BPJS TK dan selalu mengarahkan pasien ke pendaftaran untuk informasi jadwal dokter apabila pasien ada kontrol Lanjutan.
6.	Ketidak lengkapan pengisian form rekam medis oleh PPA.	P	Perubahan alur analisa rekam medis.
		D	Mendisplinkan petugas menjalankan SPO.
		S	Ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis oleh semua PPA.
		A	Sosialisasi ke semua PPA tentang ketepatan dan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sehingga tidak ada lagi DRM yang tidak lengkap.
7.	Surat Rujukan penuh masih manual belum SIMRS	P	Pengajuan fitur Rujuk Penuh di SIMRS ke programmer

		D	Karu koordinasi dengan programmer
		S	Surat rujukan penuh tidak lagi manual tetapi bisa langsung terhubung ke VCLAIM sehingga bisa mengurangi waktu tunggu di pendaftaran
		A	1. Follow up ke programmer 2. Monitoring dan evaluasi SIMRS
8.	Perubahan surat kontrol pasien tidak sesuai tanggal IU	P	Mengadakan rapat untuk alur perubahan surat kontrol
		D	Koordinasi dengan Karu IFSRS dan Karu Poli
		S	Untuk perawat poli lebih teliti kembali bila akan menginputkan surat kontrol pasien
		A	Bila terjadi perubahan surat kontrol maka farmasi menarik surat kontrol yang di bawa pasien untuk selanjutnya dan mengarahkan pasien ke CSO untuk ubah dan cetak surat kontrol terbaru

3.7.8 Permasalahan CSSD

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Kebutuhan mesin steam plasma belum terpenuhi.	P	Mengajukan kebutuhan mesin ke PT.
		D	Koordinasi dengan Vendor dan DPJP terkait kebutuhan mesin steam plasma.
		S	Instrument bedah saraf memerlukan perlakuan khusus terkait cara dekontaminasi dan sterilisasinya.
		A	1) Membuat telaah terkait mesin yang saat ini digunakan dan yang dianjurkan. 2) Koordinasi dengan DPJP (dr Fachri, Sp.BS) bahwa sterilisasi alat bedah saraf menggunakan autoclave dengan cara alat dikemas satu persatu.

3.7.9 Permasalahan Laundry

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Hasil pencucian membuat kain terkena bercak putih.	P	Memperbaiki alur pencucian.
		D	Menerapkan alur baru.
		S	Monitoring dan evaluasi alur baru, mencari penyebab kerusakan.
		A	1. Melakukan pemilahan baju dan linen dari unit menggunakan handscoon baru (tidak terkena zak kimia). 2. Melakukan pemisahan pencucian antara linen dan baju IKO.
2.	Pencatatan jumlah linen tidak valid.	P	Memperbaiki pencatatan menggunakan digital.
		D	Pencatatan jumlah linen menggunakan google spreadsheet.
		S	Pencatatan manual beresiko angka tidak terbaca dengan baik sehingga jumlah linen tidak valid.

		A	Pencatatan digital akan dimulai pada awal Bulan Januari 2025, sebelumnya akan dilakukan SO. Rencana dilakukan stok opname setiap bulan. Pencatatan real per lantai.
--	--	---	---

3.7.10 Permasalahan Radiologi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Respon Time Pelayanan Radiologi	P	Memperbaiki respon time pelayanan radiologi.
		D	Kolaborasi antara perawat dan radiographer dengan DS Radiologi.
		S	Pencatatan dapat diketahui respon time pelayanan radiologi dari selesai periksa sampai dengan selesai hasil.
		A	Melakukan pencatatan waktu permintaan dan selesai hasil di Google Spreadsheet.
2.	Menerima permintaan pemeriksaan pasien IGD tanpa ada inputan di SIMRS.	P	Perbaiki alur pelayanan pemeriksaan radiologi dari unit.
		D	Mendisiplinkan petugas menjalankan sesuai SPO.
		S	Petugas IGD sering kali meminta pemeriksaan sebelum dilakukan input untuk menegakan diagnosis. Perawat juga menghapus inputan tanpa konfirmasi petugas radiologi setelah selesai pemeriksaan dan hasil sudah dicetak.
		A	Pemeriksaan dilakukan jika sudah ada inputan di SIMRS. Pemeriksaan yang dihapus tanpa konfirmasi maka menjadi beban petugas yang menghapus.
3.	Pemeriksaan Cito Bed tidak sesuai dengan kriteria	P	1. Mengidentifikasi kriteria pemeriksaan cito bed yang sesuai. 2. Melakukan analisis akar masalah untuk mengetahui penyebab pemeriksaan cito bed tidak sesuai dengan kriteria. 3. Mengembangkan rencana untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan cito bed.
			1. Mengadakan pelatihan untuk tim medis dan tim keperawatan tentang kriteria pemeriksaan cito bed yang sesuai. 2. Mengembangkan checklist untuk memastikan pemeriksaan cito bed sesuai dengan kriteria. 3. Mengimplementasikan sistem pelaporan untuk memantau kualitas pemeriksaan cito bed.
			1. Peningkatan kualitas pemeriksaan cito bed sesuai dengan kriteria. 2. Identifikasi masalah yang masih ada dan perlu diperbaiki.
		A	1. Menyusun SPO pemeriksaan cito bed berdasarkan kriteria. 2. Mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan cito bed.

			3. Mengembangkan rencana untuk memantau dan mempertahankan kualitas pemeriksaan cito bed. 4. Mengadakan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas pemeriksaan cito bed tetap sesuai dengan kriteria.
--	--	--	---

3.7.11 Permasalahan Instalasi Gizi dan Dapur

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Pendistribusian alat makan tidak tercatat dengan baik	P	Memperbaiki alur pengecekan fasilitas RS sebelum pasien KRS.
		D	Kolaborasi Ahli Gizi dengan Pendaftaran IGD, Perawat, CS Pantry, CS Ruangan dan Kasir.
		S	Fasilitas RS resiko hilang karena pasien jika tidak dibuatkan alur yang jelas. Petugas wajib memberikan edukasi untuk meminimalisir kehilangan/kerusakan.
		A	Membuat SPO “Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS”. Sosialisasi kepada Unit Terkait
2.	Selisih antara jumlah barang pada kartu stok dan jumlah fisik bahan makanan	P	Pendisiplinan pengisian kartu stok.
		D	Kolaborasi dengan tim pengolahan dan penyaji dalam pengisian kartu stok bahan makanan.
		S	Risiko kehabisan stok bahan makanan apabila tidak teratur mengisi kartu stok bahan makanan.
		A	Sosialisasi ulang kepada tim pengolahan dan tim penyaji dalam pengisian kartu stok bahan makanan.

3.8 Profil SDM

3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	39	13	6	7	0
		S1 Farmasi		1	0	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		20	12	8	0
		SMK		4	3	1	0
		S1 Akuntansi		0	0	0	0

10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	1	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	6	6	0	0
		D3 Keperawatan		6	5	1	0
16	IGD	Profesi Ners	25	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		9	7	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRS	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	27	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		14	13	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	8	6	5	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		13	7	6	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	15	6	4	0	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	9	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	25	12	6	6	0
		D3 Keperawatan		13	8	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0

		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		8	8	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	7	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	4	0	1
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		2	0	2	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	10	2	1	1	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	7	1	0
30	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	10	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	4	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		4	4	0	0
33	PIPP & MPP	Profesi Ners	5	2	1	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0
36	SDM	S1 Psikologi	2	1	0	1	0
		S1 Ilmu Sosial		1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	46	17	8	9	0
		SMA		24	20	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter	Pendidikan Dokter	5	4	1	4	0

	Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis					
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0

	Gigi Periodontis						
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			460				

Keterangan :
Terdapat penonaktifan sementara 2 staf TTK di unit farmasi dikarenakan magang pribadi, terdapat 1 penambahan dokter spesialis penyakit dalam.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan April 2025 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada Maret April 2025, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 10 Mei 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

NO	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	MULAI BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
2	Batas Media 99	PERUSAHAAN	05 Juni 2024	05 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
3	BPJS KESEHATAN	ASURANSI	01 Januari 2025	31 Desember 2025	Pelayanan Kesehatan	2035/E-PKS/DIR/XII/2024	651/KTR/VII-05/1224
4	CV AUMERTA ANGGUN	PERUSAHAAN	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	PELAYANAN KESEHATAN	164.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	-
5	ESWEJE Aesthetic Center	INSTANSI KESEHATAN	01 Maret 2024	01 Maret 2027	Sterilisasi alat kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9,1202E+12
6	Pelayanan Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	1754/E-PKS/DIR/XII/2022	-
7	Indonesia Smelting Technology	PERUSAHAAN	01 Juni 2024	01 Juni 2026	Rujukan Pelayanan	194/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	005/HRGA-IST/V/2024
8	Instruktur Zumba	AKRE	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Instruktur Zumba	067/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	-
9	Klinik Mutiara Sehat (Karanglo, Lawang, Karangploso)	INSTANSI KESEHATAN	02 Agustus 2021	02 Agustus 2026	Pelayanan Laboratorium	429.77/I-PKS/DIR/VIII/2021	069/PKS/PDP/VIII/2021
10	Klinik Endisa Husada	INSTANSI KESEHATAN	01 Agustus 2023	01 Agustus 2026	Rujukan Pelayanan	148.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
11	Klinik Losari Medika	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2027	Rujukan Pelayanan	-	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024
12	Klinik Pratama Beauty Medika Singosari	INSTANSI KESEHATAN	25 Mei 2024	25 Mei 2027	Rujukan Pelayanan	145/DPM.E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2024
13	Klinik Rawat Jalan Mitra Prima Care	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2027	Pelayanan Kesehatan	346/DPM/E-PKS/DIR/XII/2024	025/MPC/E-PKS/KA/XII/2024
14	Klinik Utama Medika	INSTANSI	24	24 September	Rujukan Pasien	299/DPM/E-	-

		KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/IX/2024	
14	Klinik Utama Rawat Jalan Akasia	INSTANSI KESEHATAN	25 April 2024	25 April 2027	Pelayanan Kesehatan	116/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	011/KUA/E-PKS/HMS/III/2024
15	Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Difabel	AKRE	14 September 2022	13 September 2025	Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Difabel	1378/E- PKS/DIR/X/2022	-
16	Penerjemah Bahasa Madura	AKRE	01 Agustus 2022	02 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Madura	1305/E- PKS/DIR/IX/2022	-
17	Penerjemah Bahasa Asing	AKRE	01 Agustus 2022	01 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Inggris	1288/E- PKS/DIR/IX/2022	-
18	Persada Hospital	INSTANSI KESEHATAN	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Pelayanan Kesehatan	152.45//DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.HS/MOU/X/PH-2022
19	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	19 Agustus 2024	19 Agustus 2026	Penyediaan Darah	246/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0904/02.06.28/UTD/VIII/2024
20	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Juni 2023	30 Juni 2023	Rujukan Pelayanan	-	768/E-PKS/DIR/V/2023
21	PMI Kota Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	01 Desember 2025	Penyediaan Darah	1790/E- PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
22	PRAKTEK BIDAN MANDIRI NIA IRAWATI, S.TR.KEB	INSTANSI KESEHATAN	07 Februari 2024	26 Februari 2027	Rujukan dan Pelayanan Penunjang	081/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	-
23	PT AA International Indonesia	ASURANSI	02 September 2019	02 September 2020	Pelayanan Kesehatan Grab	-	-
24	PT Administrasi Medika	ASURANSI	01 Juli 2024	01 Juli 2027	Asuransi		071/PKS/AdM/ManagedCare/VII2024
25	PT AIA Financial	ASURANSI	04 November 2020	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	No.069/DPM/E- PKS/DIR/X/2020	No. 639/AIA/-DPM/XI/2020
26	PT AJ Central Asia Raya	ASURANSI	02 Juni 2017	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	277/RSPH/E- IKS/DIR/VI/2017	DIR/PKS-RS/1455/VI/2017
27	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Mei 2012	30 APRIL 2013 (selanjutnya)	PELAYANAN KESEHATAN		

				perpanjang otomatis)			
28	PT Alfiza Medika Utama	INSTANSI KESEHATAN	07 Maret 2024	07 Maret 2028	Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024
29	PT Aloita Prima (Harris Hotel Malang)	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	-
30	PT ANTARMITRA SEMBADA CAB. MALANG	PERUSAHAAN	01 Desember 2024	01 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	304.1.DPM/E- PKS/DIR/X/2024	344/MLG/AMS/XII/2024
31	PT APLIKANUSA LINTASARTA	ASURANSI	25 Februari 2015	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MOU/00300/2015
32	PT ASABRI	ASURANSI	13 Desember 2023	12 Desember 2026	PELAYANAN KESEHATAN	1902/E- PKS/DIR/XII/2023	PEFJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
33	PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA	ASURANSI	12 Oktober 2023	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/E- PKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
34	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2017	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
35	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA	ASURANSI	18 November 2024	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	698.21/DPM/I- PKS/DIR/IX/2024	391/ALLISYA-LGL/AG/XI/2024
36	PT ASURANSI ASTRA BUANA	ASURANSI	01 September 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN KESEHATAN	1033/RSPHS/E- PKS/DIR/VIII/2020	26/HID-PM/ASURANSIASTRA/IX/2020
37	PT ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
38	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	ASURANSI	01 Oktober 2023	01 Oktober 2028	Asuransi	183.3/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	157/GI/OPS/Prov-PKS/X/2023
39	PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia (Mandiri Inhealth)	ASURANSI	01 Februari 2023	31 Januari 2025	Asuransi	028.2/DPM/E- PKS/DIRR/11/2023	0.32/AJII.KOP-SBY/PKS/0123
40	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	ASURANSI	01 Desember 2024	01 Desember 2025	PELAYANAN KESEHATAN	361/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	331-11/EB-CONT/2024

41	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (ASURANSI MAG)	ASURANSI	28 Januari 2020	27 Januari 2024	RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
42	PT Asuransi Reliance Indonesia	ASURANSI	06 November 2024	06 November 2027	Asuransi	338/DPM/E- PKS/DIR/XI/2024	024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024
43	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	ASURANSI	07 September 2020	07 September 2025	PELAYANAN KESEHATAN	368/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	163/LGL-ARI/PKS/RS-COB/IX/2020
44	PT ASURANSI SINARMAS	ASURANSI	01 September 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
45	PT ASURANSI SINARMAS MSIG	ASURANSI	10 September 2012	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		063/PKS-AJSMSIG-RS/IX/2012
46	PT ASURANSI TAFAKUL KELUARGA	ASURANSI	02 Januari 2017	01 Januari 2020	PELAYANAN KESEHATAN	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/I/2017
47	PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA	ASURANSI	30 Oktober 2021	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	612/RSPHS/E- PKS/DIR/X/2019	300/PKS/DIR/TKP/X/2019
48	PT AXA SERVICES INDONESIA (ADMEDIKA)	ASURANSI	15 Agustus 2013	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		067/AGR-LEG/ASI/VIII/2013
49	PT Bestari Murni Anugrah	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	rujukan pelayanan	159/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
50	PT BNI LIFE INSURANCE	ASURANSI	25 Juli 2016	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	082/RSPH/E- IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
51	PT CAKRA SURYA HUSADA	PERUSAHAAN	02 Agustus 2022	02 Agustus 2025	ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2022	138/MOU/VIII/CSH/2022
52	PT Citra Karsa Dinamika	PERUSAHAAN	01 Juli 2024	01 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	196/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
53	PT Docdoc Healthcare Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2024	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	-
54	PT Equity Life Indonesia	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	091/ELI/LGL/X/19

55	PT EQUITY LIFE INDONESIA	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		090/ELI/LGL/X/19
56	PT Fullerton Health Indonesia	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis		-	640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
57	PT Global Assistance & Healthcare	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
58	PT Green Mountains Natural Food	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	225/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	01/GMN/KS/VI/2024
59	PT HANWA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI	16 Maret 2015	15 Maret 2016	PELAYANAN KESEHATAN		0088/HLI-GH/PKS-RS/03-2015
60	PT Indo Aneka Atsiri	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	06 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	066/IAA/HRGA/VI/2024
61	PT INDOLAKTO PANDAAN	PERUSAHAAN	10 Januari 2014	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		
62	PT Indonesia Marine	PERUSAHAAN	10 September 2024	10 September 2027	Pelayanan Kesehatan	-	-
63	PT INTERNATIONAL SERVICES PASIFIC CROSS	VENDOR	03 Oktober 2022	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
64	PT JASA RAHARJA	ASURANSI	04 Juli 2022	04 Juli 2027	PENAGANAN DAN PENYELESAIAN SATUAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022
65	PT Java Smartindo	PERUSAHAAN	01 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
66	PT JAYA OBAYASI	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	360/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	
67	PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	ASURANSI	17 Juli 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	034/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	092/KBM-DPM/PKS/VII/2020
68	PT LABBIOGEN ARTHA MEGA	INSTANSI KESEHATAN	02 September 2024	01 September 2027		262/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	B-MKT 01/001/623/VII/2024

69	PT MALANG INTERMEDIA PERS	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
70	PT Medilink Digital Media	ASURANSI	22 Maret 2024	22 Maret 2027	Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024
71	PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI	ASURANSI	28 November 2016	Perpanjangan Otomatis	APLIKASI LAYANAN KESEHATAN	150/PKS- RSPRIMAHUSADA- MAT/DIR/XI/2016	
72	PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL	ASURANSI	08 Juli 2024	08 Juli 2027	PELAYANAN KESEHATAN	200/DPM/E- PKS/DIR/2024	001/MSI/VI/2024
73	PT PAN PACIFIC INSURANCE	ASURANSI	31 Agustus 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
74	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	172/DPM/E- PKS/DIV/VI/2024	-
75	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	
76	PT PLN (Persero)	ASURANSI	02 Juli 2024	31 Desember 2025		261/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0017.Add/HKM.02.01/F010800300/2022
77	PT Prima Sarana Jasa - Asuransi SOS	ASURANSI	17 September 2018	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	735/E- PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
78	PT Prudential Life Assurance	ASURANSI	28 Januari 2021	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	047/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2020	1578/PMN-PLA/XI/2020
79	PT Suprima Mitra Adihusada	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
80	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	11 Juni 2024	10 Juni 2026	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	110/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	JAN-09/C.5.1/2024
81	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	01 Januari 2023	31 Desember 2025	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E- PKS/DIR/I/2023	JAN-01/DIR/2023
82	PT TIRTA INVESTAMA	PERUSAHAAN	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	PELAYANAN KESEHATAN		
83	PT Tonggak Ampuh	PERUSAHAAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	263/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	-
84	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Agustus	31 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	150.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	050/AK/2/VII/TBINA-Kenaf/2023

			2023				
85	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT	PERUSAHAAN	27 Oktober 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	1076/RSPHS/E-PKS/DIR/IX/2020	002/AK/10/V/TBINA-Kenaf/2020
86	PT Unggul Anugrah Sejahtera	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	Rujukan Pelayanan	160/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
87	PT Uniplastindo Interbuana	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2027	Pelayanan Kesehatan	224/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	-
88	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	04 Januari 2021	04 Januari 2024	PELAYANAN KESEHATAN	303/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	002/PKS-COB/I/2021
89	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	22 Maret 2024	22 Maret 2027	PELAYANAN KESEHATAN	183/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	014/PKS-COB/III/2024
90	PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (YMPI)	PERUSAHAAN	01 Juni 2022	01 Juni 2025	PELAYANAN KESEHATAN	004/DPM/E-PKS/VI/2022	/YMPI/II/II/2022
91	PT Yanmar Diesel Indonesia	PERUSAHAAN	15 April 2024	15 April 2027	Pelayanan Kesehatan	108/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	107/YADIN/Pdn/Pga/IV/2024
92	PT Zurich Asuransi Indonesia TBK	ASURANSI	25 Juni 2024	24 Juni 2029	Asuransi	151/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	268/ZAI-LEG-AGR/VI/2024
93	RS Islam UNISMA Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Januari 2024	31 Desember 2026	Rujukan Pelayanan	222.11/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	08/PKS/RSI-4/I/2024
94	RS Lavalette	INSTANSI KESEHATAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027		236/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	DA01-ADDNM-BB/P-B/24-07-16/138
95	RS Prima Husada Sukorejo	INSTANSI KESEHATAN	01 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pelayanan Kesehatan	1376/E-PKS/DIR/X/2022	1608/RSPJS/E-PKS/DIR/X/2022
96	RS Siti Miriam Lawang	INSTANSI KESEHATAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	264/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	566/HMS/RSSM/VIII/2024
97	RSIA Puri Bunda	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2026	Rujukan Pelayanan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/II/2024
98	RSUD Bangil	INSTANSI	22 Juli	22 Juli 2027	Rujukan Pelayanan	222/DPM/E-	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024

		KESEHATAN	2024			PKS/DIR/VII/2024	
99	Yayasan Bhakti Luhur	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Pelayanan Rohaniawan Agama Kristen	1753/E- PKS/DIR/XII/2022	-
100	RS PANTI NIRMALA	INSTANSI KESEHATAN	07 Oktober 2022	06 Oktober 2025	PELAYANAN RUJUKAN	152.44/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
101	PKM SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	12 April 2022	12 April 2027	TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS	593/I- PKS/DIR/IV/2022	440/894/35.07.103.135.2022
102	KLINIK IDAMAMUK	INSTANSI KESEHATAN	16 Juni 2021	PERPANJANG OTOMATIS	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	/005/VI/2021
103	KLINIK RAWAT INAP MUSLIMAT SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	15 April 2023	15 April 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
104	KLINIK TIRTO HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	18 September 2023	18 September 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
105	KLINIK UTAMA JANTUNG HUSNA MEDIKA MALANG	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	32/11/26	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR-HMMMALANG/XII/2023
106	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR NIA ANITA	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	347/DPM/E- PKS/DIR/2024	
107	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR INDRAWAN DWANTORO	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	348/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	
108	RSJ DR RADJIMAN WEDIODONONGRAT LAWANG	INSTANSI KESEHATAN	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023
109	RSUD DR SAIFUL ANWAR	INSTANSI KESEHATAN	01 November 2024	01 November 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	234/DPM/E- PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024
110	KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN MAWAR WASKITHA HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	23 Januari 2024	22 Januari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
111	PRAKTEK BIDAN MANDIRI RIZA KHUTMI, S.S.T	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	05 Februari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	
112	RSU UNIVERSITAS	INSTANSI	05	22 Agustus	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	248/DPM/E-	081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024

	MUHAMMADIYAH MALANG	KESEHATAN	Agustus 2024	2027		PKS/DIR/VIII/2024	
113	IBAZZ AESTHETIC MEDICAL CENTER BY DR UMMAH	INSTANSI KESEHATAN	14 Juni 2024	14 Juni 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	180/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	
114	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MALANG	INSTANSI KESEHATAN	02 Januari 2025	02 Januari 2026	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD & IMPLANT	2053/E- PKS/DIR/XII/2024	100-3-7/103/35-07-313/2025